۱-۹ طبقه‌بندی معلولیت از دیدگاه توان‌بخشی

معلولین از دیدگاه توان‌بخشی، سه دسته‌اند: معلولین جسمی، معلولین ذهنی و روانی و معلولین اجتماعی.

- طبقه‌بندی معلولین از دیدگاه توان‌بخشی
  - ۱. معلولین جسمی
    - ۱-۱- معلولین قطع عضو
      - ۱-۱-۱-قطع اندام فوقانی یا بخشی از آن
      - ۱-۱-۲- قطع اندام تحتانی یا بخشی از آن
      - ۱-۱-۳- قطع اندام فوقانی یا تحتانی یا بخشی از آنها
    - ۱-۲- اختلالات سیستم عصبی و ضایعات نخاعی
      - ۱-۲-۱- فلج یک عضو
      - ۱-۲-۲-فلج یک طرفه بدن
      - ۱-۲-۳-فلج پاها
      - ۱-۲-۴-فلج دستها و پاها (فلج چهاراندام)
    - ۱-۳- ناهنجاری‌های ارتوپدی
      - ۱-۳-۱- مفصلی
      - ۱-۳-۲-استخوانی
      - ۱-۳-۳-عضلانی
    - ۱-۴- اختلالات بیولوژیکی و متابولیسمی
      - ۱-۴-۱-قلبی و عروقی
      - ۱-۴-۲-کلیوی
      - ۱-۴-۳- تنفسی(ریوی)
      - ۱-۴-۴-صرع
      - ۱-۴-۵-دیابت
      - ۱-۴-۶-هموفیلی و تالاسمی
    - ۱-۵- نابینایی
      - ۱-۵-۱-نابینای مطلق
      - ۱-۵-۲-نابینا
      - ۱-۵-۳-نیمه بینا
      - ۱-۵-۴-دیربینا
    - ۱-۶- ناشنوایی
      - ۱-۶-۱-ناشنوای مطلق
      - ۱-۶-۲-ناشنوا
      - ۱-۶-۳-نیمه شنوا
      - ۱-۶-۴-سخت شنوا
    - ۱-۷-سالمندان
  - ۲. معلولین ذهنی روانی
    - ۲-۱- معلولین ذهنی
      - ۲-۱-۱-آموزش پذیر
      - ۲-۱-۲-تربیت پذیر
      - ۲-۱-۳-پناهگاهی (ایزوله)
    - ۲-۱- معلولین روانی
      - ۲-۲-۱-ناسازگاران (اختلالات هیجانی و رفتاری)
      - ۲-۲-۲-مبتلایان به بیماری‌های روانی مزمن
  - ۳. معلولین اجتماعی
    - ۳-۱-کودکان آسیب‌دیده
      - ۳-۱-۱-کودکان بی‌سرپرست
      - ۳-۱-۲-کودکان خیابانی
      - ۳-۱-۳-کودکان فراری
      - ۳-۱-۴-کودکان بزهکار
    - ۳-۲- محکومین درازمدت زندان‌ها
    - ۳-۳- معتادین
    - ۳-۴- منکدیان
    - ۳-۵- روسپیان (زنان ویژه)

نمودار ۳-۱. طبقه‌بندی معلولین از دیدگاه توان‌بخشی.

قرنیه[1] قرنیه قسمت شفاف جلوی کره چشم است که از پشت آن ساختمان‌های داخلی‌تر کره چشم مثل عنبیه[2] و مردمک[3] دیده می‌شود. قرنیه چشم را می‌توان به شیشه پنجره تشبیه کرد. همان‌طور که اگر شیشه پنجره کثیف باشد اشیاء بیرون تار دیده می‌شوند، اگر بر روی قرنیه کسی لکه یا کدورتی وجود داشته باشد فرد اشیاء را تار می‌بیند. به علاوه همان‌طور که از پشت یک شیشه موجدار یا مشجر اشیاء کج و ناصاف دیده می‌شوند. در صورتی که سطح قرنیه ناهموار باشد اشیاء ناصاف و تار دیده می‌شوند. قرنیه انسان یک تفاوت مهم با شیشه پنجره دارد و آن هم اینکه[4] شیشه پنجره یک سطح صاف است درحالی‌که قرنیه بخشی از یک کره است[5] این ساختمان کروی باعث می‌شود که قرنیه چشم مثل یک ذره بین عمل کند و نورهایی را که از محیط خارج وارد کره چشم می‌شوند به صورت پرتوهای همگرا درآورد که تصویر واضحی روی شبکیه ایجاد کنند. البته در همه افراد این امر به صورت دقیق اتفاقی نمی‌افتد. مثلاً اگر انحنای قرنیه کسی بیشتر از حد طبیعی باشد تصاویر به جای آنکه روی پرده شبکیه بیفتد در جلوی پرده شبکیه تشکیل می‌شود. چنین فردی دچار نزدیک بینی[4] می‌شود. همچنین اگر انحنای قرنیه کسی کمتر از حد طبیعی باشد تصاویر به جای آنکه روی پرده شبکیه بیفتند در پشت آن تشکیل می‌شوند. چنین فردی دچار دوربینی[5] خواهدشد. به طوری که می‌بینیم قرنیه افراد نقش مهمی در تعیین دوربینی یا نزدیک‌بینی یا شماره چشم افراد دارد به همین علت اکثر روش‌های جراحی برای اصلاح دید و شماره عینک روی این بخش از چشم انجام می‌گیرد.

عنبیه و مردمک: عنبیه بخش رنگی پشت قرنیه است که رنگ چشم افراد را تعیین می‌کند رنگ این بخش در چشم افراد مختلف متفاوت است و از آبی و سبز تا عسلی و قهوه‌ای تغییر می‌کند. در وسط عنبیه سوراخی به نام مردمک وجود دارد که مقدار نور وارد شده به چشم را تنظیم می‌کند. کار مردمک مثل پرده‌ای است که پشت پنجره آویزان شده و نور ورودی به اتاق را کم و زیاد می‌کند همان‌طور که وقتی نور خارج شدید و زیاد باشد، پرده را می‌بندیم تا نور کمتری به اتاق وارد شود، وقتی چشم

در درمان به‌جز تجویز دارویی، درمان با الکترو شوک[1] نیز بنا بر تشخیص روان‌پزشک در برخی بیماری‌های روانی کاربرد دارد.

الکتروشوک: این روش درمانی با گذراندن مقداری برق از الکترودهایی انجام می‌پذیرد که روی سر بیمار و در حالت بیهوشی کار گذاشته می‌شود. بیشترین کاربرد آن در درمان افسردگی است و براساس نظر روان‌پزشک ممکن است تا چندجلسه تجویز شود. اثرات درمانی آن سریع‌تر از دارو درمانی است و به دلیل بیهوشی، بیمار هیچ تجربه‌ای از احساس برق‌گرفتگی در طول الکتروشوک نخواهدداشت. فقط ممکن است پس از به هوش آمدن سردرد مختصری داشته و تا دقایقی گیج‌ومنگ باشد که این از عوارض بیهوشی و زودگذر است. مهمترین عارضهٔ الکتروشوک فراموشی کوتاه مدت است که معمولاً پس از چند هفته خود به خود بهبود می‌یابد. (احمدی سرتختی، ۱۳۸۹).

مشاوره با بیمار و خانواده: اختلالات روانی نه تنها سبب ناکارآمدی بیماران روانی می‌شوند، بلکه خانواده‌های آنها را نیزبه شدت تحت تأثیر قرارداده و عملکرد آنها را مختل می‌سازد این تأثیرگذاری در ابعاد مختلفی همچون سلامت روان و عملکرد اجتماعی و اقتصادی قابل مشاهده بوده و در مجموع، بهزیستی خانواده را کاهش و فشار زیادی بر آنها تحمیل می‌کند (سارتوریوس و همکاران، ۲۰۰۳، ترجمه برجعلی و همکاران، ۱۳۹۰).

خانواده به‌صورت یک نظام واحد به هم پیوسته عمل می‌کند که بین اعضای آن روابط ویژه‌ای وجود دارد این روابط بر کارکرد این نظام و ارتباط آن با دنیای بیرون تأثیر می‌گذارد. تغییر در یکی از اعضای خانواده بر کل نظام و بر تک تک اجزای آنها و روابط آنها با جهان بیرون اثر دارد و آن را دگرگون می‌سازد. بسیاری از اوقات وجود بیماری روانی در یکی از اعضای خانواده به معنی اختلال در روابط کلی افراد خانواده است و از طرف دیگر بهبود فرد بیمار به بهبود کارکرد و روابط کل افراد خانواده بستگی دارد. یکی از دردناک‌ترین جنبه‌های مرتبط با بیماری‌های روانی نه نفس خود بیماری یا علائم آن، بلکه نگرش‌ها و دیدگاه‌های افراد جامعه نسبت به بیماران روانی و خانواده‌های آنان می‌باشد. درصد زیادی از خانواده‌های بیماران روانی مورد تبعیض و تمسخر قرار می‌گیرند و به دلیل انگ یا برچسب، شمار قابل توجهی از آنها از وجود بیمار روانی در خانواده احساس

---

1. Electro Convulsive Therapy(ECT)

اقدامات توان‌بخشی معتادین: از اقدامات مؤثر در این مسئله مبادرت در امر بازپروری معتادین می‌باشد. بازپروری معتادین، در معنای کلی، عبارت از فعالیت‌های تربیتی، آموزشی، پزشکی و مددکاری اجتماعی که در جهت اعتیادزادیی و بازگردانیدن فرد معتاد به شرایط طبیعی زندگی صورت می‌گیرد.

به کمک بازپروری، می‌توان شخصیت و منش و رفتار فرد معتاد را بازسازی کرد و او را آمادهٔ زندگی و کار و پذیرش مسئولیت‌های فردی و اجتماعی ساخت، به عبارت دیگر بازپروری فعالیتی است علمی و تخصصی که از طریق آن به مدد شیوه‌ها، فنون تکنولوژی و یا بهره‌گیری از دانش‌های جدید فرد از بندهای اعتیاد نجات می‌یابد و شرایط و امکانات سازگاری با محیط اجتماعی برای او فراهم می‌شود (محسنی تبریزی، الف ۱۳۸۰)

۸-۸ متکدیان

تکدی پدیده‌ای است اجتماعی که هم بر سرنوشت فرد و هم بر کل جامعه اثر می‌گذارد. تکدی از آن رو پدیده‌ای اجتماعی است که در هر جامعه صورتی خاص می‌یابد، انواعی چند می‌پذیرد و با روش‌های خاص متحقق می‌شود. زمانی که در یک جامعه ارزش‌ها سخت مخالف تکدی است، افراد بی‌بضاعت راه‌های دیگری برای ارتزاق می‌یابند و حال آنکه در برخی از جوامع تکدی را از آغاز همچون شیوه‌ای معمول و مقبول مطرح می‌سازند.

متکدیان از طریق جلب ترحم دیگران و جمع‌آوری اعانات، گاهی علاوه بر تأمین معاش خود به مال‌اندوزی می‌پردازند. مسئله عمدهٔ گروه متکدیان، مضاعف بر سربار بودن، آمادگی برای ارتکاب جرائم مختلف است. بررسی‌های انجام شده محرز ساخته که معمولاً در تعداد قابل توجهی از جرائم، ردپای متکدیان مشهود است. ساخت خاص هر جامعه زمینه‌ساز کمیت و کیفیت پدیده تکدی است. به بیان بهتر تکدی در هر جامعه شکل خاص آن جامعه را به خود می‌گیرد و بدون شناخت کل آن جامعه قابل تفسیر یا تقلیل نیست.

بین تکدی و جامعه نوعی کنش و واکنش وجود دارد. از جانبی تکدی در بستر جامعه پدید آمده، رشد می‌یابد و از جانبی دیگر پس از پیداییش خود بر جامعه تأثیر می‌گذارد. شهری که در آن هزاران متکدی وجود دارد خواه ناخواه چهره‌ای زشت،

اقدامات توان‌بخشی معتادین: از اقدامات مؤثر در این مسئله مبادرت در امر بازپروری معتادین می‌باشد. بازپروری معتادین، در معنای کلی، عبارت از فعالیت‌های تربیتی، آموزشی، پزشکی و مددکاری اجتماعی که در جهت اعتیادزادیی و بازگردانیدن فرد معتاد به شرایط طبیعی زندگی صورت می‌گیرد.

به کمک بازپروری، می‌توان شخصیت و منش و رفتار فرد معتاد را بازسازی کرد و او را آمادهٔ زندگی و کار و پذیرش مسئولیت‌های فردی و اجتماعی ساخت، به عبارت دیگر بازپروری فعالیتی است علمی و تخصصی که از طریق آن به مدد شیوه‌ها، فنون تکنولوژی و یا بهره‌گیری از دانش‌های جدید فرد از بندهای اعتیاد نجات می‌یابد و شرایط و امکانات سازگاری با محیط اجتماعی برای او فراهم می‌شود (محسنی تبریزی، الف ۱۳۸۰)

۸-۸ متکدیان

تکدی پدیده‌ای است اجتماعی که هم بر سرنوشت فرد و هم بر کل جامعه اثر می‌گذارد. تکدی از آن رو پدیده‌ای اجتماعی است که در هر جامعه صورتی خاص می‌یابد، انواعی چند می‌پذیرد و با روش‌های خاص متحقق می‌شود. زمانی که در یک جامعه ارزش‌ها سخت مخالف تکدی است، افراد بی‌بضاعت راه‌های دیگری برای ارتزاق می‌یابند و حال آنکه در برخی از جوامع تکدی را از آغاز همچون شیوه‌ای معمول و مقبول مطرح می‌سازند.

متکدیان از طریق جلب ترحم دیگران و جمع‌آوری اعانات، گاهی علاوه بر تأمین معاش خود به مال‌اندوزی می‌پردازند. مسئله عمدهٔ گروه متکدیان، مضاعف بر سربار بودن، آمادگی برای ارتکاب جرائم مختلف است. بررسی‌های انجام شده محرز ساخته که معمولاً در تعداد قابل توجهی از جرائم، ردپای متکدیان مشهود است. ساخت خاص هر جامعه زمینه‌ساز کمیت و کیفیت پدیده تکدی است. به بیان بهتر تکدی در هر جامعه شکل خاص آن جامعه را به خود می‌گیرد و بدون شناخت کل آن جامعه قابل تفسیر یا تقلیل نیست.

بین تکدی و جامعه نوعی کنش و واکنش وجود دارد. از جانبی تکدی در بستر جامعه پدید آمده، رشد می‌یابد و از جانبی دیگر پس از پیداییش خود بر جامعه تأثیر می‌گذارد. شهری که در آن هزاران متکدی وجود دارد خواه ناخواه چهره‌ای زشت،

۳. تدوین برنامهٔ سازگاری زندانی با زندگی در خارج از زندان در ماه‌های آخر محکومیت با استفاده از امکانات موجود در زندان‌ها وخانواده توسط مددکاران اجتماعی زندان (مرخصی کوتاه مدت) (دانش، ۱۳۷۲).

۸-۷ معتادین

تعریف نسبتاً ساده و در عین حال دقیق سازمان جهانی بهداشت از معتاد عبارت است از: فرد با هر نوع وابستگی دارویی و یا روانی به مواد مخدر، معتاد شناخته می‌شود. اصولاً معتاد به کسی اطلاق می‌گردد که به یکی از مواد افیونی اعتیادزا وابستگی نسبی و رفتاری پیدا کرده، به‌طوری‌که در صورت قطع این عمل، با مشکلات جسمی، روانی و رفتاری به تنهایی و یا با هم رو به رو گردد.

علاوه بر این معتاد با تداوم مصرف از نظر ظاهری و رفتاری، به تعریف صوری معتاد در جامعه شبیه شده، آرام آرام هنجارهای جامعه معتادان و فرهنگ متعلق به ایشان را می‌پذیرد، و در نتیجه مصداق برچسبی می‌شود که معتاد نام دارد.

بسیاری از محققان مسائل مربوط به اعتیاد به خصوص اکثر افراد عادی جامعه براین باورند که ساختمان شخصیت برخی افراد برای پذیرش اعتیاد مساعدتر از دیگران است. اینان می‌پندارند که این زمینه مساعد بی گمان شرط اول و لازم ابتلاست و بدین‌ترتیب مسئله را بیش از حد ساده می‌کنند.

تحقیقات اخیر با استناد به مطالعات جامع و مدلل نشان داده شده است که در کنار افراد وابسته به یکی از مواد مخدر، تعداد قابل توجهی از افرادی را می‌توان یافت که از نظر شخصیتی مستعد اعتیاد به مواد مخدرند، یعنی در معرض خطر اعتیاد به یکی از انواع مخدرها قرار دارند. بی‌تردید افرادی که مستعد اعتیاد شناخته می‌شوند، بیش از دیگران در معرض خطر وابستگی قرار دارند. گرچند مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته است از جهت پیشگیری بی‌نهایت سودمند است، باید توجه داشت که تنها این عده نیستند که به اعتیاد گرایش پیدا می‌کنند. البته شرایط عاطفی شخصی برای سوق‌دادن فرد به اعتیاد شرطی لازم است اما مطلقاً شرط کافی به حساب نمی‌آید. (عودهی مقدم و جغتایی، ۱۳۸۵).

دانشگاه پیام نور

توان‌بخشی گروه‌های خاص

دکتر علی‌اصغر کاکوجویباری اعظم شریفی



در حیطه کودکان موجب شده است تا این تعریف نیز دچار چالش‌هایی گردد و تعریف‌های دیگری نظیر موارد زیر نیز ارائه شود:

"توان‌بخشی عبارت است از فرآیندی متشکل از اقدامات هدفمند[1] در جهت قادرسازی[2] شخص معلول، به‌منظور دستیابی به سطح نهایی توانایی و عملکرد جسمی، ذهنی، روانی، اجتماعی و حفظ این توانایی‌ها".

" توان‌بخشی وسیله‌ای است در جهت تغییر زندگی معلولان برای استقلال بیشتر". (کاکوجویباری و همکاران، ۱۳۹۱).

۱-۳ اهداف توان‌بخشی

به‌طور کلی می‌توان چنین گفت که "هدف نهایی فرآیند توان‌بخشی، درمان نیست، بلکه افزایش و ارتقاء عملکردهای فرد و بالابردن سطح توانمندی فرد جهت انجام امور و کارکردها به‌صورت مستقل است". "اهداف توان‌بخشی نوین براساس دیدگاه ارزش مداری افراد ناتوان و با تکیه بر توانمندی‌های موجود این گروه از افراد جامعه، در دو دسته قابل طبقه‌بندی است، دسته اول عبارتند از: اهدافی که مرتبط با شخص آسیب‌دیده می‌باشد و دسته دوم عبارتند از اهدافی که مرتبط با جامعه و بسترهای اجتماعی لازمه دراین‌خصوص قرار می‌گیرند. اهداف کلی درخصوص شخص آسیب‌دیده عبارت است از:

- پیشگیری از تشدید عوارض و مشکلات حاصل از عامل ناتوان‌کننده؛
- ارتقاء توانمندی‌های موجود؛
- به‌کارگیری فرد آسیب‌دیده در عملکردهایی واقعی و متناسب؛
- کمک به سلامت روانی واعتماد بنفس.

اهداف کلی درخصوص جامعه و بسترهای اجتماعی لازمه عبارتست از:

- آماده‌سازی پذیرش شخص آسیب‌دیده به‌عنوان یک فرد دارای ارزش و کارکردهای اجتماعی؛
- ایجاد شرایط مناسب در جامعه برای افراد آسیب‌دیده به لحاظ امور ساخت و ساز تسهیلات زندگی شهری؛

- ایجاد زمینه‌های شغلی و فرصت‌های درآمدزایی برای افراد آسیب‌دیده برابر با سایرین؛
- پذیرش حق و حقوق شغلی افراد آسیب‌دیده برابر با سایرین.

۱-۴ تاریخچهٔ توان‌بخشی در جهان

پدیدهٔ معلولیت سابقه‌ای به قدمت تاریخ زندگی بشری دارد. تحقیقات باستان‌شناسان نشان می‌دهد که ناهنجاری‌های اسکلتی از عهدهای بسیار دیرین موجود بوده، مومیایی‌های ۵۰۰۰ سال قبل از میلاد، گواه سل ستون فقرات و تورم مفاصل است. مصریان باستان اولین گروه‌هایی بودند که نسبت به معلولین و زندگی آنان علاقمندی نشان دادند. در نوشته‌های قدیمی مصر (پاپیرس) ۱۵۵۰ سال قبل از میلاد، توصیه‌ها دستورالعمل‌های پزشکی، سحر و جادوهایی برای درمان بسیاری از بیماری‌ها آمده است. در این سند تاریخی مطالبی نیز برای درمان عقب‌ماندگی ذهنی، صرع، نابینایی و ناشنوایی ذکر شده است. اما به‌طور کلی نگرش حذف معلولان، هنوز در بسیاری از جوامع حاکم بود.

رومیان و یونانیان بر این عقیده بودند که یک جامعه پویا و زنده از توان بالقوه شهروندان نشأت می‌گیرد. آنان قوانینی تصویب نمودند که براساس آن افرادی که قادر نبودند به برتری جامعه کمک کنند، در اولین فرصت حذف شوند. به مرور و با گذشت زمان، توجه به زندگی معلول از جنبه‌های پزشکی آغاز شد و مسئله درمان در مرحله اول اهمیت قرار داشت اما همچنان تا نیمه قرن هیجدهم، هیچ‌گونه امکانات آموزشی برای معلولین در نظر گرفته نشد. از دیدگاه رومیان و یونانیان، انواع معلولیت نیاز به توجه داشتند، ناشنوایی، نابینایی و بیماری روانی و در این میان مسئله بیماران روانی در افکار پزشکان و فلاسفه، بیشترین توجه را به خود اختصاص داد. انسان‌های اولیه عمیقاً معتقد بودند که عامل ایجاد و اختلال جسمی و روانی، خدایان هستند و معلولیت به‌عنوان تنبیه به کسانی تحمیل می‌شود که مشمول غضب قرار گرفته‌اند، اما بقراط سعی کرد که علم پزشکی را از خرافات تفکیک کند و در نتیجه تلاش در جهت تشخیص و درمان بیماران آغاز گردید.

اکثریت انسان‌ها می‌گردد و شامل همه نمی‌شود به‌عبارت دیگر تعدادی به‌رغم انسان‌بودن به‌دلیل شرایطی از این قاعده مستثنی می‌گردند و همگن با سایرین نبوده و از توانایی‌های مشابه محروم می‌شوند، عموماً به این گروه از انسان‌ها، معلول اطلاق می‌گردد.

از آنجاکه معلولیت هم بر سرنوشت فرد و هم بر کل جامعه اثر می‌گذارد مسئله‌ای اجتماعی تلقی می‌گردد و توان‌بخشی به عنوان یک پدیده پاسخی به نیاز فرد و جامعه است که از یک سو به زندگی فرد معلول در جامعه امید ببخشد و از سویی دیگر جامعه را برای پذیرش معلول به عنوان یک شهروند آماده سازد.

۲-۱ تعریف توان‌بخشی

توجه به معنی واژه توان‌بخشی[1] می‌تواند نقطه آغاز مناسبی برای دستیابی به تعریفی کامل باشد. این کلمه از دو بخش تشکیل گردیده است، بخش اول به معنای "دوباره"[2] و "مجدد" است وبخش دوم به معنای "توانمندسازی"[3] می‌باشد بنابراین معنای کامل و دقیق آن در زبان فارسی "بازتوانی" خواهد بود اما به علت فراگیرشدن اصطلاح "توان‌بخشی" در کلیه امور اداری و کتب و نامگذاری‌های مراکز و مجتمع‌های ارائه‌کننده چنین خدماتی از این واژه استفاده می‌شود. توجه به موارد فوق‌الذکر و تنوع عوامل تاثیرگذار می‌تواند توجیه‌کننده طیف وسیع دیدگاه‌های کاربردی و عملکردی در این خصوص باشد. ولی نکته اصلی و مورد توافق همگانی در تعریف توان‌بخشی که به‌عنوان یک توصیف ساده و همه شمول مورد استفاده و کاربرد قرار می‌گیرد، این مسئله است که توان‌بخشی مجموعه اقدامات و مداخلاتی[4] را در بر می‌گیرد که موجبات ارتقاء[5] و رشد[6] عملکرد فرد آسیب‌دیده می‌شود و بر سلامت جسمی و سلامت روانی فرد تاثیر بسزایی می‌گذارد تا کیفیت زندگی[7] وی بهبود یابد. هر چند که تعریف فوق‌الذکر در موارد بسیاری می‌تواند راهگشا و کلیدی تلقی گردد، اما با بسط فناوریی پزشکی و همچنین افزایش طول عمر نوع بشر، حیطه‌هایی نظیر توان‌بخشی سالمندان و توان‌بخشی اجتماعی و با الگوهای پیشگیرانه و ارتقاءدهنده‌ای نظیر توانمندسازی‌های عصبی

---

1 Rehabilitation

گردآمدن بخشی از نیروی کارآمد پزشکی و وابسته پزشکی و بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته در جهت مداوای آنان گردید. این نگرش که معلولین، علیرغم محدودیت‌های خود، قادر به بروز شایستگی‌های جسمی و ذهنی و قابلیت شرکت فعال در امور اجتماعی هستند و نقص عضو نمی‌تواند مانعی در این مسیر ایجاد کند، گسترش پیدا کرد.

از بین رشته‌های مربوط به توان‌بخشی، تخصص ارتوپدی احتمالاً اولین تخصص پزشکی بوده که گسترش پیدا کرده است. در قرن هجدهم در سوئیس مدرسه‌ای برای افراد فلج و معلول، توسط «جین اندرونل» دایر گردید. نورولوژی تا پایان قرن نوزدهم به‌صورت یک تخصص پزشکی جداگانه مطرح نبود در این دوره "دکتر چارکوت"[1] عوامل خونریزی مغزی را با موفقیت مشخص نمود. اثرات ضایعات نخاعی را توصیف کرد و اولین بار توضیح دقیقی از فلج کودکان و عدم تعادل حرکتی ارائه داد. اگر چه مطالعات علمی درخصوص اختلالات روانی و درمان آن توسط "فیلپ پینل"[2] در سال ۱۸۰۰ شروع گردید. روان‌پزشکی تا یک قرن بعد که "امیل کروپ لین"[3] اولین بار طبقه‌بندی بیماران روانی را ارائه داد و "زیکموند فروید"[4] رویکرد روان درمانی را معرفی نمود، یک تخصص شناخته شده نبود (کوپینگ[5] و همکاران، ۲۰۰۱، نقل از کاکوجویباری و همکاران، ۱۳۹۱).

شروع گسترش رویکرد پزشکی، در ارتباط با معلولین در قرن نوزدهم آغازی برای شکل‌گیری مفهوم توان‌بخشی بود. در اوایل قرن نوزدهم در اروپا چند مرکز برای افراد فلج ایجاد شد که بیشتر متمرکز بر خدمات نگهداری بودند. در سال ۱۹۰۶ « دکتر کن‌راد»[6] نخستین آمارگیری معلولین را در برلین انجام داد و این کار منجر به ایجاد مرکزی شد که به‌عنوان اولین مرکز جامع توان‌بخشی جهان از آن یاد می‌شود. گسترش و توسعه برنامه‌های توان‌بخشی، آهسته و کند بود و قبل از جنگ جهانی اول، متوقف شد. در فاصله بین جنگ جهانی اول و دوم، توان‌بخشی متمرکز بر بازتوانی جسمی و حرفه‌ای افراد معلولی بود که در ارتباط با جنگ مجروح شده بودند.

با ظهور دین مسیحیت[1]، دیگر تعدد انواع خدایان مطرح نبود اما در آن زمان معتقدان به این دین نوظهور چنین تصور داشتند که خداوند به‌خاطر گناهان انسان‌ها و یا پدران آنان، چنین تنبیهی را بر معلولان روا داشته‌است. با آغاز قرون وسطی، پیشرفت آهسته و بطئی که در جهت روشنگری و رهایی از خرافات ملاحظه می‌شود، متوقف شد و مجدداً عقاید اولیه درخصوص اعتقاد به روح پلید و جن حاکم گردید. در همین زمان یعنی قرون وسطی قوانین کلیسا تبعیضاتی بر علیه معلولین ایجاد نمود. آنان حق استفاده از ارث، گواهی و شهادت در دادگاه را نداشتند و همچنین از عقد قرارداد و سایر حقوق محروم گردیدند. در قرن سیزدهم موقعی که هنری سوم پادشاه انگلستان دارای دختری ناشنوا شد، یک مورخ معاصر وی، دخترک را چنین توصیف کرد،" کودک گنگی که به هیچ دردی نمی‌خورد." در قرن شانزدهم در آلمان افراد عقب مانده ذهنی داخل قفس محبوس می‌شدند.

در قرن سیزدهم موقعی که هنری سوم پادشاه انگلستان دارای دختری ناشنوا شد، یک مورخ معاصر وی، دخترک را چنین توصیف کرد، کودک گنگی که به هیچ دردی نمی‌خورد. در قرن شانزدهم در آلمان افراد عقب‌مانده ذهنی داخل قفس محبوس می‌شدند. درخصوص عقب‌ماندگان ذهنی، نگرش‌های گوناگونی وجود داشت. برخی حرکات و صحبت‌های زیرلب عقب‌ماندگان ذهنی را گفتگو با شیطان می‌دانستند و گروهی نیز آن را رابطه رمزآمیز بین فرد و الهام الهی تلقی می‌کردند. تا روشنگری‌های قرن هجدهم تمدن‌های اروپایی با ایده سحر و جادو خو گرفته بودند. بالاخره فضای سحر و جادو و بسیاری از خرافات دیگر در فضای رنسانس که منتهی به اطلاعات جدید در پزشکی و روان‌شناسی شد فروکش نمود. با کنار رفتن این‌گونه خرافات، امنیت معلولین افزایش یافت و زندگی آنان تا حدودی ارزش پیدا کرد. در این زمان به علت وقوع رویدادهای متعدد، عارضه معلولیت از لحاظ کمی و سپس در اثر پیشرفتهای علم پزشکی از لحاظ کیفی، دستخوش دگرگونی شد. جنگ‌های پراکنده میان کشورهای اروپایی، آسیایی، انقلاب‌های متعدد در اقصی نقاط جهان و حوادث طبیعی دیگر در افزایش کمی معلولین نقش قابل توجهی ایفاء کرده‌اند. افزایش کمی تعداد معلولان پس از جنگ جهانی اول باعث حساس‌شدن جامعه نسبت به معلولین، اختصاص بودجه،

از جنگ جهانی دوم تا به امروز، مفهوم توان‌بخشی به سرعت و به‌طور وسیعی گسترده شده و نیاز به یک برنامه ملی که تمامی معلولیت را پوشش دهد پیش از پیش احساس می‌شود. تعدادی از پیشکسوتان این رشته در امریکا کمک‌های فوق‌العاده‌ای مبذول داشته‌اند از جمله در سال ۱۹۴۵ "دکتر راسک" طرح اقدامات توان‌بخشی را برای نظامیان نیروی هوایی امریکا برنامه‌ریزی و ارائه نمود. این برنامه برای تسریع در پایان دادن به دوران نقاهت و بازگردانیدن افراد به خدمت مجدد طراحی شد اما بعد برای کلیه مجروحین جنگ و افراد غیرنظامی به اجرا درآمد. "دکتر کسلر"[۲]، پزشک دیگر امریکایی، برنامه توان‌بخشی را برای نیروی دریایی سازماندهی نمود و زمانی که به‌عنوان رئیس توان‌بخشی بین‌المللی فعالیت می‌کرده پیام توان بخشی از طریق وی به سراسر جهان اعلام گردید.

از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم که حرکت توجه به توان‌بخشی علمی و آموزش و پرورش ویژه طی اتفاقاتی که در کتب مربوط به شکل‌های مختلف آورده شد آغاز گردیده و از بعد از دو جنگ جهانی اول و دوم که جنگ افزارهای انفجاری بیداد آفریدند، به اوج رسید. تکنولوژی جدید و مهندسی توان‌بخشی تا جایی که ممکن بود ابزار، ادوات و امکاناتی را ابداع کردند که تا حد زیادی جبران نقص فرد را نموده، توانمندی و مستقل زیستن آنان را افزایش بخشید. جوامع صنعتی به‌تدریج در ساخت و سازها و معماری‌های شهری نیز به رعایت حال معلولان توجه نشان دادند. در دهه شصت قرن بیستم میلادی مسئولین و کارشناسان امور اجتماعی و توان‌بخشی نیاز به بازنگری در روند عرضهٔ خدمات در جامعه را درک کردند. دلیل عمدهٔ آن نیز فزونی رو به تزاید تعداد افراد معلول از یک سو و افزایش روز افزون مشکلات معیشتی این گستره وسیع از انسان‌ها از سوی دیگر بود. حاصل تحقیقات نشان داد ایجاد مراکز و مؤسسه و انباشتن گروهی از معلولان در آن به هیچ وجه شیوهٔ مناسب و صحیحی نیست. لذا طرحی نو با عنوان «توان‌بخشی مبتنی بر جامعه»[۳] جایگزین شد که راهبرد آن آماده‌سازی جامعه جهت حضور افراد معلول در آن بود. باید جامعه از طریق آموزش، شیوهٔ تطابق‌یابی و همزیستی افراد معلول در کنار افراد عادی را فراگیرد. باید در

توان‌بخشی آموزشی: هدف توان‌بخشی آموزشی عبارت است از فراهم نمودن شرایط ارتقاء دانش و مهارت‌ها در قالب انتقال یافته‌ها و اطلاعات. برنامه‌های آموزشی خاص افراد آسیب‌دیده می‌تواند موارد زیر را شامل شود:

- برنامه آموزش انطباقی[۱]
- برنامه آموزش امور "خودیاری"[۲] به افراد کم توان ذهنی
- برنامه‌های آموزش تحرک و جهت‌یابی[۳] به افراد کم‌بینا و نابینا
- برنامه تربیت شنیداری به افراد مبتلا به آسیب شنوایی
- آموزش مهارت‌های خودیاری و مهارت‌های "فعالیت‌های روزمره زندگی"[۴] به انواع معلولان جسمی- حرکتی نظیر بیماران ضایعات نخاعی، سکته مغزی، فلج مغزی، بیماران دچار ضایعات ارتوپدی

توان‌بخشی حرفه‌ای: توان‌بخشی حرفه‌ای مجموعه اقداماتی است که به جذب، استخدام و نگهداری معلول در شغل مناسب می‌انجامد و بدان وسیله معلول می‌تواند از امکانات و توان‌های خود به بهترین نحو استفاده کند. به عبارت دیگر، توان‌بخشی حرفه‌ای مجموعه خدمات تخصصی پزشکی- روان‌شناسی- آموزشی- اجتماعی است که برای رشددادن امکانات توانجو از طریق ایجاد آمادگی جسمانی - روانی، راهنمایی و آموزش شغلی، کاریابی و به‌کارگمایی و پیگیری ضمن اشتغال اعمال می‌شود. چون انسان موجودی چند بعدی است توان‌بخشی معلولین باید در همهٔ ابعاد روانی، جسمانی، اقتصادی، اجتماعی و شغلی انجام پذیرد تا نتیجهٔ مطلوب به‌بار آید(شفیع‌آبادی، ۱۳۸۸).

توان‌بخشی پزشکی (توان‌پزشکی): توان‌بخشی پزشکی یا به عبارت ساده‌تر توان‌پزشکی عبارت است از مجموعه اقدامات تشخیصی درمانی که در جهت بهبود نقص عارض‌شده و پیامدهای ناتوان‌کننده ناشی از نقص در فرد معلول به انجام می‌رسد. در توصیف توان‌بخشی پزشکی باید پزشک متخصص را به‌عنوان مدیر تیم‌های توان‌بخشی تخصصی در نظر داشت. در این حیطه پزشکان وارد شده به حیطه‌های توان‌بخشی معمولاً در راستای تخصص خود به تیم‌های تخصصی توان‌بخشی وارد می‌شوند. **توان‌بخشی قلبی** یکی از حیطه‌های نوین در عرصه توان‌بخشی، توان‌بخشی

ساخت‌وسازهای معماری امکان تردد و حضور افراد معلول نیز رعایت شود. باید تسهیلات ویژه برای استفاده افراد معلول از امکانات اجتماعی فراهم گردد. باید حقوق افراد معلول تا حد برابر با یک فرد غیرمعلول به وی پرداخت گردد. باید در برنامه‌ریزی و در تصمیم‌گیری اجتماعی حق افراد معلول رعایت شود(WHO، ۱۹۹۴) سازمان بهداشت جهانی سال ۱۹۸۱ میلادی را به‌عنوان سال جهانی توجه به معلولان نام‌گذاری نموده و با اعلام آمارهای تکان‌دهنده‌ای (از جمله جهانی با پانصد میلیون معلول یا از هر ده نفر انسان در سراسر دنیا یک نفر در رنج معلولیت بسر می‌برد) دولتمردان جوامع مختلف را مکلف نمود تا نسبت به بهبود وضع معلولان جامعه خود اهتمام ورزند سپس به‌منظور پیگیری کار یک دورهٔ ده ساله از ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۲ را نیز دههٔ برنامه توجه به معلولان نامید و دولتمردان را مکلف نمود در پایان دهه فوق گزارش عملکرد خود را در قالب منطقه‌ای عرضه کنند و پس از آن نیز به منظور اتمام برخی از برنامه‌های نیمه تمام، ده سال دوم را از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۲ طرح‌ریزی نمود.

۱-۵ تاریخچه توان‌بخشی در ایران

در کشور ایران نیز، توان‌بخشی متکی بر قانونی است که در سال ۱۳۴۷ مورد تصویب و تأیید مسئولین قانونگذاری وقت قرار گرفته است و دولت مکلف شده است تا جهت تجدید فعالیت و حرفه‌آموزی و تقویت روحی کسانی که به علت نقص عضو و یا از دست دادن قسمتی از توانایی خود قادر به انجام کار نیستند، انجمنی به نام انجمن توان‌بخشی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی ایجاد نماید.

تا قبل از سال ۱۳۴۸ چون انجمن توان‌بخشی دارای مرکز درمانی مستقلی برای ارزشیابی و توان‌بخشی معلولین نبود، ناگزیر برای این منظور از امکانات مراکز درمانی عمومی و خصوصی موجود شهری استفاده می‌شد تا اینکه در سال ۱۳۴۸ بیمارستان شفایحیاییان برای انجام امور پزشکی و درمانی معلولین از طرف وزارت بهداری به انجمن توان‌بخشی واگذار گردید. پس از تشکیل وزارت رفاه اجتماعی سابق، انجمن توان‌بخشی از وزارت کار و امور اجتماعی منتزع شد و زیر نظر وزارتخانه مذکور و مستقل و بر مبنای اساسنامهٔ تصویبی خود، فعالیت می‌نمود تا اینکه در سال ۱۳۵۵ با

انحلال وزارت رفاه اجتماعی، انجمن توان‌بخشی زیر نظر وزارت بهداری و بهزیستی وقت قرار گرفت و تا اوایل سال ۱۳۵۸ زیر نظر وزارتخانه مذکور به وظایف محوله را انجام می‌داد.

در اوایل سال ۱۳۵۸ با تشکیل سازمان بهزیستی کشور انجمن توان‌بخشی از وزارت بهداری جدا و در سازمان بهزیستی کشور ادغام گردید که هم‌اکنون نیز به‌صورت یک حوزهٔ معاونت توان‌بخشی در سازمان مزبور فعالیت می‌کند (میرخانی، ۱۳۷۸).

لازم به ذکر است که برای تشکیل اولین دوره آموزش فیزیوتراپی در دانشگاه تهران خانم "مارگریت جانسن"[1] از طرف سازمان بهداشت جهانی به نام مربی فیزیوتراپی به ایران معرفی شد. پس از آن دانشکده علوم توان‌بخشی در سال ۱۳۵۲ بنا به پیشنهاد انجمن توان‌بخشی با سه رشته تحصیلی فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتاردرمانی در مقطع کارشناسی شروع به کار کرد. در سال ۱۳۵۵ رشته شنوایی شناسی در مقطع کارشناسی در دانشکدهٔ علوم توان‌بخشی تأسیس گردید که البته قبل از آن در مقطع کاردانی در دانشگاه شهید بهشتی تدریس می‌شد همچنین در سال ۱۳۶۱ این دانشکده اقدام به جذب دانشجو در رشته ارتوپدی فنی نمود که ابتدا در سطح کاردرمانی و سپس در مقطع کارشناسی آموزش می‌بینند.

۱-۶ حیطه‌های توان‌بخشی

ذیلاً به اختصار به تعریف هریک از حیطه‌ها پرداخته شده است[2].

توان‌بخشی روانی: مجموعه اقداماتی که برای کاهش بحران‌های عصبی – روانی در فرد آسیب‌دیده و خانواده و اطرافیان فرد آسیب‌دیده صورت می‌پذیرد و موجب ارتقاء و بهبود سازگاری آنها با شرایط به‌وجود آمده می‌شود، را توان‌بخشی روانی نام نهاده‌اند. نکته بسیار مهم و حائزاهمیت در مورد توان‌بخشی روانی این است که به دلیل اهمیت و فراگیری اقدامات مذکور توسط کلیه اعضاء تیم توان‌بخشی، توان‌بخشی روانی به‌طور مستقل مطرح نیست بلکه همان‌طور که در نمودار ذیل مشخص گردیده است در کلیه انواع توان‌بخشی جریان دارد.

قلبی است. در سال ۱۹۹۵ براساس توصیه آژانس بین‌المللی تحقیقات و مراقبت‌های بهداشتی (AHCPR)[1] "توان بخشی قلبی" به‌عنوان بخشی از مراقبت‌های قلبی به‌طور رسمی پذیرفته شد. در تعریف و تبیین توان بخشی قلبی می‌توان چنین گفت که" توان بخشی قلبی جزء اصلی از مراقبت‌های بیماران مبتلا به نارسایی قلبی و عروقی با تظاهرات بالینی گوناگون و متفاوت می‌باشد" (گوشه، ۱۳۸۳).

توان‌بخشی سالمندی: به‌عنوان یکی از رشته‌های نوین در کارکرد توان‌بخشی و حیطه‌های تازه وارد به عرصهٔ توان‌بخشی تعریف می‌شود. هدف ازتوان‌بخشی سالمندی عبارت است از: ارزیابی دقیق، درمان و مراقبت‌های ممتد در امر بهداشت و سلامت سالمندان تا عملکردهای مستقل آنها در بالاترین سطح ممکن نگهداری و حفظ شود (کامرانی، ۱۳۸۴).

۱-۷ اصطلاحات مرتبط با معلولیت

امروزه در سطح بین‌المللی ما به سه واژه که معمولاً به‌طور یکسان به کار برده می‌شود، و در عین حال از نظر مفهوم متفاوتند، برخورد می‌کنیم. این سه واژه عبارتند از: نقص[2]، ناتوانی[3] و معلولیت[4] (حاج میرفتاح، ۱۳۶۶) اما از نظر سازمان بهداشت جهانی (W.H.O) واژهٔ معلولیت، یک مفهوم کلی است که سه بعد اصلی را پوشش می‌دهد:

۱. مسائل مربوط به ساختار و عملکرد بدن؛

۲. مسائل مربوط به فعالیت‌های فرد معلول در جامعه ؛

۳. مسائل مربوط به مشارکت فرد معلول در جامعه.

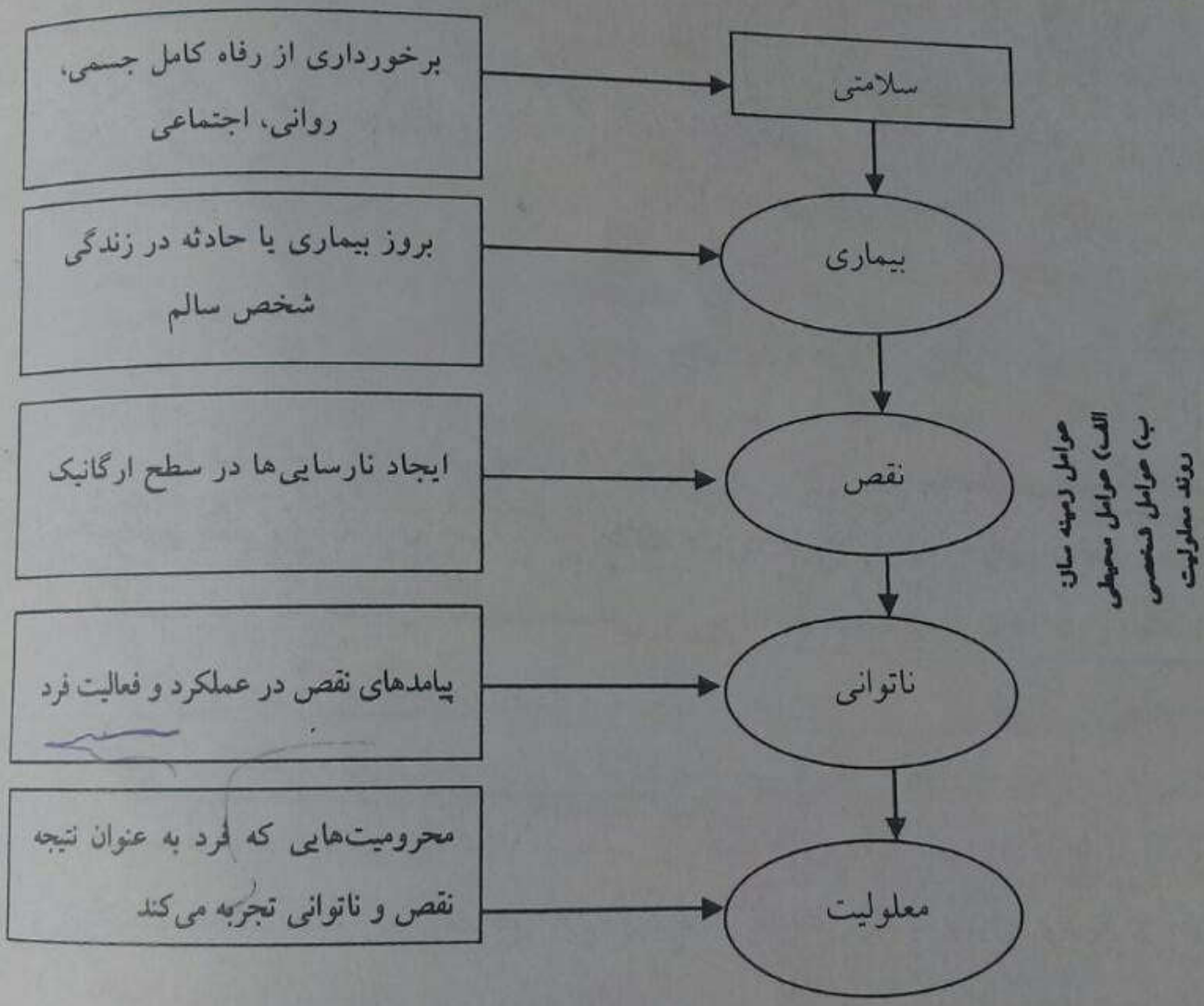
ابعاد مذکور به صورت نقص، ناتوانی و معلولیت طبقه‌بندی شده است. (میرخانی، ۱۳۷۸).

تعریف نقص: مفهوم نقص که از آن تحت عنوان اختلال هم نام برده می‌شود، مرتبط است با غیرعادی‌بودن ساختار، نمود ظاهری بدن، کارکرد ارگانیسم و سیستم بدن که می‌تواند ناشی از هر دلیلی باشد. به عبارت دیگر هرگونه فقدان یا ناهنجاری در زمینهٔ جسمانی، روانی، عملکردی یا آناتومی انسان، نقص نامیده می‌شود (میرخانی، ۱۳۷۸).

تعریف ناتوانی: هرگونه محدودیت یا فقدان در توانایی انجام فعالیت‌هایی که در سطح طبیعی، از هر انسانی انتظار می‌رود، ناتوانی نامیده می‌شود (میرخانی، ۱۳۷۸).

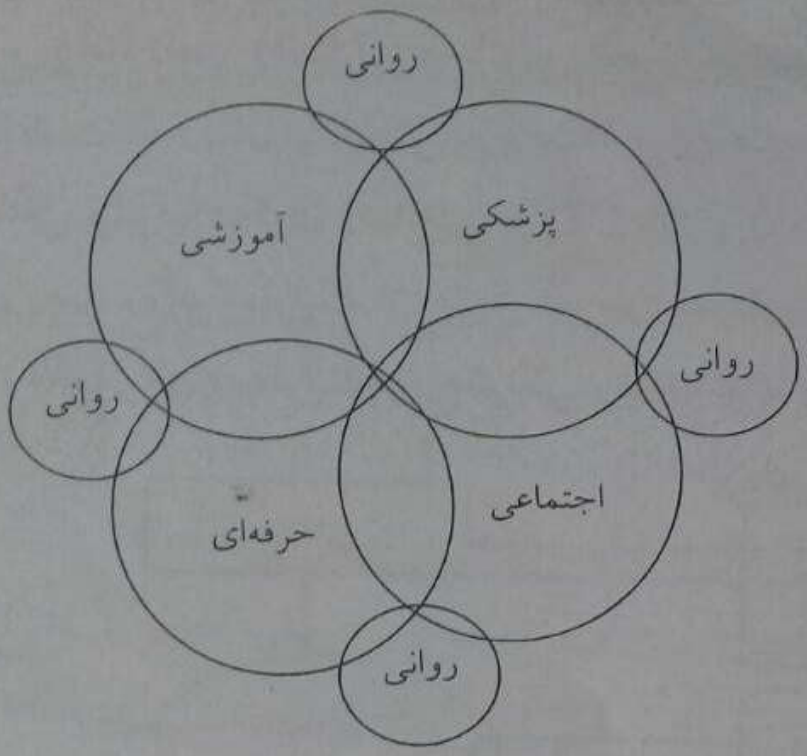
تعریف معلولیت: معلولیت مرتبط است با محرومیت‌هایی که فرد به عنوان نتیجه و پیامد نقص (اختلال) و ناتوانی تجربه می‌کند؛ به عبارت دیگر معلولیت عبارت است از فقدان یا کاهش فرصت‌ها برای سهیم‌شدن در زندگی اجتماعی، در سطحی برابر با دیگران (صالحی، ۱۳۷۲).

بررسی روند معلولیت از طریق نمودار: نمودار ۲-۱ بیانگر تمایز بین مفاهیم «نقص»، «ناتوانی» و « معلولیت» و چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر است. در این نمودار



نمودار ۲-۱. چگونگی روند معلولیت

عوامل زمینه‌ساز که روند معلولیت را به وجود می‌آورد، نشان داده شده است. منظور از عوامل محیطی که خارج از کنترل فرد است شامل نگرش جامعه، ویژگی دسترسی به امکانات جامعه و سیستم قانونی می‌باشد و منظور از عوامل شخصی که مربوط به ویژگی‌های فردی می‌باشد شامل سن، جنس، شرایط جسمانی، شیوهٔ زندگی، عادات،



شکل ۱-۱. جایگاه توان‌بخشی روانی

توان‌بخشی اجتماعی: این حیطه از توان‌بخشی زمینه‌ساز حضور فرد در اجتماع است و بنابراین به رفع موانع و مشکلات در این رابطه جهت فراهم نمودن شرایط بازگشت فرد به عملکردهای اجتماعی می‌پردازد. عمده فعالیت‌ها در حیطه توان‌بخشی اجتماعی بر حول دو محور است:

- تغییر استانداردهای رایج در زندگی اجتماعی (که مطابق با عملکردهای افراد عادی تعریف شده‌اند) در راستای بهینه‌سازی الگوهای دسترسی و خدمات رسانی به افراد آسیب‌دیده. تغییر شرایط در این زمینه می‌تواند طیف بسیار وسیع و گوناگونی را شامل شود که تظاهرات اولیه آن در تغییر الگوهای سازه‌ای ساختمان‌های عمومی نمود می‌یابد و یا در سیاست‌های قانون‌گذاری‌های کلان کشوری به‌صورت محسوس متبلور می‌گردد.
- فراهم‌نمودن شرایط حضور در مکان‌های مناسب و متناسب دارای تجهیزات و امکانات لازم برای فرد آسیب‌دیده جهت فائق‌آمدن بر نقص و ضایعه.

این طبقه‌بندی از معلولین دربردارندهٔ انواع معلولیت‌ها می‌باشند که در نمودار صفحهٔ قبل شمارهٔ (۳-۱) نشان داده شده است (کریمی‌درمنی، ۱۳۸۵).

۱-۱۰ میزان شیوع

با توجه به تنوع شدت معلولیت از نوع خفیف تا بسیار شدید، درکشور ایران میزان معلولیت بدون احتساب معلولیت خفیف ۴/۲ تا ۵درصد و با احتساب معلولیت خفیف بین ۷ تا ۱۰درصد بر آورد شده است. تعداد معلولینی که تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور قرار دارند در سال ۱۳۹۱ براساس گزارش معاون امور توان‌بخشی سازمان بهزیستی کشور ۹۱۹ هزار و ۱۶۳ نفراعلام گردیده است (سخنگویی، ۱۳۹۱مندرج در سایت خبر آنلاین).

بنابر آمار سازمان جهانی بهداشت هم اکنون بیش از ۶۰۰ میلیون نفر از ساکنان جهان به علل مختلف جسمی، روانی و اجتماعی دچار ناتوانی و معلولیت هستند که ۸۰ درصد این افراد در کشورهای جهان سوم زندگی کرده و یک سوم آنان را کودکان تشکیل می‌دهند. آمارها نشان می‌دهد که از هر ۱۰ کودکی که در جهان متولد می‌شود یک معلول به دنیا می‌آید و یا بعد به‌دلیل یک اتفاق، معلول می‌شود. به‌طور میانگین حدود ده درصد از افراد هر جامعه را معلولین تشکیل می‌دهند. آمار منتشره سازمان ملل نشان می‌دهد که در حدود ده درصد از جوانان دنیا یعنی ۲۰۰ میلیون نفر، دارای معلولیت در شش گروه جسمی، حرکتی، ذهنی، بینایی، شنوایی- گفتاری و روانی هستند (عظیمی، ۱۳۹۱، مندرج در سایت تبیان زنجان).

۱-۱۱ خودآزمایی

۱. تاریخچه توان‌بخشی در ایران را توضیح دهید.
۲. ۵ مورد از اقداماتی که در توان‌بخشی آموزشی به‌کار برده می‌شود را بیان نمایید.
۳. توان‌بخشی قلبی و سالمند را توضیح دهید.
۴. حیطه توان‌بخشی ...روانی..... به طور مستقل مطرح نمی‌شود.
۵. در سال ۱۳۵۲ در ایران پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی در رشته‌های تحصیلی فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتار درمانی آغاز شد.
۶. پیامدهای نقص در عملکرد فعالیت فرد منجر به ..... خواهد ز
۷. معلولین از دیدگاه توان‌بخشی به معلولین جسمی، .....و.....طبقه‌بندی می‌ش
۸. در طبقه‌بندی معلولیت از دیدگاه توان‌بخشی، زنان ویژه (روسپیان)در گرو قرار دارند.

حیطه توان بخشی روانی بطور مستقل نیست.

در سال ۱۳۵۲ در ایران پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی در رشته‌های تحصیلی فیزیوتراپی- کاردرمانی و گفتار درمانی آغاز

سابقه اجتماعی، آموزشی و خصوصیات روحی و روانی است که در نحوهٔ تجربه‌کردن معلولیت اثر می‌گذارد. (کریمی درمنی، ۱۳۸۵).

۱-۸ طبقه‌بندی معلولیت از دیدگاه پزشکی

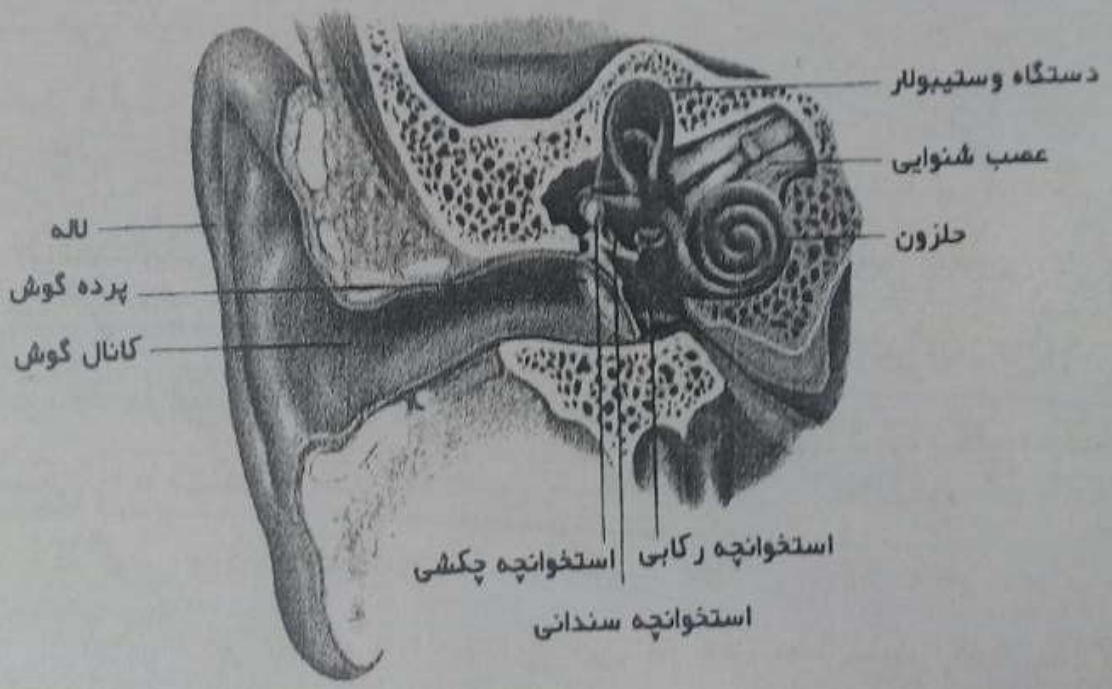
معلولیت‌ها، با توجه به امکانات بازتوانی و ترمیمی و نتایج اجتماعی، اقتصادی به طور کلی در چهار گروه عمدهٔ زیر طبقه‌بندی می‌شوند که هر کدام از این گروه‌ها شامل معلولیت‌های متعدد و متنوع می‌باشند:

- معلولیت‌های حسی شامل معلولیت‌های بینایی و شنوایی
- معلولیت‌های احشایی شامل معلولیت‌های قلبی عروقی، تنفسی و کلیوی
- معلولیت‌های حرکتی شامل انواع معلولیت‌های حرکتی و اعصاب
- معلولیت‌های روانی شامل معلولیت‌های ذهنی و روانی

به‌طورکلی از نظر پزشکی، معلولیت‌های عمده و تشکیل‌دهندهٔ ۴ گروه بالا عبارتند از:

- معلولیت‌های بینایی
- معلولیت‌های شنوایی
- معلولیت‌های تنفسی
- معلولیت‌های ناشی از نارسایی مزمن کلیه
- معلولیت‌های ناشی از دیابت
- معلولیت‌های مربوط به آنزیموپاتی‌ها و اختلالات متابولیسم
- معلولیت‌های ناشی از سوختگی‌ها
- معلولیت‌های ناشی از بیماری‌های روماتیسمی
- معلولیت‌های ناشی از قطع‌شدگی اندام‌ها
- معلولیت‌های ناشی از بیماری‌های عضلانی
- معلولیت‌های حرکتی با منشاء مغزی
- معلولیت‌های ناشی از صرع
- معلولیت‌های ناشی از نارسایی ذهنی کودکان
- معلولیت‌های ناشی از بیماری‌های روانی مزمن (قضایی، ۱۳۶۸).

لاله گوش صدا را جمع‌آوری می‌کند و صدا از طریق کانال خارجی به پرده گوش فرستاده می‌شود و پرده گوش صدا را به ارتعاش تبدیل می‌کند و زنجیره استخوانچه‌ای این ارتعاشات را به حلزون منتقل می‌کند و مایعات حلزونی شروع به حرکت کرده و سلول‌های مویی را تحریک می‌کنند این تحریک باعث می‌شود سلول‌های مویی پیام‌های عصبی تولید کنند، عصب شنوایی این پیام‌های تولیدشده را جمع‌آوری می‌کند و در نهایت مغز پیام‌ها را از عصب شنوایی دریافت و آن را به‌عنوان صدا تفسیر می‌نماید.



۱-۲. شکلی از برش عرضی ساختمان گوش

۲-۳ تعریف معلولیت شنوایی

آسیب شنوایی[1] کارکرد غیر طبیعی یا نقص شنوایی به دلیل اختلال شنوایی می‌باشد و کم‌شنوایی[2] نشانگر معلولیت یا ناتوانی شنوایی است و می‌تواند از لحاظ شدت طیفی از خفیف تا عمیق را شامل بشود.

شنوایی را معمولاً با دسی بل که نوعی سنجش نسبی شدت صوت است اندازه‌گیری و گزارش می‌کنند[3] فرد با شنوایی طبیعی به کسی اطلاق می‌گرددکه نسبت به بسامدهای

قرار می‌دهد و فقط ژنتیک عامل ایجادکننده این نقص نیست عواملی نظیر آسیب صوتی، ضربه و عفونت می‌توانند نقص شنوایی ایجاد نمایند.

گوش کردن، سخن گفتن، نوشتن و خواندن مهارت‌های زبانی محسوب می‌گردند. چنانچه مهارت گوش‌دادن تحت‌الشعاع آسیب شنوایی قرار بگیرد و فرد دچار کم‌شنوایی گردد بر اساس زمان شروع و شدت معلولیت لطمات اساسی بر پیکره مهارت‌های زبانی وارد خواهد آمد و متعاقب با آن فرد کم‌شنوا در برقراری ارتباط کلامی با سایرین، پیشرفت تحصیلی و برآوردن نیاز خود در جامعه دچار مشکل خواهد شد و به همین دلیل دریافت خدمات توابخشی به‌عنوان مسئله‌ای مهم در پیشرفت وی محسوب می‌گردد.

۲-۲ ساختمان گوش

ساختار دستگاه شنوایی از سه بخش تشکیل شده است:

گوش بیرونی[۱]: گوش بیرونی مشتمل بر کانال شنیداری خارجی و لالهٔ گوش می‌باشد. این کانال به غشای صماخی (پردهٔ گوش)[۲] ختم می‌شود که مرز بین گوش بیرونی و گوش میانی است. لالهٔ گوش بخشی از گوش است که در طرفین سر قرار دارد. همان طور که مارتین[۳] (۱۹۸۱) اظهار می‌دارد، لالهٔ گوش بخشی از گوش است که کاملاً قابل رؤیت است، اما از لحاظ شنیدن کمترین اهمیت را دارا می‌باشد. کانال شنیداری خارجی مشتمل است بر موهای زبر[۴] و موم آلود (موم گوش)[۵]، که مسئولیت محافظت از ساختارهای عمیق‌تر گوش در مقابل حشرات و ذرات گردوغبار را برعهده دارند، نقش گوش بیرونی در انتقال اصوات، نقشی نسبتاً جزئی است.

گوش میانی[۶]: گوش میانی مرکب است از پردهٔ گوش و سه استخوان بسیار ظریف (استخوانچه‌ها)[۷] به نام‌های چکشی[۸]، سندانی[۹] و رکابی[۱۰] که در فضایی پر از هوا

فصل دوم

توان‌بخشی معلولان شنوایی

اهداف فصل

در پایان این فصل از شما انتظار می‌رود بتوانید:

۱. قسمت‌های مختلف ساختمان گوش را نام برده و عملکرد هر یک را توضیح دهید.
۲. تمایز ناشنوایی و سخت شنوایی را بیان کنید.
۳. تفاوت نقص شنوایی انتقالی و حسی عصبی را بیان کنید.
۴. زیان‌های تشخیص دیر هنگام آسیب شنوایی را استنباط نمایید.
۵. لیست اقدامات توان‌بخشی برای خردسال کم‌شنوارا مشخص نمایید.
۶. تفاوت آموزش والدین و مشاوره با والدین را بیان کنید.
۷. نقش مددکار اجتماعی را در مشاوره با والدین توضیح دهید.
۸. تفاوت آموزش گفتار و آموزش گفتارخوانی را در توان‌بخشی شنوایی توضیح دهید.
۹. مشکلات اشتغال و کاریابی کم‌شنوا را تشریح کنید.
۱۰. فواید استفاده از سمعک در پیشرفت توان‌بخشی کودک کم‌شنوا را بیان کنید.

۲-۱ مقدمه

گوش انسان وضعیتی آسیب‌پذیرتر از چشم را دارا می‌باشد. گوش دارای مجرایی است که در وقت استراحت و حتی درهنگام خواب مشابه چشم، بسته و محفوظ عمل نمی‌کند. گوش عضوی حساس از بدن محسوب می‌شود که هر آسیبی آن رامورد تهدید

است. یکی از بیماری‌های بسیار شایع مؤثر بر حس شنوایی اتواسکلروزیس[1] است که تشکیل شدن استخوان اسفنجی در اطراف استخوانچه رکابی و در اطراف دریچه بیضی است. تشکیل استخوان اسفنجی حرکت استخوانچه رکابی را در دریچه بیضی محدود می‌کند و به کاهش تدریجی شنوایی منجرمی‌شود علت این بیماری ناشناخته است اما به نظر می‌رسد مستعد بودن فرد از نظر ارثی اهمیت داشته باشد (عادل قهرمان و همکاران، ۱۳۸۵).

عوامل پس از تولد: عفونت‌های پس از تولد مانند سرخک، اوریون، آنفولانزا، تب تیفوئید و مخملک همه با نارسایی شنوایی همراه است. عارضه دیگری که به عفونت پس از تولد مربوط است التهاب گوش میانی است که نوعی تورم گوش میانی است. این عارضه می‌تواند از سرماخوردگی، بزرگ‌شدن لوزه‌ها و لوزه سوم ناشی می‌شود با اینکه التهاب گوش میانی می‌تواند فرد را در هر سنی مورد تهدید قرار دهد، اما در اصل یک بیماری دوران کودکی محسوب می‌شودو عمدتاً در کودکان زیر دوسال رخ می‌دهد (پلتون و وایتلی[2]، ۱۹۸۳). برآورد می‌شود که این بیماری در پنج درصد کودکان زیر ده سال رخ می‌دهد (مارتین، ۱۹۸۱). تشخیص این بیماری به‌ویژه در نوزادی که دارای علائم آشکار نیستند دشوار است و التهاب گوش میانی بالاترین همبستگی را با مشکلات شنوایی در پی خواهدداشت.

لالهٔ گوش و کانال شنیداری خارجی گوش خارجی اهمیت کمتری برای شنوایی (در مقایسه با گوش میانی ودرونی) دارند ولی این امر بدان معنا نیست که مشکلات همراه با گوش بیرونی موجب مشکلات واقعی تعلیم و تربیتی نمی‌شود. شرایط چندی در گوش بیرونی، به‌ویژه در کانال شنیداری خارجی، می‌تواند کودک را به فردی دارای مشکل شنوایی تبدیل کند. برای مثال کودکان ممکن است در معرض کم‌شنوایی به‌خاطر حضور اشیای خارجی در گوش خارجی باشند. (هالاهان وکافمن، ۱۹۴۴، ترجمه ماهر، ۱۳۸۷).

۲-۵ انواع نقص شنوایی

دانستن علل نقص شنوایی و انواع مختلف آن از این جهت اهمیت دارد که در امر آموزش، درمان و توان‌بخشی بعضی از کودکان و دانش‌آموزان آسیب دیده مفید فایده

مختلف شنیداری، حساسیتی (از نظر شدت) در حدود ۱۵-۰ دسی بل داشته‌باشد. کنز[۱] (۲۰۰۲) شش طبقه برای شناسایی مقدار آسیب شنوایی مورد استفاده قرار می‌دهد که هر طبقه ویژگی‌های خود را دارا می‌باشد. (به جدول شماره ۱-۲مراجعه شود).

۱-۲. جدول شدت صوت و طبقه‌بندی درجات آسیب شنوایی

درجات آسیب شنوایی	مقدار شدت صوت(دسی بل)
خفیف[۲]	۲۵-۱۶ دسی بل
مختصر[۳]	۴۰-۲۶دسی بل
متوسط[۴]	۵۵-۴۱دسی بل
متوسط روبه شدید[۵]	۷۰ – ۵۶ دسی بل
شدید[۶]	۹۰ – ۷۱ دسی بل
عمیق[۷]	۹۰ دسی بل به بالا

از سویی براساس ابعاد پرورش زبانی ومیزان بهره‌مندی از ارتباطات، معلولیت شنوایی تحت عنوان ناشنوا و سخت شنوانیز نام‌گذاری شده است. ناشنوا فردی است که ناتوانی اومانع ازپردازش موفقیت‌آمیز اطلاعات زبانی ازطریق حس شنوایی (با استفاده یا بدون استفاده از ابزارهای کمک شنوایی) می‌شود. وسخت شنوا به فردی اطلاق می‌گردد که با استفاده از وسایل کمک شنوایی قادر به پردازش موفقیت‌آمیز از طریق حس شنوایی باشد. (پیتون[۸]، ۱۹۹۱). اگرچند در عرف ناشنوا به کسی گفته می‌شود که هیچ‌گونه شنوایی ندارد اما در حقیقت از نظر صوتی عده بسیارمعدودی را می‌توان یافت که دستگاه شنوایی آنها کاملاً از بین رفته باشد. بیشتر افرادی که از نظر آموزشی در گروه ناشنوایان قرار می‌گیرند دارای مقدارجزئی شنوایی هستند، یعنی حس شنوایی آنها کاملاً از بین نرفته است (نودهی مقدم و جغتایی، ۱۳۸۵).

قرار دارند، در انتقال اصوات و با ارتعاشات پردهٔ گوش زنجیرهٔ استخوانچه‌های چکشی، سندانی و رکابی با دریچهٔ بیضی که رابط گوش میانی و درونی است، برخورد می‌کند. برای پیشگیری از اتلاف معنی‌دار انرژی بین ارتعاش پردهٔ گوش و ارتعاش دریچهٔ بیضی زنجیرهٔ استخوانچه‌ها به چنان شیوه‌ای ساخته شده است که حائز مزایای قوانین فیزیکی غضروف‌ها باشند. (دیویس[1]، 1978a؛ گودهیل و گاگن هیم[2]، ۱۹۷۱ ؛ مارتین، ۱۹۸۱).

گوش درونی[3]: گوش درونی که به اندازهٔ یک لوبیاست، یک مکانیسم پیچیده از هزاران بخش متحرک است (مارتین، ۱۹۸۱) به لحاظ پیچیدگی‌هایش اغلب لابیرنت[4] خوانده می‌شود. گوش درونی را می‌توان بر حسب عملکرد به دو بخش مکانیسم دهلیزی[5] و حلزون گوش تقسیم نمود. با وجود این، این دوبخش مستقل از هم عمل نمی‌کنند. مکانیسم دهلیزی در قسمت بالای گوش درونی واقع است، اطلاعات مربوط به حرکت از طریق عصب دهلیزی به مغز می‌رود و این مکانیسم مسئولیت حس توازن را به عهده دارد.

حلزون گوش مهم‌ترین اندام شنیدن محسوب می‌شود ودر زیر مکانیسم دهلیزی واقع شده است. این اندام حلزونی شکل شامل بخش‌های ضروری برای تبدیل کنش مکانیکی گوش میانی به نشانه‌های الکتریکی در گوش درونی است و درواقع نشانه‌های الکتریکی به مغز منتقل می‌گردند. در یک گوش سالم، صوت موجب حرکت استخوانچه‌های چکشی، سندانی و رکابی گوش میانی می‌شود. وقتی استخوانچه رکابی حرکت می‌کند به دریچهٔ بیضی فشار وارد می‌آورد و موجب می‌شود مایع حلزون گوش درونی سیال گردد. حرکت مایع به نوبهٔ خود موجب زنجیرهٔ پیچیده‌ای از رویدادها در حلزون گوش شده و سرانجام به تحریک عصب حلزونی می‌انجامد و با این تحریک عصب حلزونی یک تکانش الکتریکی به مغز ارسال و صدا شنیده خواهدشد (هالاهان و کافمن[6]، ۱۹۹۴، ترجمه ماهر، ۱۳۸۷).

به بیانی ساده عملکرد کلی دستگاه شنوایی بدین‌گونه است:

۲-۴ سبب‌شناسی

تعدادی از عوامل ممکن است موجب معلولیت شنوایی شوند بین علت آسیب‌دیدگی شنوایی و میزان از دست‌دادن شنوایی، ارتباط وجود دارد. از دست‌دادن بسیار زیاد شنوایی، به‌دلیل منژیت سرخچه مادرزادی و عوامل ارثی رخ می‌دهد. حداقل پنجاه درصد کودکان مدرسه رو که آسیب‌دیدگی ناشی از این علل سه‌گانه دارند، در طیف عمیق (بیش از ۹۰ دسی بل) دچار نقص شنوایی هستند. (کارچمر[1] و همکاران، ۱۹۷۹). به اختصار به هر یک از این عوامل به تفکیک پرداخته شده است.

عوامل پیش از تولد: علت عمده کم‌شنوایی‌های مادرزادی عفونت است که به شایع‌ترین آن می‌توان به سیتومگالو ویروس و سرخجه مادرزادی[2] اشاره نمود.

سیتومگالو ویروس مادرزادی نوعی عفونت ویروسی است که از طریق تماس نزدیک از ماده‌های مترشحه جسمانی شخص مبتلا سرایت می‌کند. همچنین راه دیگر سرایت آن انتقال خون و سرایت از مادر مبتلا به نوزاد تازه متولد شده است. سیتومگالو ویروس شایع‌ترین رویداد ویروسی در میان نوزادان است. هر سال حدود ۴۰۰۰۰ نوزاد به این ویروس مبتلا می‌شوند. بیماری سیتومگالو ویروس با زردی، کوچک سری، کم‌خونی هموگلوبین، ناتوانی هوشی، بزرگی طحال و کبد و نارسایی شنوایی همراه است. با وجود اینکه برای درمان سیتومگالو ویروس واکسنی وجود ندارد برخی اقدامات پیشگیری مانند اطمینان پیداکردن از سلامت انتقال خون، بهداشت خوب و اجتناب از تماس با اشخاص مبتلا به ویروس امکان‌پذیر است. از طریق آزمایش آمینوسنتز، سیتومگالو ویروس در رحم قابل تشخیص است، هرچند که درخصوص درستی آمینوسنتز در تشخیص این عارضه تردید زیادی وجود دارد (موون[3] و همکاران، ۱۹۹۵). سرخجه مادرزادی نیز اختلالی است که سبب نقص جنینی شده و از سرخجه مادر ناشی می‌شود. نشانه‌های آن آب مروارید یا آب سیاه، نقص‌های قلبی عروقی، عقب‌ماندگی ذهنی، عقب‌ماندگی روانی حرکتی و کاهش شنوایی حسی عصبی از نوع شدید یا عمیق می‌باشد (عادل قهرمان و همکاران، ۱۳۸۵).

عوامل ارثی: با وجود اینکه بیش از ۲۰۰ نوع کم‌شنوایی مربوط به عوامل وراثتی شناخته شده است، هنوز علت ۵۰ در صد از موارد نارسایی شنوایی ناشناخته باقی‌مانده

۲-۴ سبب‌شناسی

تعدادی از عوامل ممکن است موجب معلولیت شنوایی شوند بین علت آسیب‌دیدگی شنوایی و میزان از دست‌دادن شنوایی، ارتباط وجود دارد. از دست‌دادن بسیار زیاد شنوایی، به‌دلیل منژیت سرخچه مادرزادی و عوامل ارثی رخ می‌دهد. حداقل پنجاه درصد کودکان مدرسه رو که آسیب‌دیدگی ناشی از این علل سه‌گانه دارند، در طیف عمیق (بیش از ۹۰ دسی بل) دچار نقص شنوایی هستند. (کارچمر[1] و همکاران، ۱۹۷۹). به اختصار به هر یک از این عوامل به تفکیک پرداخته شده است.

عوامل پیش از تولد: علت عمده کم‌شنوایی‌های مادرزادی عفونت است که به شایع‌ترین آن می‌توان به سیتومگالو ویروس و سرخجه مادرزادی[2] اشاره نمود.

سیتومگالو ویروس مادرزادی نوعی عفونت ویروسی است که از طریق تماس نزدیک از ماده‌های مترشحه جسمانی شخص مبتلا سرایت می‌کند. همچنین راه دیگر سرایت آن انتقال خون و سرایت از مادر مبتلا به نوزاد تازه متولد شده است. سیتومگالو ویروس شایع‌ترین رویداد ویروسی در میان نوزادان است. هر سال حدود ۴۰۰۰۰ نوزاد به این ویروس مبتلا می‌شوند. بیماری سیتومگالو ویروس با زردی، کوچک سری، کم‌خونی هموگلوبین، ناتوانی هوشی، بزرگی طحال و کبد و نارسایی شنوایی همراه است. با وجود اینکه برای درمان سیتومگالو ویروس واکسنی وجود ندارد برخی اقدامات پیشگیری مانند اطمینان پیداکردن از سلامت انتقال خون، بهداشت خوب و اجتناب از تماس با اشخاص مبتلا به ویروس امکان‌پذیر است. از طریق آزمایش آمینوسنتز، سیتومگالو ویروس در رحم قابل تشخیص است، هرچند که درخصوص درستی آمینوسنتز در تشخیص این عارضه تردید زیادی وجود دارد (موون[3] و همکاران، ۱۹۹۵). سرخجه مادرزادی نیز اختلالی است که سبب نقص جنینی شده و از سرخجه مادر ناشی می‌شود. نشانه‌های آن آب مروارید یا آب سیاه، نقص‌های قلبی عروقی، عقب‌ماندگی ذهنی، عقب‌ماندگی روانی حرکتی و کاهش شنوایی حسی عصبی از نوع شدید یا عمیق می‌باشد (عادل قهرمان و همکاران، ۱۳۸۵).

عوامل ارثی: با وجود اینکه بیش از ۲۰۰ نوع کم‌شنوایی مربوط به عوامل وراثتی شناخته شده است، هنوز علت ۵۰ در صد از موارد نارسایی شنوایی ناشناخته باقی‌مانده

واقع می‌گردد اختلالات شنوایی ممکن است مربوط به گوش خارجی یا گوش میانی و یا گوش داخلی باشد (گورابی، ۱۳۸۱).

نقایص شنوایی را می‌توان بر حسب محل ضایعه در سیستم شنوایی به گروه‌های ذیل تقسیم نمود.

نقص شنوایی انتقالی: این نوع کم‌شنوایی زمانی اتفاق می‌افتد که بر سر راه انتقال صوت از کانال گوش خارجی به گوش داخلی مانعی ایجاد شود. در این موارد عملکرد گوش داخلی طبیعی بوده ولی ارتعاشات صوتی قادر به راهیابی به حلزون از راه انتقال هوایی نیستند. پارگی پرده گوش، وجود جسم خارجی در کانال گوش و التهاب گوش میانی می‌توانند باعث بروز نقص شنوایی از نوع انتقالی شوند. اغلب کم‌شنوایی‌های انتقالی از طریق دارو یا عمل جراحی برطرف می‌شوند.

نقص شنوایی حسی – عصبی: این نوع کم‌شنوایی زمانی اتفاق می‌افتد که سلول‌های مویی حلزون یا الیاف عصب شنوایی ضایعه دیده باشند. کم‌شنوایی حسی – عصبی غیرقابل برگشت است و اغلب گزارش شده که فرد مبتلا، صحبت دیگران را می‌شنود، ولی قادر به درک آن نمی‌باشد. تأثیر سوء داروها بر گوش داخلی، سروصدای غیرمجاز، سرخجه مادرزادی، اوریون، مخملک و پیرگوشی می‌توانند کم‌شنوایی از وع حسی – عصبی ایجاد نمایند.

نقص شنوایی آمیخته: هنگامی که فردی تواماً دچار کم‌شنوایی انتقالی و حسی-عصبی گردد به نقص شنوایی آمیخته دچار گشته است. در این حالت اگرنقص شنوایی انتقالی هم برطرف شود نقص حسی عصبی همچنان باقی می‌ماند به همین دلیل این نوع نقص شنوایی به‌طور صد در صد بهبود نمی‌یابد.

نقص شنوایی مرکزی: این نوع کم‌شنوایی با کاهش حساسیت شنوایی همراه نیست ولی به درجات مختلف کاهش در درک شنیداری را نشان می‌دهد. یعنی ممکن است فردیک شنوایی طبیعی داشته باشد، ولی قادر به درک گفتار نباشد. کشف کم‌شنوایی مرکزی نیاز به آزمایشات تخصصی شنوایی‌شناسی دارد.

و مطابق گزارش سازمان آموزش و پرورش استثنایی ایران در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹تعداد ۱۰۶۰۱ نفر افراد دارای آسیب شنوایی در مدارس خاص تحت آموزش و توان‌بخشی قرار داشتند (این تعداد افراد کم‌شنوایی که در مدارس عادی تحت آموزش قرار دارند را در برنمی‌گیرد).

۲-۷ آزمون‌های شنوایی

هریک از آزمون‌های شنوایی برای هدف‌های خاصی طراحی شده است و قابلیت‌های متفاوتی دارد، به برخی از این آزمون‌ها به اختصار پرداخته شده است.

شنوایی‌سنجی تن خالص[۱]: اولین و اساسی‌ترین آزمون به‌منظور اندازه‌گیری میزان شنوایی محسوب می‌شود و این آزمون توسط دستگاه شنوایی‌سنجی[۲] و توسط فردی به نام شنوایی‌شناس[۳] در محلی به نام کلینیک شنوایی که از نظر آکوستیکی دارای شرایط ویژه‌ای است انجام می‌شود. هر گوش به‌طور مجزا مورد آزمون قرار می‌گیرد و پس از انجام آزمون ودریافت پاسخ‌های بیمار با رسم مقادیر شدت در برابر مقادیر بسامد، نمودار شنوایی[۴] تن خالص حاصل می‌گردد.

شنوایی سنجی گفتاری[۵]: تست ساده‌ای است که از طریق آن می‌توان توانایی درک اصوات گفتاری را در فرد تشخیص داد. هدف اصلی این روش این است که تعیین نماید در چه شدتی فرد توانایی درک اصوات گفتاری را دارد.

شنوایی سنجی از طریق بازی[۶]: این تکنیک در اصل برای ایجاد همدلی با کودک و برانگیختن او جهت پاسخ‌دهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. آزمایشگر موقعیت آزمون را به شکل یک بازی آماده می‌کند با استفاده از تن خالص یا گفتار آزمایشگر به کودک انجام فعالیت‌های مختلف را در مواقعی که علامتی را می‌شنود آموزش می‌دهد. فعالیت‌ها به گونه‌ای طراحی‌شده که برای کودک جذاب باشند، برای مثال ممکن است از کودک خواسته شود با شنیدن صدا یک بلوک را بردارد، یک عروسک را در آغوش بگیرد یا کتابی را باز کند.

شنوایی سنجی از طریق بازتاب‌ها[1]: نوزادان معمولاً رفتارهایی بازتابی نسبت به اصوات نشان می‌دهند. این رفتارها برای آزمون قوهٔ شنوایی سودمندند. آنچه در آغاز تولد وجود دارد بازتاب مورو[2] است که به‌عنوان حرکت صورت، بدن، دست‌ها، پاها و به هم خوردن چشم‌ها تعریف می‌شود (دیویس، ۱۹۷۸b). پاسخ دیگری که می‌تواند جهت تعیین توانایی شنیدن مورد استفاده قرار گیرد پاسخ جهت‌دار است. این پاسخ زمانی مشهود می‌شود که کودک سر و بدن خود را به سوی منبع صدا بر می‌گرداند.

شنوایی سنجی پاسخ برانگیخته[3]: بیمار در انجام این آزمون‌ها و نتیجه آزمون کمترین نقش و تأثیر را دارد. با ارائه تحریک صوتی، واکنش‌های الکتریکی حاصل‌شده، می‌تواند ثبت شود و نیازی به پاسخ‌دهی بیمار نمی‌باشد. در این آزمون قسمت‌های مختلفی نظیر عصب هشتم مغزی، هسته‌های حلزونی و کورتکس شنوایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و محل ضایعه مشخص می‌شود. ازجمله این دستگاه‌ها به دستگاه پاسخ شنوایی ساقه مغز[4] اشاره می‌شوند که می‌توان آن را در تشخیص کاهش شنوایی کودکان بسیار خردسال و افراد سخت آزمونی که با شنیدن صوت در آزمون‌های شنوایی سنجی تن خالص، قادر به ارائه واکنش نیستند، به‌کار گرفت و استفاده نمود.

۲-۸ نیازها و اقدامات توان‌بخشی

با توجه به توضیحات پیشین برخی از آسیب‌دیدگی‌های شنوایی با اقدامات دارویی و جراحی قابل درمان هستند و فرد پس از بهبودی به زندگی عادی بازمی‌گردد نظیر کم‌شنوایی‌هایی که از نوع نقص شنوایی انتقالی محسوب می‌شوند زمینه این بحث به افرادی تعلق دارد که از بدو تولد دچار آسیب شنوایی شده‌اند و کاهش شنوایی که بر آنان عارض گردیده قابل درمان نبوده و فرد نیازمند بهره‌گیری ازخدمات توان‌بخشی شده است.

تشخیص زودهنگام معلولیت شنوایی: تشخیص زودرس کم‌شنوایی بهترین راهکار برای پیشگیری از معلولیت شنوایی محسوب می‌شود. از آنجایی که سنین اولیه

کودکی بیشترین اهمیت را در رشد مهارت‌های گفتار و زبان دارد کم‌شنوایی خصوصاً در این سن تأثیرات عمیق و نامطلوبی را بر روند زندگی وی خواهد گذاشت.

گوش‌دادن اولین مهارت زبانی محسوب می‌شود که فرد در جریان رشد خود فرامی‌گیرد اگر این مهارت تحت تأثیرآسیب شنوایی قرار بگیرد و به موقع عوامل جبران‌کننده این نقیصه به‌کار گرفته نشود لطمات اساسی بر مهارت‌های زبانی فرد وارد خواهد آمد (کاکوجویباری و همکاران، الف ۱۳۸۹، شریفی و همکاران، ۱۳۸۹).

برنامه‌های بهداشتی سازمان و نهادهای بهداشتی بین‌المللی، منطقه و ملی بر تشخیص زودرس و انجام بیماریابی در سنین نوزادی تکیه و تأکید دارند کودکانی که در سنین تولد تا شش ماهگی مورد تشخیص واقع می‌شوند در مقایسه با کودکانی که بعد از این سن شناسایی شده‌اند توانایی‌های زیادی در زمینه رشد توسعه گفتار و زبان شامل مفاهیم زبانی معنی‌دار و دامنه لغات درک شده داشته‌اند.

امروزه بیماریابی شنوایی نوزادان بدو تولد به‌وسیله آزمون‌های استاندارد الکتروفیزیولوژیک مانند پرتوهای صوتی گوش[۱] در بیمارستان‌های مجهز به این دستگاه توسط کارشناسان شنوایی‌شناسی انجام می‌پذیرد تا در زمان بهنگام، نوزادان مبتلا به کم‌شنوایی شناسایی گردند.

به هر میزان که تشخیص کاهش شنوایی از سنین زبان‌آموزی فاصله بگیرد و کودک از خدمات توان‌بخشی محروم گردد رشد مهارت‌های زبانی او به تعویق خواهد افتاد (اسوان ویک وواتسون[۲]، ۲۰۰۵). این مسئله که ضایعه شنوایی در چه مقطع سنی عارض شده باشد بسیار مهم است زیرا بزرگ‌ترین مشکل در اختلال شنوایی وقتی است که کودک در اولین سنین رشد به آن مبتلا شده و هنوز تکلم و ارتباط زبانی را نیاموخته باشد. پرورش رشد زبانی و مفاهیم کودک کم‌شنوا به دلیل محرومیت از مهارت گوش‌دادن دچارآسیب می‌شود و این آسیب زمانی نمود بیشتری پیدامی‌کندکه تشخیص معلولیت شنوایی، استفاده از سمعک[۳] و بهره‌مندی ازخدمات توان‌بخشی با تأخیر قابل ملاحظه‌ای همراه شود (کاکوجویباری و همکاران، ب ۱۳۸۹).

نقص شنوایی غیرعضوی[1]: افراد دچار این نقص در دو گروه طبقه‌بندی و تعریف می‌شوند.

گروه اول: خود دو دسته هستند، دسته اول به هر دلیل تمایل دارند خود را کم‌شنوا جلوه دهند در حالی که اصلاً ضایعه‌ای در سیستم شنوایی آنها وجود ندارد و یا اگر ضایعه‌ای هم وجود دارد به حدی نیست که وانمود می‌نمایند و دسته دوم کسانی هستند که بالواقع دچار کم‌شنوایی هستند ولی به دلایل گوناگون نظیر موفقیت در پذیرش و استخدام، کم‌شنوایی خود را پنهان می‌کنند و تظاهر به سالم بودن دارند[2].

گروه دوم: کسانی هستند که به‌دلیل مشکلات عاطفی - روانی علیرغم اینکه هیچ‌گونه ضایعه‌ای در سیستم شنوایی خود ندارند احساس کم‌شنوایی می‌کنند. این افراد باید تحت نظر متخصصین اعصاب و روان، و یا روان‌شناس بالینی مورد مشاوره و درمان قرار بگیرند.

۲-۶ میزان شیوع

برآورد تعداد کم‌شنواپان به لحاظ نوع نگاه به مسئله بسیار متفاوت است. مواردی نظیر تفاوت در تعاریف، جمعیت‌های مورد مطالعه ودقت درآزمون ازعلل ارقام گوناگون محسوب می‌شود (هالاهان و کافمن، ۱۹۴۴، ترجمه ماهر، ۱۳۸۷).

مطابق آمار تعیین شده سازمان‌های بین‌المللی از جمله یونسکو تعداد تقریبی افرادی که به لحاظ تفاوت‌های محسوس فردی نیاز به برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای دارند در هر جامعه بین ۱۰ الی ۱۵ درصد می‌باشد. به‌طور کلی مطابق بررسی‌ها و تحقیقات صاحبنظران آموزشی و محققان آموزش و پرورش استثنایی به‌طور متوسط ۱/۵ درصد از حدود ۱۲ درصد کودکان و دانش‌آموزان سنین مدرسه‌رو (۷ الی ۱۸ سال و یا ۶ الی ۱۷ سال) که به نحوی از برنامه‌های آموزش و پرورش استثنایی بهره‌مند هستند در گروه کم‌شنوا قرار دارند (افروز، ۱۳۸۶). براساس گزارش معاونت توان‌بخشی سازمان بهزیستی از مجموع ۹۱۹ هزار و ۱۶۳ نفر معلول تحت پوشش بهزیستی، تعداد ۱۱۳ هزار و ۴۴۵ نفر دارای معلولیت شنوایی هستند (سخنگویی، ۱۳۹۱، مندرج در سایت خبر آنلاین).

مداخله پزشکی: متخصصان متعددی از جمله متخصصان ژنتیک، پزشک خانواده، متخصص گوش و حلق و بینی، جراح اعصاب و شنوایی‌شناس به‌صورت گروهی در ارزیابی و مداخله پزشکی نقش دارند. پیشگیری از نارسایی شنوایی دغدغه اولیه متخصصان ژنتیک است. تعداد بسیاری از نارسایی‌های شنوایی ارثی هستند و طی دوران رشد پیش از تولد هنگام تولد یا پس از تولد رخ می‌دهند. بنابراین متخصصین ژنتیک در پیشگیری از ناتوانایی‌ها از طریق مشاوره خانوادگی و غربالگری پیش از تولد نقش مهمی ایفاء می‌کنند. پزشک کودک وپزشک خانواده با تشخیص اولیه نارسایی شنوایی می‌تواند از اثرات ناتوانی بر رشد همه جانبه فرد پیشگیری کند یا آن را به حداقل برساند به‌طور کلی مسئولیت پزشک خانواده و پزشک کودک شناسایی مشکل و ارجاع آن به متخصصان مربوطه است. چنین مسئولیتی مستلزم آشنایی پزشک با خانواده و انجام یک مجموعه آزمایش‌ها بر روی کودک است. پزشک متخصص گوش و حلق و بینی مانند پزشک کودکان مشکلات بالقوه را غربال می‌کند و برای شناسایی نشانه‌هایی که با نقص‌شنوایی انتقالی‌یا حسی عصبی همراه است از آزمون‌های شنوایی به عمل آمده توسط شنوایی‌شناس کمک می‌گیرد. تشخیص آسیب شنوایی توسط پزشک واقدامات لازم جهت رفع و بهبودی و همچنین توصیه به لزوم اقدامات توان‌بخشی در صورت تشخیص به کم‌شنوایی حسی عصبی اهمیت به‌سزایی در پیشرفت روند توان‌بخشی خواهد داشت.

مشاوره با والدین: وقتی به والدین گفته می‌شود فرزند شما قدرت شنیدن ندارد نباید انتظار داشت آنها به سادگی آن را پذیرفته و با آرامش پیگیر سایر امور مرتبط باشند. به هر حال شنیدن وجود یک نقص دائمی در فرزند تازه متولد شده برای پدر و مادر، یک شوک و یک بحران بسیار سنگین است. خصوصاً در نقص شنوایی که ظاهر کودک معمولاً هیچ علامت و مشخصه بارزی ندارد. گویی هر بار نگاه‌کردن به چهره معصوم و دوست‌داشتنی فرزند نوزاد و تصور اینکه او هیچ چیز نمی‌شنود و نخواهد شنید برای آنها بسیار دشوار است و این خود مشکل بزرگی بر مشکل اصلی می‌افزاید زیرا کودک به جز ناشنوایی، اختلال دیگری ندارد و بنابراین هوشیار است (داورمنش و براتی سده، ۱۳۸۵).

در این زمینه لزوم مشاوره با والدین و آرام‌کردن آنها ضروری است. وظیفه مددکار اجتماعی در کاهش فشارها بعد از تشخیص آسیب شنوایی از والدین به‌ویژه مادران از اهمیت خاصی برخوردار است و در این راستا باید والدین درباره معلولیت شنوایی راهنمایی شوند و با والدین دیگرکه دارای فرزند با این معلولیت هستند در تعامل قرار بگیرند تا از طریق تشکیل جلسات گروهی نسبت به پذیرش واقعیت، بهره‌مندی از تجربیات یکدیگر و کاهش آلام دست یابند. ارائه خدمات راهنمایی، مشاوره و مددکاری به والدین به‌منظور جلوگیری از عواقب ناشی از معلولیت فرزند در کارکردهای خانواده به ویژه روابط زناشویی بسیار مؤثر می‌باشد. والدین باید مورد حمایت درمانگران (اعضای تیم توان‌بخشی) قرار بگیرند و مددکار اجتماعی باید شرایطی فراهم نماید تا به سؤالات آنان در زمینه‌های چگونگی برقراری عاطفی با فرزندان، مسائل تربیتی، نحوه برخورد با رفتار مردم کنجکاو، تولد فرزند دیگر و اطمینان از سلامتی او پاسخ داده شود (رنجبر، ۱۳۷۵).

مشاورین جهت برطرف‌نمودن هرگونه مشکلات احتمالی والدین در رابطه با پدیدهٔ آسیب شنوایی کودکشان، باید زمینه‌هایی را جهت پذیرش و کنارآمدن با این مشکلات در والدین فراهم آورندبه این منظور باید جلسات مشاوره‌ای گروهی و فردی بر پا سازند واز هرگونه تحت فشار قراردادن و یا غیرمنطقی خواندن مشکل والدین پرهیز نمایند و در آنان حس اطمینان و دلگرمی ایجاد کنند (کاکوجویباری و همکاران، ۱۳۷۸).

اغلب فرایند مشاوره با والدین خردسالان دچار نقص شنوایی به‌صورت گروهی از کارامدی بالایی برخوردار است چون در گروه هر والد با گروهی همگن مواجهه می‌شود که با پدیده‌ای مشترک به نام کم‌شنوایی در گیرند. آنها با تسهیل‌گری مشاور به مبادله واکنش‌های هیجانی – شناختی متنوع به یکدیگر اقدام می‌کنند و از این طریق به گذار از انکار، کسب اگاهی از واقعیت، عبور از ماتم سلامتی فرزند و رسیدن نسبی به پذیرش واقعیت معلولیت شنوایی اقدام می‌کنند. برای طی این مسیر به حداقل ۱۵جلسه مشاوره گروهی نیازمند است. در این راه والدینی که مسایل پیچیده‌تری دارند به موازات مشاوره گروهی به مشاوره فردی نیز نیاز دارند (کاکو جویباری و طاهری، ۱۳۷۲).

آموزش به والدین: خانواده به شدت به آموزش جهت آشنایی با شیوه برخورد با کودک کم‌شنوا و چگونگی برقراری ارتباط با او نیاز دارد. والدین باید دقیقاً با معلولیت

متخصصان تعلیم و تربیت توجه زیادی به سن شروع آسیب‌دیدگی شنوایی دارند و برهمین اساس بین نیازهای فردکم‌شنوای پیش زبانی (ناظر بر آسیب شنوایی به هنگام تولد یا اوایل زندگی کودک می‌باشد و به سنینی تعلق دارد که هنوز زبان و گفتار شکل نگرفته است) و کم‌شنوای پس زبانی (بر رخداد کم‌شنوایی در سنینی بعد از رشد گفتار و زبان دلالت می‌کند) تفاوت می‌گذارند (بریل[1] و همکاران، ۱۹۸۶).

تجویز به موقع سمعک و عادت به آن: شاید بزرگترین هنر یا وجه تمایز انسان به حیوانات را بتوان سخنوری و زبان‌آموزی انسان به حساب آورد که دارای مکانیزم بسیار پیچیده‌ای است. جریان طبیعی زبان‌آموزی با تحریک شنیداری آغاز می‌گردد، بنابراین در فرد آسیب‌دیده شنوایی قبل از هر چیز باید میزان باقی‌مانده شنوایی مشخص شود و سمعک مناسب در اختیار او قرار گیرد و محرکات سمعی به وی ارائه شودحتی اگر کودک مبتلا به نقص شنوایی در طیف کاهش شنوایی شدید یا عمیق باشد. (کلارک[2]، ۱۹۸۹، ترجمه کاکوجویباری و شمالی، ۱۳۷۸).

بعد از تشخیص معلولیت شنوایی، تجویز و انتخاب سمعک مناسب برای کودک کم‌شنوا توسط کارشناس شنوایی‌شناسی صورت می‌پذیرد. در ملاحظات قبل از تجویز سمعک توجه به مسائل روان‌شناختی والدین کودک و مشاوره مطلوب و تغییر نگرش آنان نسبت به کم‌شنوایی و سمعک می‌تواند به نحو قابل ملاحظه‌ای در اقدامات زنجیره‌ای توان‌بخشی شنوایی مؤثر واقع گردد.

والدین ضرورت دارد نسبت به نحوه نگهداری و لزوم استفادهٔ مرتب و مداوم از سمعک و اهمیت به‌کارگیری از این وسیله به‌منظور استفاده بهینه از باقیمانده شنوایی در کودکشان، اطلاعات لازم را از کارشناسان شنوایی شناسی دریافت نمایند.

تجویز سمعک بعد از تشخیص بهنگام کم‌شنوایی سبب می‌شود باقیمانده شنوایی کودک کم‌شنوا تقویت گردد و تا حدی تجربه شنیدن برای وی حاصل گردد. استفاده مداوم از سمعک و خدمات توان‌بخشی تا حد قابل ملاحظه‌ای باعث کاهش شکاف دانش زبانی کودک کم‌شنوا با همتای شنوا خواهد شد (کایسهایمل[3] وهمکاران، ۱۹۹۷).

شنوایی و مشکلی که فرزند آنها با آن روبه‌روست آشنا شوند. آنان باید اقداماتی را که در روند رشد فرزند خود می‌باید به انجام برسانند، بشناسند و برای آن برنامه‌ریزی کنند. همچنین باید تدریجاً با شیوه‌های ارتباط غیرصوتی آشناشده و براساس آن با کودک فهم و درک متقابل ایجاد کنند (داورمنش وبراتی سده، ۱۳۸۵).

آرام[1] و همکاران (۲۰۰۸) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند مادرانی که به معلولیت شنوایی کودکان خود بیشتر واقف هستند تعامل بهتری با مربیان کودکستان فرزندانشان دارند و پیشرفت کودک در افزایش خزانه لغات و آگاهی از متن بیش از آنکه به سن وجنسیت کودک مرتبط باشد به همکاری والدین وابسته بوده است.

در اطلاعات پرسش نامه‌ای که از والدین در پژوهش‌های نمن گوس چالک و وبستر[2] (۲۰۰۳) به‌منظور تأثیر نقش والدین در پیشرفت مهارت خواندن کودکان کم‌شنوا به عمل آمد نشان داده شدکه در ارتقا بخشی به توسعه مهارت خواندن کودکان کم‌شنوا نکات برجسته‌ای نهفته است که نیاز به تمرین دارد و این تمرینات حرفه‌ای از یک سو و آگاهی والدین و تعامل فکری آنان با معلمین ازسوی دیگر در توسعه باسوادی این کودکان مؤثر به‌نظر می‌آید.

والدینی که دارای خرد سال نقص شنوایی هستند در اولین مواجهه احساس می‌کنند از کفایت‌های والدینی برخوردار نمی‌باشند. نمی‌توانند با فرزندشان ارتباط برقرار کنند، نیازهای وی را درک کنند، پیامی مبادله کنند، به وی در بر قراری ارتباط با دیگران کمک کنند، از سمعکش نگهداری کنند و از آن برای درک زبانی بهره بگیرند، درکی از رفتار اشاره‌ای او داشته باشند، در رشد شنیدن، تکلم و گفتارخوانی به وی یاری رسانند. به واقع والدین، مهارت‌های والدینی را اغلب در مسیر زندگی طبیعی با کمترین نیاز آموزشی فرا می‌گیرند لیکن‌یادگیری مهارت‌های والدینی برای والدین خردسالان کم‌شنوا بدون آموزش حاصل نمی‌شود. بر این اساس ایجاد کفایت‌های والدینی برای والدین کودکان کم‌شنوا اقدامی توان‌بخشی است که متخصصان شنوایی و مربیان دورهٔ پیش‌دبستانی باید به آن همت گمارند (کاکو جویباری و طاهری، ۱۳۷۲).

تربیت شنوایی، آموزش گفتار و گفتارخوانی: کودکان با شنوایی سالم یاد می‌گیرند که چطور با اطرافیان خود از طریق گوش دادن به آنها، صحبت کنند و از زبان

در کلاس به مواردی نظیر رعایت میزان فاصله با کودک، قرارگرفتن در میدان دید و مقابل چهره او به هنگام صحبت‌کردن و نحوه تابش نور توجه داشته باشد.

کودک کم‌شنوا، خانواده، مربی(معلم)، شنوایی شناس و گفتار درمانگر تیم ثابت در برنامه توان‌بخشی شنوایی محسوب می‌شوند. پیشرفت برنامه توان‌بخشی با تمرین و تکرار تکنیک‌های درمانی در منزل توسط والدین و در کلاس توسط معلم مربوطه وابستگی بسیار نزدیکی دارد. بدون شک اگر خانواده طی آموزش‌های مستقیم و مشاوره‌ای نسبت به اهمیت خدمات توان‌بخشی آگاه گردد، توصیه‌ها را در منزل برای پیشرفت کودک اجرایی خواهد ساخت.

سوادآموزی و تحصیل: پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کم‌شنوا به‌دلیل کمبود مهارت‌های زبانی در مقایسه با همتایان شنوا عموماً با تأخیر مواجه است ولی این مسئله مانعی در سوادآموزی کم‌شنوا تلقی نمی‌گردد.

نیازهای کودکان با کمبودهای شنوایی با نیازهای کودکان شنوا تفاوت چندانی ندارد، تنها کودکان با مشکلات شنوایی نیازمند درک بیشتر و بهتر از طرف والدین، اطرافیان و دست‌اندرکاران آموزش وپرورش برای جبران یا رفع نقص خودهستند. (سیف نراقی و نادری، ۱۳۸۹). در کشور ما بخش قابل ملاحظه‌ای از کودکان دارای آسیب شنوایی در مدارس خاص و استثنایی تحت اموزش قرار می‌گیرند ولی آنهایی که دارای نقص شنوایی کمتری می‌باشند و سخت شنوا نامیده می‌شوند از امکان تحصیل در مدارس عادی نیز برخوردارند. به این نوع اموزس در مدارس عادی اموزش تلفیقی ویا اموزش فراگیر می‌گویند. به تصمیم‌گیری درباره این که کودک از چه نوع آموزشی بهره گیرد نوعی اقدام توان‌بخشی اموزشی است که توسط شنوایی‌شناس و کارشناس اموزش و با مشورت والدین حاصل می‌گردد.

انتخاب روش ارتباط: متخصصین تعلیم و تربیت به‌منظور پیشرفت مهارت‌های ارتباطی و تحصیلی فرد کم‌شنوا از روش‌های متفاوتی استفاده می‌کنند که به اختصاربه برخی از روش‌ها اشاره شده است.

روش شفاهی – شنیداری[1]: با این روش سعی می‌شود که باقیمانده شنوایی فرد را تقویت نموده و از طریق گفتارخوانی و تکلم برای رشد مهارت‌های ارتباطی استفاده

به‌طور هدفمند و معنی‌دار استفاده نمایند، آنها درک و بیان لغت را آغاز می‌کنند، همان‌طور که آنها در گوش‌دادن و استفاده از زبان برای هدف‌های ارتباطی مختلفی با تجربه‌تر می‌شوند و از نظر شناختی به رشش می‌رسند، توانایی آنها برای ارتباط برقرارکردن، ماهرانه‌تر می‌شود (کاکاوند، ۱۳۸۵).

کودکان شنوا در سنین زبان‌آموزی در متن زندگی طبیعی، زبان را فرا می‌گیرند ولی کودکان کم‌شنوا در نتیجه آسیب شنوایی دچار اختلال در مهارت گوش‌دادن می‌شوند و از فراگیری زبان به شیوه طبیعی و معمول محروم می‌گردند و جبران این محرومیت مستلزم ارائه خدمات توان‌بخشی و آموزش‌های ویژه به آنها می‌باشد. شنوایی‌شناس با ارائه خدمات تربیت شنوایی به تقویت مهارت گوش‌دادن کودک کم‌شنوا می‌پردازد و کودک آموزش می‌بیند که با استفاده از سمعک و بهره‌گیری از باقیمانده شنوایی به کشف صدا، تشخیص و درک صدا توجه داشته باشد. کودک کم‌شنوا باید نحوه شکل‌دهی به صدا از طریق به‌کارگیری اندام تکلمی (زبان، کام و لب‌ها) و بیان‌کردن توأم با صدا را بیاموزد و با میزان و شکل صداها آشنا شود. آموزش‌ها در قالب شناسایی صدا و ترکیب آنها (واج‌شناسی)، آشنایی با ساختار درونی کلمات (صرف) و نحوه ترکیب و ساختن جمله (نحو) از جمله وظایف متخصصان گفتار درمانی[1] می‌باشد.

کودک کم‌شنوا همچنین باید بیاموزد که در طی بیان و گفتار تنها صوت نیست که به بیان مطلب منجر می‌گردد بلکه مجموعه حالات و حرکات چهره نیز در انتقال پیام مؤثر هستند، به همین منظور ضرورت دارد که تحت آموزش گفتارخوانی قرار بگیرد. در گفتار خوانی تأکید کودک صرفاً به لب‌های گوینده (لب‌خوانی) نیست بلکه برای دریافت معنا دقت به کل صورت و چگونگی بیان فرد در حین صحبت‌کردن مورد توجه قرار می‌گیرد. جهت ایجاد شرایط مناسب برای گفتارخوانی ضروری است معلم

مشاغل درخور مهارت‌هایشان هدایت گردند زیرا پیدا کردن شغل برای کم‌شنوا یک مشکل است و ماهیت آن شغل مشکل دیگری است و اکثر کم‌شنوایان در کارهایی مشغول به فعالیت هستند که از سطح تخصص‌شان بسیار پایین‌تر است.

حمایت‌های اجتماعی، قانونی: افرادی که از بدو طفولیت دچارمعلولیت شنوایی می‌شوند، افرادی ساده‌اندیش بوده و از پیچیدگی‌های ارتباط انسانی نظیر تعارفات، رودربایستی‌ها، ریاها و دو رویی‌ها چندان اطلاعی ندارند و به این علت امکان دارد مورد سوء استفاده قرار گرفته یا احیاناً به سوء رفتار متهم شوند. بنابراین ضرورت دارد تا کادر مددکاری اجتماعی زمینه‌های اجتماعی و قانونی این گونه افراد را خصوصاً در جوانی و بدو ورود مستقل به جامعه تحت نظر و حمایت قرار دهد.

۲-۹ ابزارهای توان‌بخشی

برخی ابزارهای توان‌بخشی شنوایی از ابزارهای مورد استفاده در توان‌بخشی شنوایی می‌توان به سمعک (کمک شنوایی) ودستگاه کاشت حلزون اشاره نمود.

سمعک: در اولین نگاه بلندگوی ساده‌ای است که مانند هر تقویت‌کننده دیگر از سه قسمت اساسی میکروفن، تقویت‌کننده و بلندگو تشکیل شده است.

میکروفون: انرژی صوتی را دریافت و به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند و به تقویت‌کننده ارائه می‌دهد.

تقویت‌کننده: ضمن کنترل کیفیت صوت، انرژی الکتریکی را تقویت می‌کند.

بلندگو: موج الکتریکی تقویت شده توسط تقویت‌کننده را به موج صوتی تبدیل وارد گوش می‌نماید و در واقع عکس میکروفون عمل می‌کند.

انرژی الکتریکی لازم برای انجام این عملیات در سمعک توسط باطری تأمین می‌گردد. اندازه و سایز باطری‌ها با توجه به انواع سمعک متفاوت است.

سمعک‌ها انواع متنوعی دارندکه به گروه‌های جیبی، پشت گوشی، داخل گوشی، داخل کانال (داخل مجرای گوش خارجی) و عینکی طبقه‌بندی می‌شوند.

هر فرد آسیب دیده شنوایی به‌طور بالقوه می‌تواند کاندید استفاده از سمعک باشد و عقایدی که در انتخاب سمعک به سطوح یا انواع خاصی از کم‌شنوایی توجه دارند

نمونه در مدارسی که ازاین روش بهره می‌گیرند، معمولاً از زبان اشاره استفاده نمی‌کنند زیرا معتقدند اگر به کودک اجازه برقراری ارتباط توسط زبان اشاره داده شود، وی تلاش لازم را برای یادگیری تکلم نخواهد کرد.

زبان اشاره و روش هجی‌کردن با انگشتان[1] **(روش دستی)**: در این روش بر استفاده از الفبای دستی و زبان اشاره به‌عنوان وسیله آموزش و پرورش دانش‌آموزان کم‌شنوا در کلاس درس تأکید دارند. در واقع در این روش چشمان شاگرد جای گوش او را می‌گیرد. کودکان و دانش‌آموزان با آموزش زبان اشاره از طریق اشاره قادر به بیان مقصود خود و تفهیم آن به مخاطب هستند. متخصصانی که اعتقاد به آموزش روش دستی دارند بر این باورند که رشد زبان کودکانی که از زبان اشاره و هجی‌کردن با انگشتان بهره نمی‌گیرند، نسبت به کودکانی که از این روش‌ها استفاده می‌کنند، عقب‌تر است.

روش مختلط[2] **یا جامع (ترکیبی)**: این روش اختلاطی از هجی‌کردن با انگشتان دست، زبان اشاره، گفتار خوانی، تکلم و تقویت شنوایی به‌طور همزمان است و در واقع تأکیدی است بر حقوق معلم و دانش‌آموز کم‌شنوا که با استفاده از همه روش‌های برقراری ارتباط، در توسعه و رشد مهارت صحبت‌کردن و درک معانی بکوشند. مدافعان این روش عقیده دارند که استفاده از این شیوه آموزشی به علت جامع‌بودن آن، بر نیازها و توانایی‌های فردی دانش‌آموزان کم‌شنوا مبتنی است و فرصت‌های لازم را برای پیشرفت مهارت‌های زبانی دانش‌آموزان کم‌شنوا فراهم می‌آورد.

هرکدام از این روش‌ها مدافعان خاص خود را داردکه نمونه‌های موفقی از عملکرد خود را ارائه می‌دهند بنابراین نمی‌توان به یقین اظهار داشت که کدام روش ارجح است؟ این که کدام روش ارتباطی برای کودک مفیدتر است تصمیمی توان‌بخشی آموزشی و اجتماعی است که توسط مدرسه و با مشورت والدین باید تولید شود.

در آموزش مهارت‌های ارتباطی به کودکان کم‌شنوا توجه داشتن به ویژگی‌های ذهنی، روانی و نیز شرایط محیطی کودک جهت گزینش شیوه آموزشی، بسیارحائز اهمیت است (سیف نراقی و نادری، ۱۳۸۹).

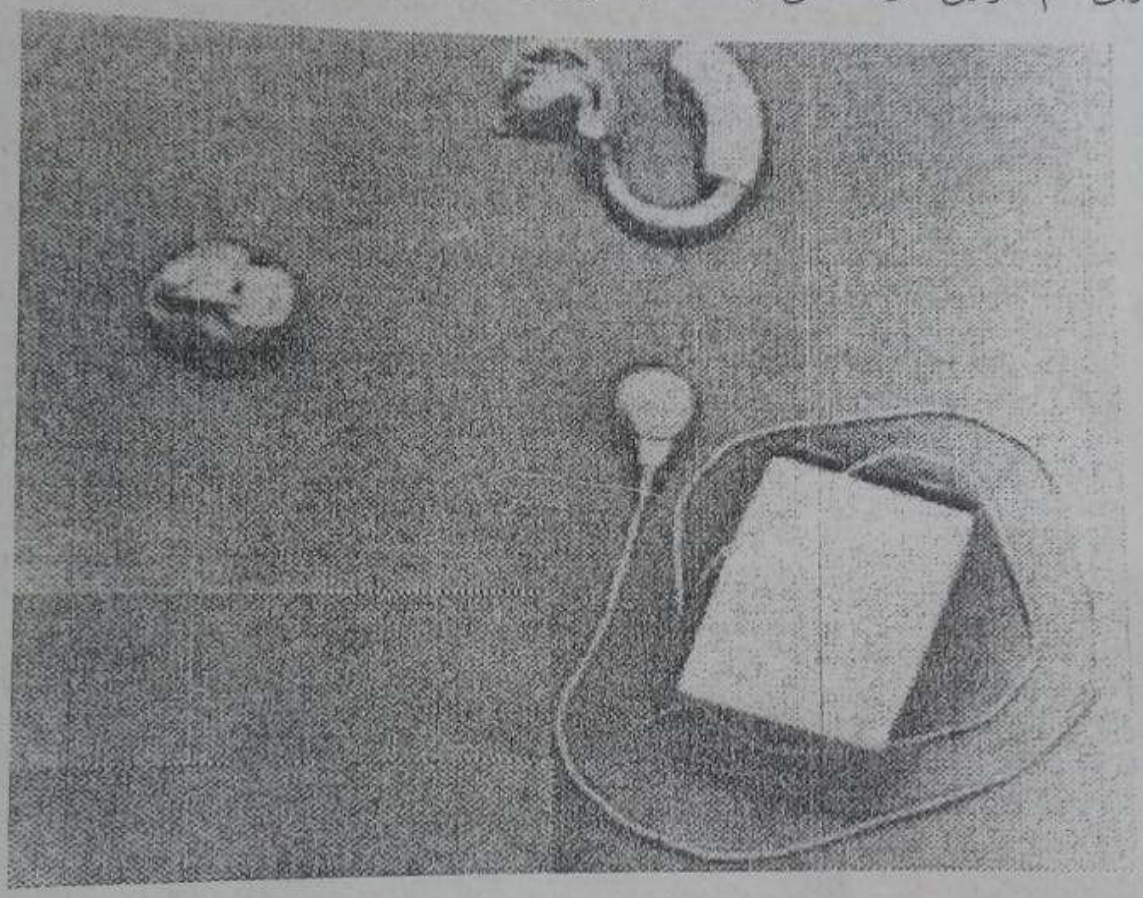
توانبخشی حرفه‌ای: با اینکه افراد آسیب‌دیده شنوایی می‌توانند مستخدمین خوبی باشند اما بسیاری از آنها بیکارند و جمعیت بزرگی نسبت به شغل‌هایی که دارند شایستگی بیشتری دارند آنها در هنرهای دستی حضور مضاعف و در حرف تخصصی و مدیریتی حضور ناچیزی دارند. با فراهم‌آمدن فرصت‌های آموزشی در دوره بعد از دبیرستان حرکت روبه رشدی در موقعیت شغلی افراد آسیب دیده شنوایی حاصل آمده است و هرگونه مشکلی که در زمینه‌های شغلی آنان ایجاد می‌شود بیش از آنکه به فقدان مهارت‌های شغلی معلولین شنوایی مرتبط باشد به ضعف مهارت‌های ارتباطی آنان وابسته است (هالاهان و کافمن، ۱۹۴۴، ترجمه ماهر، ۱۳۸۷).

هرجا که کار و حرفه با سخن گفتن و ارتباط کلامی و یا صوتی همراه نباشد، کم‌شنوایان به مراتب حتی بهتر از همنوعان عادی خود مهارت نشان می‌دهند و در رشته‌های فنی ترسیمی، هنرهای ترسیمی و تجسمی موفق‌تر عمل می‌کنند ولی در رشته‌های نظری و اموری که مستقیماً به کلام وصوت وابسته است، دچارمشکل می‌شوند.

اشتغال و کاریابی: در نیمه دهه ۱۹۶۰ بررسی‌های انجام شده درباره وضع شغلی بزرگسالان آسیب دیده شنوایی حقایق ناگواری را نمایان ساخت. میزان بیکاری آنهادر مقایسه با افراد شنوا چهار برابر بیشتر بود و نوع کاری که توانسته بودند به‌دست آورند اغلب جنبهٔ نیمه‌ماهر یا غیرماهر داشت در همان زمان کوشش‌هایی جهت شناسایی همه افراد کم‌شنوایی که از کالج‌ها و دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل یا در آنها ثبت نام کرده بودند، انجام شد. از ۶۵۳ نفری که مطالعه روی آنها انجام گرفت تنها ۱۳۳ نفر توانسته بودند تحصیلات خود را تمام کنند که همگی دارای آسیب شنوایی قبل اززبان آموزی بودند. یکی از عوامل روشنی که بر نوع مشاغل کم‌شنوا تأثیر می‌گذارد فرصت‌های آموزشی محدود آنها می‌باشد و اغلب مسائلی که بزرگسالان کم‌شنوا در جامعه با آن مواجه هستند، در زمینه کاریابی می‌باشد دارابودن مهارت‌های زبانی محدود، آموزش‌های ناقص تحصیلی و تعصبات کارفرمایان، یافتن شغل را برای این افراد بسیار مشکل ساخته است. (کرک و گالاگر[1]، ۱۹۰۴، ترجمه جوادیان، ۱۳۸۵).

ضروری است طی تلاش تیمی، کم‌شنوایان دریافتن شغلی مناسب تحت حمایت قرار بگیرند و با کسب تصویر واضحی از توانمندی‌ها و امکانات حرفه‌ای به سمت

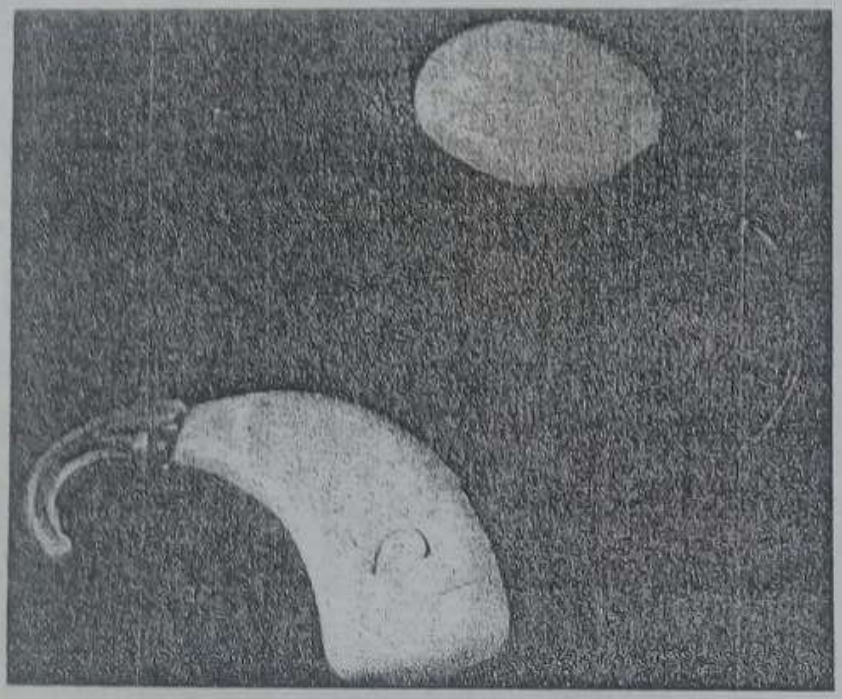
باید کنار گذاشته شوند، کم‌شنوایی‌های انتقالی اغلب پاسخ مطلوبی به درمان پزشکی و یا جراحی می‌دهند و در مواقعی که امکان استفاده از آنها وجود داشته و خود بیمار نیز راضی باشد به‌عنوان درمان انتخابی مطرح می‌شوند با این وجود ممکن است به دلایلی بیمار با کم‌شنوایی انتقالی خواهان استفاده از سمعک باشد که در اغلب مواقع نیزاین نوع درمان با موفقیت همراه است. امروزه تجویز وسایل کمک شنوایی اغلب برای کم‌شنوایی‌های حسی- عصبی و در ابعاد محدودتر در کم‌شنوایی‌های آمیخته صورت می‌پذیرد که پیش آگهی آنها به‌ویژه در صورت درگیری سیستم اعصاب شنوایی مرکزی به خوبی کم‌شنوایی‌های انتقالی نیست (جعفری و عباسعلی پور کبیره، ۱۳۸۰).



۳-۲. اشکالی از سمعک (جیبی، پشت گوشی و داخل گوشی)

دستگاه کاشت حلزون: در سیستم شنوایی طبیعی انرژی صوتی وارد شده به مجرای گوش خارجی در حلزون به پیام‌های عصبی تبدیل می‌گردد تا از طریق عصب شنیداری و سیستم اعصاب شنیداری مرکزی به قشر مغز انتقال‌یافته و در آنجا تفسیر گردد، درصورتی‌که حلزون آسیب دیده یا عملکرد نداشته باشد امکان تبدیل انرژی صوتی به پیام عصبی وجود نخواهد داشت. (جعفری و عباسعلی پورکبیره، ۱۳۸۰).

ورمولن[1] و همکاران (۲۰۰۷) طی تحقیقی که برروی کودکان کاشت حلزون انجام دادند به این نتیجه رسیدند که علیرغم اینکه این کودکان در مقایسه با همتایان شنوای خود در مقوله درک مطلب پیشرفت کندی را نشان می‌دهند ولی نسبت به همتایان کم‌شنوا پیشرفت درخور توجه دارند.



۴-۲. شکلی از دستگاه کاشت حلزون با پردازشگر گفتار سطح گوشی

۲-۱۰ خودآزمایی

۱. کارکرد گوش درونی را توضیح دهید.
۲. تفاوت نقص شنوایی انتقالی و حسی - عصبی چیست ؟
۳. تفاوت آموزش والدین و مشاوره با والدین را توضیح دهید.
۴. نقش شنوایی‌شناس در تشخیص زودهنگام آسیب شنوایی را توضیح دهید.
۵. قسمت‌های مختلف سمعک را توضیح دهید.
۶. . . . . مؤثرترین راهکار برای پیشگیری از معلولیت شنوایی محسوب می‌شود.
۷. اقداماتی که درامرتربیت شنوایی کودک کم‌شنوا صورت می‌پذیرد شامل چه مواردی می‌باشد؟
۸. لزوم و ضرورت حمایت‌های اجتماعی در فرد کم‌شنوا را توضیح دهید.
۹. فقدان مهارت‌های شغلی در معلولین شنوایی به. . . . . آنان وابسته است.

---

1. Vermeulen

کاشت حلزون نوعی روش درمانی برای افراد با کم‌شنوایی حسی - عصبی در حد عمیق است. در این نوع کم‌شنوایی استفاده از سمعک برای بیمار مفید فایده نبوده و کمک شایانی به وی نکرده است. از این دستگاه می‌توان در بزرگسالان و کودکان دچار کم‌شنوایی قبل و پس از زبان‌آموزی استفاده کرد. دستگاه کاشت حلزون از دو بخش داخلی و خارجی تشکیل شده است. بخش داخلی، پروتز کاشت نام دارد و از طریق جراحی زیر پوست قرار می‌گیرد و بخش خارجی پردازشگر گفتار نام دارد و پشت لاله گوش قرار می‌گیرد.

صداها از طریق میکروفون پردازشگر گفتار جمع‌آوری می‌شود و پردازشگر گفتار صداهای رمزگذاری‌شده را به محرک‌های الکتریکی تبدیل می‌کند و این محرک‌ها ازطریق پوست به پروتز کاشت (بخش داخلی) می‌رسند، پروتز کاشت، محرک‌های الکتریکی را به الکترودهایی که به روش جراحی در حلزون کاشته شده اند هدایت می‌کند و در نهایت عصب شنوایی محرک‌های الکتریکی را دریافت کرده و آن را به مراکز شنوایی در مغز می‌فرستد و مغز این علائم را به‌عنوان صدا می‌شناسد.

درباره این که چه سنی درباره کاشت حلزون مناسب است تردید وجود دارد اما به نظر می‌رسد در سنین اولیه بهتر است. از نظر (انجمن کاشت حلزون[1]، ۲۰۰۰)کودکان از ۱۸ ماهگی تا۱۷ سالگی، اگر در هر دو گوش نارسایی شنوایی عمیق داشته باشند و هم کودک و هم خانواده انگیزش بالا و انتظارات متناسبی را دارا باشند موردهای مناسبی برای کاشت حلزون محسوب می‌شود. همچنین این انجمن توصیه می‌کند به دنبال جراحی لزوماً کودک باید در یک برنامه آموزشی مبتنی بر رشد مهارت‌های شنیداری شرکت کند. این انجمن در مورد بزرگسالانی که تمایل به کاشت حلزون دادند هشدار بیشتری می‌دهد مبنی بر اینکه آنها باید تمایل قوی برای ورود به جهان شنیداری داشته باشند. بسیاری از افراد کم‌شنوا با کاشت حلزون در کودکان مخالفند و بسیاری نیز از این موضوع حمایت می‌کنند. افرادی نیز مخالف کاشت حلزون در هر شخص و در سنی هستند و حتی از فرد آسیب‌دیده شنوایی که با تصمیم شخصی نسبت به کاشت حلزون اقدام کرده است حمایت نمی‌کنند.

در محیط پر نور قرار می‌گیرد مردمک تنگ می‌شود تا مقدار نور کمتری وارد چشم شود. به همین صورت وقتی چشم در محیط کم نور قرار می‌گیرد مردمک گشاد می‌شود تا نور بیشتری وارد چشم شود.

اطاق قدامی[1]: اطاق قدامی فضای کوچکی است که بین قرنیه و عنبیه قرار دارد. در این فضا مایعی به نام زلالیه[2] جریان دارد که به شستشو و تغذیه بافت‌های داخل چشم کمک می‌کند. همان‌طور که در یک استخر برای پاک ماندن استخر مرتباً مقداری آب خارج می‌شود و به جای آن آب تصفیه شده وارد می‌شود، در چشم هم مرتباً مقداری از مایع زلالیه خارج می‌شود و مایع زلالیه جدیدی که در چشم تولید شده است جایگزین آن می‌شود. اگر به هر دلیلی تعادل بین تولید و خروج این مایع به هم بخورد مقدار مایع زلالیه در چشم افزایش پیدا می‌کند و فشار داخل کره چشم از حد طبیعی بیشتر می‌شود. (مقدار طبیعی فشار چشم در افراد بالغ بین ۱۰ تا ۲۱ **میلی متر جیوه است**) بالا رفتن فشار چشم به پرده شبکیه و عصب بینایی آسیب می‌زند و باعث بیماری آب سیاه می‌شود.

عدسی: عدسی یک ساختمان شفاف در پشت عنبیه است که در متمرکزکردن دقیق پرتوهای نور بر روی شبکیه به قرنیه کمک می‌کند. ضخامت عدسی چشم در شرایط مختلف تغییر می‌کند و بسته به آنکه شیء مورد نظر در چه فاصله‌ای از فرد قرار داشته باشد ضخامت عدسی کم و زیاد می‌شود.

زجاجیه[3]: زجاجیه مایع ژله مانند شفافی است که داخل کره چشم را پر می‌کند و به آن شکل می‌دهد. زجاجیه از پشت عدسی تا روی پرده شبکیه وجود دارد. با گذشت سن ساختمان ژله مانند زجاجیه تغییر می‌کند و در بعضی جاها حالت آبکی پیدا می‌کند. در این حال بعضی قسمت‌های زجاجیه شفافیت خود را از دست می‌دهد و سایه‌ای روی پرده شبکیه[4] می‌اندازد که فرد آن را به صورت اجسام شناور کوچکی می‌بیند که مثل مگس در میدان بینایی بالا و پایین می‌روند. این حالت اصطلاحاً مگس‌پران گفته می‌شود.

فصل سوم

توان‌بخشی معلولان بینایی

اهداف فصل

در پایان این فصل از شما انتظار می‌رود بتوانید:

۱. عملکرد کلی چشم را بیان کنید.
۲. تفاوت نیمه بینایی و نابینایی را بر اساس دو ملاک مشخص کنید.
۳. سبب‌شناسی معلولیت بینایی را نام ببرید.
۴. طبقات معلولیت بینایی را نام ببرید و تفاوت آنها را بیان کنید.
۵. اعضای تیم توان‌بخشی افراد دارای معلولیت بینایی را مشخص کنید.
۶. پیشرفت تحصیلی افراد دارای معلولیت بینایی را تشریح کنید.
۷. اهمیت آموزش قبل از دبستان برای معلولین بینایی را بیان کنید.
۸. چهار مورد از نیازهای توان‌بخشی معلولین بینایی را نام ببرید.
۹. کاربرد موسیقی درمانی در توان‌بخشی معلولین بینایی را تشریح کنید.

۳-۱ مقدمه

هیچگاه نمی‌توان با روی هم گذاردن پلک‌ها و بستن چشم به واقعیت نابینایی پی‌ببریم، زیرا آنچه ندیدن را به نابینایی مبدل می‌کند دائمی‌بودن آن است. چشم قوی‌ترین راه ارتباطی موجود زنده و مخصوصاً انسان با محیط است.

افراد مبتلا به آسیب‌های بینایی بسته به شدت آسیب بینایی، سن و وقوع نابینایی در کسب مهارت‌های روزانه، تحرک و جهت‌یابی و فعالیت‌های آموزشی که به‌صورت

گسترده‌ای با حس بینایی بستگی دارد با مشکل مواجه می‌گردند و به منظور کاهش عوارض نابهنجار ناشی از آسیب بینایی، تجدید و تقویت قوای روحی و اجتماعی و ارائه امکانات و خدمات آموزشی و حرفه‌ای به خدمات توان‌بخشی نیاز دارند.

۳-۲ ساختمان چشم

دیدن یعنی قدرت دریافت نورهای مرئی و در نتیجهٔ آن قدرت احساس شکل، رنگ و اندازهٔ اشیاء خارجی. چشم در حالت عادی طیف محدودی از نورهای موجود را دریافت نموده و پس از فعل و انفعالاتی آنها را تبدیل به پیام‌های عصبی کرده، به بخش پس‌سری مغز [1] منتقل می‌کند تا به این طریق، پیام‌های فوری دریافت شده از چشم را احساس و ادراک کنیم. به هریک از اجزای مهم ساختمان چشم ذیلاً اشاره می‌گردد:

پلک: وقتی جسم نوک تیزی به چشم ما نزدیک می‌شود ما بی‌اختیار پلک‌ها را می‌بندیم. پلک‌ها در حقیقت ساختمان‌های تمایزیافته‌ای از جنس پوست و عضلات زیر پوستی هستند که وظیفه محافظت از چشم‌ها را بر عهده دارند. مژه‌ها مثل یک صافی از ورود گرد و غبار و ذرات مختلف به داخل چشم جلوگیری می‌کنند. خود پلک‌ها دو وظیفه مهم دارند. اول آنکه مثل یک دیوار دفاعی جلوی قسمت عمده ای از کره چشم را می‌گیرند و از کره چشم محافظت می‌کنند، دوم آنکه پلک‌ها هر ۵ تا ۱۰ ثانیه یک بار باز و بسته می‌شوند که این امر به شسته‌شدن میکروب‌ها و ذرات خارجی از سطح چشم کمک می‌کنند و در حقیقت سطح چشم را جارو می‌کند. به علاوه باز و بسته‌شدن پلک‌ها به توزیع یکنواخت اشک بر روی کره چشم کمک می‌کند.

ملتحمه: ملتحمه یک لایه شفاف محافظ است که سطح داخلی پلک‌ها و روی سفیدی کره چشم را می‌پوشاند. در ملتحمه رگ‌های خونی و گلبول‌های سفید به مقدار زیادی وجود دارد. این رگ‌ها و سلول‌های دفاعی تا حد زیادی از ورود میکروب‌ها و عوامل بیماری‌زا به قسمت‌های عمقی چشم جلوگیری می‌کند. به علاوه ترشحات ملتحمه سطح چشم را نرم و مرطوب نگه می‌دارد و در حقیقت سطح چشم را روغن‌کاری می‌کند که این امر باعث آسان‌ترشدن حرکات چشم در جهات مختلف می‌شود.

شبکیه: شبکیه یک پرده نازک حساس به نور (شبیه فیلم عکاسی) است که در عقب کره چشم قرار دارد. پرتوهای نوری که به شبکیه برخورد می‌کنند به پیام‌های عصبی تبدیل می‌شوند که از طریق عصب بینایی به مغز منتقل می‌شوند و در مغز تفسیر می‌شوند. در شبکیه انسان انواع مختلفی از سلول‌های گیرنده نوری وجود دارد که میزان حساسیت آنها به نور متفاوت است. گیرنده‌های نوری استوانه‌ای بیشتر برای دید در محیط‌های تاریک به کارمی‌روند. گیرنده‌های مخروطی برای تشخیص رنگ و جزئیات ظریف تمایز یافته‌اند. ترتیب قرارگیری این سلول‌ها در شبکیه طوری است که در ناحیه مرکزی شبکیه تعداد گیرنده‌های مخروطی بیشتر است. بنابراین وقتی فردی به‌صورت مستقیم به شیئی نگاه می‌کند تصویر آن شیء مستقیماً روی شبکیه در جایی می‌افتد که تعداد سلول‌های مخروطی بیشتر است و در نتیجه شیء با وضوح بیشتری مشاهده می‌شود.

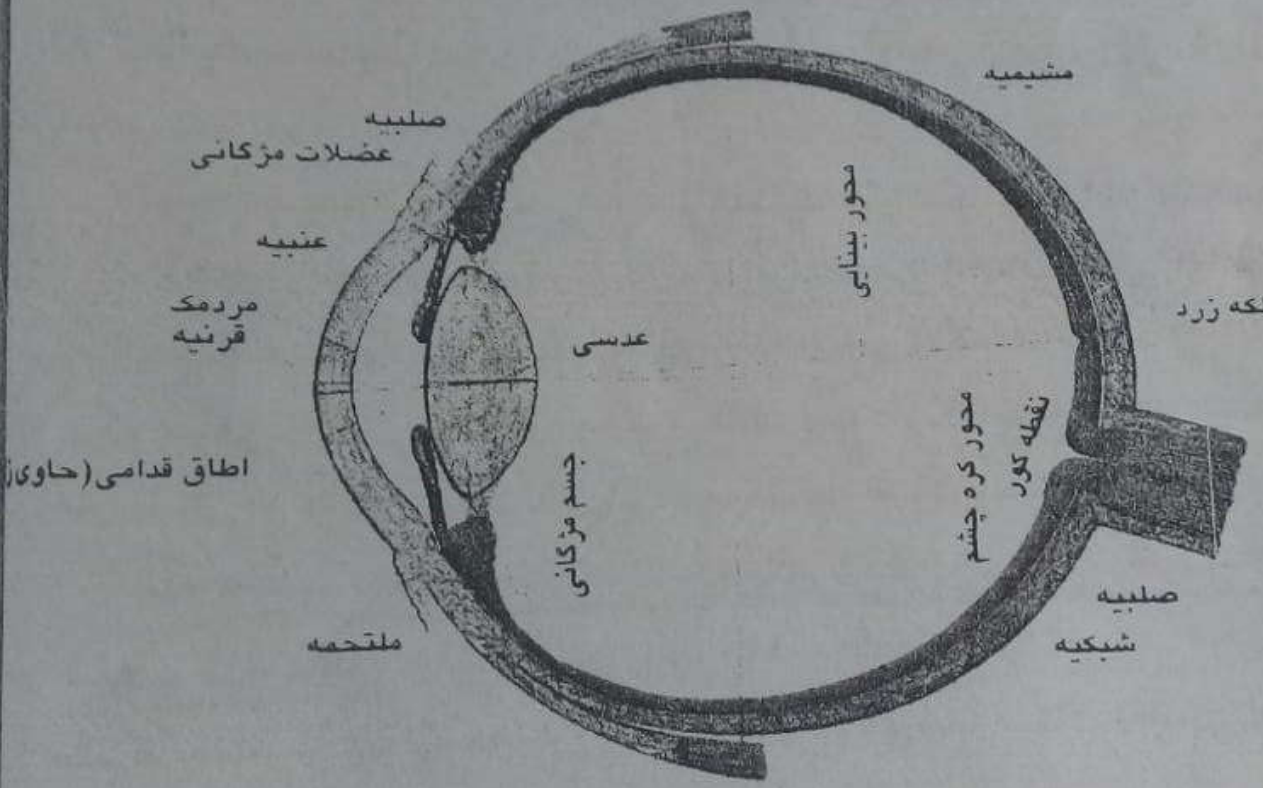
مشیمیه[1]:مشیمیه پرده نازک سیاه رنگی است که دور شبکیه را احاطه کرده است. این پرده تعداد زیادی رگ‌های خونی دارد که مواد غذایی را به بخشهایی از شبکیه می‌رساند. به علاوه سلول‌های این لایه حاوی تعداد زیادی رنگ دانه سیاه ملانین است که رنگ سیاهی به این بخش از چشم می‌دهد. وجود رنگ سیاه مانع از انعکاس نورهای اضافی در داخل کره چشم می‌شود و به تشکیل تصویر واضح‌تر کمک می‌کند.

صلبیه[2]:صلبیه بخش سفید رنگ نسبتاً محکمی‌است که دورتا دور کره چشم به جز قرنیه را می‌پوشاند و از ساختمان‌های داخل کره چشم محافظت می‌کند. این بخش از چشم اثر مستقیمی در فرایند بینایی ندارد و در واقع مثل یک اسکلت خارجی از کره چشم محافظت می‌کند.

عصب بینایی: عصب بینایی که رابط کره چشم و مغز می‌باشد از عقب کره چشم خارج می‌شود و از طریق سوراخی در استخوان پروانه‌ای جمجمه به مغز می‌رسد. این عصب پیام‌های بینایی را به مغز ارسال می‌کند و این پیام‌ها در مغز تفسیر می‌شوند.

به بیانی ساده کارکرد کلی چشم بدین‌گونه است که چشم نورهایی را که از خارج دریافت می‌کند طوری روی پرده شبکیه متمرکز کند که تصویر دقیقی از شی

مورد نظر روی پرده شبکیه ایجاد شود. شبکیه این تصاویر را به صورت پیام‌های عصبی به مغز ارسال می‌کند و این پیام‌ها در مغز تفسیر می‌شوند. بنابراین برای واضح دیدن، قبل از هرچیز لازم است که نور به طور دقیق روی پرده شبکیه متمرکز شود. ساختمان چشم شبیه یک کره است در قسمت جلوی این کره یک پنجره شفاف به نام قرنیه وجود دارد. نور از محیط خارج وارد قرنیه شده پس از عبور از مردمک به عدسی می‌رسد. عدسی نور را به صورت دقیق روی شبکیه متمرکز می‌کند تا تصویر واضحی بر روی شبکیه ایجاد شود. برای آنکه اشیاء به صورت دقیق و واضح دیده شوند لازم است مسیری که نور در چشم طی می‌کند شفاف باشد و قرنیه و عدسی نور را درست روی شبکیه متمرکز کنند.



۱-۳. شکلی از برش عرضی ساختمان چشم

۳-۳ تعریف معلولیت بینایی

یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین گروه‌های معلولین جسمی، معلولیت بینایی است از آنجا که این معلولیت در تمام موارد مطلق نبوده و اکثراً افرادی که نقص بینایی[1] دارند از دید

مختصر و حتی قابل استفاده‌ای برخوردارند، لذا امکان بیان تعریف جامعی را مشکل می‌سازد و مسئله گروه‌بندی را به میان می‌آورد.

تعاریف معلولیت بینایی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: تعریف قانونی و تعریف آموزشی. تعریف قانونی برتیزی و میدان بینایی تأکید دارد درحالی‌که تعریف آموزشی که جدیدتر از تعریف اولی نیز هست، مبتنی بر کارکرد از میزان باقی مانده بینایی در ارتباط با اهداف آموزشی است. اهمیت تعریف اول این است که افرادی را که مشمول استفاده از برنامه‌های نظیر معافیت مالیاتی، استفاده از کتابخانه‌ها، فرصت دریافت موادآموزشی ویژه و حق استفاده از برنامه‌های توان‌بخشی را مشخص می‌نماید و تعریف دوم که تعریفی آموزشی است معلولیت‌های بینایی را به گونه‌ای که برای مقاصد و برنامه‌های آموزشی مناسب است دسته‌بندی می‌کند.

بر اساس تعریف آموزشی تیلور[1] (۱۹۸۳، به نقل از پیتون[2] و همکاران ۱۹۹۱) افراد با نقایص بینایی شدید را به دودسته تقسیم کرده است:نابینا ونیمه بینا. افرادی که میزان بینایی آنها اجازه استفاده از خطوط نوشتاری را برای مقاصد آموزشی به آنها نمی‌دهد می‌توانند از روش بریل[3]، لامسه و وسایل شنیداری در آموزش استفاده کنند. افراد با بینایی جزئی یا نیمه بینا[4] می‌توانند در امر آموزش از باقیمانده بینایی خود استفاد کنند و برای یادگیری از کتاب‌هایی با خطوط درشت یا وسایلی که خطوط را بزرگ‌نمایی می‌کنند، استفاده نمایند.

درجه‌بندی نقص بینایی: نقص بینایی عبارت است از بدکاری عصب چشمی یا بینایی که مانع از دیدن بهنجار فرد می‌شود. وقتی که فردی نمی‌تواند حداقل با یک چشم به گونه هنجار ببیند، دارای نقیصه بینایی است. این افراد ممکن است محرکات را کم نور، تیره یا خارج از مرکز بینایی ببینند. آنها ممکن است تنها بخشی از یک شی را دیده یا هر چیزی را به این صورت که زیر توده سیاهی از ابر پنهان شده باشد، ببینند. آنها ممکن است هراز گاهی لکه‌های تاریکی را ببینند. توانایی استفاده از آنچه توسط مردم قابل رؤیت است، متفاوت است و می‌توان درجات متنوعی برای تیزی بینایی در

نظر گرفت. اصطلاحاتی نظیر نابینایی، نقص بینایی، کم‌بینایی[1] و معلولیت بینایی، گویای مشکلات دیداری عمده ای هستند. (پیتون، ۱۹۹۱).

در حالت کلی می‌توان نقص بینایی رابه نابینای مطلق[2]، نابینا[3]، نیمه‌بینا و دیربینا[4] درجه‌بندی کرد و با تکیه بر تعاریف قانونی و آموزشی به ویژگی‌های آن پرداخت. (کریمی درمنی، ۱۳۸۵).

نابینای مطلق: به فردی اطلاق می‌گردد که دارای ویژگی‌های زیر باشد:

- هیچ‌گونه دیدی ندارد یا هیچ گاه آن را نداشته است.
- نور برای آنان قابل رؤیت نیست.

نابینا: به فردی اطلاق می‌گردد که دارای ویژگی‌های زیر باشد:

- قدرت بینایی وی پس از حداکثر ترمیم برابر با $\frac{۲۰}{۲۰۰}$ است (دید نرمال $\frac{۲۰}{۲۰}$ است).
- زاویهٔ دید وی کمتر از ۲۰ درجه است (میدان دید به حدی است که نگاه کردن شخص از داخل یک لوله شبیه است که به آن دید تونلی گویند.)
- تشخیص نور و حرکت از فاصله یک متری برایش مقدور نیست.
- با هیچ وسیله‌ای نمی‌تواند از طریق بینایی آموزش ببیند.
- آموزش تنها از طریق حس شنوایی و لامسه امکان پذیر است.

نیمه بینا:به فردی اطلاق می‌گردد که دارای ویژگی‌های زیر باشد:

- قدرت بینایی در چشم بهتر و با استفاده از وسایل کمک بینایی از $\frac{۲۰}{۲۰۰}$ بیشتر و از $\frac{۲۰}{۷۰}$ کمتر است. (نتیجتاً $\frac{۲۰}{۲۰۰}$ مرز بین نابینایی و بینایی است)
- با استفاده از ذره‌بین و خطوط درشت و نظایر آن به مطالعه و آموزش می‌پردازد.

دیربینا: به فردی اطلاق می‌گردد که با توجه به نقصی که در بینایی‌اش وجود دارد از باقیماندهٔ بینایی‌اش با استفاده از وسایل کمک بینایی، بهره‌برداری نسبی نماید. (بدیهی است قدرت دید وی از $\frac{۲۰}{۷۰}$ بیشتر است).

۳-۵ میزان شیوع

سازمان بهداشت جهانی در روز جهانی نابینا در سال ۲۰۰۲ طی بیانیه ای اعلام کرد حدود ۴۵ میلیون نفر در جهان نابینا هستند که ۹۰ درصد آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند و تقریباً ۱۸۰ میلیون نفر نیز اشکال بینایی دارند. این آمار نشان می‌دهد در هر ۵ دقیقه یک نفر و در هریک دقیقه یک کودک در نقطه‌ای از دنیا دچار نابینایی می‌شود و ۸۰ درصد این نابینایی‌ها اجتناب‌ناپذیر هستند (کریمی درمنی، ۱۳۸۵).

مطابق گزارش سازمان آموزش و پرورش ایران در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ تعداد ۱۹۸۱ دانش‌آموز دارای آسیب بینایی در مدارس خاص استثنایی تحت آموزش قرار داشتند. به علاوه تعدادی دیگر از این گروه در مدارس عادی به‌صورت تلفیقی و فراگیر تحت آموزش قرار داشتند که از آمار آن اطلاعی در دست نیست.

۳-۶ طبقه‌بندی

علاوه بر دسته‌بندی افراد با نارسایی بینایی دریکی از دو دستهٔ نابینا و نیمه بینا، یکی از انواع طبقه‌بندی در مشکلات بینایی زمان ابتلای فرد به این عارضه است. (۱) فردی که از ابتدای طفولیت دچار شده است (زود نابینا) و (۲) فردی نابینایی که در سال‌های بعد زندگی مبتلا شده است (دیر نابینا[۱]).

لازم است در اینجا به یک نکته تأکید شود و آن این که نابینایی‌یا ناتوانی در دیدن، خود واجد طیف وسیعی است که از حد «نابینایی قانونی» تا «نابینایی مطلق» می‌تواند باشد. به عبارت ساده‌تر واژهٔ نابینا به معنای ندیدن کامل نیست چه بسا نور و سایه روشن محو نیز می‌تواند علیرغم وجود نابینایی قابل رؤیت باشد. «نابینایی قانونی» را می‌توان حدی از «نابینایی» در نظر گرفت که مقبولیت عام داشته، مورد پذیرش افراد صاحب‌نظر در جهان است. در نتیجه نابینایی قانونی الزاماً انسان فاقد دید کامل یا انسان نابینای مطلق نیست. در بررسی که روی گروهی نابینای قانونی به انجام رسید فقط ۱۸ درصد آنان نابینای مطلق بودند و بقیه تا حدی قدرت دید و تشخیص نورها و تصاویر محو را با دشواری داشتند (داورمنش و براتی سده، ۱۳۸۵).

طبقه‌بندی دیگری که مورد استفاده قرار می‌گیرد به‌صورت زیر است:

- **معلولیت بینایی عمیق:** در این معلولیت انجام‌دادن بسیاری از تکالیف درشت بینایی برای دانش‌آموز مشکل است و وی برای انجام‌دان فعالیت‌های ظریف قادر به استفاده از بینایی نیست.

- **معلولیت بینایی شدید:** در این نوع برای انجام‌دادن تکالیفی که به بینایی نیاز دارد، زمان و انرژی زیادتری لازم است و سطح کارکردی دانش‌آموز حتی به کمک وسایل ویژه و انطباق روش‌ها (در مقایسه با افراد بینا) از دقت کمتری برخوردار است.

- **معلولیت بینایی متوسط:** در این معلولیت انجام‌دادن تکالیف به کمک وسایل ویژه و روشنایی مناسب ممکن می‌شود و سطح کارکردی دانش‌آموز با دانش‌آموزانی که بینایی بهنجار دارند قابل مقایسه است (نامنی و همکاران، ۱۳۸۹).

۳-۷ ارزیابی بینایی

برای ارزیابی بینایی در سنین مختلف از آزمون‌های گوناگونی استفاده می‌شود ساده‌ترین و رایج‌ترین آزمون برای ارزیابی تیزی دیداری، استفاده از تابلو اِسنِلن[1] است که در مطب چشم پزشکان و برخی محل‌های عمومی چون مدارس و بیمارستان‌ها وجود دارد.

با توجه به تشخیص شخص از نظر درشتی و ریزی حرف E فاصله وی از تابلو و به‌خصوص تعیین جهت حرف مزبور در سطرهای مختلف میزان بینایی یا کمبود دید فرد تعیین می‌گردد. نحوه بررسی بدین ترتیب است که فرد در فاصله ۶متری از تابلو قرار می‌گیرد و پزشک با استفاده از عدسی‌های مختلف و یا پرسش در مورد سطور نوشته شده در روی تابلوی ثابت، میزان بینایی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

معمولاً مقدار دید یا بینایی را با استفاده از کسرهای استاندارد شده $\frac{۱۰}{۱۰}$ یا $\frac{۲۰}{۲۰}$ که حداکثر میزان بینایی برای یک چشم سالم است، مقایسه می‌نمایند که این میزان با مقدار بینایی در یک چشم سالم پس از ترمیم با وسایل کمکی مانند عینک، لنز و ذره‌بین برابر است. اگر مقدار بینایی از کسرهای فوق کمتر باشد نقص بینایی پدید آمده است و چنانچه مقدار بینایی از آن بیشتر باشد تیزبین نامیده می‌شود. (کاکاوند، ۱۳۸۵).



۲-۳. نمونه‌ای از تابلوی اسنلن

ارزیابی میدان دید: یکی از جنبه‌های بینایی که بررسی آن از اهمیت زیادی برخوردار است، میدان دید می‌باشد. زاویهٔ دید بسیاری از افرادی که دید مرکزی مناسبی دارند، در حدود ۱۷۰ درجه است. اما این زاویه در برخی از مشکلات چشمی به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد. در کودکان خردسال برآورد تقریبی میدان دید فقط با استفاده از وسایلی مانند توپ‌های استیکار[1] ممکن است. برای ارزیابی میدان دید، درحالی‌که کودک به‌طور مستقیم به طرف جلو نگاه می‌کند، توجه او را به شیئی که در مقابلش قرار گرفته است، جلب می‌کنند. در این هنگام شی دیگری (که به آرامی از

۳-۴ سبب‌شناسی

از جمله ضایعات بینایی که با استفاده از عینک یا روش‌های درمانی ویژه قابل رفع است می‌توان از نزدیک‌بینی، دوربینی، تاربینی، لوچی[۱] را نام برد. این گونه ضایعات معمولاً با ناتوانی و معلولیت همراه نیست.

آنچه که در ضایعات بینایی، نابینایی رسمی‌را ایجاد نموده و قادر به ایجاد ناتوانی و معلولیت در فرد مبتلا می‌گردد مواردی است که در زیر به برخی از مهمترین آنها اشاره می‌شود:

- ضایعات ارثی و مادرزادی، که کودک به علت عوامل ارثی‌یا زمینه‌های مادرزادی از بدو تولد دچار ضایعات چشمی شدید یا نابینایی می‌گردد.
- سوء تغذیه و کمبود ویتامین A که هرساله هزاران نفر افراد در مناطق محروم دنیا را دچار عارضهٔ خشک‌شدن قرنیه چشم نموده و به نابینایی سوق می‌دهد.
- ابتلا به بیماری تراخم[۳]: تراخم‌یک بیماری چشمی‌عفونی است که بر اثر آلودگی محیط و تماس آلودگی با چشم از طریق دست آلوده یا حشرات به وجود می‌آید. سوزش و سرخی چشم، اشک آلودی، نورگریزی، احساس درد و تاری چشم از علائم اولیهٔ ابتلا به تراخم است.
- **آب سیاه**[۴]: معمولاً از حدود بعد از ۳۵ سالگی بر اثر فشار زیاد داخل چشم که مانع از جریان‌یافتن خون در داخل چشم و عصب بینایی شده و موجب کوری می‌شود. علامت اولیهٔ آن احساس دیدن هاله‌ای در اطراف منبع نور است.
- **آب مروارید**[۵]: لکه‌های سفید در مردمک دیده می‌شود. در این بیماری دید دور و تشخیص رنگ‌ها به‌طور جدی آسیب می‌بیند.
- بیماری قند یا دیابت که موجب پارگی عروق در شبکیه چشم گردیده و چنانچه خونریزی روی شبکیه جذب نگردد، موجب از بین رفتن دید مفید چشم می‌گردد.
- آسیب‌دیدگی اندام بینایی بر اثر وارد شدن ضربه در حوادث، سوانح و همچنین مسمومیت‌های دارویی و ... .

پیشرفت تحصیلی: پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان با نارسایی بینایی در مقایسه با همسالان بینا تأخیر قابل ملاحظه‌ای دارد. در واقع پیشرفت تحصیلی این دانش‌آموزان اغلب به دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری شباهت دارد. متغیرهای متعددی بر پیشرفت دانش‌آموزان با نارسایی بینایی اثر می‌گذارد. در حوزه زبان نوشتاری این کودکان در سازماندهی افکارشان برای نوشتن انشا مشکلات بیشتری دارند زیرا در رمزگشایی برای خواندن تأخیر دارند. همچنین دانش آموران با آسیب بینایی اغلب از کتاب‌های بریل یا چاپ درشت به‌عنوان واسطه‌ای برای رمزگشایی استفاده می‌کنند. هنگام استفاده از این واسطه‌ها، فرایند رمزگشایی کندتر می‌شود. درک مطلب خواندن نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد زیرا درک مطلب خواندن وابستگی زیادی به تجربه‌های خواننده دارد. بنابراین، چون دانش‌آموزان با آسیب‌های بینایی در مقایسه با همسالان بینا تجربه‌ای محدود دارند، اطلاعات زیادی برای انجام تکالیف خواندنی ندارند. دلایل اجتماعی دیگر برای تأخیر در پیشرفت تحصیلی شامل مواردی مثل غیبت‌های زیاد از مدرسه به‌دلیل نیاز به جراحی یا درمان‌های چشم و نیز شکست در برنامه‌هایی که با نیازهای ویژه آنها همخوانی نداشته است می‌شود. به‌طور متوسط کودکان با نارسایی بینایی از همسالان بینا ۲ سال عقب‌تر هستند.

رشد اجتماعی: توانایی کودکان با نارسایی بینایی برای سازگاری با محیط اجتماعی به عوامل وراثتی و تجربی بستگی دارد. واقعیت این است که هریک از ما جهان را به شیوه خاص خودمان تجربه می‌کنیم اما پیوندهای مشترک این امکان را به ما می‌دهد که برای ادراک‌هایمان از جهان پیرامون مبنایی را در نظر بگیریم. یکی از این پیوندها برخورداری از حس بینایی است. بدون ادراک ما از خود و پیرامون به‌طور اساسی متفاوت خواهد بود. این تفاوت‌ها در ادراک برای فردی با نارسایی بینایی برخی چالش‌های اجتماعی هیجانی ایجاد می‌کند. یکی از مهم‌ترین مسائلی که کودکان نابینا با آن دست به گریبان هستند، دوست‌یابی است. یافتن فردی که بتواند احساس‌ها، شادی‌ها و رازهایشان را با او در میان بگذارند. بدیهی است که اگر کودک یا نوجوانی به سازگاری با خویشتن نرسیده باشد، قادر به سازگاری با دیگران نخواهد بود. فقدان بینایی بر یادگیری تقلیدی از حالات چهره، حرکات و اشاره‌های ضمنی نیز اثر

مراحل پیشرفته‌تر تحول می‌داند[۱] و معتقد است که کودک هنگامی به درون‌سازی اطلاعاتی که از محیط پیرامونش کسب کرده است، می‌پردازد که ساخت‌های پیش نیازی را که مبتنی بر فعالیت‌های حسی- حرکتی است، در اختیار داشته باشد. بنابراین، کودک باید واجد امکانات و ابزارهای لازم برای انجام دادن یک سلسله فعالیت‌ها و کسب تجربه‌های لازم باشد. پس ممکن است محرومیت از حس بینایی تحول روانی کودک نابینا را به تاخیر اندازد. طبق نظریهٔ پیاژه هنگامی که کودک نابینا دورهٔ حسی- حرکتی را طی می‌کند اگر مداخلهٔ به موقع صورت نگیرد، تجربهٔ اکتسابی که خود شامل تجربهٔ جسمانی و تجربهٔ منطقی- ریاضی است، می‌تواند به‌طور جدی با تاخیر مواجه شود. واضح است که اکتشاف دنیای اطراف برای کودکی که معلولیت بینایی دارد بسیار دشوارتر است.

مهارت‌های گفتاری و زبانی: رشد گفتار و زبان کودکان بینا ابتدا از طریق یکپارچه‌سازی تجربه‌های دیداری و نمادهای واژه‌های گفتاری صورت می‌گیرد. با توجه به میزان نارسایی بینایی، کودکان با نارسایی بینایی از نظر رشد مهارت‌های گفتاری و زبانی تأخیر محسوسی دارند. زیرا آنها نمی‌توانند از نظر دیداری واژه‌ها را با اشیا تداعی کنند به همین دلیل، این کودکان باید بر درون داد شنوایی و لمسی تکیه کنند و رشد گفتاریشان میزان کندتری دارند. زمانی که کودکان به مرحلهٔ قان و قون که از مراحل رشد گفتاری است می‌رسند، کودکان نابینا در مقایسه با همسالان خود تولید صدای کمتری دارند. البته ممکن است تولید کمتر صدا به این دلیل باشد که کودک با اشتیاق بیشتری گوش می‌کند. هرچند که وقتی این کودکان گفتار را می‌آموزند، معمولاً روان است.

کودکان سنین پیش‌دبستانی و سنین مدرسه با نارسایی ممکن است پدیده‌ای را نشان دهند که کلامی گرایی یا به‌کارگیری افراطی گفتار (پرحرفی) نامیده شده است. به این معنی که افراد واژه‌هایی را به کار می‌برند که معانی آنها را به خوبی نمی‌دانند. بیشتر پژوهش‌ها نشان می‌دهند که نوعی محدودسازی معانی کلمات و فقدان بسط افراطی در کودکان نابینا رایج است (هاردمن[۲] وهمکاران ۱۹۴۸، ترجمه علیزاده و همکاران، ۱۳۸۹؛ نامنی و همکاران، ۱۳۸۹).

حاشیهٔ میدان دید کودک به طرف مرکز میدان دید وی حرکت می‌کند) به وی ارائه می‌شود. موقعیت شی دوم هنگامی که کودک به آن توجه می‌کند با دقت ثبت می‌گردد.

ذکر این نکته لازم است که تفسیر نتایج این قبیل آزمون‌ها چندان آسان نیست. ارزیابی دقیق‌تر میدان دید مستلزم استفاده از وسیله‌ای به نام پریمیتر است. در این روش از کودک می‌خواهند تا به‌طور مستقیم به جلو نگاه کند و نقطهٔ نورانی کوچکی به آهستگی در اطراف میدان دید وی پدیدار می‌شود. میدان دید کودک با تشخیص نقطه‌های نورانی تعیین می‌گردد.

۳-۸ ویژگی‌های افراد نابینا

هوش: کودکان با نارسایی بینایی ادراکشان از جهان را بر مبنای درون داد حواس می‌گذارند. این امر به ویژه در مورد کودکان مادرزادی بیشتر صدق می‌کند زیرا تجربه یادگیری این کودکان به‌دلیل فقدان بینایی به شدت محدود است. در نتیجه، فرصت‌های یادگیری روزمره‌ای که افراد بینا به‌طور عادی دریافت می‌کنند، مانند خواندن روزنامه صبح یا تماشای گزارش خبری تلویزیون، به‌طور کلی برای آنها متفاوت است.

با بررسی ادبیات موجود دربارهٔ تحول عقلی کودکان نابینا مشخص می‌شود که این کودکان در زمینه‌های هوشی با همسالان خود تفاوت دارند، این تفاوت‌ها شامل گستره‌ای از ادراک مفاهیم فضایی[1] تا دانش عمومی‌در مورد دنیای اطراف است. این اعتقاد که معلولیت بینایی می‌تواند بر جنبه‌هایی از تحول عقلانی تأثیر منفی داشته باشد، همواره به‌طور کامل تایید نشده است. از جمله اینکه بین کودکان بینا و نابینای ۱۱ تا ۱۲ سال از نظر تحول شناختی تفاوت چندانی وجود ندارد یا تفاوت بسیار اندک است. صاحب‌نظران این عدم تفاوت را ناشی از جبران تأخیرهای موجود پس از اکتساب کامل زبان می‌دانند که از طریق آموزش‌های ویژه حاصل می‌شود.

پیاژه معتقد است یادگیری، از اعمال کودک بر دنیای فیزیکی به وجود می‌آید. کودک ابتدا از طریق اکتشاف‌های دیداری و لمسی و درک این نکته که اشیاء در بیرون از خود او وجود دارند و دایمی‌اند، نسبت به اشیاء و وقایع پیرامون خود آگاه می‌شود. پیاژه تجربه‌های حسی- حرکتی[2] را عامل مهمی در تحول‌شناختی کودک و رسیدن او به

---

1. Understanding spatial concepts

است. افزون بر این، ممکن است توانایی اندازه‌گیری‌شدهٔ کودک معلول بینایی در محیط فیزیکی خاص او، کارکرد کاملاً متفاوتی از آنچه این توانایی برای کودک بینا دارد، داشته باشد. ارزیابی که برای تعیین نقطه‌های قوت و ضعف هریک از افراد معلول بینایی صورت می‌گیرد، فرایند پیچیده‌ای است که بهترین وجه از طریق روی آورد چند جانبه به انجام می‌رسد. اطلاع از نقاط ضعف و قوت فرد و هم چنین اطلاع از پیشینهٔ وی، ارزیابی را معنادار می‌سازد. به‌عبارت دیگر، آنچه بر انتخاب ابزار سنجش اولویت دارد، پاسخگویی به سؤال‌ها در مورد کودک خاصی است که مورد آزمون قرار می‌گیرد.

انتخاب آزمون‌های مناسب، اطلاع از وضعیت بینایی دانش‌آموز، تکمیل اطلاعات حاصل از آزمون‌ها با مشاهده‌های معنادار، مصاحبه‌ها و تشخیص وجود سایر معلولیت‌ها از عوامل بسیار مهم در ارزیابی به شمار می‌روند. ارزیابی بالینی نیز از ارزیابی‌های مهم است که توسط پزشک انجام می‌گیرد. به‌رغم کوشش‌های بسیاری که در امر پژوهش صورت گرفته است، هنوز معلولان بینایی به اندازهٔ همسالان بینای خود از موقعیت‌های سنجش و توان‌بخشی برخوردار نیستند. در سنجش کودکان معلول بینایی باید از مقایسه آنها با کودکان بینا خودداری کرد و توجه داشت که روش‌های مبتنی بر مقایسه با هنجارهای گروهی، لزوماً بهترین شیوه سنجش کودکان معلول بینایی نیست. زیرا این کودکان بسته به باقی‌مانده بینایی، نابینایی پیش‌یا پس از تولد، واکنش والدین در قبال معلولیت و سبب‌شناسی‌های گوناگون حتی در یک طبقهٔ همگون نیز، گروهی نامتجانس هستند و برای سنجش هریک از توانایی‌های آنان، سنجش انفرادی لازم است. بسیاری از ارزیابی‌های تحولی، سن عقلی را مبنای مقایسه قرار می‌دهند که این کار برای مقایسه خوب است، اما در رابطه با هنجار سنی، تفاوت‌های بسیاری وجود دارد. واضح است که کاستی‌های مشاهده شده در این افراد از پیامدهای طبیعی معلولیت بینایی و شرایط همراه آن ناشی می‌شود. ارزیابی‌یکی از اجزای مهم طراحی برنامهٔ آموزش انفرادی نیز به شمار می‌رود (نامنی و همکاران، ۱۳۸۹).

در سنجش توان‌بخشی افراد با مسائل و مشکلات بینایی نیز همانند سایر معلولیت‌ها مهم ترین موردی که باید مورد بررسی قرار گیرد میزان تأثیر این مشکلات بر زندگی و توانمندی‌های کارکردی فرد است. در کنار این حوزه مهم مواردی مانند تعیین میزان آسیب و نیز سنجش سایر جوانب و توانمندی‌های فرد در

می‌گذارد. کودک نابینا قادر نیست از حالت‌ها و اطوار بدنی[1] دیگران تقلید کند و در نتیجه یکی از اجزاء بسیار مهم نظام ارتباط اجتماعی، یعنی زبان بدنی[2] در او ایجاد نمی‌شود.

جابه‌جایی و جهت‌یابی[3] محدودیت اصلی افراد با نارسایی مشکل در جابه‌جایی از یک مکان به مکان دیگر است. این افراد به‌دلیل مشکل بینایی موقعیت خود را در فضا درک نمی‌کنند، در نتیجه آنها نمی‌توانند در جهت درست حرکت کنند و از صدمه دیدن می‌ترسند و به همین دلیل برای حفاظت از خودشان می‌کوشند تحرک خود را محدود نمایند. نارسایی بینایی بر هماهنگی حرکات ظریف اثر می‌گذارد و با توانایی دستکاری اشیاء تداخل می‌کند. ضعف در هماهنگی چشم- دست در یادگیری چگونگی استفاده از ابزارهای مرتبط با مهارت‌های شغلی و مهارت‌های زندگی روزمره مشکل ایجاد می‌کند. پیشگیری یا ترمیم مشکلات حرکتی ظریف مستلزم آموزش به‌کارگیری ذره‌بین‌های کمک بینایی و بهبود مهارت‌های حرکتی ظریف است. این آموزش‌ها باید هر چه زودتر شروع شوند.

رشد ادراکی- حرکتی رشد ادراکی- حرکتی نه تنها در رشد مهارت‌های جابه‌جایی نقش اساسی دارد بلکه برای رشد شناخت، زبان، اجتماعی شدن و شخصیت نیز اهمیت دارد. اغلب کودکان با نارسایی بینایی در مقایسه با همسالان بینا توانایی تمیز ادراکی بیشتری دارند. این موضوع متفاوت از برداشت عمومی‌است که تصور می‌شود ازدست‌دادن بینایی موجب ایجاد استعداد بیشتر در سایر حواس می‌گردد برای مثال افراد نابینا می‌توانند صداهایی را بشنوند یا بوهایی را حس کنند که افراد بهنجار قادر به درک آنها نیستند (هاردمن و همکاران، ۱۹۴۸، ترجمه علیزاده و همکاران، ۱۳۸۹).

۳-۹ نیازها و اقدامات توان‌بخشی

ارزیابی سنجش[2] یکی از عمده‌ترین دشواری‌های افرادی است که با کودکان نابینا سروکار دارند. سنجش کاملاً دقیق این کودکان با مجموعه‌ای از مقیاس‌های رایج، حتی

استوار باشد. لیکن مادری که دارای فرزند معلول بینایی است تجارب پیشین برایش کفایت ندارد. چنین مادری نمی‌تواند از خردسالش به درستی مراقبت کند، به فرزندش بیاموزد به تنهایی حرکت کند، راهی برای غذا خوردن و یا لباس پوشیدن پیدا کند، موقعیت مکانی اطراف خویش را شناسایی کند. والدین برای رسیدن به چنین کفایت‌هایی به مداخله متخصصین نیازمندند تا به آگاهی‌ها و مهارت‌هایی جدیدی دست‌یابند. این مهارت‌ها کفایت‌ها و شایستگی‌های والدینی برای زندگی با فرزند معلول بینایی نامیده می‌شوند. این مداخله می‌تواند توسط متخصص توان‌بخشی بینایی، کاردرمان و یا معلمان صورت گیرد. متخصص به والدین، اغلب مادر، کمک می‌کند تا به آگاهی و مهارت جدیدی برای مواجهه مؤثر و کارآمد با فرزندشان دست یابند. این مهارت‌ها درک میزان و نوع آسیب بینایی فرزند، ارتباط برقرارکردن، درک نیاز، ایجاد موقعیت برای تحرک و استقلال حرکتی، خودیاری در غذاخوردن و لباس پوشیدن، درک جهت، بازی‌کردن، تربیت حواس در موقعیت طبیعی زندگی، آماده‌کردن فرزند برای تجارب اجتماعی و مهد کودک و مدرسه را در برمی‌گیرد (نیمن[1]، (۱۹۹۸)، ترجمه سنایی و همکاران، ۱۳۷۸).

آموزش قبل از دبستان: تجربه‌های پیش‌دبستان برای رشد و تحول کودکان معلول بینایی اهمیت بسیاری دارد. اگر به کودکان نابینا فرصت داده شود، می‌توانند پا به پای همسالان بینای خود بازی کرده و بیاموزند. تنها شرط لازم برای جایگزینی کودکان معلول بینایی در مراکز پیش‌دبستانی عمومی، داشتن ذهنی باز، بازخوردی مثبت و اندکی خلاقیت است. با کمی‌نوآوری مربی، کودک نابینا به سادگی به اندازه همسالان بینای خود از برنامه آموزشی استاندارد پیش‌دبستان بهره خواهد جست. تجربه پیش‌دبستان، سرآغاز آشنایی با دنیای افراد بیناست. به‌طور کلی، برنامه پیش‌دبستان به‌دلیل تنوع در تجربه‌های یادگیری و روی آوردی ملموس، مستلزم تغییرات اندکی است؛ زیرا همه مربیان پیش‌دبستان از تحول معمول کودکان اطلاع دارند و با روش‌های آموزشی مناسب این سن آشنا هستند. کودک نابینا نیز می‌تواند همان مفاهیمی را که به سایر کودکان آموزش داده می‌شود، فراگیرد و تنها تفاوت در شیوه یادگیری اوست. کودکان نابینا باید

برخی دیگر قادرند در این مهارت، در سطوح مختلفی پیشرفت کنند. این مهارت‌ها به‌ترتیب توالی عبارتند از: آگاهی دیداری، تقارب، تطابق، تناوب و یا خیره‌شدن، دنبال‌کردن، تشخیص فاصلهٔ نزدیک و دور، مهارت‌های ادراک بینایی، به دقت نگریستن، میدان دید پیرامونی، هماهنگی دست و چشم و ادراک رنگ و شکل.

توان‌بخشی زود هنگام: برنامهٔ مداخلهٔ زود هنگام مبتنی بر مرکز برای کودکان ۶- ۲ سال‌های که نیازمند محیط یادگیری منحصر به فرد مرکز آموزش توان‌بخشی افراد نابینا و مبتلا به اختلال‌های بینایی هستند، شامل این خدمات است:

- روی آورد تیمی که به وسیلهٔ معلم برای برنامه‌ریزی و اجرای برنامهٔ انفرادی هر کودک هماهنگ شده است.
- فراهم‌آوردن تجربه‌های یک به یک و گروهی متناسب با سطح تحولی کودک.
- تیم چند رشته‌ای مرکب از معلمان، درمانگرها و دستیارانی که دربارهٔ تأثیر معلولیت بینایی بر تحول کودکان آموزش دیده اند.
- برنامه‌های مربوط به نابینایی و معلولیت بینایی، مانند تحول جسمی و حسی، تحرک و جهت‌یابی، مهارت‌های ارتباطی زمینه ساز خواندن و نوشتن، ارزیابی و تقویت بینایی که به وسیلهٔ افراد متخصص تنظیم شده است.
- حمایت از توحیدیافتگی
- تدارک گردهمایی‌ها و کارگاه‌هایی برای والدین.
- تنظیم برنامه‌هایی برای دانش افزایی متخصصان (نامنی و همکاران، ۱۳۸۹).

تربیت حواس: حس لامسه و شنیداری از حواس بسیار مهم در آموزش و توان‌بخشی این کودکان می‌باشد برای افراد نیمه بینا و استفاده آنها از باقی‌مانده بینایی دو دیدگاه کاملاً متمایز وجود دارد. دیدگاه نخست این است که این افراد باید از راه به‌کارگیری وسایل بزرگ نمایی، تصویری و وسایل کمک آموزشی ویژه حداکثر استفاده را از باقی‌مانده بینایی کارکردی نمایند. همچنین هر تمرینی را که کارایی بینایی باقی‌مانده را افزایش می‌دهد، انجام دهند. این دیدگاه عکس فلسفه سنتی‌تر حفظ یا نگهداری بینایی است، دیدگاه اخیر از به کارگیری محدود چشم حمایت می‌کند. این دیدگاه بر این عقیده است که دانش‌آموزان با نارسایی بینایی اگر از بینایی باقی‌مانده

از سایر حواس خود استفاده گسترده‌تری نمایند. این کودکان به والدین و مربیانی نیاز دارند که از طریق تجربه‌های ملموس متعدد دنیا را به آنان عرضه نمایند.

ارتباطات: همان‌طورکه کودکان بینا با مطالب چاپی آشنا می‌شوند، برای کودکان نابینای خردسال پیش‌دبستانی نیز که آشنایی با کلمه‌ها و برچسب‌ها را شروع می‌کند، معرفی بریل مفید است. در این سن کودکان نابینا بریل را با کتاب‌های قصه، برچسب‌ها، داستان‌های تجربی و شکل سادهٔ بریل در سطح غیررسمی تمرین می‌کنند.

تحرک و جهت‌یابی[1]: کودکان نابینا از نخستین سال‌های زندگی برای داشتن کارکرد مستقل و آگاهی از محیط خود به یادگیری روش‌هایی که بتواند آنها را به رفت‌وآمد مطمئن و کارآمد قادر سازد، نیاز دارند. لازم است موارد زیر مورد ارزیابی قرار گرفته یا آموزش داده شود:

آگاهی بدنی، آگاهی فضایی، آگاهی شنوایی، روش استفاده از راهنمای بینا، مهارت‌های عصازنی، حرکت مستقل در محیط‌های آشنا، دنبال‌کردن، آگاهی محیطی، روش‌های محافظت‌کننده و جستجوی اشیای بر زمین افتاده.

مهارت‌های زندگی روزمره: لازم است کودکان نابینا نیز همانند همسالان بینای خود مراقبت از خود را فرا گیرند. این امر ممکن است مستلزم آموزش مستقیم مستمر و با استفاده از تحلیل وظایف باشد. برای همهٔ کودکان، توانایی شرکت در فعالیت‌های روزمرهٔ خانواده، هم به‌منظور توسعهٔ عزت نفس[2] و هم از جنبه یادگیری کارکردی مستقل، اهمیت دارد. زمینه‌هایی که باید مورد توجه قرار گیرد، عبارتنداز: قبول مسئولیت بهداشت شخصی، مرتب‌کردن وسایل شخصی، لباس پوشیدن، غذا خوردن، آماده‌کردن غذا، استفاده از تلفن و خانه‌داری.

مفهوم «خود» و اجتماعی‌شدن: کودکان نابینا به آموزش چگونگی بازی‌کردن و تعامل با وسایل نیازمندند. این کودکان از طریق تقلیدکردن یاد نمی‌گیرند، بلکه لازم است که بازی و تعامل آنان با دیگران توسعه‌یافته و مورد تشویق قرار گیرد. یادگیری رویایی با مردم یکی از اجزای طبیعی و مهم فراگیری زندگی در جامعه است. حفاظت از کودک در قبال بازی‌های شلوغ و پر جنجال کودکان هم سن، او را ازیک مرحلهٔ

جبرانی نیز انجام می‌گیرد. از دیدگاه کاردرمانی[1] باید شرایطی برای فرد فراهم آورد که علی‌رغم وجود مشکل خود بتواند در اجتماع حضور داشته و مشارکت نماید. یکی از مدل‌های مطرح در کاردرمانی مدل شخص- کار- محیط است. هر کدام از این سه قطب خود دارای عواملی هستند که می‌تواند یکی از گزینه‌های ارزیابی و درمان فرد با ناتوانی و حتی از موضوعات مورد بحث در ارتقاء کیفیت زندگی افراد سالم باشند. در حیطه ارزیابی می‌توان موانع و تسهیل‌گرهای محیطی، عوامل فردی مانند سنجش حس لامسه، عمقی و شنوایی، و الزامات مربوط به تکلیفی که باید انجام شود را مورد توجه قرار داد. از این رو در افراد نابینا یکی از حوزه‌هایی که درمانگر می‌تواند در آن دخالت داشته باشد، محیط زندگی فرد و ازبین‌بردن موانع محیطی باشد. تا به این ترتیب با اصلاح محیط تبادل میان سه قطب افزایش‌یافته و فرد به عملکرد کاری بالاتری دسترسی داشته باشد (ترومبلی و رادمسکی[2]، ۲۰۰۵).

مشاوره والدین: رؤیاهای والدین قبل از تولد فرزند با سلامتی همراه است. انتظار تولد فرزند سالم مانع از آمادگی والدین برای مواجهه با فرزند معلول از جمله معلول بینایی می‌گردد. غالباً تولد چنین فرزندی با شوک و ناباوری همراه است. به علاوه تولد فرزند معلول معادله‌های متعارف زندگی را به هم می‌ریزد. والدین برای زندگی با چنین فرزندی به زمان نیاز دارند تا از وقوع رخداد معلولیت آگاه شوند. پس از آگاهی از واقعیت رخداده، آنها دچار بحران می‌گردند. آنها برای پذیرش واقعیت معلولیت واکنش‌های مختلفی از خود نشان می‌دهند تا بتوانند از ماتم سلامت فرزند عبور کنند. در مرحله ماتم که مرحله‌ای بحرانی است آنها به تسهیل مشاوره‌ای نیاز دارند. این مداخله به مشارکت روان‌شناس عضو تیم توان‌بخشی نیازمند است. تسهیل مشاوره‌ای روان‌شناس عبور از بحران ماتم را آسان می‌کند. مشاوره در این امر غالباً به‌صورت گروهی صورت می‌گیرد. در مواردی که بحران پیچیده باشد مشاوره فردی نیز ضرورت می‌یابد (کاکوجویباری و طاهری، ۱۳۷۲).

آموزش والدین: هر مادری که دارای کودکی عادی است بر اساس تجربه و آگاهی پیشین دارای مهارت‌هایی است که وی را برای زندگی با فرزندش آماده می‌کند. این مهارت‌ها ممکن است مبتنی بر تجربه نسل قبل ویا تجربه و آگاهی مستقیم خودش

کمتر استفاده نمایند برای مدت طولانی‌تری می‌توانند همان دید محدود خود را حفظ کنند (هاردمن وهمکاران، ۱۹۴۸، ترجمه علیزاده و همکاران، ۱۳۸۹).

نیازمندی‌های توان‌بخشی افراد نابینا با توجه به سن آغاز نابینایی تا حدودی متفاوت است. در فردی که زود نابینا است موارد زیر انجام می‌شود:

- تقویت سایر گیرنده‌های حسی و آشنا شدن با خود و محیط اطراف از طریق شنوایی، لامسه و سایر حواس (داورمنش و براتی سده، ۱۳۸۵). در این زمینه کاردرمانگران توجه ویژه‌ای بر تصویر بدنی و نیز شمای بدنی دارند. آنها سعی دارند با تقویت حواسی مانند حس عمقی و وستبولار آگاهی فرد از بدن خود را افزایش دهند. ایجاد یک تصویر بدنی خوب می‌تواند زمینه ساز مناسبی برای کارکردهای مراقبت از خود و امور روزمره فرد باشد و کارکردهای شناختی فرد نیز تقویت می‌گردد. در فرد با ناتوانی مربوط به بینایی و نیز پردازش بینایی تصویر بدنی می‌تواند در آموزش جهت‌یابی و سایر موارد یک عامل کلیدی باشد (کیس اسمیت[1]، ۲۰۰۵).
- ایجاد مکان آرام و پر محبت برای زندگی. این امر معمولاً با مشاوره و آگاهی والدین و توسط روان‌شناسان و گاهی توسط کاردرمانگران انجام می‌گیرد.
- دسترسی به وسایل ارتباطی مناسب. مددکاران از جمله اعضای تیم توان‌بخشی هستند که می‌توانند منابع مالی و خدماتی مناسب را به مراجع خود معرفی نمایند.
- آموزش لازم در زمینه خواندن و نوشتن که توسط مربیان انجام می‌گیرد.
- آموزش و ایجاد مهارت در رشته‌ای خاص از علم یا زمینه‌ای از اشتغال (حرفه‌آموزی).

افراد دیر نابینا نیز تقریباً موارد مشابهی از خدمات را دریافت می‌کنند با این تفاوت که این افراد با تغییر شغل و کاریابی روبه‌رو خواهند شد. این افراد نیز نیازمند حمایت‌های قانونی و اجتماعی هستند (داورمنش و براتی سده، ۱۳۸۵).

آموزش تحرک و فعالیت برای زندگی مستقل: هدف از این نوع آموزش، که اهداف مهم توان‌بخشی نابینایان می‌باشد، این است که نابینا می‌تواند برای خود زندگی مستقل داشته باشد و احتیاج به دیگران نداشته باشد. آموزش شامل موارد زیر می‌گردد:

- آموزش استفاده از عصای سفید که معرف نابینایان در جامعه می‌باشد و جنبهٔ بین‌المللی دارد.
- آموزش استفاده از نقشه‌های راهنمای برجسته
- استفاده از وسایل الکترونیکی که به وسیلهٔ آن وجود اشیا حس می‌شود
- انواع وسایل کمکی مخصوص نابینایان مانند ساعت، ماشین حساب، ماشین تحریر، ضبط صوت. (حلم سرشت ودل پیشه، ۱۳۷۱).

آموزش: چشم پزشکان، متخصصین بینایی سنجی، کاردرمانگران و روان‌شناسان از اعضای اصلی تیم درمان و توان‌بخشی افراد با مشکلات و ناتوانی‌های بینایی هستند. متخصص بینایی به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا بتوانند از حداکثر امکان باقی‌مانده بینایی خود استفاده نمایند. این کمک‌ها شامل مواردی از قبیل حذف نورهای شدید غیرضروری در محیط کار، رفع موانع بازدارندهٔ حرکت در محیط، استفاده از کتابهای با حروف چاپی و درشت و به‌کارگیری نورپردازی ویژه‌ای برای افزایش فرصت‌های بینایی می‌شود. با وجود اینکه کودکان نیمه‌بینا می‌توانند از این راهبردها استفاده کنند، برخی از آنها از خط بریل بهره می‌گیرند چرا که آنها تنها قادر به دیدن حرکات محدود و سایه‌ها هستند.

آموزش خط بریل: روش خواندن و نوشتن جهانی که نابینایان از آن استفاده می‌کنند، خط بریل نام دارد. بریل خوانی‌یکی از رایج‌ترین شیوه‌های خواندن و نوشتن برای افراد مبتلا به معلولیت شدید بینایی و نابینایی کاردکردی به شمار می‌رود. کسب توانایی مناسب در خواندن و نوشتن به بریل، طی سال‌های مدرسه، برای دانش‌آموز نابینا اهمیت دارد. آشنایی با بریل، مزایای متعدد ملموس و غیرملموسی- از جمله افزایش احتمال دست‌یابی به شغل مولد و اعتماد به نفس بیشتر- را به همراه دارد.

به‌طور کلی می‌توان گفت که در نظام خط بریل حروف و علایم از ترکیب یک تا شش نقطهٔ برجسته به‌وجود می‌آید که این نقطه‌ها به‌صورت نقطه‌های افقی در دو ستون عمودی قرار می‌گیرد. در خط بریل، حروف الفبا و سایر علامت‌هایی که در خواندن و نوشتن به کار می‌رود با تغییر موقعیت مکانی نقطه‌ها تشکیل می‌شود.

ورزش؟ ورزش راه مناسبی برای پیوند هر چه بیشتر افراد معلول با جامعه است. شرکت در ورزش‌ها، به ویژه ورزش‌های تیمی، برای بلوغ عاطفی و روانی کودکان

حیاتی در تحول باز می‌دارد. باید کودک نابینا را در پیوستن به دویدن، کشتی گرفتن و بازی‌های جنجالی هم‌کلاسی‌ها تشویق کرد. چنانچه کودک بیش از اندازه مورد حمایت قرار گیرد، ممکن است به تشویق بیشتر و توضیح چگونگی این نوع بازی‌ها احتیاج داشته باشد. خراش‌های زانو و اشک‌های ناشی از ضربه فقط چند لحظه دوام دارد، اما آثار منفی محدودکردن کودک، در سراسر زندگی با او می‌ماند.

اطلاع از وضعیت چشم: لازم است کودکان نابینا علت نابینایی خود را بدانند و بتوانند دربارهٔ آن با دیگران صحبت کنند. این ادراک سبب پذیرش و توانایی کنارآمدن با این نارسایی می‌شود. نابینایی به این معنا نیست که کودک به‌طور کامل فاقد بینایی قابل استفاده است. بیشتر کودکان نابینا مقادیر متفاوتی از باقیماندهٔ بینایی دارند که می‌تواند بسیار مفید باشد. عواملی مانند نوع اختلال چشم، خستگی، میزان روشنایی، هیجان‌زدگی و غیره بر دید کودک کم بینا تأثیر دارد. با وجود این، کودک کم‌بینا، اغلب در شرایط نامطلوبی قرار داده می‌شود.

فناوری: کودکان نابینا به تجربه‌های زودهنگام با وسایل مناسب نیاز دارند. وسایلی که از نظر فناوری در سطح بالایی هستند برای نابینایان به سرعت در حال تحول است و تأثیر فزاینده‌ای بر زندگی آنان خواهد داشت. از جمله وسایل مناسب برای این سن، ضبط صوت و رایانه است.

مهارت‌های فکر کردن: کودکان نابینا برای داشتن کاردکرد در دنیای واقعی به تفکر منطقی و حل مسئله نیاز دارند. بسیاری از کودکان نابینا در زمینهٔ تفکر با نقایصی مواجه هستند و این مهارت‌ها را باید به‌طور مستقیم به آنها آموزش داد. تصمیم‌گیری، برطرف‌کردن تعارض و حل مسئله از موارد مهم در این زمینه است. کودکان خردسال ازطریق انجام‌دادن کارها به‌طور مستقل، حل مسئله رایاد می‌گیرند. دانستن این نکته است که چه موقع کاری را به تنهایی انجام دهد و چه زمانی تقاضای کمک کند. ارائه کمک بیش از اندازه به کودک نابینا وابستگی را به وی می‌آموزد. این عمل، فرصت‌های حل مسئله و اطمینان به خود را از کودک سلب می‌کند.

تحریک بینایی: بسیاری از کودکان نابینا مقداری باقیماندهٔ بینایی دارند. با وجود این، ممکن است بدون مداخله نتوانند از بینایی که دارند، استفاده کنند. بعضی از

منافع بسیاری دارد. با شرکت در ورزش‌ها در فرد اعتماد به نفس و استقلالی به‌وجود می‌آید که به موفقیت در زندگی منجر می‌شود. این امر در ورزش و تربیت بدنی نابینایان و افراد مبتلا به اختلال‌های بینایی نیز صدق می‌کند. ورزش به تحول هر چه بیشتر شخصیت، خودسازی و ارتباط نابینایان با افراد بینا کمک کرده و انزواطلبی و عدم تحرک ناشی از نابینایی را کاهش می‌دهد. ورزش با تأثیرگذاری بر روح و روان افراد، موقعیت مناسب‌تری را برای انجام دادن وظایف و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی فراهم می‌آورد.

برخی کودکان نابینا به علت تحرک کم در کودکی در نوجوانی نیز حرکاتی کند و کودکانه دارند و چنان دستان خود را جلو می‌گیرند که موجب جلب توجه می‌شود. افراد نابینا برای سازگاری با محیط و تسلط بر واکنش‌های درونی خویش باید به فعالیت‌های ورزشی بپردازند. ورزش و بازی در ایجاد هماهنگی بین اندام‌ها، موزونی حرکات، شناخت جهات مختلف و تمرکز نقش مؤثری را بر عهده دارد. از آنجا که بسیاری از افراد مبتلا به معلولیت بینایی به شرکت در فعالیت‌های ورزشی- تفریحی و سرگرم کننده تمایل ندارند، بنابراین لازم است که دسترسی به امکانات ورزشی مناسب برای آنان ساده بوده و اطرافیان، آنان را به مشارکت در این گونه فعالیت‌ها شرکت کنند (نامنی و همکاران، ۱۳۸۹).

توان‌بخشی حرفه‌ای: برنامهٔ خدمات توان‌بخشی حرفه‌ای به مددجویان در کسب آموزش‌های ضروری، مهارت‌ها، کارآموزی و حمایت لازم برای به دست آوردن شغل و نگهداری آن کمک می‌کند. بسیاری از افراد نابینا در صورت فراهم‌بودن شرایط، امکان رسیدن به مدارج عالی دانشگاهی را دارند و می‌توانند شغلی مناسب و درخور پیدا کنند، اما طبعاً نه همه.

خدمات توان‌بخشی حرفه‌ای در مورد زیر به افراد کمک می‌کند:

- تعیین هدف شغلی و معرفی منابع خاص برای کسب مهارت و حمایت لازم جهت کار در این زمینه.
- برطرف‌کردن موانع ورود به دوره‌های بعد از دبیرستان و سایر مؤسسه‌های آموزشی به‌منظور حصول اطمینان از دسترسی مددجو به آموزش و کارآموزی که به استخدام منجر می‌شود.

محیط حرکتی‌شان ایمن است. لذا وظیفه اول درمانگر فراهم‌آوردن اطمینان در مراجع از بابت ایمن‌بودن محیط است.

۳-۱۲ خودآزمایی

۱. نابینایی را از منظر قانونی توضیح دهید.

۲. چرا آموزش قبل از دبستان برای خردسال نابینا ضروری است ؟

۳. ..... بیماری چشمی عفونی است که بر اثر دست آلوده و یا حشرات به وجود می‌آید.

الف) آب سیاه　　ب) آب مروارید

ج) تراخم　　د) دیدن هاله‌ای

۴. اشعه نوری که از شی دیده شده منعکس می‌شوند ابتدا از. . . . . عبور می‌کند.

الف) قرنیه　　ب) زلالیه

ج) مردمک　　د) عدسی

۵. اهمیت ورزش را به عنوان یک نیاز توان‌بخشی در فرد نابینا توضیح دهید.

۶. ۳ مورد ازموارد توابخشی حرفه‌ای در نابینا را ذکر کنید.

۷. آموزش تحرک و فعالیت مستقل در فرد نابینا شامل چه مواردی می‌باشد؟

۸. موسیقی درمانی در نابینایان شامل چه اقداماتی می‌باشد.

۹. ارائه کمک بیش از حد به کودک نابینا فرصت‌های. . . . . و. . . . . را از کودک سلب می‌کند.

۱۰.وظیفه اول درمانگر در موسیقی درمانی نابینا، فراهم‌آوردن اطمینان در مراجع از بابت. . . . . است.

مشارکت‌دادن فعال آنان در جهان است. همچنین هدف کلی موسیقی درمانی را دستیابی و حفظ سطح مطلوب و بهینه عملکردیا سازگاری در همهٔ حوزه‌های زندگی دانسته‌اند.

اهداف عینی: منظور از اهداف عینی هدف‌هایی است که با دستیابی به آنها، مسیر نیل به هدف‌های کلی میسر می‌شود. این اهداف را می‌توان چنین برشمرد:

- اصلاح و ارتقای تصویر از خود و هوشیاری نسبی به بدن.
- افزایش مهارت‌های ارتباطی.
- افزایش استفاده هدفمند از انرژی‌های خود.
- کاستن از ناسازگاری‌ها.
- افزایش استقلال شخصی و خودراهبری.
- تحریک خلاقیت و تصویرسازی.
- اصلاح و ارتقای مهارت‌های حرکتی ظریف و درشت و افزایش هماهنگی بیشتر در این مهارت‌ها.

۳-۱۱ موسیقی درمانی برای افراد نابینا

آهنگ‌ها و آوازهایی که نابینایان را موظف می‌سازد تا حرکت کنند، یا قسمتی از اندام خود را لمس نمایند، می‌توانند در تقویت تصور درست از بدن مورد استفاده قرار گیرند. این تصور پیش نیاز حرکت موفقیت‌آمیز در فضاست. موسیقی ریتمیک آموزش حرکت به نابینایان را تسهیل می‌کند و حتی به نابینایان مادرزاد کمک می‌کند تا گام‌زدن و راه‌رفتن را به آرامی‌به دست بیاورند. همچنین کسب مهارت‌ها و اعتماد به نفس، فراگیری مفاهیم فضایی و انجام حرکات جابه‌جایی ساده و حرکاتی که از طریق اجرای آواگری و بازی‌های موزیکال و حرکات موزون ساده اجرا می‌شوند، می‌توانند به مهارت‌های نابینایان جهت حرکت و تشخیص در فضا کمک مؤثری نمایند.

از فعالیت‌های موزیکال می‌توان برای ایجاد ویا بهبود درک شنوایی در نابینایان هم بهره گرفت. ابراز احساسات و عواطف از طریق موسیقی از دیگر اهداف کاربرد موسیقی در نابینایان است.

برای شروع کار، موسیقی درمانگر باید میل و گرایش به انجام فعالیت‌های حرکتی را در نابینا ایجاد کند. لازمه این کار آن است که مراجعین اطمینان‌یابند که

فصل چهارم

توان‌بخشی معلولان ذهنی

اهداف فصل

در پایان این فصل از شما انتظار می‌رود بتوانید:

۱. دو تعریف کم‌توانی ذهنی را با یکدیگر مقایسه و تفاوت‌ها و شباهت‌ها را مشخص کنید.
۲. شیوع کم‌توانی ذهنی را بر اساس معیارهای مختلف گزارش کنید.
۳. عوامل مربوط به کم‌توانی ذهنی را لیست کنید.
۴. طبقه‌بندی کم‌توانی ذهنی را بر اساس DSM-IV را با ذکر نام بیان کنید و تفاوت دو طبقه را مشخص کنید.
۵. علت وقوع سندرم دان، فنیل کتونوری و هیدروسفالی را بیان کنید.
۶. مهارت مراقبت از خود را با ذکر موارد بیان کنید.
۷. توان‌بخشی حرفه‌ای را در معلولان ذهنی تعریف کنید.
۸. اعضای تیم توان‌بخشی افراد کم‌توان ذهنی را مشخص کنید.
۹. نیازها و برنامه‌های توان‌بخشی را برای کودکان کم‌توان ذهنی شدید استنباط و لیست نمایید.
۱۰. نقش بازی درمانی را در پیشرفت کودک کم‌توان ذهنی توضیح دهید.

۴-۱ مقدمه

تأخیر در راه رفتن، صحبت‌کردن و عدم‌توانایی در انجام امور متناسب با سن زنگ‌های

خطری هستند که وجود کودکی غیرطبیعی را اعلام می‌دارند. علل و عوامل مختلفی می‌توانند موجب نقص ذهنی بشوند.

نقیصه ذهنی پدیده‌ای پیچیده به شمار می‌آید و به همین دلیل به سختی می‌توان نسبت به آن تشخیص و قضاوت قطعی داشت گاهی با بزرگی یا کوچکی بیش از حد جمجمه همراه می‌شودو تشخیص وجود نقیصه را آسان می‌کند لیکن این موضوع همیشگی نیست. فرد مبتلا به نقیصه ذهنی به خدمات توان‌بخشی نیاز دارد تا علیرغم داشتن نقص ذهنی به حداکثر توان بالقوه خود دست پیدا کندوبه یک زیست متعارف دست یابد.

۲-۴ تعریف کم‌توانی ذهنی

با وجود تاریخ طولانی و بحث‌های متعدد در زمینهٔ کم‌توانی ذهنی، هیچ‌گاه تعریف واحدی از آن به دست نیامده است که مورد قبول تمام صاحب‌نظران باشد. یکی از دلایل این امر می‌تواند موضع عملی غالب متخصصان در برخورد با افراد دارای کم‌توانی ذهنی و خانواده‌های آنها و نادیده گرفتن مسائل نظری باشد. تعاریفی که در آغاز ارائه می‌شد تنها بر مبنای مشکلات جسمانی و ذهنی بوده است.

با گذر زمان مشخص شد که مسائل اجتماعی، اقتصادی و تربیتی نیز در ایجاد کم‌توانی ذهنی مؤثر هستند. یکی از تعریف‌های حاضر، کم‌توانی ذهنی را عدم‌توانایی در پردازش اطلاعات در راستای تعادل زیستی- روانی می‌داند که عموماً با هوش بهر پایین‌تر از حالت طبیعی و کاهش کارایی، تطابق و سازگاری همراه است و این شرایط ناشی از سایر اختلالات روانی نبوده و در سن رشد اتفاق افتاده است. تعریف دیگری که در این زمینه وجود دارد مربوط به انجمن ناکارآمدی‌های ذهنی امریکا[1] که در حال حاضر انجمن کم‌توانی ذهنی ورشدی آمریکا نامیده[2] می‌شود، است. این انجمن، کم‌توانی ذهنی را در سال ۱۹۵۹ با تکیه بر توانمندی‌های هوشی (ذهنی) و رفتار انطباقی تعریف نمود. این تعریف در گذر زمان بازبینی‌شده و تعریفی که هم اکنون مورد پذیرش است به‌صورت زیر می‌باشد:

بررسی و هدایت افراد شاغل به‌منظور کسب اطمینان از اینکه آنان در ایجاد دلبستگی نسبت به همکاران موفق هستند.

در آموزش و مشاورهٔ حرفه‌ای افراد متخصصی مانند کاردرمانگران، مشاوران، معلمان توان‌بخشی، مربیان تحرک و جهت‌یابی، روان‌پزشکان و روان‌شناسان و مددکاران همکاری دارند (داورمنش و براتی سده، ۱۳۸۵. نامنی و همکاران، ۱۳۸۹).

۳-۱۰ موسیقی درمانی

موسیقی درمانی[1] عبارت است از استفادهٔ ساختارمند از تجربه‌های موسیقایی به‌منظور تسهیل‌نمودن تغییرات مثبت و ایجاد این تغییرات در رفتار آدمی. توضیح درباره اجزای این تعریف به درک موضوع کمک می‌کند:

- استفاده ساختارمند یعنی اینکه موسیقی درمانی‌یک جریان دارای هدف مشخص و معلوم است. هر جلسه از موسیقی درمانی دارای برنامه‌ریزی خاصی است و برخلاف آنچه در بعضی از موارد دیده می‌شود این نوع درمان صرفاً بداهه نوازی نیست، بلکه طراحی، اجرا و ارزیابی در تک تک جلسات وجود دارد و این برنامه‌ریزی مطابق با نیازهای مددجو است. در موسیقی درمانی توجه خاصی به ارزیابی پیشرفت‌ها می‌شود.
- تجربه‌های موسیقایی: عبارتند از: یکی یا همه فعالیت‌هایی که در اثر گوش‌دادن یا نواختن موسیقی روی می‌دهند و از جمله آنهاست آواز خوانی‌یا سرودخوانی یا ترنم همراه با صدای موزیک، نواختن موسیقی، انجام حرکات هماهنگ با نوای موسیقی، گوش‌دادن به موسیقی و تأثیرپذیری هیجانی و عاطفی از آن (رفتن به حس و حال) و یا کار خلاقانه کردن با موسیقی (مثلاً سرودن و نگارش موسیقی).

اهداف موسیقی درمانی: اهداف موسیقی درمانی را می‌توان در دو دسته اهداف کلی و اهداف عینی مورد اشاره قرار داد.

اهداف کلی: هدف کلی موسیقی درمانی، مشارکت فعالانه افراد در رشد و تحول جامع، تغییرات رفتاری و رشدی و انتقال مهارت‌های موسیقایی و غیرموسیقایی جلسات مربوطه به دیگر جنبه‌های زندگی و درآوردن افراد از لاک انزوا و تنهایی و

۴-۳ سبب‌شناسی

علل کروموزومی و مادرزادی از دلایل عمده کم‌توانی ذهنی به شمار می‌آیند. در موارد مادرزادی ژن‌ها و کروموزوم‌ها سالم هستند، اما عوامل مختلفی در طول بارداری موجب اختلال در رشد لایه‌های جنینی می‌گردد؛ برای نمونه بیماری سرخجه، دریافت اشعه ایکس، دیابت و بیماری‌های عفونی. این عوامل می‌توانند در حین تولد یا پس از آن نیز منجر به کم‌توانی ذهنی گردند.

از عوامل حین تولد خفگی یا قطع تنفس، صدمه مستقیم به سر و مغز، پیچیدن بند ناف، آنوکسی[1] (نرسیدن اکسیژن لازم در زمان تولد به نوزاد) و طولانی‌شدن زمان زایمان و از عوامل پس از تولد می‌توان به صدمه به سر، تومورهای مغزی، عفونت‌هایی مثل یرقان و منژیت، گرسنگی و سوء تغذیه، تشنج، محرومیت‌های فرهنگی و محیطی اشاره کرد. درخصوص تأثیر عوامل محیطی و اجتماعی باید گفت که کم‌توانی ذهنی خفیف در افراد متعلق به محرومیت فرهنگی و طبقات اجتماعی- اقتصادی پایین به‌طور قابل توجهی شایع‌تر است و اغلب بستگان و اعضاء خانواده چنین افرادی نیز دچار علائم مشابه هستند. در این طبقات معمولاً حاملگی‌های سنین نوجوانی وجود دارد که با عوارض مربوط به وضع حمل، نارس و کم‌وزن‌بودن کودک همراه است. مراقبت پزشکی ناکافی پس از تولد، سوء تغذیه و مواجه شدن با مواد سمی‌چون سرب. ضربه‌های فیزیکی نیز شایع است. بی‌ثباتی خانواده، نقل مکان‌های مکرر و تعداد افراد زیاد خانوار نیز در این خانواده‌ها فراوان است. مادران این کودکان سطح سواد کمتری دارند و از ایجاد تحریک‌های مناسب در کودکان خود ناتوان هستند (کاپلان[2]، ۲۰۰۰، ترجمه فیروز بخت، ۱۳۸۱).

۴-۴ میزان شیوع

کم‌توانی ذهنی شایع‌ترین ناتوانی رشدی است که شیوع آن ۰/۸ تا ۳ درصد افراد در جامعه می‌باشد (کیس اسمیت، ۲۰۰۵). تقریباً ۱۱ درصد از کل دانش‌آموزان با ناتوانی که بین ۶ تا ۲۱ سال هستند، کم‌توانی ذهنی دارند. آمار شیوع ارائه شده از سوی بررسی

کم‌توانی ذهنی، ناتوانی است که با محدودیت قابل ملاحظه‌ای در کارکرد ذهنی و رفتار انطباقی[2] همراه است که در مهارت‌های مفهومی[3]، اجتماعی و انطباقی تجلی پیدا می‌کند. این ناتوانی قبل از ۱۸ سالگی آغاز می‌گردد.

این تعریف بیانگر چندوجهی‌بودن این ناتوانی است. این ابعاد شامل توانمندی‌های ذهنی و رفتار انطباقی و شروع در دوران کودکی است. (تبیین‌های این موارد چنانچه بعدها نیز ذکر خواهد شد باید در زمینه فردی و با توجه به عوامل فرهنگی[4] انجام گیرد. هوش اشاره به توانمندی ذهنی مغز در حل مسئله و یادگیری دارد. رفتار انطباقی نیز عبارت از مهارت‌های اجتماعی، عملی و مفهومی‌است که افراد در زندگی روزمره خود به کار می‌گیرند. مهارت‌های مفهومی خود شامل مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های مربوط به حفظ پول و حسابگری و خود رهنمودی[5] است.

مهارت‌های اجتماعی نیز دربرگیرنده مهارت‌های بین فردی و توانستنی تعمیل و پیروی از قوانین و مقررات است. مهارت‌های عملی آن دسته از مهارت‌ها هستند که فرد برای فعالیت‌های شخصی (مانند غذاخوردن) و فعالیت‌هایی که نیازمند استفاده از ابزار هستند و نیز فعالیت‌های مرتبط با شغل، از آنها استفاده می‌کند (زارتسکای[6] و همکاران ۲۰۰۵).

انجمن کم‌توانی ذهنی آمریکا ده حیطه مهارت سازشی را توصیف می‌کند که در زندگی مهم هستند: ارتباط، خود مراقبتی، زندگی خانوادگی، مهارت اجتماعی، استفاده اجتماعی، خودهدایتی، بهداشت و ایمنی، کارکردهای تحصیلی، اوقات فراغت و کار. ازاین رو به‌طور خلاصه می‌توان گفت کم‌توانی ذهنی سه عامل کلیدی دارد که عبارتنداز: آسیب جدی به توانایی هوشی که با آزمون‌های استاندارد شده اندازه‌گیری می‌گردد، آغاز قبل از ۱۸ سالگی و در ضمن آسیب به توانایی‌های انطباقی که برای داشتن یک زندگی مستقل ضروری هستند (کیس اسمیت[7]، ۲۰۰۵).

ملی بهداشت، به‌طور قابل توجهی کمتر از برآوردهای پیشین کم‌توانی ذهنی است. براساس نمره ۷۰ یا کمتر در آزمون هوش، برآورد می‌شود که افراد با کم‌توانی ذهنی احتمالاً ۳ درصد از کل جمعیت یا حدود ۶/ ۶ میلیون نفر از مردم ایالات متحده را شامل می‌شوند. یادآوری این نکته حائز اهمیت است که ما فقط می‌توانیم میزان شیوع کم‌توانی ذهنی را تخمین بزنیم، زیرا هیچ کس نمی‌تواند تعداد افراد با کم‌توانی ذهنی را با توجه به دشواری و لزوم داشتن متخصص در تشخیص افتراقی این پدیده با بسیاری از عوارض دیگر دقیقاً محاسبه کند (هاردمن[1] وهمکاران، ۱۹۴۸، ترجمه علیزاده و همکاران، ۱۳۸۹).

اگر شیوع ۱ تا ۳ درصد کم‌توانی ذهنی را در کشور ایران نیز صادق بدانیم، با در نظرگرفتن جمعیت تقریبا ۷۵ میلیونی با رقمی‌حدود از هفتصدوپنجاه هزار تا دو میلیون و دویست و پنجاه هزار مواجه می‌شویم که رقم قابل توجهی می‌باشد. این رقم برای جمعیت دانش‌آموزی تقریبی ۱۲ میلیون نفر با همان نسبت حدوداً از یکصدوبیست و هفت هزار تا چهار صد هزار نفر خواهد بود. درحالی‌که مطابق آمار سازمان آموزش و پرورش استثنایی در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ فقط پنجاه و سه هزار دانش‌آموز کم توان ذهنی در سراسر کشور تحت پوشش مدارس خاص قرار دارند.

۴-۵ طبقه‌بندی

برحسب معلولیت جسمانی، کم‌توانی ذهنی را به دو گروه تقسیم نموده‌اند که شامل اختلال ذهنی خالص و اختلال ذهنی ناخالص است. در اختلال ذهنی خالص افراد دارای هوش‌بهر پایین‌تر از حد طبیعی هستند و هیچ‌گونه اختلال حرکتی و معلولیت جسمانی در آنها دیده نمی‌شود اما عموماً دشواری‌های رفتاری و مشکلات اجتماعی دارند. تشخیص این افراد معمولاً دیرتر از زمان معمول صورت می‌گیرد و در خانواده و نیز محیط‌های اجتماعی به‌دلیل مشکلات و مسائل رفتاری همواره با سرزنش تنبیه روبه‌رو می‌شوند و در نهایت در بزرگسالی مرتکب جرایم متفاوت می‌گردند.

در اختلالات ذهنی ناخالص علاوه بر هوش بهر پایین‌تر از حد طبیعی، اختلالات حرکتی نیز به‌دلیل آسیب نیمکره‌های مغزی یا راه‌های ارتباطی و یا اعصاب محیطی

---

1. Hardman

کم‌توان ذهنی خفیف حدود ۸۰ درصد از کم‌توانان ذهنی را تشکیل داده و وسیع‌ترین گروه از آنان را شامل می‌شوند. افراد این گروه قادر به رشد اجتماعی ارتباطی در سنین تا پنج سالگی هستند، نقیصهٔ آنها در طیف حسی حرکتی، بسیار کم است؛ در نتیجه تشخیص بسیاری از آنان از افراد عادی تا سنین بالاتر به سختی ممکن می‌گردد. در سنین نوجوانی تا پایان دورهٔ ابتدایی قادر به تحصیل هستند و در سنین بزرگسالی با حداقل حمایت قادر به کسب مهارت‌های حرفه‌ای اجتماعی مناسب هستند. فقط در برابر ناملایمات اقتصادی اجتماعی گاه نیازمند راهنمایی و کمک سایرین می‌شوند. حدود ۸۰ درصد این افراد با وجود حمایت لازم و شرایط مساعد زمینه ازدواج و تشکیل خانواده را دارا می‌باشند لیکن انچه در عمل اتفاق می‌افتد درصد اندکی خواهد بود.

کودکان با کم‌توانی ذهنی متوسط[1]: این گونه افراد از لحاظ آموزشی در سطح تربیت‌پذیر[2] بالا قرار می‌گیرند. بهره هوشی آنها ۴۹-۳۵ است. این گروه حدود ۱۲ درصد افراد مبتلا به کم‌توانی ذهنی را تشکیل می‌دهند. افراد این گروه در سنین پیش‌دبستانی قادر به صحبت‌کردن یا آموختن شیوه در ارتباط هستند، ولی هشیاری آنها نسبت به قراردادهای اجتماعی اندک است. این افراد می‌توانند از حرفه‌آموزی بهره‌مند شوند و قادرند با نظارتی متعارف به مراقبت از خود بپردازند. طی سنین دبستانی قادر به فراگیری مهارت‌های شغلی و اجتماعی هستند اما پیشرفت تحصیلی آنها تا سطح کلاس دوم ابتدایی بیشتر نیست. آنها قادر به فراگیری انجام تردد تنها در مسافت‌های بین افراد فامیل هستند. در طی سنین بزرگسالی قادر به کسب مهارت‌های ساده و غیرتخصصی با نظارت نزدیک و در کارگاه‌های حمایت شده می‌باشند. در برابر ناملایمات هر چند خفیف اقتصادی اجتماعی نیز نیازمند کمک و راهنمایی سایرین هستند.

کودکان با کم‌توانی ذهنی شدید[3]: این گروه از افراد مبتلا به کم‌توانی ذهنی ۷ درصد افراد کم‌توان ذهنی را تشکیل می‌دهند. آنها از بهره هوشی ۳۴-۲۰ برخوردارند و در سطح تربیت‌پذیر پایین قرار دارند. طی سنین پیش‌دبستانی رشد حرکتی ضعیفی داشته و تکلم در آنها حداقل میزان را دارد و همچنین ارتباط کلامی رشد بسیار نامحسوسی در آنها دارد. طی سال‌ها حرف‌زدن را آموخته ومهارت‌های اولیه بهداشتی را

وجود دارد و برحسب محل ضایعه ممکن است از یک تا چند اختلال متفاوت باشد. در اختلالات ذهنی نا خالص اختلالات رفتاری نیز محتمل است.

یکی از اولین طبقه‌بندی‌هایی که برای کم‌توانی ذهنی به کار رفته است در اوایل ۱۹۰۰ توسط گودارد[۱] بود که نظام طبقه‌بندی را بر پایهٔ سن عقلی پیشنهاد کرد. افراد با سن عقلی کمتر از ۳ سال را کودن[۲]، بین ۳ تا ۷ سال را ناقص‌العقل[۳] و ۷ تا ۱۰ سال را کند ذهن[۴] نامید. عوامل دیگری نیز برای تقسیم‌بندی اختلال ذهنی در نظر گرفته‌اند که می‌توان هوش‌بهر[۵]، شدت اختلال و محدودیت را خاطر نشان کرد (زارتسکای و همکاران، ۲۰۰۵).

هوش بهر از مباحث اصلی در روان‌شناسی است که شایستگی و استعداد یادگیری افراد را مورد بحث قرار می‌دهد. برخی از صاحب‌نظران هوش را استعداد کمی و قدرت استفاده از تجربیات و برخی دیگر مانند پیاژه آن را توانایی سازگاری و انطباق با محیط تعریف نموده‌اند. هر کدام از این تعاریف بر جنبه‌ای خاص از هوش تأکید کرده‌اند. و کسلر هوش را مجموعه شایستگی‌های فرد در تفکر عاقلانه، رفتار انطباقی و اقدام مؤثر در سازش با محیط تعریف می‌کند (اتکینسون[۶] و همکاران، ۲۰۰۰، ترجمه براهنی و همکاران، ۱۳۸۱).

به‌طور کلی می‌توان هوش را آمیزه‌ای از:

- توانایی و استعداد کافی برای یادگیری و درک امور
- هماهنگی و سازش با محیط
- و بهره‌برداری از تجربیات گذشته، به‌کاربردن قضاوت و استدلال صحیح و پیداکردن راه حل منطقی در مواجه با مشکلات دانست.
- علاوه بر موارد فوق باید به سه جنبهٔ دیگر فهم، ابداع و ابتکار نیز توجه داشت.

محاسبه هوش بهر به‌صورت تقسیم سن عقلی به ماه بر سن واقعی به ماه به دست می‌آید که حاصل‌ضرب آن در ۱۰۰ هوش بهر فرد را نشان می‌دهد.

جدیدترین تقسیم‌بندی بر مبنای سیستم حمایتی چهار مرحله‌ای است که کودکان برای اعمال روزانه خود نیاز دارند و شامل موارد ذیل است:

کم‌توان ذهنی خفیف حدود ۸۰ درصد از کم‌توانان ذهنی را تشکیل داده و وسیع‌ترین گروه از آنان را شامل می‌شوند. افراد این گروه قادر به رشد اجتماعی ارتباطی در سنین تا پنج سالگی هستند، نقیصهٔ آنها در طیف حسی حرکتی، بسیار کم است؛ در نتیجه تشخیص بسیاری از آنان از افراد عادی تا سنین بالاتر به سختی ممکن می‌گردد. در سنین نوجوانی تا پایان دورهٔ ابتدایی قادر به تحصیل هستند و در سنین بزرگسالی با حداقل حمایت قادر به کسب مهارت‌های حرفه‌ای اجتماعی مناسب هستند. فقط در برابر ناملایمات اقتصادی اجتماعی گاه نیازمند راهنمایی و کمک سایرین می‌شوند. حدود ۸۰ درصد این افراد با وجود حمایت لازم و شرایط مساعد زمینه ازدواج و تشکیل خانواده را دارا می‌باشند لیکن انچه در عمل اتفاق می‌افتد درصد اندکی خواهد بود.

کودکان با کم‌توانی ذهنی متوسط[1]: این گونه افراد از لحاظ آموزشی در سطح تربیت‌پذیر[2] بالا قرار می‌گیرند. بهره هوشی آنها ۴۹-۳۵ است. این گروه حدود ۱۲ درصد افراد مبتلا به کم‌توانی ذهنی را تشکیل می‌دهند. افراد این گروه در سنین پیش‌دبستانی قادر به صحبت‌کردن یا آموختن شیوه در ارتباط هستند، ولی هشیاری آنها نسبت به قراردادهای اجتماعی اندک است. این افراد می‌توانند از حرفه‌آموزی بهره‌مند شوند و قادرند با نظارتی متعارف به مراقبت از خود بپردازند. طی سنین دبستانی قادر به فراگیری مهارت‌های شغلی و اجتماعی هستند اما پیشرفت تحصیلی آنها تا سطح کلاس دوم ابتدایی بیشتر نیست. آنها قادر به فراگیری انجام تردد تنها در مسافت‌های بین افراد فامیل هستند. در طی سنین بزرگسالی قادر به کسب مهارت‌های ساده و غیرتخصصی با نظارت نزدیک و در کارگاه‌های حمایت شده می‌باشند. در برابر ناملایمات هر چند خفیف اقتصادی اجتماعی نیز نیازمند کمک و راهنمایی سایرین هستند.

کودکان با کم‌توانی ذهنی شدید[3]: این گروه از افراد مبتلا به کم‌توانی ذهنی ۷ درصد افراد کم‌توان ذهنی را تشکیل می‌دهند. آنها از بهره هوشی ۳۴-۲۰ برخوردارند و در سطح تربیت‌پذیر پایین قرار دارند. طی سنین پیش‌دبستانی رشد حرکتی ضعیفی داشته و تکلم در آنها حداقل میزان را دارد و همچنین ارتباط کلامی رشد بسیار نامحسوسی در آنها دارد. طی سال‌ها حرف‌زدن را آموخته ومهارت‌های اولیه بهداشتی را

متناوب[1]: حمایت‌ها براساس نیاز فراهم می‌شوند. این حمایت‌ها ممکن است (۱) نامنظم باشند، بدین معنا که فرد همواره به کمک نیاز ندارد، یا (۲) کوتاه مدت باشند، یعنی در صورت بروز تغییر در طول زندگی ارائه شوند (مانند، ازدست‌دادن شغل، یا بحران‌های وخیم پزشکی). حمایت‌ها ممکن است از نظر شدت کم یا زیاد باشند.

محدود[2]: حمایت‌ها براساس تداوم مشخص می‌شوند. زمان مورد نیاز ممکن است محدود باشد اما متناوب نیست. کارکنان کمتری مورد نیاز است و هزینه‌های آن نیز کمتر از روش‌هایی است که با سطح بسیار عمیقی از حمایت همراه هستند (مانند: آموزش استخدامی کوتاه‌مدت یا حمایت‌ها در حین انتقال از مدرسه به دوران بزرگسالی).

گسترده[3]: حمایت‌ها با مشارکت درگیری منظم (مانند روزانه) دست کم در برخی از محیط‌ها نظیر محل کار یا خانه مشخص می‌شوند و حمایت‌ها از نظر زمانی محدود نیستند (مانند حمایت شغلی بلندمدت یا حمایت از زندگی در خانه مورد نیاز است).

فراگیر[4]: حمایت‌ها باید پیوسته و بسیار عمیق باشند. آنها ناگزیر باید در محیط‌های چندگانه ارائه شده و ممکن است ماهیتی وابسته به تداوم زندگی داشته باشند. حمایت‌های فراگیر معمولاً نسبت به حمایت‌های گسترده یا کوتاه مدت، نیازمند کارکنان بیشتری بوده و بسیار عمیق هستند (هاردمن و همکاران، ۱۹۴۸، ترجمه علیزاده و همکاران، ۱۳۸۹).

ویرایش چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM- IV)[5] کم‌توانی ذهنی را در چهار سطح خفیف، متوسط، شدید و عمیق طبقه‌بندی کرده است. اگر چه این طبقه‌بندی در سال‌های اخیر تغییر کرده است اما همچنان برای توصیف این کودکان به کار می‌رود.

کودکان با کم‌توانی ذهنی خفیف[6]: این‌گونه افراد از لحاظ آموزشی در سطح آموزش‌پذیر[7] قرار می‌گیرند. آنها از بهره هوشی ۷۰- ۵۰ برخوردار می‌باشند. افراد

1. Intermittent
2. Limit

عصب‌شناختی خاصی نیست و ممکن است با کم‌توانی ذهنی همراه شود اما در اغلب موارد کودکان با اختلال یادگیری هوش متوسط و شاید بالاتر از طبیعی دارند.

- **فلج مغزی**[1]: ۷۵ درصد کودکان فلج مغزی دچار کم‌توانی ذهنی نیز هستند اما حدود ۲۵ درصد هوش متوسط دارند. فلج مغزی اختلال حرکتی است که غیرپیشرونده است و در مغز در حال رشد اتفاق می‌افتد. مشکلات حرکتی، نواقص چهره‌ای (ریختی) و عصب‌شناختی از مشکلات ایجاد شده در فلج مغزی است. این کودکان با مشکلات دیگر مانند مشکلات شناختی، حسی و روانی مواجه هستند.

۸-۴ نیازها و اقدامات توان‌بخشی

توان‌بخشی دارای چهار بخش اصلی است که تمام این بخش‌ها به‌صورت غیر قابل تفکیک با هم ارتباط دارند. توان‌بخشی پزشکی[2]، توان‌بخشی اجتماعی[3]، توان‌بخشی آموزشی[4] و توان‌بخشی حرفه‌ای[5] چهار رکن اصلی را تشکیل می‌دهند. کاردرمانگران، روان‌شناسان، مددکاران اجتماعی، پزشکان متخصص و نیز سایر اعضای تیم درمان مانند گفتاردرمانگران و کارشناسان آموزش و معلمان متخصصینی هستند که در کار ارزیابی و درمان کودکان با کم‌توانی ذهنی مشارکت دارند. کاردرمانگران بنا به رسالت خود بیشترین نقش را در توان‌بخشی کودکان با کم‌توانی ذهنی دارند و سعی دارند تا با به‌کارگیری «کار»[6] مراجع خود را به بهترین سطح مشارکت در اجتماع برسانند. در این مسیر درمانگران از رویکردهای مراجع محور[7] و مبتنی بر خانواده و جامعه استفاده می‌کنند (ترومبلی ورادمسکی، ۲۰۰۵).

البته از رویکردهای درمانی نیز که با عنوان رویکردهای اصلاحی[8] یا درمانی نامیده می‌شوند، نیز استفاده می‌کنند. در رویکرد اصلاحی دو فن اصلی مورد استفاده قرار می‌گیرد: ۱. آموزش مهارت‌های جدید، رفتارها یا عادت‌های سودمند به جای مهارت‌های ناکارآمد موجود، جایگزین می‌شوند. ۲. تغییر در فرایندهای زیست‌شناختی[9]،

---

1. Cerbral palsy
2. Medical rehabilitation
3. Social rehabilitation

فرا می‌گیرند. این گروه عموماً قادر به بهره‌مندی از امکانات حرفه‌آموزی نیستند. در بزرگسالی قادر به پذیرش وظایف بسیار ساده البته توأم با نظارت نزدیک می‌باشند.

کودکان با کم‌توانی ذهنی عمیق[1]: این دسته اساساً کمتر از یک درصد از مجموع کم‌توانان ذهنی را تشکیل می‌دهند. دارای بهره هوشی کمتر از ۲۰ هستند و در سطح حمایت‌پذیر قرار دارند. در سنین پیش‌دبستانی حداقل ظرفیت برای فعالیت حسی حرکتی را دارا هستند. نیازمند شرایطی استوار با کمک‌ها و نظارت‌های قاطع می‌باشند. در سنین سال‌های مدرسه در بعضی از آنها رشد حرکتی بیشتری دیده می‌شود و بعضی از این کودکان ممکن است قادر به فراگیری بسیار محدود مراقبت از خود بشوند. در شرایط محیطی استوار و با کمک‌ها و نظارت‌های دقیق در بزرگسالی امکان ایجاد مقداری تکلم و رشد بیشتر حرکتی و نیز مراقبت از خود در حد بسیار محدود در آنها محتمل است.

۴-۶ کم‌توانی ذهنی با علائم بالینی

سندرم داون[2]: علت بیماری یک اختلال و نقص کروموزومی‌است. این بیماران یک کروموزوم شماره ۲۱ بیشتر دارند. با افزایش سن مادر، آمار به دنیا آمدن کودک با سندرم داون بالاتر می‌رود. کودکان با سندرم داون سر کوچک و مدور و چشم‌های مورب دارند. قسمت عقب سر پهن و صاف و جلو سر گرد است. تیغه بینی این افراد پهن است و گردن کوتاهی دارند. انگشت کوچک دست خمیده و خیلی کوتاه است و در ۲۵ درصد دارای یک خط افقی در انگشت می‌باشند. قوام پایین عضلانی و شلی و بی‌ثباتی رباط‌های مفاصل از علائم مهم این کودکان است. تکلم در این کودکان با تأخیر همراه است و حتی در بزرگسالی نیز بیان خوبی ندارند. این گروه در مقایسه با همسالان خود از نظر حسی حرکتی دارای تأخیر هستند. این افراد به‌ویژه در سال‌های اولیه زندگی به‌دلیل بیماری‌های قلبی یا ریوی از دنیا می‌روند. این کودکان هوش‌بهر متفاوتی دارند که تقریبا در تمام موارد کمتر از میزان طبیعی است. کودکان با سندرم داون کودکانی دارای سطح همکاری خوب هستند و آرام و با محبت می‌باشند.

فنیل کتونوری[3]: فنیل کتونوری جزء اختلالات مربوط به سوخت و ساز مواد

پروتئینی است. این بیماری از راه ژن مغلوب و کروموزوم‌های معمولی از پدر و مادر به کودک منتقل شده و منجر به کم‌توانی ذهنی نسبتاً شدید می‌شود. علت بیماری فقدان آنزیمی است که فنیل‌آلانین را به تیروزین تبدیل می‌کند. در نتیجه نبود آنزیم فنیل‌آلانین در خون انباشته شده و سیستم عصبی دچار آسیب می‌گردد. این کودکان از نظر رشد عمومی و جسمانی اختلالی ندارند. به نظر سالم و حتی زیباتر از سایر کودکان هستند. موهای بور و روشن، چشمان آبی روشن، پوست لطیف و حساس دارند. هوش‌بهر این افراد بین ۵۰ تا ۷۰ می‌باشد. این کودکان فعال و مخرب هستند و رفتارشان بیشتر ناگهانی است. تشخیص سریع بیماری و درمان فوری در بهبودی بیمار بسیار مؤثر است. معالجه این بیماران رژیم غذایی بدون فنیل‌آلانین و سایر اسیدآمینه‌هایی است که در بدن به آن تبدیل می‌شوند. در جریان درمان رنگ موها به‌تدریج تیره‌تر می‌شود، جنب و جوش کودک کاهش می‌یابد (میلانی فر، ۱۳۶۹).

هیدروسفال[1]: این بیماری که به علت ازیاد ترشح مایع مغزی نخاعی یا عدم امکان جریان و جذب آن در بطن‌های مغزی ایجاد می‌شود، که باعث ازیاد فشار داخل جمجمه شده و در نتیجه از رشد مغزی جلوگیری می‌کند. از ماه دوم و سوم پس از تولد رشد سریع دور سرآغاز می‌شود. این بیماری با کم‌توانی ذهنی بسیار شدید و اختلالات حسی و حرکتی مانند نابینایی، ناشنوایی و فلج‌های مختلف همراه است. در این بیماری حد فاصل استخوان‌های جمجمه و ملاج‌ها به‌خصوص در ناحیه پیشانی بسیار بازمانده و استخوان‌های سر از هم فاصله می‌گیرند. سر از هر طرف بزرگ، پیشانی به جلو آمده، چشم‌ها فرو رفته و بیمار چهره به خصوصی دارد. عمل جراحی در هیدروسفالی تنها فشار مایع مغزی نخاعی را کم می‌کند ولی به هیچ عنوان اختلال رشدی مغز را جبران نمی‌کند (کیس اسمیت، ۲۰۰۵).

۴-۷ ارزیابی و ملاک‌های تشخیص

در گزارش‌های جدید سازمان بهداشت جهانی مهم‌ترین موردی که باید در ارزیابی افراد با ناتوانی مورد توجه قرار گیرد، سطح مشارکت و رفاه فرد است که هدف تمام برنامه‌های آموزشی و درمانی نیز می‌باشد. سطح بهینهٔ مشارکت زمانی حاصل می‌شود

فیزیولوژیکی، روان‌شناختی[1] و عصب‌شناختی[2] است. تمرکز بر کاهش درد مراجع و تأثیر آسیب بر عملکرد شغلی او می‌باشد (ریسکای[3]، ۲۰۰۴). کار درمانگران با اتکاء به دانش خود در زمینهٔ تعامل فرد، محیط و تکلیف‌یا فعالیت شرایط مناسبی را فراهم می‌آورند تا مراجع به الزامات[4] به‌صورت انطباقی پاسخ دهند و با استفاده یا بدون وسایل کمکی بتوانند کارهای خود را انجام دهند. مراقبت از خود، اوقات فراغت و شغل مهم‌ترین کارهای زندگی یک فرد است که باید بتواند برای ارتقاء سطح کیفیت زندگی خود، آنها را در بهترین سطح ممکن انجام دهند.

برنامه‌های درمانی اولیه برای کودکان با کم‌توانی ذهنی معمولاً بر تسهیل دستیابی به بارزه‌های رشدی[5]، غنی‌سازی محیط، رشد خودیاری، رشد زبان و مهارت‌های حرکتی و نیز آموزش والدین بنیان نهاده می‌شود. در نوجوانان با کم‌توانی ذهنی رشد مهارت‌ها و علایق شغلی، مهارت‌های اجتماعی، آموزش مراقبت‌های جنسی و مهارت‌های اجتماعی لازم و ضروری است. در واقع هدف نهایی کاردرمانگران ایجاد عملکردهایی است که به‌صورت کارکردی[6] باشند و سعی بر آن است که تغییرات دوران کودکی در جهت مثبت انجام پذیرند. در کار درمانی فعالیتی انتخاب می‌شود که برای کودک معنادار باشد و کودک به‌صورت موفقیت‌آمیز در آن شرکت داشته باشد. این فعالیت‌ها دارای هدف هستند و برای کودک با ارزش می‌باشند. گاهی نیز از رویکردهای جبرانی[7] برای جبران تأخیرها یا نواقص در عملکرد استفاده می‌گردد. این رویکردها معمولاً برای کارکردهای مراقبت از خود و مدرسه مناسب هستند. روش‌های اصلاح شده نیز زمانی که کودک برای اولین بار یاد گرفت کارهایش را انجام دهد، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال برای کودکی که توان ضعیفی دارد می‌توان پیشنهاد کرد که در حالت نشسته یا خوابیده لباس خود را بپوشد. در نهایت می‌توان گفت کاردرمانگران به‌عنوان متخصصین امور توانبخشی در اغلب موارد سعی می‌کنند برای تصمیم‌گیری از شواهد موجود استفاده کرده و تمرینات خود را مبتنی بر شواهد ارائه دهند. با استناد به شواهد علمی موجود می‌توان بهترین روش درمانی موجود را انتخاب کرد (کریس اسمیت، ۲۰۰۵).

---

1. Psychological
2. Neurological
3. Risky

مهارت‌های زیر از مهم‌ترین حوزه‌هایی هستند که درمانگران در درمان توان‌بخشی و آموزش کودکان با کم‌توانی ذهنی بر آنها توجه ویژه دارند:

مهارت‌های حرکتی: کسب مهارت‌های حرکتی یکی از مؤلفه‌های بنیادین فرایند رشد و شرایط لازم برای یادگیری موفقیت‌آمیز در سایر حیطه‌ها از جمله خودیاری و مهارت‌های اجتماعی است. رشد مهارت حرکتی درشت به‌طور کلی با جابه‌جایی از جمله تعامل بدن با محیط سروکار دارد. مهارت‌های حرکتی درشت از حرکت‌هایی که تعادل را امکان‌پذیر می‌سازند گرفته تا الگوهای جابه‌جایی سطح بالاتر به‌طور مداوم رشد می‌کنند. الگوهای جابه‌جایی باعث حرکت آزادانه فرد در محیط می‌شود. مهارت‌های حرکتی درشت شامل کنترل سر و گردن، غلتیدن، درست نگه‌داشتن راستای بدن، نشستن، سینه‌خیز رفتن، خزیدن، ایستادن، راه رفتن، دویدن، پریدن و جست‌وخیزکردن است.

رشد مهارت‌های حرکتی ظریف بیش از رشد مهارت‌های حرکتی درشت نیازمند دقت و استواری است. رشد این مهارت‌ها از جمله دست درازکردن یا گرفتن، چنگ‌زدن و دستکاری اشیاء در وهلهٔ اول به توانایی کودک در تمرکز دیداری بر شی و تعقیب چشمی هدف متحرک بستگی دارد. هماهنگی چشم و دست عامل یکپارچگی بسیاری از مهارت‌ها و همچنین رشد مهارت حرکتی ظریف است. هماهنگی چشم و دست، اساس فعالیت‌های اجتماعی و تفریحی است.

مهارت‌های مراقبت از خود: رشد مهارت‌های مراقبت از خود برای پیشرفت کودک به سوی استقلال از مراقبان خود، حیاتی است. این مهارت‌ها عبارتند از: خوردن، لباس پوشیدن و حفظ بهداشت فردی. هریک از این موارد خود شامل انواعی از فعالیت‌ها هستند.

مهارت‌های اجتماعی: آموزش مهارت‌های اجتماعی بر اهمیت یادگیری مهارت‌های حل مسئله و تصمیم‌گیری و استفاده از روابط مناسب در موقعیت اجتماعی تأکید دارد. برخی صاحب‌نظران نشان داده‌اند که ضعف در حل مسئله و تصمیم‌گیری از جمله موانع موفقیت افراد با کم‌توانی ذهنی در محیط‌های اجتماعی و مدرسه است. از این گذشته مشخص شده است که این کودکان مهارت‌های اجتماعی را از طریق مشاهده یاد نمی‌گیرند

که تعامل مناسبی میان ویژگی‌های فرد، محیط و کارهایی (فعالیت‌هایی) که فرد باید انجام دهد، به‌وجود آمده باشد. در این گزارش که به‌طور اختصار ICF [1] نامیده می‌شود، عنوان شده است که برخلاف روش‌های سنتی که در آنها بیشتر بر ارزیابی و سنجش توانمندی‌های پایه‌ای و مهارت‌های فرد تمرکز داشتند باید سطح تعامل مراجع با اجتماع و شرکت او در نقش‌ها را مورد نظر قرار داد (ترومبلی ورادمسکی [2]، ۲۰۰۵).

آزمون‌های رسمی و تاریخچهٔ بیمار برای تشخیص کم‌توانی ذهنی به کار گرفته می‌شوند. این آزمون‌ها معمولاً شامل اندازه‌گیری هوش بهریا IQ و آزمون رفتارهای انطباقی از قبیل استدلال‌کردن، دانش در رابطه با محیط و رشد مهارت‌های مراقبت از خود و کارهای روزمره است. با وجود اینکه استفاده از نمرات IQ هنوز بحث برانگیز است اما می‌تواند یک عامل مناسب در پیش‌بینی کارکرد شناختی فرد در آینده باشد. زمانی گفته می‌شود که یک کودک دچار کم‌توانی ذهنی است که نمره هوش آیا ۲ انحراف معیار پایین‌تر از مقدار طبیعی برای آن سن باشد (کیس اسمیت، ۲۰۰۵).

مواردی پیش می‌آید که فرد کم‌توانی ذهنی ندارد اما علائمی‌از آن را نشان می‌دهد، از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

آفازی [3]: آفازی(اختلال گفتاری که به‌دلیل آسیب به مناطقی از مغز با نام بروکا و ورنیکه است. این اختلال به دو صورت بیانی و درکی می‌باشد. در نوع بیانی مراجع مفهوم کلمات را می‌داند اما قادر به ادای صحیح نیست و در نوع درکی بیمار کلمات را به خوبی بر زبان می‌آورد اما کلمات بی‌مفهوم و فاقد معنا هستند)

- **اختلالات ویژه یادگیری یا رشدی**: مانند تأخیر در تکلم، ضعف در خواندن و . . . این موارد رابطه‌ای با هوش ندارند و در کودکان تیز هوش و متوسط و عقب مانده در حدود ۵- ۱۰ درصد موارد ممکن است وجود داشته باشد. در واقع در این کودکان تأخیر در یک یا چندجنبه است اما در کودکان با کم‌توانی ذهنی در تمام جنبه‌های ذهنی، کم‌توانی مشاهده می‌شود. شایان ذکر است که اختلالات یادگیری آن دسته از اختلالات هستند که بر توانایی کودک برای مهارت در تکالیف مدرسه، پردازش اطلاعات و کارآمدی ارتباط اثر می‌گذارد. این ناتوانی‌ها اغلب به‌دلیل هیچ مشکل

به‌طور خلاصه مشاوره فردی به والدین کودک با کم‌توانی ذهنی کمک می‌کند تا نسبت به موارد زیر آگاهی‌های لازم را کسب نمایند:

- درک مختصری از مفهوم کم‌توان ذهنی در کودکان
- آگاهی و فهم درجه و میزان کم‌توانی ذهنی کودکشان و توجه به این مطلب که این معلولیت در آینده چه اثری بر زندگی کودک خواهد داشت.
- آگاهی بر اثرات وجود کودک با کم‌توانی ذهنی بر خود، خانواده، فرزندان دیگر خانوداه و بالاخره بر تطابق کودک و خانواده در محدوده محیطی که زندگی می‌کنند.
- فهم این واقعیت که رفتار کودک با کم‌توانی ذهنی درصورتی‌که بسیار عمیق نباشد می‌تواند تا حدودی تحت تأثیر خدمات آموزشی، تربیتی و درمانی قرار گرفته و اصلاح شود.
- دسترسی به منابعی که در جهت خدمت به وضع خاص آنان در جامعه وجود دارد.
- چنانچه هدف از راهنمایی و مشاوره با والدین، تعلیم و مواظبت و بهبود زندگی کودک باشد، باید توجه داشت که مشاور روان‌شناسی الزاماً باید برنامه مشاوره را به‌صورت فردی طرح‌ریزی کند زیرا هریک از والدین، در مقابله با مشکلات کودکان خود، محدودیت‌های خاص و توانایی‌های ویژه‌ای دارند. عواملی چون اشتغال والدین، تعداد فرزندان دیگر خانواده، سن آنها و بالاخره تحصیلات، وضع اقتصادی اجتماعی خانواده در برنامه‌ریزی ویژه این‌گونه کودکان باید مورد توجه قرار گیرد (حلم‌سرشت و دل‌پیشه، ۱۳۷۱).

آموزش والدین: والدین کودکان کم توان ذهنی به‌ویژه در دورهٔ پیش از دبستان از مهارت‌های اولیه برای زندگی با کودکشان برخوردار نمی‌باشند. در خردسالی مراقبت و نگهداری از کودک کم‌توان ذهنی نیازمند مهارت‌هایی است که در محیط زندگی طبیعی مادران آن را نمی‌آموزند. درک نیازهای کودک و برقراری ارتباط با وی مهارتی است که بدون مداخلهٔ متخصصان توان‌بخشی، برای والدین دشوار خواهد بود. مشارکت والدین و ایفای نقش آنها در اجرای برنامه‌های توان‌بخشی بدون آموزش و ایجاد مهارت در آنها میسر نخواهد شد. آموزش آنها می‌تواند به‌صورت گروهی و در مواردی به‌صورت فردی پی‌گرفته شود (کاکوجویباری و همکاران ۱۳۷۸).

توان‌بخشی حرفه‌ای: توان‌بخشی حرفه‌ای یکی از چهار رکن اصلی در توان‌بخشی

و نیازمند آموزش ویژه هستند (کاپلان و سادوک[1]، ۱۹۹۶، ترجمه پورافکاری، ۱۳۷۹). برای این منظور فرایند چهار مرحله‌ای را ارائه نموده است:

الف) دانش‌آموزان یاد می‌گیرند که از راه ایفای نقش و شبیه‌سازی مسئله را مورد مشاهده و تحلیل قرار دهند، مسئله یا مسائل را در موقعیت تعیین و نام‌گذاری نمایند.

ب) یاد می‌گیرند گزینه‌های احتمالی را که ممکن است مسئله را حل نماید، بررسی کنند. اگر آنها نتوانند گزینه‌هایی را ارائه نمایند، نحوه دسترسی به منابعی که به ایجاد راه‌حل‌های احتمالی کمک می‌کند را خواهند آموخت.

ج) زمانی که گزینه‌های احتمالی تعیین شدند، دانش‌آموزان کارآمدترین گزینه را برای حل مسئله انتخاب می‌کنند. هنگامی که گزینه مورد نظر اجرا شد، دانش‌آموز بررسی می‌کند که آیا مسئله حل شده است. چنانچه مسئله باقی‌مانده باشد، دانش‌آموزان در این مورد که چه کاری برای تغییر طرح می‌توانند انجام دهند، تصمیم می‌گیرند.

د) دانش‌آموزان نحوهٔ استفاده از راهبردهای مورد استفاده در حل‌یک مسئله برای حل‌کردن مسئله‌های مشابه در موقعیت‌های دیگر را یاد می‌گیرند.

مهارت‌های ارتباطی: توانایی برقرارکردن ارتباط با دیگران، یکی از مؤلفه‌های اصلی رشد و تحول است. بدون برقرارکردن ارتباط، هیچ تعاملی وجود نخواهد داشت. سامانه‌های ارتباطی با کودکان کم‌توان ذهنی سه نوع کلی است: زبان کلامی، ارتباط مکمل[2] (شامل زبان اشاره) و ترکیبی از رویکردهای کلامی و اضافی.

مهارت‌های درسی: دانش‌آموزان با کم‌توانی ذهنی می‌توانند از آموزشی که بر بنیان برنامه‌های درسی کارکردی استوار شده‌اند، سود ببرند. این کودکان می‌توانند تا سطح کلاس چهارم یا پنجم خواندن را ادامه دهند. مهارت‌های خواندن، نوشتن و ریاضیات غالباً در این کودکان دچار مشکل می‌باشد (هاردمن وهمکاران، ۱۹۴۸، ترجمه علیزاده و همکاران، ۱۳۸۹).

متخصصین حاضر در تیم درمان و توان‌بخشی در جهت آموزش و درمان بالینی کودکان با کم‌توانی ذهنی از روش‌ها و رویکردهای متنوعی استفاده می‌کنند. مدل‌های پزشکی، رشدی، رفتاری، شناختی، انسان‌گرایانه، بوم‌شناختی[3] از جمله روش‌هایی

هستند که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. استفاده از رویکردهای پردازش حسی، فرایندهای ادراکی- حرکتی، و یکپارچگی حسی از رویکردهای رایج میان کاردرمانگران است (کاپلان، ۲۰۰۰، ترجمه فیروز بخت، ۱۳۸۱). روش یکپارچگی حسی[1] در سال‌های اخیر مورد توجه بیشتری واقع شده است. این روش توسط جین آیرز[2] (کاردرمانگر) در سال ۱۹۷۹ به‌وجود آمد. فرض اصلی در این رویکرد آن است که با فراهم‌سازی درون‌دادهای حسی برنامه‌ریزی‌شده و متناسب با نیازهای کودک می‌توان برون‌دادهای مورد نظر و رفتارهای انطباقی را انتظار داشت. تأکید اصلی در این روش بر سه حس دهلیزی[3] و عمیق[4] است. آیرس معتقد بود که با رعایت اصول خاصی می‌توان درون‌دادها را با هم یکپارچه کرد و رفتارهای مناسب با شرایط را از مراجع مشاهده نمود و همچنین با ایجاد رفتارهای انطباقی می‌توان یکپارچگی حسی را در فرد به سطح بالاتری ارتقاء داد. رسیدن به هدف نهایی در این رویکرد با ایجاد شرایطی با عنوان «شرایط و چالش‌های دقیقاً مناسب»[5] می‌باشد. در این شرایط فرد با تکالیفی مواجه می‌شود که نه بسیار دشوار است که موجب ناامیدی فرد گردد و نه بیش از حد ساده است که منجر به ملالت فرد شود، بلکه فعالیت‌ها در حدی است که فرد در نهایت با بدون کمک قادر به انجام موفقیت‌آمیز آنها خواهد بود (می - بن سون و کومار[6]، ۲۰۱۰).

خلاصه وظایف سایر اعضای تیم درمانی که در توان‌بخشی کودکان کم‌توان ذهنی شرکت دارند می‌تواند به‌صورت زیر باشد. روان‌شناسان نقش مهمی در ارزیابی و تعیین سطح هوش بهر فرد و نیز سنجش و درمان سایر مشکلات رفتاری و خلقی دارند. این متخصصین با به‌کارگیری روش‌های آموزشی مناسب سعی در ازمیان‌برداشتن و یا به حداقل‌رساندن موانع موجود برای بازگشت فرد به جامعه و داشتن یک زندگی مناسب دارند.

مددکاران اجتماعی به‌عنوان یک رابط مناسب در معرفی مراجع به متخصصین و صاحب‌نظران و نیز در مواردی ارائه مشاوره در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عمل می‌کنند.

در زمینهٔ آموزشی کودکان با کم‌توانی ذهنی که در مدارس استثنایی و گاهی

---

1. Sensory integration
2. Jean Ayres
3. Proprioceptive

است و در اصل نقطهٔ نهایی در این مجموعه فعالیت محسوب می‌گردد. هر کس در برخورد اول با شغلی که دارد معرفی می‌شود. این حق قانونی هر فرد معلول است که پس از مجموعه اقدامات توان‌بخشی پزشکی، آموزش‌های لازم جهت انطباق با وضعیت خود و جامعهٔ خود و همگام با اقدامات توان‌بخشی اجتماعی؛ شغلی مناسب و در خور توان خود را ابتدا آموخته و سپس به آن مشغول شود. حرفه‌ای که برای افراد مبتلا به معلولیت در نظر گرفته می‌شود باید از یک سو متناسب با توانمندی‌ها و حتی‌المقدور علایق و انگیزه‌های شخصی وی، و از سوی دیگر مبتنی بر رواج آن در بازار کار بوده و دارای جامعیت باشد و ضمناً حتی‌الامکان منزلت شخصی و اجتماعی فرد معلول را نیز تأمین نموده، علاوه بر همهٔ اینها تا حد ممکن برای او درآمدزا باشد. آماده‌سازی برای اشتغال در افراد معلول شامل حرفه‌آموزی، اشتغال و پیگیری است. حرفه‌آموزی، آماده‌سازی فرد معلول برای احراز یک شغل مناسب است. هشت سال اول زندگی که برنامه‌های آموزشی و توانپزشکی انجام می‌گیرد مرحله آماده‌سازی عمومی‌است. بخش دوم حرفه‌آموزی تخصصی است که در جهت‌یاددادن و ایجاد مهارت در حرفه‌ای خاص همراه با تداوم بخشیدن به آموزش‌های مرحله اول است. مرحله تخصصی از ۱۵ سالگی آغاز می‌شود و طی شش ماه تا سه سال می‌تواند ادامه داشته باشد. اشتغال در افراد دارای کم‌توانی ذهنی می‌تواند به‌صورت اشتغال مستقل، حمایت‌شده و اشتغال در منزل باشد. مرحله نهایی پیگیری است. وظایف مربوط به توان‌بخشی حرفه‌ای با حرفه‌آموزی و ایجاد زمینه اشتغال به پایان نمی‌رسد. بلکه آنچه تضمین‌کننده تداوم کوشش‌های به انجام رسیده است، پیگیری و تعقیب وضعیت اشتغال فرد معلول پس از به کارگماری است. فرد معلول نباید در محیط کار و اشتغال رها شود. شاید بهترین نیروها برای انجام این مهم مددکاران اجتماعی دوره دیده باشند که با سرپرستی حدود بیست تا بیست و پنج فرد معلول شاغل توسط هر مددکار کلیه جنبه‌ها و امور شغلی، اجتماعی و اقتصادی آنان به‌طور مستمر مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

۹-۴ بازی درمانی در کودکان با کم‌توانی ذهنی

بازی تجربه اصلی کودک برای ادراک جهان پیرامون است و جایگاه وی در جهان را مشخص می‌کند. به‌تدریج که کودک رشد و نمو می‌یابد در ارتباط با خود و جهان ماده،

و اجتماع پیرامونش اقدام به معناسازی می‌کند و از طریق بازی‌کردن خود را کشف می‌کند. بازی‌ها از دیدگاه اجتماعی به بازی‌های مشاهده‌ای، انفرادی، موازی، شراکتی و تعاونی دسته‌بندی می‌شوند.

لیندر با استناد به مجموعه‌ای از تحقیقات اهمیت بازی برای کودکان را به قرار زیر بر می‌شمارد:

- بازی به‌عنوان عرصه‌ای برای انجام فعالیت‌های مربوط به حل مسئله
- تداعی بازی با توانایی کودکان در تمایز بین اطلاعات مرتبط و غیرمرتبط
- ارتباط بازی با رشد کسب مهارت‌های انگیزشی و پیگیری انجام امور و فعالیت‌ها
- انجام بازی به‌عنوان کسب فرصتی برای افزایش تجارب کودک و از این طریق افزایش ذخیره واکنش‌های وی
- توانایی بازی در افزایش میزان خلاقیت عملکرد و تفکر خلاق کودک
- تداعی بازی با رشد عملکردهای سطح بالای آموزشی، شامل رشد مفاهیم مربوط به طبقه‌بندی، استدلال فضایی، نمادها و حافظه تربیتی
- بازی به‌عنوان زمینه‌ای برای تجربه و کسب مهارت‌های اجتماعی و زبانی

بنابراین بازی تنها فعالیتی نیست که کودک انجام می‌دهد بلکه فعالیت‌های مورد نیاز و ضروری برای رشد مناسب، خصوصاً در زمینه عملکردهای سطح بالاتر ذهنی است. در یک جمله می‌توان گفت بازی برای کودک مفید است.

یکی از موضوعات مهم متخصصان فعال در زمینه بازی این است که آیا کودکان مبتلا به ناتوانی‌های مختلف از نظر الگوی بازی و یا بازی‌هایی که انجام می‌دهند با سایر کودکان متفاوت هستند یا خیر؟ صاحب‌نظران تعدادی از پیش‌نیازهای لازم برای انجام بازی با اشیاء را بر شمرده است. از جمله این پیش‌نیازها می‌توان به چنگ‌زدن هدایت‌شده بصری، هماهنگی بین چشم و دست، پایداری شی، الگوهای مرتبط با عملکردهای متمایز حافظه و داشتن توانایی استفاده از نمادها اشاره کرد. به‌دلیل اینکه اغلب کودکان با ناتوانی در زمینه‌های ذکر شده دارای ناتوانی‌های مختلف هستند، لازم است والدین یا مراقبان به منظور رفع مشکلات موجود و تسهیل تعامل کودک با اشیاء و محیط و فراهم‌آوری امکان رشد کودک مداخله بیشتری داشته باشند. هنگامی که سطوح پایین عملکردهای بازی در این کودکان مشاهده می‌شود باید به‌منظور کشف

مدارس عادی صورت می‌گیرد، نقش عمده بر عهدهٔ مربیان آموزش و پرورش استثنایی می‌باشد. این مربیان آموزش را در سطح کودکان و متناسب با نیازهای آنها ارائه می‌کنند.

در صورتی که افراد دچار تأخیر و یا مشکل در زبان‌یا گفتار باشند معمولاً به گفتاردرمانگران ارجاع داده می‌شوند. پزشکان متخصص نیز نقش اصلی را در تشخیص اختلال بر عهده دارند.

مشاوره باوالدین: بزرگترین نیاز والدین اطفال کم‌توان ذهنی مشاوره در مراحل مختلف زندگی کودک است که آنها را دریافتن پاسخ معقولانه به مسائل فردیشان قادر می‌سازد. در جریان مشاوره قبل از هر چیز، ارزشیابی دقیق و همه‌جانبه که مستلزم همکاری متخصصین و تکرار جریان ارزشیابی در زمان‌های مختلف رشد کودک می‌باشد، بسیار ضروری و اساسی است. نتیجه این‌گونه ارزشیابی‌ها بایستی به‌طور دقیق و صادقانه برای والدین تفسیر شود، زیرا این کار تنها راهی است که شخص می‌تواند امیدوار باشد تا با استفاده از داده‌های آن بتواند از اثر نظارت غیرواقعی و غیرعملی اجتناب نماید. به‌طور کلی مشاوره و روان درمانی بر پایه رفع و تعدیل اختلالات عاطفی‌یا هیجانی والدین و خانواده این قبیل کودکان و پذیرش واقعیت کم‌توانی ذهنی لازم و ضروری است و سازگاری هنگامی صورت می‌گیرد که پدر و مادر و اطرافیان کودک با واقع بینی به شناخت و حل مشکل اقدام نمایند. جلسات مشاوره‌ای، والدین را کمک می‌کند تا آن دسته از احساسات خویش را که مخل ارتباط مثبت و سازنده آنان با کودکان کم توانشان است شناسایی نموده و در زمینه تعدیل یا رفع آن اقدام نمایند. تشکیل جلسات مشاوره‌ای با شرکت والدین ممکن است به دو طریق فردی و گروهی صورت پذیرد. مشاوره فردی، معمولاً برای والدینی که کودکانشان نیازهای ویژه‌ای نظیر وابستگی شدید عاطفی، انواع ناسازگاری‌ها چون پرخاشگری و بالاخره اختلالات رفتاری مشخصی دارند، مفیدتر است. مشاوره گروهی با چنین والدینی موفقیت زیادی به همراه نخواهد داشت. زیرا آنان به توجه دقیق و اقدامات فوری نیازمندند و لازم است که والدین‌یافته‌ها و اطلاعات در زمینه تشخیص و بالاخره ارزیابی درباره مشکل فرزندشان را به وضوح و به‌طور کامل بفهمند تا بتوان به حل مشکل آنان کمک کرد. تجارب عملی نشان می‌دهد که پس از تفهیم و تشخیص مشکل، پذیرش آن به‌طور

درصد افسردگی، اعتماد به نفس پایین، اضطراب و سایر مشکلات مربوط به سازگاری اجتماعی در این افراد وجود دارد. بازی درمانی برای این دسته از کودکان بسیار مناسب است زیرا به‌عنوان ابزار ارتباطی به‌منظور بیان نیازها و عواطف مطابق با توان آنان در اختیارشان قرار می‌گیرد. هدف این روش فقط تأمین و برآوردی نیازهای عاطفی این افراد است و نه ایجاد تغییراتی که صرفاً جنبه رفتاری دارند. هر چند فرارگیری این شیوه در لیست مربوط به روش‌های درمانی مربوط به این گروه از کودکان به کندی انجام می‌گیرد، اما یک بررسی انجام شده در یکی از کشورهای اروپایی (هلند در سال ۱۹۸۵) نشان می‌دهد که بازی درمانی به‌عنوان یک مداخله در مراکز نگهداری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از بازی درمانی گروهی به‌منظور تسهیل سازگاری روانی کودکانی که کم‌توانی ذهنی دارند، استفاده می‌شود. بازی درمانی منجر به افزایش میزان علاقه این کودکان به برقراری ارتباط با دیگران می‌شود که این امر خود عامل افزایش و بهبودی توان گفتاری و کلامی فرد خواهد شد (صمدی، ۱۳۸۹).

۱۰-۴ خودآزمایی

۱. طبقه‌بندی از نظر گوارد را بیان کنید.

۲. تفاوت پیامدهای کم‌توانی ذهنی خفیف و متوسط را مشخص کنید.

۳. علائم سندرم‌داون را مشخص کنید.

۴. تقریباً..... درصد از کل دانش‌آموزان با ناتوانی ۶ تا ۲۱ سال کم‌توانی ذهنی دارند.

الف) ۱۰ ب) ۱۱

ج) ۱۲ د) ۱۳

۵. به نرسیدن اکسیژن لازم در زمان تولد به نوزاد..... گفته می‌شود.

الف) آنوکسی ب) زایمان طولانی

ج) یرقان د) منتژیت

۶. اعضای تیم توان‌بخشی در معلولان ذهنی را نام ببرید.

۷. مهارت‌های مراقبت از خود و مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی چگونه در کودک کم‌توان ذهنی پرورش داده می‌شود؟

۸. از بازی درمانی به چه منظوری در فرد کم توان ذهنی استفاده می‌شود؟

فرصت‌های فراهم‌شده برای رشد پیش‌نیازهای مورد نیاز برای کسب تجارب درونی کودک اقدام به مداخله کرد.

توانایی برقراری ارتباط‌های احساسی و ابراز عقاید و خواسته‌ها و نشان‌دادن واکنش‌های عاطفی و رفتاری از طریق شیوه‌های غیرکلامی‌در انسان ذاتی است. کودکان نیز نسبت به حالات و رفتار یکدیگر آگاهی زیادی دارند. به این دلیل است که روان‌شناسان و متخصصان بازی کودکان در سطح گسترده‌ای مایل هستند که واکنش‌های خلاق کودکان کم سن را بدون واسطه مورد بررسی قرار داده و درک کنند. در چنین زمانی است که جزئیات روابط و احساسات کودکان بدون کلام و با استفاده از حرکات نشان داده می‌شود و خواسته‌ها و علایق آنان را آشکار می‌سازد. بسیاری از کودکان که بنا به دلایلی و بر حسب ضرورت ارزیابی می‌شوند و دارای مشکلاتی مانند کم‌توانی ذهنی هستند، قادر نیستند تا با استفاده از شیوه‌ها و ابزارهای روان‌سنجی به درستی مورد ارزیابی و تشخیص قرار بگیرند. شایان ذکر است که هدف از ارزیابی به روش بازی درمانی، ارزیابی توانمندی هوشی کودک و تعیین نمره هوش وی نیست، و به دست آوردن هوش‌بهر اصلاً جزء اهداف مداخلات بازی درمانی به شمار نمی‌آید، یک هدف اصلی در بازی درمانی تشخیصی تعیین سطح کارکردی و عملکرد عمومی‌کودک است.

بازی درمانی می‌تواند در مکان‌های مختلف مورد استفاده قرار بگیرد. یکی از این مکان‌ها مؤسسات نگهداری کودکان با کم‌توانی ذهنی است. پژوهشگران معتقد هستند که یکی از مهمترین مزیت‌های بازی درمانی در این مؤسسات جبران محرومیت‌های اجتماعی ناشی از نگهداری در مراکز است. نگهداری در مؤسسات ناگزیر برای این کودکان محدودیت‌های اجتماعی فراوانی به همراه می‌آورد. بازی درمانی منجر به افزایش انگیزه در این کودکان خواهد شد. برخلاف تصورات پیشین کودکان با کم‌توانی ذهنی از گروه‌هایی هستند که می‌توانند از بازی درمانی بهره‌مند شوند.

کودکان دارای کم‌توانی ذهنی یکی از گروه‌هایی هستند که انواع مختلف خدمات را دریافت می‌کنند. این افراد نیز همانند سایر افراد احساسات و فشارهای مختلفی را تجربه می‌کنند. تا سال‌های اخیر درمان این افراد اساساً بر دارو درمانی و روش‌های کنترل رفتار بدون توجه به تنش‌ها و نیازها و مشکلات عاطفی آنان تأکید داشت. حدس‌های مربوط به وجود مشکلات عاطفی در این افراد رو افزایش است و حدود ۵۰

فصل پنجم

توان‌بخشی معلولان جسمی- حرکتی

اهداف فصل

در پایان این فصل از شما انتظار می‌رود بتوانید:

۱. معلولیت جسمی- حرکتی را تعریف کنید.
۲. تفاوت گروه‌های معلولیت جسمی- حرکتی را تبیین کنید.
۳. اطلاق مغزی بودن در فلج مغزی را تبیین کنید.
۴. تفاوت دو نوع شکاف ستون فقرات را بیان کنید.
۵. تفاوت مداخله پزشکی و توان‌بخشی پزشکی را در معلولیت جسمی- حرکتی توضیح دهید.
۶. توان‌بخشی آموزشی معلولیت جسمی-حرکتی را شرح دهید.
۷. تفاوت آموزش در کلاس خاص و آموزش در مراکزخاص را بیان کنید.
۸. توان‌بخشی حرفه‌ای و اشتغال و کاریابی را در معلولان جسمی-حرکتی توضیح دهید.
۹. ضرورت حمایت‌های اقتصادی را در معلولان جسمی- حرکتی بیان نمایید.

۵-۱ مقدمه

در نگاه اول انسان موجودی است راست قامت که عمود بر زمین روی دو پا می‌ایستد و با جابه‌جاکردن پاها راه می‌رود، می‌نشیند و به حال درازکش می‌خوابد و دارای دو دست تواناست. دست‌ها و پاها همراه با تنهٔ انسان، مجموعه اندام جسمی- حرکتی او را تشکیل می‌دهند.

فلج مغزی: فلج مغزی یک ناتوانی رشدی محسوب می‌شود و یک موقعیت چندمعلولیتی است که فراتر از فقط ناتوانی حرکتی درنظر گرفته شود وقتی مغز آسیب می‌بیند توانمندی‌های حسی، شناختی وحساسیت هیجانی همراه با کارکرد حرکتی فرد معمولاً تحت تأثیر قرار می‌گیرند (کروک شانک[۱]، ۱۹۷۶)

علیرغم اینکه ممکن است افرادبا این عارضه، چندین یا ترکیبی ازعلائم مرضی را نشان دهند ولی برخی تنها یکی ازعوارض آسیب مغزی نظیر آسیب‌دیدگی حرکتی رانشان می‌دهند. تعریف معمول فلج مغزی ناظر بر شرایطی است که ویژگی آن فلج، ضعف، ناهماهنگی و یا دیگر بدکاری‌های حرکتی منبعث از آسیب وارده بر مغز کودک قبل از رسیدگی است (بت شاو و پرت[۲]، ۱۹۸۶ ؛هیلی[۳]، ۱۹۸۴).

فلج مغزی اصطلاحی است که درتوصیف قسمت وسیعی از ناتوانی‌های حرکتی که پیشرونده نیست به کار می‌رود منظور این است که حالت شخص بدتر نمی‌شود، مگراینکه توانایی و مهارت‌های موجود فرد در صورت عدم به‌کارگیری از آنها در مدتی طولانی ازبین برود.

دو نوع طبقه‌بندی که جهت فلج مغزی بسیار مورد پذیرش قرار گرفته است عبارت است از:

۱. طبقه‌بندی برحسب اندام‌های درگیر.

۲. طبقه‌بندی براساس نوع ناتوانی حرکتی.

رایج‌ترین گروه‌بندی برحسب اندام‌های درگیر بنا به نظر (دنهوف[۴]، ۱۹۷۶) عبارت است از:

- درگیری در یک سمت از بدن[۵]
- درگیری بیشتر پاها نسبت به دست‌ها[۶]
- درگیری چهار اندام بدن[۷]
- درگیری فقط در ناحیه پاها[۸].

-معلولین جسمی- حرکتی دچار ضعف و یا عدم‌توانایی در سیستم حرکتی می‌شوند و برخی برای حرکت به وسایل کمکی نیاز پیدا می‌کنند.طیف معلولیت‌های جسمی- حرکتی با توجه به سن بروز و شدت آن، ویژگی‌های شخصیتی فرد مبتلا و خانواده و نیز میزان پذیرندگی جامعه، از تنوع بالایی برخوردار می‌باشد علیرغم اینکه به راحتی نمی‌توان چارچوب معینی برای نیازمندی‌های توانبخشی این افراد به جهت تنوع مذکور تعیین نمود لیکن هیچ یک ازآنان از دریافت خدمات توانبخشی مستثنی نمی‌باشند.

۲-۵ تعریف معلولیت جسمی -حرکتی

معلولین جسمی- حرکتی کسانی هستند که به‌دلیل نقص جسمانی دچار مشکل حرکتی می‌باشند. این نقص ممکن است به‌دلیل ضایعه مغزی، آسیب‌دیدگی نخاع، ضایعات استخوانی و عضلانی به‌صورت قلع عضو و یا ناموزونی عضو حرکتی (دست‌ها و پاها) نمایان گردد باید توجه داشت که هر نقص جسمانی لزوماً دلیل بر ناتوانی فرد در انجام امور مربوطه نمی‌باشد. به‌عبارت دیگر معلول کسی است که به‌دلیل نقص جسمی- حرکتی قادر نیست فعالیت‌های عادی زندگی روزمره را به نحو مطلوب انجام دهد ویا در انجام فعالیت‌های مربوطه با محدودیت‌هایی مواجه است. (افروز، ۱۳۸۶).

معلولین جسمی- حرکتی به افرادی اطلاق می‌گردد که « هر دلیل دچار ضعف، اختلال و یا عدم توانایی در سیستم حرکتی باشند و یا برای تحرک نیاز به پاره‌ای وسایل کمکی داشته باشند. به‌طور کلی افرادی که دچار نارسایی جسمی- حرکتی هستند در ۳ گروه قرار می‌گیرند که در نمودار ۱-۲ این سه گروه به تفکیک نمایش داده شده‌اند. (کریمی درمنی، ۱۳۸۵).

نقیصه‌های دوران سالمندی طبقه‌بندی نمود به ۲ نمونه از عوامل منجربه این معلولیت در هر نقیصه اشاره شده است.

۵-۴-۱ نقیصه‌های مادرزادی

- نقیصه‌های ناشی از عوامل ناشناخته مانند شکاف ستوان فقرات.
- نقیصه‌های ناشی از مصرف داروهای اثرگذار بر جنین توسط مادر، مانند مصرف داروی ضدتهوع تالیدومید که منجر به رشدنیافتگی بخش‌های از اندام حرکتی خصوصاً دست‌ها می‌شود.

۵-۴-۲ نقیصه‌های به مراحل اولیهٔ طفولیت

- ابتلای کودک به بیماری‌های میکروبی مانند منتژیت و یا بیماری‌های ویروسی مثل فلج اطفال[1].
- آسیب‌دیدگی ناشی از وارد شدن ضربه به مغز و نخاع یا موضع حرکتی.

۵-۴-۳ نقیصه‌های بعد از مراحل اولیهٔ طفولیت

- اختلالات ژنتیک که موجب تغییرات تدریجی بافت عضلانی به فیبر چربی در اندام حرکتی می‌شود.
- آسیب‌دیدگی بخش‌های مغز و نخاع یا اندام حرکتی به‌دلیل جنگ، حوادث ورزشی، سوانح صنعتی و ترافیکی.

۵-۴-۴ نقیصه‌های دوران سالمندی

- سکته‌های مغزی که بیشتر منجر به فلج‌های یک طرفه در بدن می‌شود.
- پوکی استخوان و شکستگی‌های موضعی.

۵-۵ میزان شیوع

برآورد دقیق از میزان شیوع این نوع معلولیت‌ها بسیار دشوار است در هر گروه سنی در

انواع ناتوانی حرکتی که طبقه‌بندی دیگری از فلج مغزی محسوب می‌شود به اختصار عبارتند از:

- انقباضی[۱] که در این نوع، فرد مبتلا دارای عضلات سفت منقبض و متشنج می‌باشد و ۵۰ درصد از فلج مغزی ازاین نوع است،
- حرکت غیرارادی[۲] که دلالت بر پیدایش حرکات غیرارادی کند و مکرر دارد و مشکل اصلی در قسمت مفاصل است زیرا حرکات غیرارادی به‌طور غیرمنظم از مفاصل سرچشمه می‌گیرد
- عدم تعادل مخچه‌ای[۳] این حالت ناشی از آسیب مخچه‌ای بوده و فرد بیمار قادر به حفظ تعادل خود نیست و دچار ناهماهنگی عضلانی است.
- ترکیبی[۴] حالت نادری می‌باشد و ممکن است به‌صورت انقباضی و حرکات غیرارادی با هم ایجاد شود.

(منتژیت، ضربه‌های دوران بارداری، تولد زودرس (تولد زودتر از ۴۰ هفته و با وزنی کمتر از۲ کیلو)، ضایعات زمان تولد، کمبود اکسیژن در هنگام تولد، نارسایی و اختلال در جریان خون‌رسانی به مغز (لخته‌شدن خون در مغز) و تومورهای مغزی ازجمله عوامل مهم در ایجاد فلج‌های مغزی می‌باشد) (افروز، ۱۳۸۶).

شکاف ستون فقرات متداول‌ترین نارسایی ناتوانی ساز دایمی‌از هنگام تولد، شکاف ستون فقرات است (انجمن شکاف ستون فقرات آمریکا[۵]، ۱۹۹۹). ویژگی این وضعیت شکاف غیرعادی در ستون فقرات است که از روزهای اول بارداری، معمولاً حتی قبل از آنکه مادر بداند باردار است، شروع می‌شود. به واسطهٔ فرایند تقسیم و تمایز سلول لولهٔ عصبی در جنین در حال رشد شکل می‌گیرد. در حدود روزهای ۲۶ تا ۲۷، این لولهٔ عصبی به دلایلی نامعلوم به‌طور کامل بسته نمی‌شود، این بسته‌نشدن موجب شکل‌های گوناگون ستون فقرات می‌شود و در بسیاری موارد با توجه به محل شکاف، بعضی از قسمت‌های بدن فلج می‌شوند (سوجانسکی[۶] و همکاران، ۱۹۹۷)

۱. افرادی که دچار قطع عضو[۱] شده‌اند:	۱-۱- قطع اندام فوقانی یا بخشی از آن ۱-۲- قطع اندام تحتانی یا بخشی از آن ۱-۳- قطع اندام فوقانی و تحتانی یا بخش‌هایی از آنها
۲. افرادی که در عملکرد اعضای بدن دچار نقص هستند:	۲-۱- فلج یک اندام ۲-۲- فلج یک طرف بدن ۲-۳- فلج پا ۲-۴- فلج چهار اندام
۳. افرادی که دچار تغییر شکل در اندام حرکتی هستند:[۲]	۳-۱- اگر این تغییر شکل (انحراف) به سمت راست یا چپ (طرفین) باشد، اسکولیوز[۳] نامیده می‌شود ۳-۱-۱- اگر این تغیر شکل (خمیدگی) به سمت جلو باشد، فرورفتگی کمر (لوردوز)[۴] نامیده می‌شود ۳-۱-۲- اگر این تغیر شکل (خمیدگی) به سمت عقب باشد، گوژپشتی[۵] نامیده می‌شود ۳-۲- تغییر شکل بازوان و دستها ۳-۳- تغییر شکل پاها

نمودار ۱-۵. گروه‌بندی معلولیت جسمی - حرکتی

۳-۵ شایع‌ترین آسیب‌های منجربه معلولیت

از شایع‌ترین بیماری‌ها و آسیب‌های که عوارض آن به شکل معلولیت‌های جسمی- حرکتی نمایان می‌گردد می‌توان به فلج مغزی[۶]، شکاف ستون فقرات[۷]، سکته مغزی[۸] و ضایعات نخاعی[۹] اشاره داشت.

سکته مغزی اولین علت معلولیت در کهنسالان است و درایالات متحده علت ۳ میلیون معلولیت شناخته شده است. (سلمان روغنی، ۱۳۸۰).

مطالعات همه‌گیرشناسی نشان داده‌اند که سکته مغزی به‌صورت تصادفی روی نمی‌دهد و عوامل خطرساز متعددی نظیر افزایش فشارخون، ناهنجاری‌های قلبی، بیماری قند، افزایش چربی‌های خون، چاقی، استعمال دخانیات در بروز آن دخالت دارند. (حلم سرشت ودل پیشه، ۱۳۷۱).

ضایعات نخاعی: مجموعه بیماری‌ها واختلالاتی که منجر به ضایعه نخاع شوکی و ستوان فقرات گردد به ضایعات نخاعی مرسوم بوده و به افرادی که دچار این نوع ضایعات می‌گردند معلولین نخاعی می‌گویند.

نوع فلجی براساس اینکه ضایعه در فواصل کدامیک از مهره‌ها رخ بدهد متفاوت است مثلاً اگر ضایعه نخاعی بین مهره‌های ۳ تا ۷ گردنی رخ بدهد اثر آن به‌صورت فلج چهارستون بدن (دست‌ها، پاها و تنه) ظاهر می‌گردد که به‌دلیل بالابودن سطح ضایعه و فلج گردن به پایین به مراتب مشکلات بیشتر و نیاز به مراقبت افزایش می‌یابد ولی اگر آسیب بر مهره‌های پشتی و پایین‌تر وارد آید، انسان از هردو پا فلج می‌شود.

آسیب نخاعی وقتی رخ می‌دهد که نخاع دچار آسیب یا قطع‌شدگی بشود، آسیب ممکن است در اثر سقوط، تصادف خودرو و یا آسیب‌های ورزشی که موجب کشیدگی بیش از اندازه نخاع می‌شود به وجود بیاید در برخی موارد نادرنیز ممکن است شدت این آسیب‌ها زیاد باشد و نخاع دچار قطع شدگی بشود. درچنین شرایطی نخاع دچار له‌شدن و تورم می‌شود وپس از چند ساعت خونریزی اتفاق می‌افتد و به‌تدریج فرایند خودتخریبی ایجاد می‌شودکه طی آن محل آسیب‌دیده به‌تدریج تحلیل رفته و ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر به‌وجود می‌آید. (باو[1]، ۲۰۰۰).

۵-۴ سبب‌شناسی

از دیدگاه سبب‌شناسی، نقیصه‌های جسمی- حرکتی رامی‌توان در نقیصه‌های مادرزادی، نقیصه‌های مربوط به مراحل اولیهٔ طفولیت، نقیصه‌های بعد از مراحل اولیهٔ طفولیت و

این احتمال وجود دارد که به عملکرد هوش آسیب برسد یا نرسد. شکاف ستون فقرات را معمولاً به دو نوع شکاف ستون فقرات پنهان یا شکاف ستون فقرات کیسه‌ای طبقه‌بندی می‌کنند. شکاف ستون فقرات نوع پنهان نوع خفیفی است که در آن کوچکی در یک یا چند ساختار مهره‌ای وجود دارد. بسیاری از افراد دارای شکاف ستون فقرات پنهان از وجود این وضعیت خبر ندارند تا آنکه برای دلیلی دیگر از ستون فقرات خود با اشعه ایکس عکس بگیرند. شکاف ستون فقرات پنهان تأثیر بسیار ناچیزی بر رشد کودک شیرخوار می‌گذارد و شکاف ستون فقرات کیسه‌ای نوعی بدشکلی ستون فقرات است که در آن کیسه‌ای غده مانند از یک شکاف واقعی در پشت کودک بیرون زده است (هاردمن و همکاران، ۱۹۲۸، ترجمه علیزاده و همکاران، ۱۳۸۹).

عوارض این ضایعه طیف وسیعی از فقدان حسی وحرکتی تا فلجی هر دو اندام تحتانی و عدم کنترل ادرار را در برمی‌گیرد. اختلالات مجاری ادرار، تغییر شکل‌های استخوانی و حساسیت‌های پوستی از دیگر عوارض این بیماری هستند. (حاج بابایی و دهقانی، ۱۳۷۲).

جراحی به‌منظور تصحیح نقص در همان اوان نوزادی انجام می‌گیرد و میزان مرگ و میرکودکان مبتلا به این عارضه کاهش یافته است (کورابک وکاوو[1]، ۱۹۸۶). با مراقبت‌های ارتوپدی مناسب کودک می‌تواند با عصا یا چوب زیربغل و یا صندلی چرخدار تحرک داشته باشد و عدم کنترل ادرار و مدفوع اغلب مهمترین موانع حضور کودک مبتلا در مدارس عادی تلقی می‌گردد.

سکته مغزی: اگر تغذیه خونی قسمتی از مغز قطع گردد، مغز دچار ضایعه شده و علائمی را به دنبال خواهدداشت که سکته مغزی نامیده می‌شود. علت سکته مغزی در مغز، در نتیجه پاره‌شدن یک رگ خونی که در قلب و یا ایجاد انسداد توسط رسوبات در داخل شریانی که خون مغز را تأمین می‌کند یا لخته خونی که در قلب یا در یک شریان تشکیل می‌شود و سپس از محلی که لخته در آن قسمت ایجادشده کنده شده، و به سمت مغز می‌رود، است. به دنبال سکته مغزی احتمالاً بیمار بیهوش می‌گردد و این حالت ممکن است چند ساعت ویا حتی چندروز طول بکشد وازطرفی امکان دارد مدت بیهوشی خیلی کوتاه بوده باشد، به محض هوش‌آمدن بیمار قادر به استفاده از یک دست یا یک پا و یا هر دو یا کل آن سمت بدنش که مقابل قسمت ضایعه دیده مغز است نخواهد بود (نودهی مقدم وجغتایی، ۱۳۸۵).

هر جامعه عوامل زیادی می‌توانند موجب نقص‌های خفیف تا شدید جسمی - حرکتی شوند، آمارهای جهانی رقم معلولان جسمی‌حرکتی تا زیر ۶۰ سال را در کل جمعیت رقمی حدود یک درصد اعلام می‌کند که البته در بالای ۶۰ سال این نسبت افزایش می‌یابد (داورمنش وبراتی سده، ۱۳۸۵).

مطابق گزارش سازمان آموزش و پرورش استثنایی ایران در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ تعداد ۱۶۲۵نفر دانش‌آموز دارای اختلال جسمی- حرکتی در مدارس خاص مشغول تحصیل بودند. بر این اساس سایر دانش‌آموزان دارای این اختلال به احتمال بیشتر در مدارس عادی به تحصیل ادامه می‌دهند.

۵-۶ نیازها و اقدامات توان‌بخشی

طیف معلولیت‌های جسمی- حرکتی با توجه به سن بروز، نوع معلولیت و شدت آن ازیک سو و ویژگی‌های شخصیتی فرد مبتلا، خانوادهٔ او و جامعهٔ او با توجه به میزان پذیرندگی وضعیت به وجود آمده یا عدم پذیرش از سوی دیگر و نیز میزان قابل دسترسی‌بودن امکانات توان‌بخشی از تنوع بسیار بالایی برخوردار است. به این دلیل است که می‌توان‌یک نقص عارض شده را در جایی، موردی ساده و قابل پذیرش تلقی نمود و همان را در جایی دیگر موردی آسیب‌زننده، تلخ و نومیدکننده دانست. به این جهت به سختی می‌توان برای نیازمندی‌های توان‌بخشی افراد مبتلا به معلولیت جسمی- حرکتی چارچوب معینی تعیین کرد (داورمنش وبراتی سده، ۱۳۸۵).

با توجه به اینکه تنوع معلولیت جسمی‌حرکتی به شکلی است که به سختی می‌توان الگوی ثابت و معینی به‌منظور ارائه خدمات توان‌بخشی برای آن درنظر گرفت برهمین اساس چارچوب ذیل به شرح مختصر نیازهای توان‌بخشی افرادی اختصاص دارد که از بدو طفولیت دچاراین معلولیت بوده‌اند.

تشخیص و تعیین نوع و شدت معلولیت: شناسایی نشانه‌های تأخیر در رشد به‌گونه‌ای که مداخله را بتوان هر چه زودتر آغاز کرد، در پیشگیری از ناتوانی‌ها حائز اهمیت است. توجه به اینکه کدام قسمت از اعضای حرکتی فرد و چگونه دچار نقص حرکتی شده است و اینکه معلول مبتلا به فلج حرکتی است و یا اینکه دچار قطع عضو شده است امری ضروری به شمار می‌آید و ارزیابی دقیق در جهت تشخیص میزان و

و مدارس، مراکز و یا مؤسسات آموزشی و حرفه‌ای متناسبی را برای جایگزینی مطلوب او پیشنهاد نمود.

به‌طور کلی جایگزینی دانش‌آموز معلول جسمی- حرکتی دریکی از مراکز آموزشی می‌بایست با توجه به نتایج حاصله از ارزیابی‌های جامع و با نظر کمیته‌ای مرکب از اولیای دانش‌آموز، مسئولین امور آموزشی، روان‌شناس، مشاور و یا مددکار اجتماعی، فیزیوتراپیست و پزشک متخصص با در نظر گرفتن امکانات و تسهیلات موجود انجام پذیرد. همه کودکان به برنامه‌های آموزشی یکسانی نیازمند نمی‌باشند. این برنامه‌ها به توانایی‌های جسمی و نیازهای فردی هر کودک بستگی دارد. عموماً آموزش این قبیل از کودکان به‌صورت‌های زیر مقدور خواهد بود.

آموزش در مدارس عادی همراه با سایر دانش‌آموزان: این شیوه آموزشی برای آن دسته از کودکانی که معلولیت شدیدی نداشته و تا حد قابل قبولی قادر به استفاده از امکانات عمومی مدرسه می‌باشند، می‌تواند کاملاً متناسب باشد. بدیهی است در این صورت می‌بایست تسهیلات ویژه و فوق‌العاده‌ای که دانش‌آموز نیاز دارد برای او فراهم آورد. معلمان می‌توانند از وسایل کمکی و سازشی متفاوتی استفاده کنندو با هماهنگ ساختن محیط آموزشی با نیازهای فردی، به دانش‌آموزان معلول جسمی- حرکتی کمک کنند. به‌عنوان مثال با وسیع‌تر ساختن فاصله میان نیمکت‌ها در کلاس درس برای عبور صندلی چرخدار از میان آنها، می‌توان اثرات سوء معلولیت را بر دانش‌آموز کمتر نمود. البته چگونگی حس روابط متقابل دانش‌آموز معلول با سایر دانش‌آموزان امری است که بستگی زیادی به وضعیت روانی - اجتماعی خود دانش‌آموز و نقش اولیای مدرسه و به ویژه معلمین مربوطه بر عهده دارند، خواهد داشت.

آموزش در کلاس‌های خاص: در مواردی که تعداد قابل ملاحظه‌ای از دانش‌آموزان معلول جسمی- حرکتی در مدرسه عمومی‌جایگزین شوند، براساس ضرورت و به فراخور ویژگی‌های آنان می‌توان در مدرسه عادی کلاس خاصی را با وسایل و تجهیزات ویژه، نظیر میز و صندلی مخصوص برای دانش‌آموزان معلول ایجاد نمود. در این صورت این دانش‌آموزان اوقات مشترکی را با سایر دانش‌آموزان مدرسه و با حضور معلمین مشترک و رابط خواهند داشت.

برای فرد معلول طراحی کرده و اقدام به ساختن آن می‌نماید. همچنین در صورت تشخیص مشکل گفتاری وبراساس تشخیص نوع و شدت مشکلات گفتاری، کودک از خدمات توان‌بخشی گفتاری توسط گفتاردرمانگر بهره‌مند می‌گردد.

در این میان لازم است خانواده‌ها نیز به توصیه‌های درمانی درمانگران توجه داشته باشد و تمرینات درمانی را مبتنی بر توصیه‌های درمانگران در مورد کودک خود به انجام بگذارند. درمانگرها در مدارس علیرغم اینکه خدمات را مستقیماً به دانش‌آموزان دچار معلولیت جسمی- حرکتی ارائه می‌دهند به‌منظور اجرا و پیگیری‌های خدمات توان‌بخشی به ارائه جلسات آموزشی و توجیهی با معلمین و والدین به‌صورت فردی و گروهی می‌پردازند و در پیشرفت برنامه‌های آموزشی ایفای نقش کنند. دانش‌آموزان از انتظارات و پشتیبانی‌های هماهنگ کادر توان‌بخشی، آموزشی و خانواده استفاده بیشتری می‌برند و برای تقویت مهارت‌های آموزشی این تیم باید بای یکدیگر ارتباط نزدیکی داشته و به‌صورت اعضای مؤثر در یک گروه فعالیت داشته باشند.

مشاوره با خانواده: با توجه به اینکه خانواده هیچ‌گاه بروز چنین وضعیتی را در کودک خود پیش‌بینی نمی‌کرده‌است در نتیجه طی برخورد با چنین مشکلی دچار شوک بحران شدید و اضطراب می‌شود. لازم است خانواده خصوصاً والدین و به‌ویژه مادر، هر عضو مؤثر خانواده در جلسات مختلف مورد مشاوره قرار گرفته و جهت پذیرش معلولیت فرزند چه به‌طور فردی و چه در جلسات مشاورهٔ گروهی آمادگی لازم برای پذیرش این موضوع رابه دست بیاورد توجه داشتن به شرایط خانوادگی، وضعیت روانی - اجتماعی اعضای خانواده معلول و روابط فی ما بین از عوامل کاملاً مؤثر در ایجاد و تقویت نگرش‌های مثبت و سازنده در فرد معلول نسبت به محیط زندگی و فعالیت‌های هدفمند و جهت دارخواهد بود.

ارائه خدمات مشاوره و مددکاری به این والدین به‌منظور پیشگیری از مشکلات احتمالی خانوادگی که در نتیجه حضور کودک معلول ممکن است بر خانواده عارض گردد ضرورت دارد.

آموزش به خانواده: آنچه به بحران خانواده دامن می‌زند عدم آگاهی و اطلاع خانواده از چند و چون قضیه است و اینکه برای بهبود فرزند معلول خود چه اقدامی انجام دهند و به چه کسانی مراجعه کنند خانواده و خصوصاً والدین باید نقص را

شدت معلولیت فرد از اقدامات مهم و نخستین جریان بازپروری و توان‌بخشی می‌باشد. (افروز، ۱۳۸۶).

در معلول جسمی - حرکتی باید وضعیت نقص و اینکه چه نوع پیش آگهی دارد مشخص گردد. ممکن است در مواردی همچون فلج مغزی در ابتدا به جز سفتی عضلات و تأخیر در مهارت‌های حرکتی (متناسب با سن) علامت ظاهری قابل تشخیص دیگری موجود نباشد اما بعد از مدتی به‌تدریج کژی‌ها در عضلات و اندام ظاهر گردد و یا وضعیت به شکلی ثابت و از همان ابتدا گویای یک وخامت فیزیکی در بدن طفل باشد و عموماً عضوی از همان ابتدا نقص خود را به نمایش گذارده باشد و این مسئله مستلزم تشخیص دقیق پزشکی لازم است که بهترین اشخاص در این زمینه پزشکان متخصص توان‌بخشی می‌باشند و در رده‌های بعد پزشکان متخصص ارتوپدی، متخصص اعصاب و متخصصان اطفال را می‌توان نام برد. (داورمنش و براتی سده، ۱۳۸۵).

مداخله پزشکی: درمان‌های اولیه در مورد کودکان مبتلا به معلولیت جسمی- حرکتی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است در برخی موارد این معلولیت را می‌توان ازطریق درمان‌های طی در مراحل آغازین اصلاح نمود و یا با درمان‌های اولیه شدت برخی از ناتوانی‌های حرکتی را به حداقل رساند و از رشد معلولیت‌های اضافی جلوگیری کرد. به‌عنوان مثال کودکان مبتلا به فلج مغزی که از خدمات درمانی در سنین اولیه استفاده می‌کنند ممکن است از انقباض‌ها و بدشکلی‌ها مفصلی که در سنین بعدی اعمال کودک را محدود می‌سازند کمتر برخوردار شوند (کرک وگالاگر[1]، ۱۹۰۴، ترجمه جوادیان، ۱۳۸۵).

جراحی‌های ترمیمی، دارو درمانی‌های اولیه، رژیم درمانی و ارائه توصیه‌های پزشکی شرط اول رسیدن به بهبود کودک معلول جسمی‌حرکتی با حداقل پیشگیری از دامنهٔ گسترش نقص یا حتی به تأخیر انداختن سیر انتشار نقص است در واقع فعالیت‌های پزشکی معمولاً اولین و ضروری‌ترین اقدامات به‌شمار می‌آیند.

توان‌بخشی پزشکی: اقدامات توان‌بخشی به‌منظور جلوگیری از ناتوانی بیشتر و کاهش دردها، کژی‌ها و محدودیت‌های دامنهٔ حرکتی توسط فیزیوتراپیست و کاردرمانگر انجام می‌پذیرد. کارشناس ارتوپدی فنی باید در صورت لـــزوم وسایل کمکی ویا جانشینی

بشناسند و با توجه به توصیهٔ درمانگرها در مواجه با این معلولیت برخورد منطقی و صحیح داشته باشند. این آگاهی سبب می‌شود ازدلسوزی بیش از اندازه و عادت‌دادن کودک معلول به تنبلی و وابستگی اجتناب کنند و در جهت استقلال و خودگردانی فرزندشان اهتمام بورزند.

والدین باید بیاموزند که چه برنامه‌هایی برای بهبود فرزندشان انجام دهند، این موضوع که آنان به چه مراجعی باید مراجعه کنند تا حد زیادی بار نگرانی‌ها را کاهش خواهد داد. در این زمینه یک تیم تخصصی مددکاری اجتماعی و روان‌شناسی بهترین کمک را می‌تواند به خانواده ارائه دهد. وجود دوره‌های آموزش فردی و گروهی همراه با در اختیارگذاردن کتابچه‌ها و نوارهای ویدیویی آموزشی مناسب می‌تواند از جمله بهترین کمک‌ها باشد.

مددکار اجتماعی خانواده فرد معلول را نسبت به ماهیت معلولیت و پیامدهای آن آگاه می‌سازد و از طریق آموزش غیرمستقیم، نسبت به تغییررفتار و نگرش آنان در مورد معلولیت اقدام می‌نماید در این نقش مددکار اجتماعی خانواده را به سمتی هدایت می‌کند که بتواند معلولیت را به جای یک تراژدی یا فاجعه غم‌انگیز پدیده‌ای چالش برانگیز تلقی کند (میرخانی، ۱۳۷۸).

توان‌بخشی آموزشی: اجرای برنامه‌های درسی وآموزش مهارت‌های تحصیلی نباید منجر به بروز مشکلاتی برای کودکان معلول شده و هیچ کودکی نباید به دلیل معلولیت جسمی – حرکتی از تحصیل محروم شود. امروزه در جوامع مترقی ودر خیلی از کشورهای در حال توسعه اهمیت زیادی به تحصیل و درس خواندن معلولین جسمی – حرکتی قائل هستند. تسهیلات و امکانات آموزشی عمومی‌و مدارس عادی را تا حد امکان به شکلی متناسب‌سازی می‌کنند که چنین کودکانی بتوانند همانند همسن‌های عادی خود در کلاس‌های درس حضور پیدا کنند. طرح و تنظیم برنامه‌های آموزشی برای دانش‌آموزان معلول جسمی– حرکتی زمانی می‌تواند متناسب و مفید واقع گردد که بر اساس یک ارزیابی دقیق از وضعیت دانش‌آموز معلول و نیازهای خاص او انجام پذیرد. براساس ارزیابی دقیق و مشخص‌نمودن محدودیت‌ها و توانایی‌ها و شایستگی‌های فرد معلول است که می‌توان برنامه آموزشی مناسب و خدمات توان‌بخشی مؤثری را تدوین نموده

توجه به نیاز بازار کار و متناسب با شرایط اجتماعی شغلی مناسب انتخاب و زمینه‌های انجام آن در مدتی معین به نوجوان‌یا جوان آموخته شود.

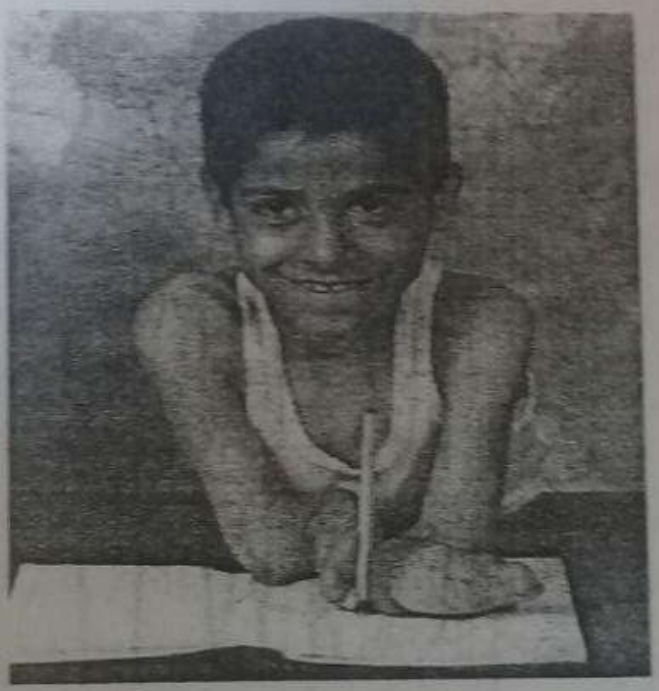
اشتغال و کاریابی: کودکان معلول جسمی، با بزرگترشدن ممکن است با عوامل متعددی نظیر فعالیت‌های محدود، انتخاب‌های شغلی اندک، انتظارات نامشخص از زندگی و تبعیضات عمدی و غیرعمدی مواجه شوند این مسائل مشکلات ویژه‌ای را در رابطه با ادراک شخصی و سازگاری آنان به وجود می‌آورد و ممکن است به خدمات توان‌بخشی و مشاوره‌ای مختلفی نیاز پیدا کنند (کرک وگالاگر، ۱۹۰۴، ترجمه جوادیان، ۱۳۸۵) در مورد نوجوانان یا جوانان دچار معلولیت جسمی- حرکتی ملاحظات شغلی از درجه بالای اهمیت برخوردارست (فونوش[1] وهمکاران، ۱۹۸۲).

در تعیین یک هدف شغلی، ارزیابی واقع‌گرایانه از توانایی‌های خاص و ناتوانایی‌ها و نیز ارزیابی دقیق انگیزش فرد اهمیت اساسی دارد. برخی از ناتوانایی‌ها آشکارا بعضی انتخاب‌های شغلی را غیرممکن می‌سازد درحالیکه بعضی ناتوانی‌ها تحت‌الشعاع انگیزش بالا قرار می‌گیرد و فرد معلول با استفاده کامل از کنش باقی‌مانده ممکن است نیل به یک موقعیت حرفه‌ای غیرمعمول را برای خود ممکن سازد. برای نمونه، تام دمپسی[2]، یکی از بهترین دروازه‌بان‌های فوتبال، دارای یک دست و پای معیوب مادرزادی بود.

بیشتر صاحبان مشاغل بر حسب عادت با نگاه به مجموعه توانمندی افراد نسبت به میزان کارایی آنان قضاوت می‌کنند در حالی که باید صرفاً به انتظاراتی که در انجام کار محوله از افراد دارند توجه نشان دهند. ممکن است فردی که روی صندلی چرخدار حرکت می‌کند توانایی دست‌هایش در کارآمدی نسبت به انجام یک وظیفهٔ شغلی به مراتب بیشتر از افراد عادی باشد. یا امکان دارد فردی که به لحاظ فقدان یا ناتوانی در یک دست از تنها دست دیگرش استفاده کند، کارآمدی بیشتری در انجام کارهایی که فقط توسط یک دست باید انجام شود، داشته باشد.

کودکی که عقب‌ماندهٔ ذهنی است و چهار اندامش درگیر این ناتوانی است، آشکارا نمی‌تواند حقوقدان، تکنسین آزمایشگاه یا یک ماشین نویس شود. اما در مورد کسی که دچار همین عارضه حرکتی است ولی هوش بالایی دارد، چنین شخصی ممکن

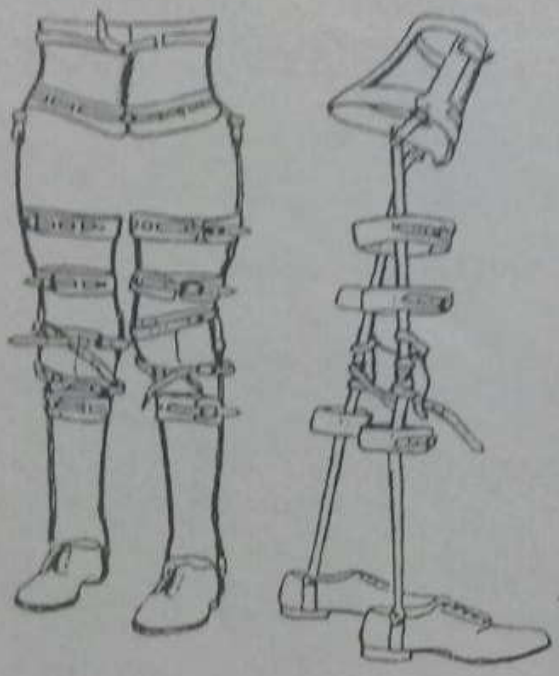
آموزش در مراکز خاص: برای تعدادی از دانش‌آموزان معلول جسمی- حرکتی که عموماً علاوه بر نقص حرکتی دارای نارسایی‌ها، مسائل و مشکلات متعددی می‌باشند، لازم است که مدارس و مراکز خاصی با همه امکانات و تجهیزات لازم آموزشی، توانبخشی و درمانی، همراه با نیروی انسانی متخصص مورد نیاز پیش‌بینی نمود.



هیچ کودکی نباید به صرف معلولیت جسمی و حرکتی از تحصیل محروم باشد.

۲-۵. تصویر کودک معلول جسمی-حرکتی

توانبخشی حرفه‌ای: شرایط ذهنی، هوش و استعدادهای ویژه معلول همواره عامل مهمی در پیشبرد برنامه‌های توانبخشی شغلی و حرفه‌ای او محسوب می‌گردد. ممکن است شدت معلولیت در فرد به حدی باشد که رسیدن به مدارج عالی میسر نباشد یا به‌دلیل ضعف در ارتباطات و تعاملات انسانی اجتماعی در اوایل مراحل طفولیت یا ضعف اندک ذهنی درس خواندن تا حد عالی مقدور نباشد. در چنین صورتی باید از حدود ۱۵ سالگی به فکر داشتن شغل مناسب بود. شغلی که تا حدی تأمین معاش نموده و ضمناً منزلت شخصی و اجتماعی نیز ایجاد کند. شغلی که متناسب با حد توانمندی‌ها و حتی‌الامکان منطبق با علایق شخصی نوجوان معلول باشد. باید با



۳- ۵. نمونه‌ای از ارتز بلند با کنترل ستون فقرات

وسایل کمکی فنی: این وسایل را می‌توان به دو دسته وسایل ساده و وسایل حرکتی تقسیم نمود:

وسایل ساده: این وسایل به اشکال مختلف برای چاره‌سازی به هر مشکلی طراحی و ساخته شده است. مثلاً قاشقی که در عین حال کارد نیز می‌باشد، برای شخصی که فقط از یک دست استفاده می‌کند و یا وسایل و امکاناتی که برای پوشیدن جوراب یا کفش و یا برداشتن چیزی از زمین برای کسی که قادر به خم‌شدن نیست. از این قبیل وسایل کوچک که برای زندگی عادی در منزل یا در محل کار برای معلولین جسمی- حرکتی فراهم شده فوق‌العاده زیاد است تا آنها بتوانند در انجام کارهای روزانه مستقل باشند. (قضایی، ۱۳۶۸).

وسایل حرکتی: وسایل حرکتی بسته به نوع معلولیت فوق‌العاده متنوع است از اهم آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود.

کراچ: وسیله‌ای است که برای استفاده از نیروهای اندام فوقانی در راه رفتن و حرکت‌دادن بدن مورد استفاده قرار می‌گیرد نظیر عصای زیربغل، عصای آرنجی و عصاهای دستی یک یا چندپایه.

است بتواند بر محدودیت فیزیکی و برچسب اجتماعی همراه با آن چیره شود و در یک حرفه، مثل حقوق، که در آن بیشتر ذهنی است تا فیزیکی موفق گردد. (هالاهان و کافمن[1]، ۱۹۴۴، ترجمه ماهر، ۱۳۸۷). نظایر این‌گونه مهارت‌ها به میزان زیاد در افراد مبتلا به انواع مختلف معلولیت‌ها قابل مشاهده است. بسیاری از افراد مبتلا به معلولیت جسمی- حرکتی به راحتی قادر به کار در محیط‌های عمومی و زمینهٔ اشتغال افراد عادی هستند. بعضی نیز شاید به علت میزان معلولیت‌شان و شرایط ذهنی روانی لزوماً باید در کارگاه‌های حمایتی که امکانات اولیه برای وضعیت اضطراری آنها مهیاست فعال شوند. برخی دیگر نیز آن چنان با معلولیت عمیق دست به گریبانند که قادر به حرکت و جابه جایی بین محیط زندگی و محیط کار نیستند و می‌بایست زمینهٔ اشتغال آنها را در همان محل زیست آنها برایشان فراهم نمود. به هر حال حتی‌المقدور یک فرد معلول جسمی- حرکتی باید ساعاتی از روز را به اشتغالی درآمدزا سرگرم باشد تا احساس مفیدبودن و منزلت شخصی بکند. (داورمنش و براتی سده، ۱۳۸۵)

حمایت‌های اجتماعی اقتصادی: تنها نیاز یک جوان مبتلا به معلولیت داشتن شغل مناسب نیست. نیاز به حمایت اقتصادی دارد و معمولاً شغل آنها پاسخگوی مسائل مالی آنها نیست. آنان هزینه‌هایی به مراتب بیش از افراد عادی دارند. باید مدام معاینه شوند، وسایل مختلف مثل انواع ارتز و پروتز تهیه کنند. استراحت بیشتری نیاز دارند. باید از نظر مالی تا حدی حمایت شوند. از طرف دیگر باید تفریح و مسافرت داشته باشند. باید در کلوب‌های تفریحی مناسب ثبت نام نموده، اوقات فراغت و تفریح داشته باشند. زندگی توأم با معلولیت زندگی دشوار و کسالت‌آوری است. باید در شرکت در برنامه‌های تفریحی، به‌طور کامل مورد حمایت قرار گیرند که این امر مستلزم حضور مددکاران اجتماعی علاقه‌مند و کارآزموده است.

حمایت‌های قانونی: افراد مبتلا به معلولیت جسمی- حرکتی باید در مقابل قوانین اجتماعی، جزایی و کیفری مورد حمایت‌های ویژه‌ای قرار بگیرند. به‌منظور برابری با افراد عادی جامعه باید شرایط جسمی- آنها در نظر گرفته شود. آنان باید با حقوق خود آشنا بوده ضمناً از مزایای قانونی خاص خود بهره‌مند شوند. مطابق قانون جامع معلولان مصوب اردیبهشت ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، کلیه وزارتخانه‌ها،

سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی موظفند در تولید و احداث ساختمان و اماکن عمومی و معابر با متناسب‌سازی امکان دسترسی و بهره‌مندی معلولان جسمی– حرکتی را فراهم نمایند. بر پایه همین قانون شهرداری‌ها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار ساختمان‌ها و اماکن عمومی که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند، خوداری نمایند (روزنامه رسمی‌کشور، ۱۳۸۳).

۵-۷ دستگاه‌ها و وسایل کمکی

معلولین جسمی– حرکتی از امکانات کمکی که شامل دستگاه‌ها و وسایل کمک فنی می‌باشد، استفاده می‌کنند.

دستگاه‌ها: دستگاه‌ها در کل شامل ارتز[1]ها و پروتز[2]هاست.

ارتز: به کلیهٔ وسایل کمکی اطلاق می‌گردد که برای جلوگیری از بدشکلی‌ها و یا تصحیح آنها و یا نگه‌داری و تثبیت قسمت‌های مختلف بدن به موازات آنها به کار می‌روند؛ به بیان ساده‌تر به دستگاهی که برای نگه‌داری و کمک به یک عضو مورد استفاده قرار می‌گیرد ارتز گفته می‌شود. ارتزها متناسب با محل قرارگیری روی اندام‌ها و تنه‌ها تقسیم‌بندی می‌گردند که عبارتند از ارتزهای اندام‌های فوقانی، تحتانی، ستون فقرات و کفش طبی.

پروتز: پروتز عبارت است از جایگزینی عضوی مصنوعی برای عضوی که از دست رفته است مثل دست یا پای مصنوعی. پروتزها متناسب با محل قطع عضو نام‌گذاری می‌شود. پروتزهای اندام‌های تحتانی بسته به محل قطع عضو و توانایی فرد به او اجازهٔ راه رفتن به‌صورت نسبتاً عادی و راحت را خواهد داد و پروتزهای اندام فوقانی به دو دسته کارا و تزئینی تقسیم می‌شود که وظایف عمدهٔ آنها در اندام فوقانی، انجام بعضی از حرکات دست و حالت تزئینی است.

فصل ششم

توان‌بخشی در برخی از بیماری‌های خاص

اهداف فصل

در پایان این فصل از شما انتظار می‌رود بتوانید:

۱. نشانه‌های درخودماندگی را توضیح دهید.
۲. ضرورت تشخیص زود هنگام و مداخلات پزشکی را در فرد دچار اتیسم به عنوان یک اقدام توان‌بخشی توضیح دهید.
۳. مشکلات اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی را لیست کنید.
۴. نسبت جنسیت را در اختلالات درخودماندگی، کمبودتوجه/بیش‌فعالی و ام‌اس مقایسه و نتیجه‌گیری کنید.
۵. خدمات توان‌بخشی وآموزشی دانش‌آموزان دچار کمبود توجه/بیش‌فعالی را تشریح کنید.
۶. ملاحظات آموزشی در افراد دچار صرع را توضیح دهید.
۷. نحوه مواجهه مسئولین مدرسه با دانش‌آموز دچار صرع را توضیح دهید.
۸. برنامه توان‌بخشی ام‌اس را تشریح کنید.
۹. اعضای تیم توان‌بخشی پزشکی در ام‌اس را نام ببرید.
۱۰. راه‌های اصلی انتقال ویروس ایدز را توضیح دهید.
۱۱. نقش روحانیون را در افزایش آگاهی آحاد جامعه در شناسایی و پیشگیری ایدز توضیح دهید.

۶-۱ مقدمه

شناخت دقیق و همه جانبه از نیازها و انتظارات معلولین نقطه شروع و عامل کلیدی برای دستیابی به نتایج موفقیت‌آمیز خدمات توان‌بخشی به‌شمار می‌آید در این فصل به‌منظور آشنایی، به برخی بیماری‌های خاص و اقدامات توان‌بخشی که در فرد مبتلا به بیماری صورت می‌پذیرد، پرداخته شده است و تشریح هر بیماری و نیازهای توان‌بخشی آن به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است.

۶-۲ اتیسم

تعریف و توضیح اتیسم[1] یکی از بیماری‌های دوران کودکی و مربوط به گروه اختلالات فراگیر رشدی[2] می‌باشد. گاهی آن را به اتیسم شیرخوارگی یا اتیسم کودکی نام‌گذاری کرده‌اند. اتیسم را به خواب و خیال در بیداری تعبیر می‌کنند. اتیسم یک ناتوانی تکاملی[3] است و دامنه و شدت آن وسیع است (درخشیده، ۱۳۸۴) و با طیف وسیعی از ناتوانی‌ها همراه می‌شود که دامنه این ناتوانی در افراد مبتلا به اتیسم متفاوت است، بعضی می‌توانند در سطح بالایی با اطرافیان خود ارتباط برقرار کنند وگفتاری خوب و هوش قابل قبولی داشته باشند و برخی آسیب‌شناختی و زبانی بسیار بالایی دارند و حتی هرگز قادر به صحبت کردن نخواهند بود (ناصح، ۱۳۸۸).

علیرغم دامنه وسیع رفتارها در این افراد، انزوای اجتماعی، عقب‌ماندگی ذهنی، نقایص زبانی و رفتارهای کلیشه‌ای و یکنواخت نشانه‌های مورد توافق و تأکید در این اختلال است. بیشتر کودکان اتیسم از کودکان عقب‌مانده ذهنی هستند. بین ۷۷ تا ۸۹ درصد از آنان هوش‌بهر کمتر از ۷۰ دارند اما از نظر نوع و ماهیت نقایص شناختی با کودکان عقب‌مانده ذهنی متفاوت هستند (کاکاوند، ۱۳۸۵).

افراد مبتلا به اتیسم اغلب از تماس چشمی اجتناب می‌کنند و انزوای اجتماعی نشان می‌دهند، آنها معمولاً دوستان کمی دارند و حتی آنهایی که کارکرد بالاتری دارند از نظر اجتماعی عجیب و غریب به نظر می‌رسند (سیمپسون[4]، ۱۹۹۶؛ تسای واسکات میلر[5]، ۱۹۸۸).

---

1. Autism
۲. اختلالات فراگیر رشدی به علت تأثیری که بر همه جنبه‌های رشدی برجا می‌گذارند و همچنین به‌دلیل آنکه این تأثیرات می‌تواند به شکل پایدار بر مراحل بعدی زندگی فرد نیز مؤثر باشند به این نام خوانده می‌شوند.
3. Developmental Disability(DD)
4. Simpson

واکر: وسیله‌ای است برای آن دسته از معلولین که جهت راه‌رفتن به تکیه‌گاه بیشتری نیاز دارند و جنس آن از آلومینیوم و در فرم‌ها و اندازه‌های مختلف و قابل تنظیم از نظر ارتفاع ساخته می‌شود.

صندلی چرخدار (ویلچر): این وسیله در زمره وسایل تحرک برای کسانی است که غالباً قادر به راه رفتن با دیگر وسایل حرکتی مانند کراچ و واکر نمی‌باشند و یا این وسایل پاسخگوی احتیاجاتشان نیست.

جنس این وسیله از فلز ساخته شده است ودارای چهارچرخ است که این چرخ‌ها معمولاً ترمز داشته و قابل تا شدن هستند. صندلی‌های چرخداری از نوع موتوری و الکترونیکی نیز وجود دارد که فرد معلول به تنهایی قادر به هدایت آن می‌باشد و بهترین وسیله جابه‌جایی برای معلولین به‌ویژه در خارج از منزل محسوب می‌شود.

۵-۸ خودآزمایی

۱. گروه‌های معلولیت جسمی حرکتی را توضیح دهید.

۲. تفاوت ارتز و پروتز را بیان کنید.

۳. ..... از اولین علت معلولیت در کهنسالان است.

الف) ضایعه نخاعی　　ب) سکته مغزی

ج) دیابت　　د) پوکی استخوان

۴. متداول‌ترین نارسایی ناتوانی ساز دایمی از هنگام تولد..... است.

الف) بیماری قند　　ب) ناهنجاری قلبی

ج) ضایعه نخاع شوکی　　د) شکاف ستون فقرات

۵. تفاوت مشاوره با خانواده و آموزش خانواده را در معلولان جسمی- حرکتی توضیح دهید.

۶. نگرش جامعه نسبت به اشتغال و کاریابی معلولان جسمی- حرکتی چگونه می‌باشد؟

۷. تفاوت آموزش در مدارس عادی با مراکز خاص را توضیح دهید.

۸. به چه دلیل حمایت قانونی برای معلول جسمی- حرکتی یک نیاز توان‌بخشی محسوب می‌شود؟

۹. فرد معلول جسمی- حرکتی باید ساعاتی از روز را به اشتغالی درآمدزا سرگرم باشد تا احساس

آزمایش و یا رادیوگرافی خاصی وجود ندارد و تشخیص دقیق براساس مشاهده وضعیت ارتباطی و رفتار کودک و سطح رشدی وی صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه سایر اختلالات کودکی نیز می‌توانند بر رشد ارتباطی، زبان و رفتار اجتماعی تأثیر بگذارند بنابراین شناسایی اینکه این مشکلات مربوط به اختلال اتیسم باشد تشخیص را با دشواری مواجه می‌سازد.

تشخیص کودکان مبتلا به این اختلال نیاز به اجرای دو مرحله دارد.

مرحله اول: در این مرحله تست غربالگری رشد کودک توسط پزشک کودک به‌عمل می‌آید. مشاهدات و اطلاعات والدین در مورد رشد کودک و تاریخچه آن می‌تواند کمک اساسی به این مرحله باشد. از ابزارهای غربالگری در این مرحله که به‌طور سریع اطلاعات را درباره رشد اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی کودک جمع‌آوری می‌کنند می‌توان به چک‌لیست اتیسم طفولیت[1]، ابزار غربالگری برای اتیسم در ۲ سال اول[2] اشاره نمود. این ابزارها تشخیص قطعی و دقیقی برای کودک ارائه نمی‌دهد بلکه کمک می‌کند به اینکه آیا کودک نیاز به ارجاع برای تشخیص‌های جامع‌تر دارد یا خیر؟ (رافعی، ۱۳۸۷).

مرحلهٔ دوم: به‌منظور تشخیص دقیق و جامع، در ارزشیابی از مجموعه‌ای از درمانگران و متخصصینی که در تشخیص نقص‌های رشدی متبحر هستند کمک گرفته می‌شود. از اعضای این تیم می‌توان به پزشک اطفال، روان‌پزشک کودک، روان‌شناس بالینی، کاردرمانگر، فیزیوتراپ، گفتار درمانگر اشاره داشت.

در حال حاضر معیارهای تعریف شده سازمان جهانی بهداشت[3] و معیارهای انجمن روان‌پزشکی آمریکا[4] از اصلی‌ترین معیارهای تشخیصی اتیسم به‌شمار می‌آیند (داورمنش و براتی‌سده، ۱۳۸۵).

هیچ دارویی اختصاصی برای اختلال اتیسم کشف نشده‌است و تقریباً همه درمان‌های مؤثر از نوع درمان‌های رفتاری هستند. تجویز دارو نظیر مصرف آرام‌بخش‌ها معمولاً به جهت کاهش بی‌قراری و اضطراب کودک به مدت کوتاه یا طولانی صورت می‌گیرد (درخشیده، ۱۳۸۴).

---

1. Checklist of Autism in Toddlers (CHAT)
2. Screening Tool of Autism in Tow-year –olds (STAT)
3. World Health Organization(W. H. O)

سبب‌شناسی: توصیفات سبب‌شناسی اتیسم به‌طور قابل ملاحظه‌ای در چند دهه گذشته تغییر کرده است این باور که اتیسم ناشی از وجود والدین طردکننده و سرد است در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ رایج بوده است اما پژوهشگران هم‌اکنون در تبیین این اختلال بیشتر برروی آسیب‌کاری مغز و سیستم عصبی متمرکز شده‌اند و طرفداران دیدگاه زیستی بر مؤلفه‌های ژنی، کروموزوم‌ها، عوامل زیست شیمیایی و عامل عصبی تأکید دارند و طرفداران دیدگاه شناختی در توجیه این اختلال بر اشکال در کارکردهای شناختی مثل کارکرد اجرایی، حافظه، طبقه‌بندی، درک اجتماعی و نظریه ذهن تأکید می‌کنند. در یکی از فرضیه‌ها اعتقاد بر این است که این‌گونه کودکان نظریه ذهنی ندارند بدین معنی که آنها نمی‌توانند وجود وضعیت‌های ذهنی مثل باورها یا امیال را درک کنند (کاکاوند، ۱۳۸۵).

میزان شیوع برآورد شده است که در هر ده هزار کودک، ۵ نفر به این اختلال مبتلا می‌شوند و این اختلال ۵- ۴برابر در پسرها بیشتر از دخترها می‌باشد (رافعی، ۱۳۸۷). علیرغم اینکه دختران به نسبت کمتری به اتیسم مبتلا می‌شوند ولی عوارض این اختلال در دختران به مراتب بیشتر از پسران است و کارکردهای ذهنی وهوشی دختران نسبت به این اختلال بیشتر از پسران آسیب می‌پذیرد.

در ایران آماری از نرخ شیوع اختلال اتیسم در دست نمی‌باشد ولی اگر نرخ ۰/۰۵ درصد افراد جمعیت عمومی را در مورد کشور خود نیز صادق بدانیم می‌توان برآورد کرد که حدود ۳۵ هزار کودک اتیستیک در کشور وجود داشته و نیازمند دریافت خدمات می‌باشند (داورمنش وبراتی سده، ۱۳۸۵).

۶-۳ نیازهای توان‌بخشی در افراد دچار اتیسم

تشخیص زودهنگام ومداخله پزشکی: اتیسم چنانچه به موقع تشخیص داده شود فرصت مداخلات مثبت را به وجود می‌آورد. علائم این بیماری در سال‌های اول زندگی شروع می‌شود. والدین اغلب در سال‌های دوم و سوم به ناراحتی کودک پی‌می‌برند ولی آنچه مسلم است بیماری حتماً قبل از سی ماهگی شروع می‌شود (میلانی فر، ۱۳۸۹).

تأکید بر اهمیت غربالگری و تشخیص‌های اولیه و زود هنگام، ملاحظات مفید و به موقعی را برای این کودکان فراهم خواهد کرد برای تشخیص اتیسم هیچ گونه

مشاوره با والدین: پس از اینکه تشخیص به وجود اتیسم در کودک نهایی شد، طبیعی است که خانواده افسرده و غمگین شود زیرا اهداف، آرزوها و تصورات آنها در مورد فرزندشان نابود می‌گردد. آنها با یک حقیقت تازه روبه‌رو می‌شوند که فرزندشان از نظر عاطفی مشکل داشته و نیازمند مراقبت‌های اولیه می‌باشد و قبول این واقعیت نوعی بحران تلقی می‌شود و استرس بسیاری برای خانواده ایجاد می‌کند. خانواده‌هایی که با مشکل خود سازگار نشده‌اند در ایجاد تعادل بین نیازهای فرزندشان با نیازهای خود ناتوان می‌مانند و ممکن است نیازهای کودک را نادیده گرفته و درمانش را به تعویق اندازند. بسیاری از خانواده‌های دارای کودک اتیسم از اینکه جامعه پیرامون و حتی نزدیکان، رویکرد شناختی منفی نسبت به آنها و کودک دارند رنج می‌برند. مردم ممکن است مسائل مربوط به اتیسم را درک نکنند و نگاه توأم با ترحم داشته باشند، در بسیاری از کشورهای دنیا خانواده‌های دارای کودک اتیسم تشکیل گروه‌هایی را داده‌اند که برای هم منبع حمایتی هستند و با حمایت‌های عاطفی و حتی مالی به یکدیگر نقش مؤثری را در کاهش فشارهای روانی خود داشته‌اند.

افزایش ارتباط و همدلی بین زوجین و مشاوره با روان‌شناس و مددکار اجتماعی می‌تواند در کاهش اضطراب و افزایش مقاومت خانواده مؤثر واقع شود تا خانواده بتواند کودک را با مجموع ناهنجاری‌ها و مشکلاتش بپذیرد.[۲]

آموزش به والدین: زمانی که والدین تفاوت کودکشان را با سایر همسالانش بپذیرد با اعتماد و اطمینان به دنبال کسب اطلاعات و آموزش‌های لازم خواهد رفت و رفتارش را براساس نیازها و محدودیت‌های کودک تطبیق خواهد داد واز ناهنجاری‌های رفتاری و ارتباطی کودکش تعجب نخواهد نمود. وجود یک خانواده پذیرا و با ثبات سبب خواهد شد که با خویشتن‌داری توصیه‌های توان‌بخشی و ملاحظات آموزشی فرزندشان را جدی بگیرند و به آن عمل نمایند.

خدمات توان‌بخشی وآموزشی: با توجه به تنوع مشکلات در فرد مبتلا به اتیسم در حوزه توان‌بخشی، گفتار درمانگر به‌منظور بهبود در مهارت‌های ارتباطی شامل گفتار و زبان و کاردرمانگر جهت افزایش مهارت‌هایی نظیر تمرکز، دقت و توجه و

ظاهر نمی‌شود، بنابراین برای طرح‌کردن این تشخیص در سنین اولیه لازم است محتاطانه عمل نمود (کاکاوند، ۱۳۸۵).

کمبود توجه/ بیش‌فعالی درواقع اختلالی با شروع زودرس همراه با نشانه‌های رفتاری است که قبل یا همزمان با آغاز مدرسه خود را نشان می‌دهد (انجمن روان‌پزشکی آمریکا[1]، ۲۰۰۰). بنابراین شناسایی دقیق و مداخله زودهنگام در طی پایه‌های ابتدایی (مهدکودک و پایه اول) بهترین راه برای جلوگیری از نقایص معنی‌دار رفتاری، تحصیلی، اجتماعی در این کودکان تلقی می‌گردد.

مؤثرترین مداخله‌ها برای کمبود توجه/ بیش‌فعالی مشتمل بر داروهای محرک‌های روانی (به‌عنوان مثال متیل فنیدیت با نام تجارتی ریتالین) و اصلاح رفتاری در موقعیت‌های خانه و مدرسه است (پلهام[2] وهمکاران، ۱۹۹۸).

این موضوع کاملاً روشن است که پاسخ‌های کودکان به داروهای محرک ودرمان رفتاری، کاملاً فردی و تابع ویژگی‌های آنهاست، یک مقدار از داروهای محرک یا سطحی از درمان رفتاری ممکن است برای کودک مؤثر و برای دیگری غیرمؤثر باشد. (کاکاوند، ۱۳۸۵).

مشاوره با والدین: اغلب خانواده‌های دارای چنین کودکی، در معرض گستره وسیعی از فشارهای روانی قرار دارند، شرایط زناشویی والدین به شدت تحت تأثیر وضعیت کودکانشان قرار می‌گیرد. بعد از تشخیص اختلال در کودک، والدین ممکن است احساس گناه، شرم و یا ترس کنند. گاهی این احساسات به شکل جر و بحث و اتهام‌زدن‌های آشکار به یکدیگر تظاهر می‌کند که طی آن والدین همدیگر را سرزنش می‌نمایند، یک مشخصه عمده این قبیل کودکان، پاسخ‌ندادن آنها به رهنمودهای والدین است، مشکلات روحی خانواده با قضاوت‌های ناهماهنگ سایرین که علت مشکلات کودک را قصور والدین قلمداد می‌کنند، تشدید می‌گردد و از آنجا که چنین کودکانی نیاز به محیطی آرام و ایمن دارند، وضعیت تنش‌زای خانواده سبب بروز مشکلات اضافی نظیر رفتار خودسرانه و نافرمانی در آنان خواهد شد. خدمات مشاوره‌ای و تعامل والدین با سایر والدین کودکانی که مشابه آنها هستند به‌منظور ایجاد همدلی در احساس ناکامی، موفقیت و دریافت راهبردهای حمایتی کاملاً سودمند است.

و توانایی کار در کارگاه‌های حمایت‌شده زیر نظر یک کارفرما و مدیری که درکار با اشخاص کم‌توان تجربه داشته باشد را دارند. با وجود این، ضعف در مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی اغلب علت بسیاری از مشکلات آنها در سطوح مختلف می‌باشد و آنها پیوسته در راستای تلاششان برای زندگی مستقل به دلگرمی و حمایت‌های خانواده و اجتماع نیاز خواهند داشت. یک محیط پرورشی در خانه، مدرسه و در صورت رسیدن به شغل و کار به آنان کمک می‌کند تا زندگی‌شان را از طریق رشد و یادگیری توسعه دهند.

۶-۴ کمبود توجه/ بیش‌فعالی

تعریف و توضیح اختلال کمبود توجه/ بیش‌فعالی[۲]، از شایع‌ترین اختلال رفتاری کودکان، به‌ویژه دانش‌آموزان دبستانی است و از برجسته‌ترین ویژگی‌های این اختلال بی‌قراری افراطی و توجه بسیار ضعیف است که به رفتار تکانشی[۲] و فاقد سازمان منجر می‌شود.

بی‌توجهی و تکانش‌گری در کودکان مبتلا به کمبود توجه/ بیش‌فعالی، موجب ارتباط آشفته و اختلال در عملکرد اجتماعی آنها می‌شود و برای بیشتر کودکان آغاز و حفظ دوستی با همکلاسی‌ها بسیار دشوار است. (استورمونت[۳]، ۲۰۰۱).

اختلال کمبود توجه/ بیش‌فعالی مشکل عملکردی[۴] نیز تعبیر شده است. این کودکان به نظر می‌رسد نمی‌توانند رفتاری را طبق برنامه‌ریزی مشخص انجام داده ویا تکلیف خاصی را در یک محدوده زمانی مشخص به اتمام برسانند. (هورووینز و روست[۵]، ۲۰۰۷، ترجمه باغداساریانس و باقری کریمی، ۱۳۹۰).

این کودکان در تعامل با همتایان، فاقد سازمان و درمانده‌اند و اغلب ازسوی آنان به خاطر رنجش‌آوربودن طرد می‌شوند (روزنهان و سلیگمن[۶]، ۱۹۹۷).

امروزه، هم مطالعات گذشته‌نگر و هم‌پیگیری‌های آینده نشان می‌دهند که در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد ازکودکان مبتلا به کمبود توجه/ بیش‌فعالی در بزرگسالی نیز نشانه‌های بیماری را دارا هستند در ۳۰ درصد از کودکان در بزرگسالی هیچ علامتی از این اختلال

یکپارچگی حسی[1] و در صورت ضعف مهارت‌های حرکتی، فیزیوتراپیست جهت تقویت این ضعف فعالیت دارند.

هدف از مداخله‌های رفتاری، مهارت‌آموزی به کودکان و کاستن از رفتارهای مخرب است. از جمله این مداخله‌ها می‌توان به افزایش مهارت‌های اجتماعی، افزایش فعالیت‌های اجتماعی، افزایش توجه، کاستن از میزان پرخاشگری و کاهش صدمه‌زدن به خود اشاره نمود. (داورمنش، ۱۳۸۵).

ویژگی‌های اتیسم و شدت مشکلات به‌طور چشمگیر از فردی به فرد دیگر متفاوت است در نتیجه دامنهٔ گسترده‌ای از تنوع فعالیت‌ها در ملاحظات آموزشی و خدمات توان‌بخشی مورد توجه قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال موسیقی درمانی به‌منظور اینکه موسیقی با دنیای متنوع ریتم و ارتباطات غیرکلامی ریتمیک و موسیقیایی روش نافذی در برقراری ارتباط و تحریک پاسخ‌های کودکان اتیسم به شمار می‌آید در مورد پیشرفت این کودکان به‌کارگرفته می‌شود.

کودکان دچار اتیسم تمایل طبیعی به بازی ندارند و این کودکان تعامل به‌صورت اجتماعی را تکلیف سخت می‌یابند و در نتیجه اغلب به نظر می‌آیند که قادر به یادگیری بازی با دیگران نیستند اما اگر بازی به‌وسیله افراد بزرگسال برای کودکان طراحی شود آنها پایگاهی مشترک می‌یابند و می‌توانند از این طریق تجربه‌های اجتماعی کسب کنند. (کاکاوند، ۱۳۸۸).

کفایت زندگی و شغل: قضاوت در مورد آیندهٔ این کودکان امری دشوار است. شاید تشخیص اتیسم طی چندین جلسه مراجعه به متخصصین و انجام آزمایشات و ارزیابی‌ها به‌وضوح حاصل شود اما اظهار نظر در مورد کار، مدرسه، تحصیل، عملکرد شغلی و اجتماعی کودک در آینده آسان نیست. مطالعات زیادی نشان می‌دهد که تنها نسبت کمی ازاین افراد به زندگی مستقل دست می‌یابند. برای افراد با اختلال شدید داشتن زندگی مستقل و عملکرد اجتماعی نسبتاً خوب در آینده نا ممکن است. برخی امکان داشتن زندگی و شغل مستقل به ویژه با کمک دوستان و خانواده را کسب می‌کنند و برخی از این افراد ازدواج می‌کنند. عده‌ای به ویژه افرادی که دارای عملکرد بالایی هستند می‌توانند به‌طور موفقیت‌آمیزی در مشاغل عادی کار کنند. برخی ظرفیت

دیده نمی‌شود و احتمالاً در ۲۰ تا ۳۰ درصد از کودکان مبتلا پیش آگهی خیلی نامناسب خواهد بود و پیامدهای ناشی از بیماری به‌صورت مشکلاتی از قبیل رفتارهای ضد اجتماعی، مصرف سوء مواد بروز خواهد کرد. در گروهی که حدواسط این دوگروه قراردارند تا بزرگسالی دارای نشانه‌های بیماری هستند اما مبتلا به اختلالات روانی شدید از قبیل: رفتارهای ضداجتماعی و سوء مصرف مواد نمی‌شوند و فقط نمایش‌دهنده همان علائم دوران کودکی خواهند بود، در این افراد علائم اختلال وجود دارد اما به شکلی با سن و رشد متناسب است (وندر[1]، ۱۹۳۴، ترجمه صرامی فروشانی، ۱۳۸۷).

سبب‌شناسی: علت آشکار واحدی برای کمبود توجه/ بیش‌فعالی وجود ندارد. متغیرهایی مربوط به خود کودک نظیر عوامل عصب‌شناختی و تأثیرات ژنتیکی در نوشته‌های پژوهشی توجه بیشتری را به خود جلب کرده است (بارکلی[2]، ۱۹۹۸؛ تانوک[3]، ۱۹۹۸).

اثرات محیطی (به‌عنوان مثال، تنش در خانواده و ضعف انضباط‌دهی والدین) به‌نظر می‌رسد شدت اختلال را تغییر بدهد، اما فی‌نفسه علت این اختلال محسوب نمی‌گردد (بارکلی، ۱۹۹۸).

میزان شیوع: تخمین میزان شیوع این اختلال در سطح جهانی در کودکان دبستانی بین ۱ تا ۶ درصد متغیر می‌باشد (تانوک، ۱۹۹۸). پذیرفته‌ترین تخمین میزان ابتلاء به این اختلال در ایالات متحده آمریکا، ۵-۳ درصد در کل جمعیت و ۷-۵ درصد در کودکان دبستانی برآورد شده است. (کوپر واریگان[4]، ۱۹۶۰، ترجمه شریعت رضوی، ۱۳۸۷).

نسبت پسران به دختران مبتلا به این اختلال در نمونه‌های مراجعان بالینی (تقریباً نسبت ۶ به ۱) و در نمونه‌های اجتماع مدار (تقریباً نسبت ۳به ۱) است (بارکلی، ۱۹۹۸؛ پاستور و روبن[5]، ۲۰۰۲).

۶-۵ نیازهای توان‌بخشی در افراد دچار کمبود توجه/ بیش فعالی

تشخیص و مداخله پزشکی: بیشتر والدین برای اولین بار فعالیت حرکتی بیش از اندازه را زمانی که کودک نوپاست مشاهده می‌کنند که اغلب با رشد حرکت مستقل کودک همزمان است اما چون در بسیاری از کودکان نوپای پر جنب و جوش بعدها این اختلال

آنچه که در همه انواع صرع‌ها مشترک به نظر می‌رسد تخلیه ناگهانی انرژی الکتریکی سلول‌های مغزی است که از آن تحت عنوان حملات صرع نام برده می‌شود (کریمی درمنی، ۱۳۸۵).

انواع صرع: از لحاظ بالینی بیماری صرع انواع متعدد و علل گوناگون دارد که شایع‌ترین تقسیم‌بندی‌ها، تقسیم صرع به نوع موضعی (مربوط به منطقه محدودی از مغز) و عمومی (تقریباً تمام محدوده مغز) می‌باشد. نوع موضعی ممکن است ازدست‌دادن هوشیاری و یا بدون آن باشد و هرکدام از آنها با انواع و اقسام وبا علائم مختلفی همراه است. (میلانی فر، ۱۳۸۹).

به اختصار به برخی انواع صرع پرداخته شده است:

صرع بزرگ[1]: در این صرع شخص مبتلا به یکباره بیهوش می‌شود و محکم به زمین می‌خورد، بدنش سفت و سخت‌شده و فریادی نامفهوم از گلوی او خارج می‌گردد، پس از اندک زمانی شروع به لرزش می‌کند، این لرزش‌ها بلافاصله تبدیل به انقباضاتی در بدن می‌شود که در نتیجه آن ممکن است فرد زبانش را گاز بگیرد و اگر مثانه بیمار پر باشد ادرار خارج گردد. حملات صرع بزرگ از چند ثانیه تا ۳ تا ۴ دقیقه طول می‌کشد که بعد از پایان حمله، شخص برای یک یا چند دقیقه در حالت خفگی است و شدیداً احساس خستگی و خواب‌آلودگی می‌کند.

صرع کوچک[2]: فراوان‌تر از صرع بزرگ است. مبتلایان به صرع بزرگ، گاه در فاصله‌های حمله‌ها، دچار حمله کوچک صرع می‌شوند. حمله کوچک صرع ناگهان و بدون مقدمه شروع و چند ثانیه طول می‌کشد، بیمار شعور و شناسایی خود را در این زمان از دست می‌دهد ولی دچار تشنج نمی‌شود و به زمین نمی‌افتد و به خواب نمی‌رود. تعداد حمله‌ها متعدد است و گاهی زمان به قدری کوتاه است، که اطرافیان متوجه نمی‌شوند (بهشتی، ۱۳۶۱).

صرع روانی – حرکتی[3]: در این نوع صرع، شخص به مدت کوتاهی دچار فراموشی شده یا نوعی حالت خلسه می‌گردد. محیط اطراف در نظرش کمی محو و تاریک می‌آید و شروع به تکلم و صحبت نامفهوم می‌کند. ممکن است در طی حملات

خدمات توان‌بخشی وآموزشی: معلمان مدارس عادی و استثنایی ضرورت دارد در مداخلات آموزشی در راستای تأمین نیازهای آموزشی و رفتاری کودکان مبتلا، دانش و شناخت کافی داشته باشند و در مواجهه با این دانش‌آموزان از صلاحیت‌های لازم در شناسایی و طرح‌ریزی برنامه آموزشی مؤثر برخوردار باشند.

در کار با کودکی که تشخیص کمبود توجه/ بیش فعالی را دریافت داشته است، افراد زیادی درگیر هستند، ضرورت مشارکت و ارتباط مداوم و هماهنگ میان این اعضاء (پزشک، روان‌شناس بالینی، روان‌شناس مدرسه، والدین، معلم، مدیر مدرسه، کاردرمان و گفتار درمانگر) می‌تواند بهبودی معنی‌داری در این دانش‌آموزان ایجاد نماید.

متأسفانه این مطلب نسبت به آنچه در دنیا مطرح می‌شود، بسیار آرمانی است ولی با وجود این، فرض می‌شود که هر چه درمان بیشتر به‌صورت کار گروهی انجام شود به همان اندازه پیامدهای بهتری برای کودک به همراه دارد.

اگرچه در طی دهه‌های متعدد پیشرفتی اساسی در شناسایی و درمان دانش‌آموزان مبتلا صورت پذیرفته است، اما مسیرهای کاری آتی با این دانش‌آموزان و بررسی مشکلات و نیازهای آنان در مقاطع راهنمایی و دبیرستان در ابعاد کارکرد تحصیلی، اجتماعی و رفتاری کمتر مورد توجه است و علیرغم نیازهای چندگانه و پیچیده نوجوانان کارهای تجربی و حمایت‌های بسیار کمی با این گروه سنی انجام گرفته شده است. درحالی‌که تعیین انواع برنامه‌ریزی‌ها در ابعاد مشاوره تحصیلی و شغلی برای آنان بسیار حائز اهمیت می‌باشد و یکی از بیشترین خطراتی که این دانش‌آموزان با آن مواجه می‌گردند فقدان علاقه آنها به امر آموزش می‌باشد و ضعف تحصیلی در حقیقت یک پیامد رایج خصوصیات رفتاری موجود در این اختلال محسوب می‌شود، در حال حاضر مشاوره و ارائه شیوه‌هایی که بتواند برای تشویق این قشر در دست‌یابی به مسئولیت بالاتر آنان در آینده مفید باشد، کم‌رنگ است و این درحالی است که این افراد در راستای پیشرفت تحصیلی و شغلی خود باید بیشتر مورد حمایت قرار بگیرند.

۶-۶ صرع

تعریف و توضیح: صرع[1] را نمی‌توان به‌عنوان یک بیماری با سبب‌شناسی واحد و تظاهرات بالینی یکسان که سیر و پیش آگهی معلومی داشته باشد، به حساب آورد ول

آموزش هستند و فقط ۵ درصد به علت اختلال شدید یادگیری به مؤسسات آموزشی مخصوص نیاز دارند (میلانی‌فر، ۱۳۸۹). لازم است معلمان در مورد صرع اطلاعات کافی داشته باشند و در تدارک کلاسی آرام و خالی از غرض وهمچنین دخالت در اجرای آموزش این کودکان تعلیمات لازم را دیده باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان مصروع به مراتب بیشتر از کودکان عادی است (فریمن[1] و همکاران، ۱۹۸۴؛ هوار[2]، ۱۹۸۴).

با وجود این نباید نتیجه گرفت که صرع مستقیماً موجب مشکلات هیجانی و رفتاری می‌شود. گذاشتن اسم صرعی، اخراج از مدرسه و احیاناً تنبیه‌های بی‌جا باعث شدت ناسازگاری می‌شود. فریمن و گروه پژوهشی او نشان داده‌اند که سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان مصروع در صورتی به‌طور چشمگیر بهبود می‌یابد که توسط معلم مورد ارزشیابی مناسب قرار بگیرند، فرصت بروز شایستگی‌هایشان را داشته باشند و از تکالیف مناسبی برخوردار گردند. (فریمن و همکاران، ۱۹۸۴).

آموزش به آحاد جامعه: در ارتقاء بخشی به آگاهی عموم و ایجاد شناخت واقع‌بینانه از این بیماری، نقش رسانه‌های گروهی می‌تواند بسیار مؤثر واقع گردد. افراد جامعه باید به‌طور منطقی با بیماری صرع برخورد کنند و اطلاع داشته باشند که این بیماری واگیر نیست و صرع صرفاً یک بیماری جسمی است که به‌دلیل اختلال در کارکرد سلول‌های مغز ایجاد شده است و با مصرف دارو تا حد ممکن حملات صرع مهار می‌شود و اکثریت این افراد قادر هستند کار[3] کنند و استخدام شوند.

حمایت‌های اجتماعی از فرد مصروع: امروزه از بیماری صرع به‌عنوان یک بیماری اجتماعی‌یاد می‌کنند به نحوی که در حال حاضر یک نفر مصروع، نه تنها باید تحت درمان باشد، بلکه محیط زندگی، تعلیم و تربیت، تحصیل، نوع شغل، کار و بالاخره آینده او باید به وسیله متخصصین، روان‌شناسان و کارشناسان تربیتی و حرفه‌ای مورد توجه قرار گیرد. (کریمی درمنی، ۱۳۸۵).

---

1. Freeman

در شخص مبتلا حرکاتی نظیر مالیدن دست‌ها به هم، راه‌رفتن بدون هدف، بازی کردن با لباس و حرکات خودبه‌خودی دهان به‌صورت جویدن دیده شود. در این نوع صرع علاوه بر علائم حرکتی، علائم روانی گوناگونی مثل تغییر در حافظه، گریه یا خنده شدید نیز دیده شود. بعد از حمله که معمولاً ۱ تا ۲ دقیقه طول می‌کشد، بیمار چیزی از زمان حمله را به وضوح به یاد نمی‌آورد.

سبب‌شناسی: در علت‌یابی صرع، دلایل متعددی ازجمله عوامل پیش از تولد، غدد مغزی، عوارض آسیب به سر، آسیب یا عفونت‌های مادرزادی و عوامل ژنتیک و برخی از داروها می‌توانند دخیل باشد (هاسلم[1]، ۱۹۹۶). ولی با این وجود علت ۷۰ درصد از حملات صرع را نمی‌توان مشخص کرد (هاردمن[2] و همکاران، ۱۹۴۸، ترجمه علیزاده و همکاران، ۱۳۸۹).

میزان شیوع: از لحاظ آماری ۱-۰/۵ درصد افراد جامعه به عارضه صرع مبتلا هستند و امکان ابتلا به صرع برای هرکسی وجود دارد (میلانی فر، ۱۳۸۹).

۶-۷ نیازهای توان‌بخشی در افراد دچار صرع

مداخلات پزشکی: صرع اساساً یک مشکل پزشکی به شمار می‌آید و متضمن مراقبت‌های پزشکی است (هالاهان و کافمن[3]، ۱۹۴۴، ترجمه ماهر، ۱۳۸۷). لذا ایجاد بستر فرهنگی مناسبی به‌منظور آگاهی‌دادن به آحاد جامعه در زمینه مراقبت‌های بهداشتی قبل از تولد، زمان تولد، درمان سریع تب، بیماری‌های عفونی، صدمه‌های مغزی و ... در پیشگیری از بروز صرع حائز اهمیت است.

در مداخلات پزشکی، براساس تشخیص پزشکان، سه نوع درمان در صرع نظر گرفته می‌شود که عبارتند از:

درمان دارویی: انتخاب دارو بستگی به نوع بیماری دارد. معمولاً درمان با یک نوع دارو شروع می‌شود و تدریجاً نیز میزان مصرف دارو در هر نوبت افزایش پیدا می‌کند تا حملات کنترل شود.

جراحی: در برخی از انواع صرع جراحی و برداشتن ناحیه مبتلا می‌تواند در ازبین‌بردن صرع مؤثر باشد.

روان درمانی: پزشک با ارائه توصیه‌ها و مشاوره به تقویت روح وروان بیمار مبادرت می‌ورزد. زیرا بیمار مصروع، بیماری است که روحیه خود را از دست داده است و امیدبخشی از سوی پزشک به بیمار از حیث اینکه بیماری علاج‌پذیر است و با مختصر تحمل و استفاده از دارو بهبودی امکان‌پذیر است در پرورش روحیه بیمار و خانواده بسیار مثمرثمرخواهد بود.

مشاوره با والدین: متأسفانه نگرش غلط جامعه به بیماری صرع باعث می‌گردد بعضی از خانواده‌ها به بیماری صرع فرزندانشان به‌عنوان‌یک پدیده شرم‌آور نگاه کنند. لذا بعد از مدتی این طرز فکر و نگرش منفی را به کودک و نوجوان مصروع خود نیز انتقال می‌دهند به‌عبارت دیگر برخی از والدین به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به فرد مصروع گوشزد می‌کنند که بیماری خود را پنهان کند. این‌گونه روش‌ها هر چند ممکن است در ظاهر موفقیت‌آمیز جلوه کند اما بعدها مشکلاتی را برای فرد ایجاد خواهد نمود از جمله باعث می‌شود که فرد مصروع همیشه یک ترس مداوم از رو در رو شدن با افراد را داشته باشد که همین امر به نوعی کمک به گوشه‌گیری و انزوای اجتماعی او خواهد کرد. همچنین عده‌ای از والدین از اینکه درمورد بیماری فرزند خود با مدیران و آموزگاران مدرسه صحبت کنند به دلایلی امتناع می‌ورزند، در حالی که خودداری‌کردن از این مسئله گاهی برای دانش‌آموز مبتلا به صرع می‌تواند خطرات جدی به دنبال داشته باشد. صحبت با مدیر، آموزگار، راننده سرویس، مربی شنا و ورزش نه تنها باعث پیشگیری از عوارض ناخوشایند نخواهد شد، بلکه این امر سبب خواهد شد تا مسئولین مدرسه عکس‌العملی مناسب و مؤثر با دانش‌آموز مصروع داشته باشند و ضرورت دارد خانواده و مدرسه اطلاعات علمی لازم و صحیح را در مورد بیماری صرع، از منابع مؤثق نظیر پزشک معالج، انجمن صرع، نشریات و مقالات علمی‌کسب کنند. (کهانی، ۱۳۸۱). به علاوه نیازمند تسهیلات مشاورهای برای مواجهه مؤثر با بیماری فرزندشان می‌باشند. آنها برای عبور از شرم بیماری فرزند و اطلاع‌رسانی به مدرسه و جامعه نیازمند خدمات مشاوره‌ای می‌باشند.

ملاحظات آموزشی: ۹۵ درصد کودکان مبتلا به صرع در مدارس عادی قابل

۹-۶ نیازهای توان‌بخشی در افراد دچار مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)

تشخیص و مداخله پزشکی: در روند تشخیص، پزشک با گرفتن شرح حال از بیمار درخصوص شروع علائم و انجام معاینات[۱] نظیر بررسی قدرت عضلات، رفلکس‌ها، هماهنگی و حس بیمار و در نهایت با نتایج حاصل از آزمایشات متعدد در تأیید بیماری اقدام می‌نماید. گرچه بعد از تشخیص، پیش‌بینی دقیق روند دوره بیماری در آینده برای افرادی که به تازگی تشخیص این بیماری در آنها داده شده است مشکل می‌باشد، اما الگوهای علائم این بیماری در طی ۵ سال اول نشانگر خوبی است که نمای درازمدت این بیماری را در این افراد نشان دهد. مثلاً بیمارانی که در طی ۵ سال اول بیماری دچار حملات کمی شده‌اند معمولاً در آینده دچار مشکلات شدید و ناتوان‌کننده نخواهند شد اما بیمارانی که در طی این ۵ سال دچار حملات مکرر و نیز لرزش اندام‌ها و اشکال در راه رفتن شده‌اند در درازمدت مستعد ابتلاء به مشکلات شدیدتری خواهند بود.

گرچه در حال حاضر هیچ‌گونه درمان قطعی برای بیماری ام اس وجود ندارد، اما تحقیقات دانشمندان باعث پیداشدن داروها و درمان‌هایی شده است که موجب کندشدن روند بیماری می‌شود و به بیمار کمک می‌کند که با علائم ومشکلات بیماری خود بهتر مواجه شود. متخصصین هشدار می‌دهند که بیماران مبتلا به ام اس نباید مصرف داروهای خود را به این خاطر که به اندازه کافی به آنها کمک نمی‌کند قطع نمایند. توقف مصرف دارویی ممکن است باعث پیشرفت سریع‌تر بیماری و بدترشدن حال بیمار گردد.

مشاوره با بیمار مبتلا به ام اس: صرف‌نظر از اینکه درمان‌های ام اس چقدر برای یک بیمار مبتلا مؤثر باشد، بیماران، خانواده‌های آنان و متخصصین در این نکته توافق دارند که زندگی با این بیماری می‌تواند دشوار و از نظر جسمی و روحی از زمان تشخیص این بیماری دردناک باشد. گاهی مواقع استرس‌هایی که در هنگام تشخیص این بیماری وجود دارد ممکن است به قدری شدید باشد که افراد بروز چنین بیماری را انکار کنند، از نظر متخصصین، انکار بیماری از طرف بیماران، روش خوبی برای مقابله با بیماری نمی‌باشد و در واقع می‌تواند بسیار خطرناک هم تلقی گردد، زیرا باعث می‌شود که بیمار به دنبال درمان بیماری خود نرود.

نخستین مرحله، مرحله ابتلا است که اچ‌ای وی به بدن منتقل می‌شود. افراد جوان ممکن است به اچ‌ای وی آلوده شوند ولی با این حال وضعیت تهدیدکنندهٔ مربوط به‌ایدز را نشان ندهند در مرحله دوم بدن بیمار شروع به تولید پادتن می‌کند. این پادتنها در حدود هفته‌های دوم تا دوازدهم پس از ابتلا به ویروس ظاهر می‌شوند. ۳۰ درصد از این افراد نشانه‌هایی شبیه به سرماخوردگی برای چندروز تا چند هفته نشان می‌دهند. مرحله سوم دستگاه ایمنی بدن ضعیف می‌شود و ویروس شروع به نابودی سلول‌های دستگاه ایمنی می‌کند، بسیاری از افراد دارای اچ‌ای وی در این مرحله علائمی نشان نمی‌دهند این مرحله بی‌نشانه است ممکن است ۳تا ۱۰ سال طول بکشد. بیش از نیمی از افراد حامل این ویروس پس از ۱۰ سال دچار بیماری ایدز می‌شوند.

تعریف سازمان جهانی بهداشت از علائم وجود بیماری ایدز در فرد عبارتند از:

- داشتن دو نشانه اصلی.
- داشتن یک نشانه فرعی.
- تشخیص اینکه نقص دستگاه دفاعی بدن به‌دلیل وجود ویروس ایدز است نه علت‌های دیگر.

نشانه‌های اصلی: کاهش ۱۰ درصد وزن بدن به‌طور ناگهانی، اسهال شدید و مداوم بیش از یک ماه، تب شدید بیش از یک ماه.

نشانه‌های فرعی: سرفه‌های مداوم بیش از یک ماه، زخم‌های خارش دار پوستی در سطوح بدن (التهاب پوست)، تبخال‌های عودکننده، عفونت قارچی (برفک)، تبخال و تاول‌های آبکی روی پوست و پرده‌های مخاطی به‌طور مزمن، تورم غدد لنفاوی در سطح بدن (هابلی[1]، ۱۹۴۸، ترجمه غفاری، ۱۳۸۶).

تعریف فوق مربوط به مراحل انتهایی بیماری است یعنی حدود ۱۰ سال بعد از ورود اچ‌ای وی به بدن علائم ایدز آشکار می‌شود و قبل از بروز علائم تنها راه تشخیص انجام آزمایشات مخصوص خونی است و هیچ علامت بالینی مشخصی وجود ندارد، اما فرد بیمار می‌تواند بیماری را به افراد زیادی منتقل کند (صفدری، ۱۳۸۹).

میزان شیوع: حدود ۷۵ تا ۹۰درصد افراد آلوده به اچ‌ای وی در محدوده سنی ۲۰ تا ۴۵ سال قرار دارند. تعداد افراد مبتلا به ایدز در ایران، برطبق آمار سال ۱۳۸۷وزارت

راه‌های اصلی انتقال ویروس ایدز

- تماس جنسی با فرد آلوده.
- سوزن‌های مشترک مخصوصاً در معتادان تزریقی و وسایل دندانپزشکی و آرایشگری آلوده
- انتقال از مادر مبتلا به جنین یا نوزاد(دوران شیردهی).
- انتقال خون و فراورده‌های خونی آلوده.
- تماس‌های شغلی در پرسنل بهداشتی مانند فرورفتن اتفاقی سوزن آلوده در پوست (انتقال شغلی).

مواردی که ویروس ایدز از طریق آنها انتقال پیدا نمی‌کند:

- اشک، عرق، عطسه و سرفه.
- دست‌دادن و در آغوش‌گرفتن، صحبت‌کردن، کنار هم نشستن و همکاری در محل کار.
- دست‌زدن به وسایل فرد مبتلا مثل سوارشدن به اتومبیل و استفاده از تلفن همراه، دست گذاشتن به دستگیره در اتاق.
- گزش حشرات باعث انتقال ویروس ایدز نمی‌شود.

۶-۱۲ خودآزمایی

۱. درخودماندگی را تعریف کنید.

۲. چرا مادرانی که کودکان اتیسم دارند به آموزش نیاز دارند ؟

۳. هر ۱۰هزار کودک. . . . . نفر به اختلال اتیسم مبتلا می‌شوند.

الف)۲ ب) ۵ ✓

ج) ۶ د) ۷

۴. به چه منظور والدین دارای کودکان اختلال کمبود توجه /بیش‌فعالی باید در تعامل با سایر والدینی که کودکان مشابه دارند باشند؟

۵. انواع صرع را نام ببرید و تفاوت آنها را مشخص کنید.

۶. روان‌درمانی چه تأثیری در بهبودی صرع ایفاء می‌کند؟

۷. . . . . مربوط به اختلالات فراگیر رشدی است.

الف) کمبودتوجه/بیش‌فعالی ب) ام اس

ج) صرع د) اتیسم ✓

۸. . . . . از نیازهای توان‌بخشی افراد مبتلا به بیش‌فعالی / کمبودتوجه نیست.

الف)تشخیص پزشکی ب) مشاوره با والدین

ج) تجهیزات خاص توان‌بخشی د) خدمات آموزشی ✓

۹. سب‌شناسی ام اس را توضیح دهید.

۱۰.نقش گفتار درمانگر را در فرد مبتلا به ام اس توضیح دهید.

۱۱.چه گروه‌هایی می‌توانند در افزایش آگاهی ایدز مؤثر واقع شوند (۵ مورد)؟

۱۲.ایدز فقط یک مشکل بهداشتی تلقی نمی‌شود بلکه معضلی اجتماعی، . . . . و. . . . . می‌باشد.

۱۳.مواردی که ویروس ایدز از طریق آن انتقال نمی‌یابد را نام ببرید. (۴مورد).

۱۴. کمبود توجه/ بیش‌فعالی در واقع اختلالی با شروع. . . . همراه با نشانه‌های رفتاری است که قبل یا همزمان با آغاز مدرسه خود را نشان می‌دهد.

اگرچه تعداد و شدت حملات صرع را که عوامل تعیین‌کننده و خامت بیماری هستند، می‌توان با درمان مناسبی کاهش داد، ولی باید دانست که حتی حملات کاملاً فاصله هم تأثیر قابل ملاحظه‌ای روی زندگی شخص و اطرافیان او دارد و به‌علاوه اختلالات روانی که غالباً با صرع همراه هستند، می‌تواند روی وضع خانوادگی، شغلی، اجتماعی بیماران بزرگسال اثر گذاشته و نیز رشد مصروعین خردسال را مختل سازد. به‌طور کلی حمایت‌کردن از افراد مصروع و خانواده آنان توسط مددکاران اجتماعی، در کاهش عوارض این بیماری در کارکرد خانواده و بالطبع شرایط روحی بیماران تأثیرگذار است.

۶-۸ مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)

تعریف و توضیح: مولتیپل اسکلروزیس[1] یا تصلب چندگانه عصبی که اصطلاحاً از آن تحت عنوان ام. اس نامبرده می‌شود، یک بیماری مزمن دستگاه اعصاب مرکزی می‌باشد که مغز و نخاع و نواحی مختلفی که با این دو قسمت در تماس هستند گرفتار این بیماری می‌شوند.

این بیماری یکی از علل مهم ناتوانی در سنین جوانی و میانسالی بوده و عمدتاً در سنین ۳۰-۲۰ سالگی شایع است و به‌ندرت در سنین کمتر از ۱۰سال و بالای ۶۰ سال شروع می‌شود (آندرسون[2] و همکاران، ۱۹۹۲). به‌طورکلی مشکلات حسی مختلف به‌ویژه آشفتگی‌های دیداری، ضعف عضلانی و مشکل در راه رفتن، اختلالات گفتاری، سرگیجه از نشانه‌های این بیماری محسوب می‌شوند و شروع بیماری معمولاً کند و تشخیص آن مشکل است. (فرانکل[3]، ۱۹۸۴).

انواع ام اس: چهار نوع اصلی بیماری ام اس عبارتند از:

نوع عودکننده – فروکش‌کننده: حمله ناگهانی، سپس تا حمله بعدی هیچ‌گونه پیشرفتی در بیماری ایجاد نمی‌شود. حمله بعدی می‌تواند خیلی زود و یا اینکه سال‌ها بعد اتفاق افتد.

حتی حد متوسط این بیماری نیز می‌تواند در تمام جنبه‌های زندگی فرد اثر بگذارد که شامل راه رفتن، دیدن، کارکردن، بازی‌کردن، رانندگی و ارتباط با خانواده و دوستان می‌باشد. وقتی بیماری ام اس در فردی تشخیص داده می‌شود بدین معنی است که بیمار و خانواده‌اش باید به‌طور ناگهانی خود را با زندگی همراه با یک بیماری مزمن، ناتوان‌کننده و کاملاً غیرقابل پیش‌بینی هماهنگ کنند. افراد مختلف وقتی متوجه بیماری خود می‌شوند واکنش‌های متفاوتی را ارائه می‌دهند. بعضی ترس سراسر وجودشان را فرا می‌گیرد و برخی دچار افسردگی شدید می‌شوند زیرا می‌پندارند که دچار یک بیماری خطرناک شده‌اند که تا آخر عمر همراه آنها خواهد بود. خانواده‌های این بیماران نیز از فهمیدن اینکه یکی از اعضاء خانواده دچار این بیماری شده است در رنج خواهند بود. واکنش اطرافیان بیمار در چگونگی برخورد با این بیماری می‌تواند بسیار متفاوت باشد. احساس ترحم و ناراحتی از واکنش‌های شایعی است که دیگران ممکن است در مواجه‌شدن با چنین بیمارانی از خود نشان بدهند.

کنار آمدن با بیماری ام اس با توجه به اینکه بیماری غیرقابل پیش‌بینی، ناامیدکننده و در حال حاضر غیرقابل درمان است، اغلب منجر به بروز افسردگی و سایر انواع اختلالات روانی می‌شود. بسیاری از بیماران مبتلا به ام اس نیاز دارند که برای رفع این مشکلات تحت خدمات مشاوره‌ای قرار بگیرند. طی خدمات مشاوره‌ای، بیماران در تغییر تفکرویا تغییر در رفتارشان نسبت به این بیماری هدایت می‌شوند و تا حد زیادی از مشکلات روحی و هیجانی مرتبط به این بیماری کاسته می‌گردد.

حمایت‌های اجتماعی و شغلی: گاهی تغییرات شناختی که در بیماران مبتلا به ام‌اس ایجاد می‌شود ممکن است منجر به اختلالاتی در به یاد آوردن اسامی، قرارهای ملاقات و کارهای روزمره شود کسانی که مشکلات این بیماری را درک نمی‌کنند ممکن است از فراموشی‌های بیمار دچار ناراحتی و دلخوری شوند، این رنجش و دلخوری‌ها به نوبهٔ خود می‌تواند بیمار را بیشتر از اطرافیانش منزوی و دور نماید و منجر به ازدست‌دادن شغلش بشود.

اختلالات شناختی حتی در موارد خیلی ضعیف هم می‌تواند روی فعالیت‌های روزانه، موفقیت در برنامه‌های توان‌بخشی و شغل بیمار بسیار تأثیرگذار باشد. (راأ[1] و همکاران، ۱۹۹۱).

بهداشت و درمان، ۱۲۵۵۶ نفر بوده است و در برخی آمارها از وجود ۳۰ تا ۴۰ هزار مبتلا به ایدز در ایران گزارش شده است (منجمی، ۱۳۸۸).

۶-۱۱ نیازهای توان‌بخشی در افراد دچار نشانگان نقص‌ایمنی اکتسابی (ایدز)

مداخله پزشکی: امروزه تعدادی دارو برای درمان عفونت‌های فرصت‌طلب و بیماری‌هایی که در افراد مبتلا به عفونت اچ‌ای وی به وجود می‌آیند، طراحی شده‌اند که تجویز این داروها تحت نظر پزشکان متخصص انجام می‌پذیرد.

علیرغم تحقیقات وسیع، پژوهشگران معتقدند حداقل تا ۱۰ سال دیگر واکسن مؤثر، بی‌خطر و قابل‌دسترس ایدز ارائه نخواهد شد حتی پس از ساخته‌شدن آن چندین سال به طول می‌انجامد تا میلیون‌ها فردی که در سراسر جهان در خطر عفونت اچ‌ای وی قرار گرفته‌اند ایمن شوند (منجمی، ۱۳۸۸).

مشاوره و آموزش به بیمار مبتلا: درمان مشکلات افراد مبتلا به اچ‌ای وی و بیماری ایدز بسیار دشوار است، کنارآمدن با برنامه دارویی و مصرف مداوم داروهای ضدویروسی و ملاقات با پزشکان، مشکل اصلی این افراد به شمار نمی‌آید بلکه انجام‌دادن این کارها برای آنها در واقع یادآور بیماری کشنده‌ای است که گرفتار شده‌اند و متعاقب با این فشار روحی، برخی درمان را رها می‌کنند درحالی‌که رعایت رژیم دارویی برای این افراد بسیار مهم است و در سلامت و طول عمر آنها نقش مهمی ایفاء می‌کند.

افراد مبتلا از اینکه انگشت نما بشوند و مورد پیش داوری قرار بگیرند بسیار بیم و هراس دارند، مشاوره یکی از مهمترین اقدامات حمایتی در رفع نگرانی این افراد خواهد بود، آنها برای کنارآمدن با واکنش‌های روانی، اضطراب و افسردگی که به دنبال مشخص‌شدن ابتلا به اچ‌ای وی به‌وجود می‌آید به کمک و راهنمایی احتیاج دارند. ایجاد حس همدردی و درک افراد مبتلا، احترام به حقوق فردی و اجتماعی در کاهش آلام آنان بی‌تأثیر نخواهد بود و قطعاً همین افراد تحت حمایت، چنانچه آموزش‌های لازم را کسب کنند با رویکردی آگاهانه در راستای احترام به حفظ سلامتی سایرین، احساس مسئولیت خواهند نمود.

نوع پیشرونده – اولیه: به‌تدریج و به‌طور پیوسته حال بیمار بدتر می‌شود. خطرناک‌ترین نوع بیماری ام اس به شمار می‌آید، حدود ۱۵ درصد بیماران به این نوع دچار هستند. بیمار به‌طور پیوسته حالش بدتر می‌شود و در بین حملات حالش هیچ‌گونه بهبودی نمی‌یابد و یا اینکه بهبودی اندکی دارد. اغلب در طی ۵ سال اول بروز بیماری، دچار ناتوانی‌های شدیدی می‌شود.

نوع پیشرونده – ثانویه: ابتدا با نوع عودکننده – فروکش‌کننده شروع می‌شود و در آخر به نوع پیشرونده تبدیل می‌شود.

نوع پیشرونده – عودکننده: آسیب‌های پیشرونده از شروع بیماری وجود دارد اما حملاتی نیز گاهی مواقع ایجاد می‌شود.

غیر از این چهار نوع ام اس، پزشکان همچنین نوع خفیفی از این بیماری را شناسایی کرده‌اند که اصطلاحاً به آن نوع «حسی خوش‌خیم» گفته می‌شود. بیمارانی که به این نوع ام اس دچار هستند دچار حملاتی می‌شوند که فقط باعث از دست رفتن بینایی و یا حس‌های دیگر آنها می‌شود این علائم معمولاً موقتی بوده واین نوع ام اس خیلی به‌ندرت باعث بروز ناتوانی‌های دائمی می‌شود با این حال حملات آن می‌تواند همانند سایر انواع ام اس به‌صورت غیرقابل پیش‌بینی رخ دهد.

سبب‌شناسی: گرچه امروزه پزشکان روش‌های متعدد و قابل اطمینانی برای تشخیص بیماری در اختیار دارند اما هنوز کسی نمی‌داند که علت ایجاد این بیماری چه چیزی می‌باشد. با وجود عوامل بسیاری که ممکن است در ایجاد بیماری ام. اس نقش داشته باشند، احتمالاً پیداشدن علل واقعی بروز این بیماری چندین سال طول خواهد کشید، با این حال پیشرفت‌های جدیدی که در زمینه نقش ژنتیک، سیستم ایمنی بدن و عوامل محیطی مثل ویروس‌ها شده‌است پزشکان را بیش از هر زمان دیگری به کشف چگونگی ابتلاء بعضی از افراد به این بیماری نزدیک‌تر کرده است. (آبراموویتز[1]، ۱۹۵۴، ترجمه همت خواه، ۱۳۸۷).

میزان شیوع: شیوع این بیماری در زنان بیشتر از مردان است و از لحاظ جغرافیایی در نواحی که از خط استوا دورتر هستند بیشتر دیده می‌شود (آندرسون و همکاران، ۱۹۹۲).

به‌غیر از احتمال ازدست‌دادن شغل به‌خاطر محدودیت‌های حرکتی که در این بیماری وجود دارد، بیماران مبتلابه ام اس مجبور هستند که تغییرات زیادی را در نحوه زندگی خود بدهند. بسیاری از افراد وقتی که تشخیص داده شد که به بیماری ام اس مبتلا هستند دست از فعالیت‌های روزمره و طبیعی خود برمی‌دارند، اما متخصصین عقیده دارند که بهتر است این افراد تا حدممکن به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

سابقاً پزشکان به بیماران مبتلا به ام اس توصیه می‌کردند که خیلی استراحت کنند و هیچ‌گونه تمرین ورزشی انجام ندهند، اما تحقیقاتی که در چند دهه اخیر صورت گرفته نشان می‌دهد که این کار لزومی ندارد و هر برنامه تمرینی که به اندازه کافی قابلیت انطباق با شرایط بدنی و محدودیت‌هایی بیمار را داشته باشد، منعی ندارد.

یکی از افرادی که با این توصیه که زیاد در بستر استراحت کنید مبارزه کرد، جیمی‌هوگا[1] قهرمان المپیک[2] در رشته اسکی بود. در سال ۱۹۷۵ میلادی به جیمی‌هوگا اطلاع داده شد که مبتلا به بیماری ام اس می‌باشد و او برخلاف توصیه پزشکان به تمرینات ورزشی خود ادامه داد و نتیجه این کار نیز بسیار درخشان بود.

خدمات توان‌بخشی: توان‌بخشی یک جزء جدا نشدنی از طرح درمان در این بیماری به شمار می‌آید، استفاده از برنامه‌های توان‌بخشی براساس نوع عوارض متفاوت است و باید برنامه‌ای خاص برای هر بیمار در نظر گرفته شود. (عظیمیان، ۱۳۷۹).

به هر یک از اهداف توان‌بخشی پزشکی این بیماران اشاره‌ای مختصر شده است:

فیزیوتراپی: حمله ناگهانی ام اس و بعد از آن، باعث به‌وجودآمدن ناتوانی‌هایی در اندام‌های بدن بیمار می‌شود. فیزیوتراپیست با انجام فعالیت‌های تخصصی و با استفاده از تجهیزات، به بیمار کمک می‌کند تا حدممکن عملکرد اندام‌هایش حفظ شود. از فیزیوتراپی برای به‌دست‌آوردن عملکرد اولیه عضلات استفاده می‌شود تا عضلات بتوانند مجدد چون گذشته (قبلاً از وقوع حمله) عمل خود را انجام دهند.

کاردرمانی: در کاردرمانی به بیمار کمک می‌شود تا مشکلاتی را که در انجام کارهای روزمره خود با آن مواجه است به نحو مناسبی اصلاح نماید. کار درمانگر به

---

1. Jamie Heuga

ارزیابی مهارت‌های حسی و حرکتی و ارزیابی دوره‌ای وضعیت پردازش درکی و شناختی این بیماران توجه دارد.

گفتار درمانی: بسیاری از بیماران مبتلا به ام اس نیاز به گفتار درمانی دارند زیرا پلاک‌های عصبی آنها باعث اختلال در صحبت‌کردن طبیعی آنها شده و باعث می‌گردد که کلماتی که به‌کار می‌برند نامفهوم باشد و یا اینکه فاصله بین کلمات آنها طولانی شده و بریده بریده صحبت کنند. گفتار درمانگر مشکل خاص هر بیماری را ارزیابی نموده و به بیمار در زمینه حل مشکلش کمک می‌نماید همچنین گفتار درمانگر با تمرینات ویژه به بیماران ام اس که دچار مشکل بلع غذا شده‌اند، کمک می‌کند.

پزشکان و گروه‌های حمایتی ازجمله تیم توان‌بخشی تمام تلاش خود را می‌کنند تا به بیماران کمک نمایند که افکار منفی را از خود دور نموده و یک زندگی خوب را در پیش بگیرند. ایجاد یک روحیهٔ مثبت، عامل مهمی در کنارآمدن با ام اس است. (آبراموویتز، ۱۹۵۴، ترجمه همت خواه، ۱۳۸۷).

۶-۱۰ نشانگان نقص ایمنی اکتسابی (ایدز)

تعریف و توضیح: نشانگان نقص ایمنی اکتسابی[1] (ایدز) به‌عنوان یک بیماری نوظهور سرتاسر جهان را تحت تأثیر قرارداده است و در حال حاضر به‌عنوان چهارمین علت مرگ در کل جهان مطرح است. در این بیماری، سیستم دفاعی بدن به شدت مختل می‌شود و در اثر نقص ایمنی ایجادشده، بسیاری از عفونت‌ها موسوم به عفونت‌های فرصت‌طلب محیط مناسبی برای رشد پیدا می‌کنند.

سبب‌شناسی: علت بیماری ایدز، ویروس نقص ایمنی بدن[2] (اچ ای وی) است. انتقال این ویروس از یک فرد به فرد دیگر ممکن است از راه تماس جنسی، انتقال خون، تزریق آلوده مواد مخدر، انتقال از مادر آلوده به جنین یا نوزاد در دوران شیردهی صورت بپذیرد. افراد دارای ایدز یک مجموعه از بیماری‌ها را به‌صورت مرحله‌ای طی می‌کنند. (لندو[3] وهمکاران، ۱۹۹۷).

فصل هفتم

توان‌بخشی معلولان روانی

اهداف فصل

در پایان این فصل از شما انتظار می‌رود بتوانید:

۱. اختلال روانی را از دیدگاه توان‌بخشی تعریف کنید.
۲. اختلالات روانی را گروه‌بندی و تفاوت آنها را مشخص کنید.
۳. روش‌های ارزیابی روان‌شناختی اختلال روانی را توضیح دهید.
۴. لیستی از نیازهای توان‌بخشی افراد دچار اختلالات روانی ارائه نمایید.
۵. پیشگیری اولیه از بروز اختلالات روانی را به عنوان نیاز و اقدام توان‌بخشی توضیح دهید.
۶. تأثیر مشاوره برای بیمار دچار اختلال روانی را تشریح کنید.
۷. ابعاد آموزش به خانواده را لیست کنید.
۸. انواع حمایت از خانواده ای که دچار بیمار با اختلال روانی است را نام ببرید.
۹. آموزش به آحاد جامعه را بر اساس نیازهای افراد دچار اختلالات روانی لیست کنید.
۱۰. اهمیت آموزش به خانواده در توان‌بخشی افراد دچار اختلالات روانی را بیان کنید.
۱۱. نقش مددکار اجتماعی را در افراد دچار اختلالات روانی توضیح دهید.
۱۲. پیامدهای منفی عدم ساماندهی به درمان اختلالات روانی در جامعه را ذکر کنید.

۷-۱ مقدمه

بیماری‌های حوزه روح و روان بیماری‌هایی هستند که به‌طور مستقیم اساسی‌ترین لایه

اختلالات خلقی[2] با تغییری در خلق (مثل افسردگی[3]) مشخص می‌شود که زندگی روانی فرد را تحت تأثیر قرار داده و سبب کاهش عملکرد وی می‌شود. اختلالات خلقی ممکن است در نتیجه یک مشکل طبی و یا مصرف مواد (مثل داروهای روان گردان) به وجود آیند.

اختلالات اضطرابی[4] وجه مشخصه این اختلالات، یا یک اضطراب فراگیر و پایدار است یا در حد هول و ترس از خروج منزل پیشرفت و حتی می‌تواند به ترس از انجام کار یا صحبت‌کردن در حضور دیگران منجر شود.

اختلالات شبه جسمی[5] در این اختلالات بیمار علائم یک بیماری را نشان داده و باور دارد که به یک بیماری یا بد شکلی دچار است در حالی که چنین بیماری یا بدشکلی وجود ندارد. درمان این اختلالات معمولاً دشوار است. در این اختلالات بیمار به صورت ناخود آگاه و یا به‌صورت مداخله‌گرانه نشانه‌های بیماری را ایجاد می‌کند تا نیازهای روان شناختی خود را ارضاء کند.

اختلالات ساختگی[6] بیمار تعمداً اقدام به تظاهر نشانه‌های اختلالات طبی یا روانی کرده و شرح حال و علائم خود را بر خلاف واقع بیان می‌کند. تنها هدف آشکار در این اختلال، ایفای نقش بیمار است بدون اینکه انگیزه دیگری وجود داشته باشد. بستری شدن در بیمارستان غالباً هدف اولیه و روش زندگی بیمار را تشکیل می‌دهد. این اختلالات دارای کیفیت وسواسی هستند ولی رفتارها و نیت بیمار حتی در صورتی که غیرقابل کنترل باشند، ارادی و آگاهانه است.

اختلالات تجزیه‌ای[7] محدود به فراموشی است. بیمار قادر نیست خاطرات مهم تشخیصی را به خاطر بیاورد اما مطالب جدید را می‌تواند بیاموزد. خاطرات فراموش‌شده معمولاً استرس‌زا هستند و فراموشی در اثر یک بیماری طبی یا مصرف دارو نمی‌باشد.

اختلالات جنسی و هویت جنسی[8] در اختلالات جنسی عملکرد جنسی تحت

---

1. Hallucination
2. Mood disorders

- **وسواس**: وسواس یک ایده، فکر، تصور، احساس یا حرکت مکرر و یا مضری است که با نوعی احساس اجبار و ناچاری ذهنی وعلاقه به مقاومت در برابر انجام آن همراه است و بیمار متوجه بیگانه‌بودن حادثه نسبت به شخصیت خود بوده و از غیرعادی و نابهنجاربودن رفتار خود، آگاه است. روان‌شناسان وسواس را نوعی بیماری از سری روان‌نژندی‌های شدید می‌دانند که تعادل روانی و رفتاری را از بیمار سلب می‌کند و او را در سازگاری با محیط دچار اشکال می‌سازد. روانکاوان وسواس را نوعی غریزه واخورده و ناخودآگاه معرفی می‌کنندوآن را حالتی می‌دانند که در آن، فکر، میل یا عقیده‌های خاص که اغلب وهم‌آمیز و اشتباه است آدمی را در بند خود می‌گیرد، آنچنان که حتی اختیار و اراده را از او سلب کرده وبیمار را وا می‌دارد که حتی رفتاری را برخلاف میل و خواسته‌اش انجام دهد.

وسواس‌های نوع فکری، تصورات یا تکانه‌های تکراری هستندکه هوشیاری را اشغال می‌کنند و اغلب نفرت‌انگیز هستند، کنارگذاشتن یا کنترل‌کردن آنها بسیار دشوار است. این افکار صرفاً نگرانی‌های شدید درباره مشکلات زندگی واقعی نیستند و فرد مبتلا به وسواس فکری می‌داند که این افکار زاییده ذهن او هستند و از خارج به او تحمیل نشده‌اند و می‌داند که وسواس‌های فکری او افراطی و نامعقول هستند و می‌کوشد با فکر یا عملی دیگر، آنها را سرکوب یا خنثی کند. وسواس‌هاس عملی پاسخ‌هایی هستند که به افکار وسواسی داده می‌شوند، این وسواس‌ها شامل تشریفات مقرراتی (مثل شستن دست یا وارسی) یا اعمال ذهنی (نظیر شمردن یا تکرار بی‌صدای کلمات) هستندکه شخص احساس می‌کند مجبور به انجام آنها در پاسخ به وسواس فکری است. هدف وسواس‌های عملی پیشگیری یا کاهش پریشانی و یا جلوگیری از رویدادهای هولناک است، با این حال این اعمال هیچ‌گونه ارتباط منطقی با آنچه قرار است از آن پیشگیری شود نداشته و به‌وضوح افراطی هستند. (روزنهان وسلیگمن[1]، ۱۹۹۹، ترجمه سیدمحمدی، ۱۳۹۰)

- **اضطراب**: نوعی احساس ترس، خطر و حالت بیماکی است. کسی که دچار اضطراب می‌شود معمولاً دلیل منطقی برای این خوف و بی‌قراری ندارد و اگر هم دلیلی داشته باشد تناسبی با حال او ندارد. اضطراب در توضیحی ساده بخشی از درون ما

1. Rosenhan&Seligman

می‌گردد ارزیابی باعث می‌شود بدانیم چرا فرد دچار مشکل شده است و درباره اینکه چگونه می‌توان مشکل او را حل کرد بینشی در اختیار ما می‌گذارد. شیوه‌های ارزیابی روانی به سه فرایند مصاحبه بالینی، آزمون روانی و مشاهده تقسیم می‌شوند هر یک از این شیوه‌ها را می‌توان برای گردآوری اطلاعات درباره مشکلات و ناتوانی‌های بیماران به‌کار برد.

به ارائه تعریف کلی و مختصری از هر یک فرایندهای ارزیابی بدون اشاره به انواع آن بسنده می‌گردد:

مصاحبه بالینی: وسیله مطلوب روان‌شناسان بالینی و روان‌پزشکان است، این دیدگاه رایج را منعکس می‌سازد که تا وقتی کسی را ملاقات نکرده و با او حرف نزده باشیم، او را خوب نمی‌شناسیم مصاحبه‌گران ماهرنه تنها از آنچه افراد می‌گویند بلکه از اینکه چگونه آن را می‌گویند اطلاعات به‌دست می‌آورند. برای به‌دست‌آوردن این اطلاعات باید بین بیمار و مصاحبه‌گر رابطه نزدیک و خوبی وجود داشته باشد و اگر بیمار احساس کند که اظهاراتش موجب خواهد شد که او را متهم کنند یا به تصمیمات ناخوشایندی در مورد آینده وی منجر شود، نباید انتظار داشت که او رو راست باشد. برای اینکه مصاحبه بیشترین آموزندگی را داشته باشد، لازم است بیمار مصاحبه‌گر را به‌صورت فردی ببیند که تهدیدکننده نیست بلکه حمایت‌کننده است.

همدلی، صمیمیت و صداقت شخصی درمانگر در امر مصاحبه، رابطه درمانی را تسهیل می‌کند و احتمال نتیجه مثبت را افزایش می‌دهد. منظور از همدلی، توانایی درمانگر در فهمیدن دقیق و ظریف تجربیات و احساسات بیمار می‌باشد و صمیمیت زمانی است که درمانگر به بیمار خود بفهماند که عمقاً و واقعاً برای وی اهمیت قائل است و او را به‌صورت فردی می‌بیند که از قابلیت‌های انسانی برخورداراست و منظور از صداقت این است که درمانگر از ارتباط ساختگی و تصنعی اجتناب نماید و عمیقاً خودش باشد. اگر درمانگر صادق نباشد قطعاً نمی‌تواند همدل و صمیمی هم باشد.

آزمون روانی: کسب اطلاعات بیشتر روان‌شناختی، درباره ماهیت مشکلات و ناتوانی‌های فرد از طریق آزمون روانی حاصل می‌گردد. برخی از آزمون‌ها موضعی هستند به این صورت که برای روشن‌کردن یک ویژگی واحد شخصیت مانند اضطراب یا کشف‌کردن نوع خاصی از آسیب مغزی ساخته شده‌اند آزمون‌های دیگر مختلط

یعنی افکار، عواطف و رفتارهای انسان را نشانه می‌گیرند و بار ناشی از این بیماری‌ها بر افراد مبتلا، خانواده آنان و جامعه بسیارطاقت فرسا می‌باشد.

اختلالات روانی به‌ویژه ازنوع شدید به سبب ماهیت خود، حالتی رو به مزمن‌شدن دارند لذا پرداختن به این بیماری‌ها به شکل پیشگیری از بروز، درمان و کنترل و همچنین اقدامات توان‌بخشی ضروری به نظر می‌رسد و کمک ارزنده‌ای به جامعه، خانواده و فرد مبتلا به بیماری نماید.

۷-۲ تعریف اختلال روانی

اختلال روانی یک ناخوشی است که دارای تظاهرات روان شناختی یا رفتاری بوده و با ناراحتی قابل ملاحظه و اختلال عملکرد ناشی از آشفتگی‌های زیست شناختی، اجتماعی، روان‌شناختی، ژنتیکی، جسمی یا شیمیایی همراه است. معیار سنجش اختلالات روانی، میزان انحراف از پاره‌ای هنجارهای طبیعی است که هرکدام از این اختلالات دارای علایم و نشانه‌های بارزی هستند(سادوک وسادوک[1]، ۲۰۱۰، ترجمه ارجمند و همکاران، ۱۳۹۰).

اختلال روانی برخلاف بسیاری از امراض به‌طور مستقیم اساسی‌ترین ابعاد انسانی یعنی افکار، عواطف، احساسات و رفتارهای آدمی‌را نشانه می‌گیرد. از دیدگاه توان‌بخشی اختلال روانی به آن گروه از اختلالات روانی مزمن اطلاق می‌گردد که به علت بستری شدن طولانی در بیمارستان‌ها و نیز به‌دلیل گسستگی روابط خانوادگی و از دست‌دادن موقعیت‌های فردی و اجتماعی گذشته، به عادت و رفتارهایی خو گرفته‌اند که ترخیص و ادامهٔ زندگی آنان در خارج از بیمارستان و جامعه باید تحت حمایت و برخورداری از خدمات توان‌بخشی روانی صورت بپذیرد. (کریمی‌درمنی، ۱۳۸۵).

اختلال روانی مزمن: بیماری که در آن فرد اختلالات شدید و پا بر جای روانی دارد که در تعارض جدی با توانایی‌های کارکردی او در ارتباط با جنبه‌های اولیهٔ زندگی روزمره همچون مراقبت از خود، روابط با دیگران، کار یا تحصیل است و نیازمند درمان

تأثیر عوامل زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی قرار دارد. اختلال یک یا چند مورد از زمینه‌های فوق سبب اختلال عملکرد جنسی خواهد شد. نتیجه نهایی همه انواع اختلالات، ایجاد اضطراب مربوط به کارکرد جنسی است که باعث مهار پاسخ‌های جنسی شده و مشکل جنسی را تشدید می‌کند. در اختلالات هویت جنسی علامت اصلی آنها ترجیح مداوم ایفای نقش جنس مخالف و داشتن این احساس است که بیمار با جنسیت اشتباهی به دنیا آمده است.

اختلالات خوردن[1] بی‌اشتهایی عصبی توسط سه مشخصه اصلی شناخته می‌شود ۱) بیمار تا حد مشخصی به خود گرسنگی می‌دهد ۲) بیمار تمایل شدیدی به لاغربودن و یا ترس مرضی از چاقی دارد. ۳)نشانه‌ها و علائم طبی ناشی از گرسنگی کشیدن در بیمار دیده می‌شود. این اختلال در تصویر ذهنی بیمار از بدن خود همراه است (بیمار علیرغم لاغربودن فکر می‌کند به طرز نگران‌کننده‌ای چاق است).

اختلالات خواب[2]:اختلالات خواب بر اساس معیارهای تشخیصی بالینی و علت احتمالی‌شان دسته‌بندی شده اند. سه گروه عمده این اختلالات عبارت است از ۱) اختلال خواب اولیه ۲) اختلال خواب مرتبط با سایر اختلالات روانی ۳) سایر اختلالات خواب (ناشی از بیماری‌های طبی عمومی و سوء مصرف مواد).

اختلالات کنترل تکانه[3] **که در جای دیگری طبقه‌بندی نشده‌اند.** شامل اختلالاتی است که در آنها فرد قادر به کنترل خود نبوده و کنش‌نمایی[4] می‌کند. این اختلالات عبارتند از اختلال انفجاری اُدواری[5] (پرخاشگری) سرقت، آتش‌افروزی، وسواس کندن مو

اختلال سازگاری واکنش غیرانطباقی به یک فشار روانی کاملا مشخص و تعریف شده است بر حسب علائم به زیر گروه‌هایی تقسیم می‌شود. اختلال همراه با اضطراب، خلق افسرده، ترکیبی از خلق افسرده و اضطراب

اختلال شخصیت وجه مشخصه این اختلال وجود الگوهای رفتاری نا

---

1 Eating disordres

مربوط است و واکنش‌های او مناسب و طبیعی هستند. هنگامی‌که ما خطر را تجربه می‌کنیم دستخوش تغییرات بدنی و هیجانی گوناگونی می‌شویم که پاسخ ترس را تشکیل می‌دهند. پاسخ ترس دارای چهار عنصر است:

۱. **شناختی**: انتظار آسیب‌های قریب‌الوقوع، به‌عنوان مثال، فرد در خیابان پرت و تاریکی حرکتی را پشت سر خود احساس می‌کند و دچار ترس می‌شود و بروز خطر قریب‌الوقوعی را پیش‌بینی می‌کند و فکر می‌کند که با یک کیف زن مواجه شده است.

۲. **بدنی**: واکنش‌های بدنی هنگامی‌که فرد دچار ترس می‌شود رخ می‌دهند. علائمی نظیر رنگ‌پریدگی پوست، چهره بیمناک، تهوع و لرزش، تپش تند ضربان قلب، کاهش ترشح بزاق، ترشح غدد عرق و گشادشدن مردمک‌ها.

۳. **هیجانی**: دلهره، وحشت از عوامل نیرومندی هستند که با ترس همراه می‌گردند و این عوامل برای افراد آشنا هستند و هر فردی در هنگام توصیف ترس خود، آنها را به کار می‌برد.

۴. **رفتاری**: دو نوع رفتار ترس وجود دارد:

الف) پاسخ‌هایی که به شیوهٔ شرطی کلاسیک شده‌اند و واکنشهای غیرارادی به ترسیدن هستند، مثلاً کودکی که در ضمن برگشت از مدرسه در کوچه‌ای که زمانی کوچه امنی برای او بوده توسط کودکان مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرد، بعد از اینکه این واقعه چند بار رخ بدهد وقتی به آن کوچه نزدیک شود می‌ترسد و ممکن است چند واکنش ترس غیرارادی، مانند عرق‌کردن و تندشدن ضربان قلب را بروز بدهد.

ب) پاسخ‌های وسیله‌ای، که تلاشی است ارادی برای انجام کار در مورد موضوعی که فرد از آن ترسیده است. برای مثال، کودکی که مورد اذیت سایر کودکان در کوچه قرار گرفته باشد سعی می‌کند به آن کوچه نزدیک نشود.

زمانی‌که پاسخ ترس با مقدار خطر موجود در موقعیت متناسب باشد، پذیرفتنی است اما وقتی پاسخ ترس با مقدار خطر تناسب نداشته باشد، نابهنجار و اختلال هراس[1] به شمار خواهدآمد. هراس[2] نوعی ترس غیرمنطقی است به‌طوری‌که حتی بیمار می‌داند ترس او از تنهایی، تاریکی، مکان‌های بسته، ارتفاع، حیوانات و. . . غیرمنطقی و بی‌دلیل است، اما نمی‌تواند آن را از خود دور کند.

---

1 Phobic disorder
2 Phobia

آن به‌عنوان اختلال ادواری هم یاد می‌کنند. افرادی که فقط تجارب شیدایی داشته باشند معمود هستند و افراد شیدا غالب همراه با شیدایی، دوره‌هایی از افسردگی را هم تجربه می‌کنند. افراد مبتلا به‌صورت ژنتیکی در برابر این بیماری آسیب‌پذیر هستند. این افراد اغلب در خانواده‌هایی یافت می‌شوند که در آنها نسل‌های متوالی به این بیماری مبتلا بوده‌اند. (رورنهان و سلیگمن، ۱۹۹۹، ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۹).

- **روان گسیختگی (اسکیزوفرنیا)**: تقریباً یک درصد جمعیت جهان در طول زندگی خود از بیماری اسکیزوفرنیا رنج می‌برند. این اختلال معمولاً در اواخر نوجوانی یا اوایل بزرگسالی روی می‌دهد. اسکیزوفرنیا با دامنه‌ای از نشانه‌ها مشخص می‌شود. گرچه این اختلال تظاهرات بالینی بسیار متعددی دارد ولی به‌طور معمول با اختلال شدید در عملکرد همراه است. (سارتوریوس[1] و همکاران، ۲۰۰۳، ترجمه برجعلی و همکاران، ۱۳۹۰).

مبتلایان به اسکیزوفرنیا غالباً از نظر اجتماعی، گوشه‌گیر و منزوی هستند و نمی‌توان به‌آسانی با آنان ارتباط برقرار کرد. این افراد به برقرارکردن دوستی عمیق گرایشی ندارند و به دیدار دوستان رغبت زیادی نشان نمی‌دهند و معمولاً فاقد دوستان صمیمی یا نزدیک هستند. زنان و مردان این گروه در مقایسه با همسالان بهنجار خود رغبت کمتری به ازدواج نشان می‌دهند. ازعوارض این بیماری می‌توان به توهم (ادراک چیزی که بیرون از ذهن، وجود خارجی ندارد) و هذیان (باوری که ریشه در واقعیت ندارد) و اختلالات هیجانی (نشان‌دادن هیجانی که با مقتضای شرایط، هماهنگی نداشته‌باشد) اشاره داشت. پیدایش اختلال در روندها و روابط فکری و قطع تماس با دنیای واقعی از صفات مشخص اسکیزوفرنیا محسوب می‌شود. تحقیقات نشان داده است که بیشتر از یک چهارم تمام بیماران روانی که به بستری‌شدن نیاز دارند به اسکیزوفرنیا مبتلا هستند. تقریباً هیچ مرض دیگری خواه پزشکی، خواه روانی تا بدین‌حد ناتوان‌کننده و پرهزینه نیست.

۷-۴ ارزیابی روان‌شناختی

ارزیابی برای دستیابی به شناخت عمیق فرد صورت می‌پذیرد و به تشخیص منجر

ایدز فقط یک مشکل بهداشتی تلقی نمی‌گردد بلکه معضلی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز هست. بسیاری از بیماران مبتلا به ایدز به حدی در اثر نشانه‌های بیماری ناتوان می‌شوند که نمی‌توانند شغل خود را ادامه بدهند و یا ازانجام کارهای خانه نیز باز می‌مانند. این بیماری باهاله‌ای از شرم و منع‌های اخلاقی و فرهنگی همراه است که مانع از اعلام بیماری از سوی افراد می‌شود و همین مسئله به پنهان ماندن بیماری، طی‌نشدن فرایند درمان و در نتیجه شیوع سریع آن منجر می‌شود. (منجمی، ۱۳۸۸).

افزایش آگاهی آحاد جامعه در شناسایی بیماری و پیشگیری آن: ضرورت توجه به پیشگیری از بروز این بیماری و تغییردادن رفتارهای پرخطر و افزایش آگاهی آحاد جامعه بسیار مورد تأکید است. شاید افراد با نام ایدز به‌عنوان بیماری کشنده ناآشنا نباشند ولی همه آنها نمی‌دانند فردی که هم‌اکنون نشانه‌های بیماری او بروز نموده است ممکن است از ۲ تا ۱۰ سال پیش به ویروس ایدز آلوده شده باشد و طی آن مدت دیگران را نیز آلوده کرده باشد.

کسب اطلاعات صحیح و کارآمد در باب پیشگیری و کنترل ایدز به‌عنوان یک نیاز آموزشی برای همگان حائز اهمیت است. به‌منظور افزایش این آگاهی در سطح اجتماع برنامه‌های آموزشی متعددی دخیل می‌باشند که به اطلاع‌رسانی، تأثیرگذاری بر باورها و نگرش‌ها، مبارزه علیه تبعیض و پیش‌داوری، فراهم‌سازی مهارت‌های تصمیم‌گیری و توانمندسازی افرادتوجه دارد و ازجمله گروه‌هایی که می‌توانند در اجرای این برنامه‌های آموزشی بسیج شوند می‌توان به رسانه‌های همگانی (رادیو، تلویزیون و روزنامه‌ها)، مدارس (مربیان بهداشت، معلمان و مشاوران مدرسه)، مددکاران اجتماعی، مراکز تنظیم خانواده، جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر اشاره داشت.

نقش افراد با نفوذی چون روحانیون در گسترش روحیه خویشتن‌داری و تهذیب نفس خاصه در جوانان قابل اغماض نمی‌باشد. پایبندی به اصول اخلاقی و شرعی، اهرمی قوی در پیشگیری از بروز این بیماری تلقی می‌گردد و به هر میزان که پایه‌های اعتقادی و مذهبی محکمتر باشد، فرد کمتر گرفتار رفتارهای مخاطره‌آمیز خواهدشد.

به‌منظور اطلاعات بیشتر به مواردی هرچند مختصر اشاره شده است:

۳-۷ طبقه‌بندی اختلالات روانی

دست‌نامه تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی، متن تجدیدنظرشده، ویرایش چهارم[1] که در سال ۲۰۰۰ توسط انجمن روان‌پزشکی آمریکا[2] منتشر شده است، نظام طبقه‌بندی رسمی است که توسط دست‌اندرکاران بهداشت روانی برای تشخیص اختلالات روانی استفاده می‌شود که حاوی ملاک‌های تشخیصی برای ۱۷ طبقه اصلی اختلالات و متشکل از ۳۷۵ بیماری جداگانه می‌باشد (سادوک وسادوک[3]، ۲۰۱۰، ترجمه ارجمند و همکاران، ۱۳۹۰). به معرفی این ۱۷ طبقه به اختصار ذیلاً پرداخته شده است:

اختلالات مربوط به رشد: اختلالاتی نظیر کم‌توانی ذهنی یا اختلالات یادگیری که معمولا برای اولین بار در دوران نوزادی، کودکی یا نوجوانی تشخیص داده می‌شوند.

اختلالات شناختی: نظیردلیریوم[4] (روان‌آشفتگی)، دمانس[5] (زوال‌عقل) و اختلال نسیانی[6] (فراموشی) از مشخصات این طبقه می‌توان به تغییر در ساختمان و عملکرد مغز اشاره داشت که موجب اختلال عملکردهای یادگیری، موقعیت سنجی، قضاوت، حافظه و هوش می‌شوند.

اختلالات روانی ناشی از مشکلات عمومی طبی[7]: این اختلالات شامل علائم و نشانه‌های اختلالات روان‌پزشکی هستند که مستقیماً به‌دلیل بیماری‌های طبی رخ می‌دهند به عنوان مثال بیماری‌های قلبی عروقی، سیفیلیس، آبسه ممکن است باعث بروز اختلالات خلقی و یا اضطرابی و... گردد.

اختلالات مرتبط با مواد[8]، به عنوان مثال مصرف مواد نظیر الکل ممکن است به اختلالات خلقی، اضطرابی و اختلال خواب منجر گردد.

اسکیزوفرنی[9] **(روان گسیختگی):** اختلالاتی را در بر می‌گیرد که با آشفتگی تفکر و تفسیر نادرست واقعیت‌ها تظاهر کرده و اغلب با هذیان[10] و توهم[11] همراه هستند.

---

1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. DSM-IV-TR
2. American Psychiatric Association
3. Sadock &Sadock
4. Delirium
5. Dementia
6. Amnestic

سازگارانه‌ای است که عمیقاً ریشه‌دار بوده و عموماً در تمام عمر باقی می‌مانند. این الگوهای رفتاری را معمولاً می‌توان در دوران نوجوانی یا قبل از آن تشخیص داد. توانایی عملکرد افراد مبتلا در بسیاری از زمینه‌ها دچار اختلال است و غالباً قابلیت انعطاف با موقعیت‌های جدید را ندارند و به شیوه‌ای انعطاف‌ناپذیر، محدود و نادرست عمل می‌کنند.

سایر شرایطی که ممکن است از نظر بالینی مورد توجه قرار بگیرد، شامل شرایطی است که هیچ گونه اختلال روانی وجود ندارد و مشکل اصلی تشخیص یا درمان است و ممکن است شامل شرایطی باشد که مشکلات شخص آن‌قدر شدید نیستند که بتوان یک تشخیص روان‌پزشکی برای وی قائل شد ولی در عین حال باعث اختلال عملکرد می‌شوند. انواع این شرایط عبارتند از رفتار ضد اجتماعی بزرگسالان و کودکان یا نوجوانان (انجام مکرر اعمال مجرمانه)، عملکرد هوش مرزی (۸۴ تا ۷۱ :IQ)، مشکل هویت (انتخاب شغل)، مشکلات فرهنگ‌پذیری (مهاجرت).

علاوه بر طبقه‌بندی DSM-IV-TR در روان‌پزشکی اصطلاحات دیگری نیز برای توصیف بیماری‌های روانی به کار می‌روند. (سادوک وسادوک، ۲۰۱۰، ترجمه ارجمند و همکاران، ۱۳۹۰). روان‌نژندی [1] و روان‌پریشی [2] نیز در زمره این اصطلاحات قرار می‌گیرند که به جهت آشنایی به معرفی آنها پرداخته شده است.

۷-۳-۱ روان نژندی

این اختلال در نتیجهٔ کشمکش‌های روانی به وجود می‌آید که در آنها اختلال کارکرد روانی جزئی است و نمونه‌هایی نظیر ترس [3]، وسواس [4] و اضطراب [5] را می‌توان جزء این گروه از بیماری‌ها قرار داد.

- **ترس:** همه ما ترس را تجربه کرده‌ایم، میزان خطری که ما با آن مواجه می‌شویم به مقدار زیاد به شغل، جایی‌که در آن زندگی می‌کنیم و غیره مربوط می‌شود. وقتی کارگر تأسیسات نفتی دچار ترس می‌شود این ترس مستقیماً به خطر موقعیت او

می‌باشد. دستگاهی است که ما را از خطر آگاه می‌کند و در مواجهه با خطر به ما قدرت و توان می‌دهد یعنی از یک سو در برابر عامل ترسناک به ما آماده باش می‌دهد و ازسوی دیگر با فعال‌کردن غده درون ریز و آزادکردن مقدار زیادی از مواد حیاتی، قدرت، آمادگی بیشتری برای مقابله با عامل تهدیدکننده به‌وجود می‌آورد. بدین‌معنی که اضطراب نه تنها بد نیست بلکه پدیده‌ای دفاعی و ضامن بقای موجودات است که بدون آن نمی‌توان زندگی کرد به همین دلیل اضطراب عامل انطباقی[1] محسوب می‌شود، اما وقتی عامل ترساننده‌ای نباشد وآدمی از سایه خود نیز بهراسد دیگر عامل انطباق محسوب نمی‌گردد، بلکه به عاملی آزاردهنده ومزاحم برای جسم یا ذهن تبدیل می‌شود. اضطراب باعث کم‌شدن ظرفیت روانی فرد برای تعامل با دیگران، حل تعارضات بین فردی و حل مشکلات ناشی از آن می‌شود. اضطراب شدید معمولاً با تپش قلب و احساس خفگی همراه است که به وحشت و اضطراب‌های مداوم، منتشر و نوسان‌دار منجر خواهد شد. (احمدی سرتختی، ۱۳۸۹).

۷-۳-۲ روان پریشی[2]

اختلال کارکردهای روانی شدید وفراگیر است و بیمار به اختلال در تفکر، عدم‌تناسب عواطف، توهم[3] و هذیان[4] و رفتارهای غیرعادی دچار می‌شود. از انواع روان‌پریشی‌ها می‌توان به بیماری‌های افسردگی دوقطبی[5] (شیدایی - افسردگی)[6] وروان گسیختگی (اسکیزو فرنیا[7])اشاره داشت.

- **افسردگی دو قطبی:** این افسردگی[8] به تناوب با حملات شیدایی[9] همراه می‌شود، شیدایی نوعی اختلال خلقی است که با علائمی برعکس افسردگی ظاهر می‌شود. یعنی بیمار شیدا[10]، بسیار شاد است و در این وضع بسیار پرحرف، پرفعالیت، کم‌خواب و پرخور است، این وضع به‌طور خودبه‌خودی بعد از چند هفته فروکش می‌کند و بیمار به شدت افسرده می‌شود. این نوسانات را به دوقطبی‌بودن تعبیر کرده‌اند کم‌گاهی در محاکم قانونی از

---

1. Adaptive
2. Psychosis

پیشگیری اولیه از بروز اختلالات روانی: جهت پیشگیری از بروز اختلالات روانی باید زمینه‌های اختلالات روانی را از طریق آموزش به خانواده‌ها ازبین برد. برخی از موارد آموزشی عبارتند از:

- مشاوره با پزشک پیش از ازدواج (در صورت وجود موارد ارثی بیماری روانی)، تغذیه، بهداشت صحیح و آرامش روحی مادر در دوران بارداری و پیشگیری از ضربه‌های زایمانی.
- جلوگیری از عفونت دوره کودکی با انجام به موقع واکسیناسیون، پیشگیری از ضربه وارده به سر در این دوران.
- وجود رابطه صحیح بین پدر و مادر وفرزندان به‌طوری که حدود مسئولیت‌ها و نقش هریک از افراد به خوبی روشن باشد و توافق‌نظر والدین در مورد تربیت کودک که منجر به دریافت پیام‌های دوگانه نگردد.
- ایجاد استقلال و مسئولیت به موقع و حمایت و پشتیبانی به جا از کودک که هردو در شکل‌گیری امید و اعتماد به نفس کودک نقش اساسی دارند.
- توجه به نیازهای آموزشی، اوقات فراغت، تفریح سالم، درک نیازهای مراحل مختلف رشد مثل سنین نوجوانی و بلوغ و رفتار متناسب با این نیازها از طرف والدین و مسئولین پرورشی و آموزشی.

پیشگیری ثانویه و تشخیص زودهنگام: مشاوره به موقع با روان‌پزشک یا روان‌شناس بالینی می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وخامت اختلالات روانی داشته باشد بسیاری از خانواده‌ها برخی از مسائل روانی فرزندانشان را جدی نمی‌گیرند و تصور می‌کنند مسئله حادی نیست که نیاز به به درمان داشته باشد حال آنکه با مشاوره به‌هنگام می‌توان وجود یا عدم‌وجود و گاهی زمینه‌های بیماری را تشخیص داد و تا حدممکن برطرف نمود.

تأثیر دارو در اختلالات روانی: آنچه در درمان اختلالات روانی، انقلابی واقعی پدید آورده است ساخت داروهای مؤثر در این بیماری‌ها می‌باشد که در زندگی صدها میلیون نفر بیمار، تأثیرات مثبت و چشمگیری داشته است بخش عمده‌ای از اختلالات روانی با داروها معالجه می‌شودو یا در حدامکان قابل کنترل می‌باشد به‌گونه‌ای که بیمار با مصرف آنها زندگی عادی و رضایت‌بخشی را از سر می‌گیرد و برخی از داروها نیز

شرم و ناراحتی می‌کنند. (شاه ویسی و همکاران، ۱۳۸۶؛ صادقی و همکاران، ۱۳۸۲).

بسیاری از بیماران با وجود شناسایی مشکل به جهت ترسیدن از انگ اجتماعی و باورهای غلط و به تعبیری به‌دلیل وحشت از برچسب خوردن توسط اطرافیان، اقدام به درمان نمی‌کنند در این میان مشاوره با روان‌پزشک و روان‌شناس در کاهش اضطراب‌های خانواده و بیمار بسیار تأثیرگذار خواهدبود. خدمات مشاوره‌ای سبب می‌شود خانواده از ابراز عواطف اغراق‌آمیز مثبت و منفی، به‌ویژه سرزنش و خرده‌گیری از بیمار بپرهیزد و با اطمینان قلبی به بهبودی بیمارش مبادرت بورزد.

نخستین وظیفه روان‌پزشک در برخورد با یک بیمار روانی، تفهیم این موضوع است که بیماری‌های روانی تفاوتی با بیماری‌های جسمی ندارد و پزشک می‌تواند، پیشداوری‌هایی که در جامعه درباره بیماری‌های روانی وجود دارد و خرافات مربوطه را برای خانواده از بین ببرد. (فربد، ۱۳۸۹).

آموزش به خانواده: سنگر اصلی کار با بیمار روانی، خانواده اوست به همین علت باید در توان‌بخشی و درمان بیماری‌های روانی توجه ویژه‌ای به خانواده آنان بشود. بخش اعظم بار و فشار حاصل از بیماری بر خانواده و اعضای آن تحمیل می‌شود. بار مالی و اقتصادی، بار اجتماعی و مسئولیت مراقبت از بیمار گاهی اوقات بیش از حد توان خانواده‌هاست و به همین علت بعضی از خانواده‌ها پس از چند تجربه ناموفق درمان به نوعی یأس و دلسردی در زمینه درمان و توان‌بخشی بیمار خود دچار می‌شوند، تداوم این یأس گاه به بی‌تفاوتی و غفلت از بیمار و تأمین نیازهای او منجر می‌شود امری که سرانجام به یکی از دو شکل زیر تجلی می‌کند:

- تلاش برای بستری‌کردن دائمی بیمار در یک مرکز درمانی.
- در صورت عدم‌موفقیت در بستری‌کردن دائم، انکار مسئولیت‌ها و رهاسازی بیمار که در نهایت به سرگردانی و آوارگی او در کوی و خیابان می‌انجامد و سبب می‌شود تا چنین بیمارانی به خیل کارتن‌خواب‌ها و بالش سنگی‌ها بپیوندند. (داورمنش و براتی‌سده، ۱۳۸۵).

لذا لزوم آموزش به خانواده در این راستا مورد توجه است، ابعادی ازآموزش به خانواده‌ها عبارتند از:

- آموزش در زمینه ماهیت اختلالات روانی، علل و عوامل و علائم آنها.

بیمار کسب می‌کند، این دانسته‌ها به مددکار اجتماعی کمک می‌کند تا تصویر روشن و واضحی از بیمار و خانواده وی داشته باشد.

مرحله درمان: دراین مرحله فعالیت مددکار به‌صورت تیمی‌می‌باشد و در این راستا روان‌پزشک، روان‌شناس بالینی وروان پرستار برنامه‌ای مدون و منظم را اجرا می‌نمایند. اولین گام که در درمان بیمار بسیار مهم است، طبقه‌بندی بیمار است. بیمار باید در بخشی که مناسب وی باشد بستری گردد. فعالیت مددکاری در این مرحله بیشتر به‌صورت گروهی می‌باشد بدین معنی که با توجه به جنس، سن، علائق و سایر عواملی که در این زمینه مؤثر می‌باشد، بیماران روانی را در گروه‌های مختلف قرار داده و کار گروهی با آنان انجام می‌دهند. مددکاری گروهی نگرش آگاهانه و هدایت شده به طرف توسعهٔ حداکثر توانایی فرد است. در عین حال فرد از طریق گروه می‌آموزد چه موقع باید در گروه مشارکت کند و چه موقع باید کناره‌گیری کند.

مرحله بازگشت به خانواده و جامعه: مددکار اجتماعی در این مرحله ضمن آماده‌کردن بیمار برای بازگشت به خانواده و شروع زندگی اجتماعی به اعضای خانواده نیز این آموزش را می‌دهد که چگونه با بیمار روانی برخورد نمایند. افراد خانواده باید درک کنند که او یک بیمار است و نباید مورد آزار و بی‌احترامی‌قرار گیرد. علاوه بر اینها خانوادهٔ بیمار باید توجیه شوند که نسبت به رعایت مصرف به موقع و به اندازه داروهای تجویز شده از سوی پزشک معالج و نیز پیگیری درمان در زمان‌های تعیین‌شده هیچ‌گونه بی‌توجهی و قصوری نشود.

مرحله پیگیری: مددکار اجتماعی در این مرحله با استفاده از بازدید منزل نسبت به اطلاع موقعیت بیمار و خانواده‌اش پس از ترخیص از بیمارستان آگاهی می‌یابد. علاوه بر این نسبت به حمایت معنوی و مادی از این بیماران و خانوادهٔ آنان اقدام می‌نماید. زیرا بعضی از این بیماران قادر به انجام کار نیستند و منبع درآمدی نیز ندارند و می‌بایست تحت پوشش مؤسسات حمایتی قرار گیرند. حمایت مادی و معنوی مددکار اجتماعی از خانوادهٔ بیمار این امکان را به خانواده می‌دهد که در امر مراقبت از بیمار خود غفلت و سهل‌انگاری نکند.

نقش کار درمانگر و کاردرمانی در توان‌بخشی افراد دچاراختلالات روانی: هر اختلال روانی از هر نوع و به هرعلت که باشد از لحاظ روابط اجتماعی، سلوک و رفتار

دستاوردهای مثبت محروم می‌کند، بهداشت روانی هنوز ازجایگاه شایسته‌ای در نظام مراقبت سلامت و برنامه‌ریزی‌های کلان مسئولان عرصه سلامت برخوردار نیست و مستلزم عزم ملی میان سیاست‌گذاران کشور برای پرداختن به مشکلات بیماران روانی می‌باشد.

با وضعیت کنونی، دور از انتظار نخواهد بود که حضور برخی افراد دچار اختلالات روانی یا به تعبیری بیماران روانی مزمن را هر روز در سطح جامعه به طرز اسفناک شاهد باشیم، افراد خیابان گردی که زندگی آشفته‌ای را می‌گذرانند وخیابان‌ها، پارک‌ها، پایانه‌های مسافربری و ساختمان‌های نیمه‌تمام، محل زندگی این افراد است. گدایی می‌کنند یا دست به کارهای خلاف می‌زنند و حتی برخی از آنها به علت ماهیت بیماری خود، مرتکب جنایات هولناکی می‌شوند که تحت تأثیر ذهنیت هذیانی و توهمات آنها صورت گرفته است.

و در نهایت در صورت عدم سامان‌دهی

- فردچگونه در جامعه زندگی خواهدکرد؟
- دیگران چه تکلیفی نسبت به او دارند؟
- آیا اوخود را ملزم به ادامهٔ درمان می‌داند؟ اگر چنین الزامی‌را احساس نکند در قبال این وضع چه تکلیفی داریم ؟

۷-۱۰ خودآزمایی

۱. اختلال روانی مزمن را تعریف کنید.
۲. تفاوت روان نژندی و روان پریشی را بیان کنید.
۳. تشخیص به موقع در اختلال روانی به چه معناست.
۴. نقش مددکاررا در توان‌بخشی افراد دچار اختلالات روانی توضیح دهید.
۵. وظایف کار درمانگر را در توان‌بخشی افراد دچار اختلالات روانی برشمارید.
۶. . . . از اختلالات روان نژندی نیست.

الف) ترس
ب) وسواس
ج) اضطراب
د) افسردگی دو قطبی

معنوی را به سه بعد قبلی یعنی جسمی، روانی و اجتماعی اضافه کرد و از این تاریخ بود که موضوع سلامت معنوی جایگاه قوی‌تری پیدا کرد و تحقیقات بسیار زیادی در این مورد انجام شد. باید توجه داشت که هر کدام از این ابعاد دچار اختلال بشود بر روی سایر ابعاد هم تأثیر می‌گذارد و هرگاه بخواهیم عارضه‌ای از یکی از این ابعاد را درمان کنیم باید از همه مؤلفه‌های سلامت برای درمان بهره بگیریم احتمالاً همه ما شاهد موارد عدیده‌ای بوده‌ایم که یک بیماری مشابه در دو فرد با خصوصیات روانی و اجتماعی مختلف و اعتقادهای گوناگون، نشانه‌های متفاوتی از خود بروز می‌دهد و پاسخ به درمان‌ها برای آنها یکسان نیست (سلامت معنوی رکن چهارم سلامت، مندرج در سایت میکنا، ۱۳۹۰/۹/۲۲).

۷-۶ میزان شیوع

براساس آمار بین‌المللی در هر جامعه‌ای ۲۵ درصد از مردم، دچار به انواع اختلالات روانی هستند این ۲۵ درصد به معنی آن نیست که فقط شامل بیماری‌های حاد شود بلکه انواع اختلالات روان‌پزشکی از جمله وسواس، اضطراب و . . . را هم شامل می‌شود. اما از این تعداد فقط ۱۰ درصد برای درمان مراجعه می‌کنند و بقیه به دلایل مختلفی که وجود دارد از مراجعه به متخصصین و اقدام برای درمان سرباز می‌زنند (مظاهری، ۱۳۹۰).

۷-۷ نیازها و اقدامات توان‌بخشی در افراد دچار اختلالات روانی

اختلالات‌روانی را می‌توان همچون سایر مشکلات و معلولیت‌ها با ارائه برنامه‌های مناسب در اجتماع، توان‌بخشی نمود و زمینه حضور مجدد افراد مبتلا را به جامعه فراهم ساخت شاید ساده‌ترین تعریف از توان‌بخشی اختلالات روانی، تلاش مستمر به‌منظور کمک به بیمار برای نیل به یک زندگی مستقل باشد. ولی باید در نظر داشت که این اقدامی سهل‌الوصول نمی‌باشد و نیازمند صبر و شکیبایی از طرف بیمار، خانواده و متخصصان مربوطه است. برهمین اساس سازمان جهانی بهداشت در گزارش سالیانه خود در سال ۲۰۰۲ که به سلامت روان اختصاص داشت توان‌بخشی اختلالات روانی را فرایندی مستمر در نظر می‌گیرد نه یک فعالیت صرف که از جایی شروع شود و بس از مدتی هم خاتمه پیدا کند.

در درمان به‌جز تجویز دارویی، درمان با الکترو شوک[1] نیز بنا بر تشخیص روان‌پزشک در برخی بیماری‌های روانی کاربرد دارد.

الکتروشوک: این روش درمانی با گذراندن مقداری برق از الکترودهایی انجام می‌پذیرد که روی سر بیمار و در حالت بیهوشی کار گذاشته می‌شود. بیشترین کاربرد آن در درمان افسردگی است و براساس نظر روان‌پزشک ممکن است تا چندجلسه تجویز شود. اثرات درمانی آن سریع‌تر از دارو درمانی است و به دلیل بیهوشی، بیمار هیچ تجربه‌ای از احساس برق‌گرفتگی در طول الکتروشوک نخواهدداشت. فقط ممکن است پس از به هوش آمدن سردرد مختصری داشته و تا دقایقی گیج‌ومنگ باشد که این از عوارض بیهوشی و زودگذر است. مهمترین عارضهٔ الکتروشوک فراموشی کوتاه مدت است که معمولاً پس از چند هفته خود به خود بهبود می‌یابد. (احمدی سرتختی، ۱۳۸۹).

مشاوره با بیمار و خانواده: اختلالات روانی نه تنها سبب ناکارآمدی بیماران روانی می‌شوند، بلکه خانواده‌های آنها را نیزبه شدت تحت تأثیر قرارداده و عملکرد آنها را مختل می‌سازد این تأثیرگذاری در ابعاد مختلفی همچون سلامت روان و عملکرد اجتماعی و اقتصادی قابل مشاهده بوده و در مجموع، بهزیستی خانواده را کاهش و فشار زیادی بر آنها تحمیل می‌کند (سارتوریوس و همکاران، ۲۰۰۳، ترجمه برجعلی و همکاران، ۱۳۹۰).

خانواده به‌صورت یک نظام واحد به هم پیوسته عمل می‌کند که بین اعضای آن روابط ویژه‌ای وجود دارد این روابط بر کارکرد این نظام و ارتباط آن با دنیای بیرون تأثیر می‌گذارد. تغییر در یکی از اعضای خانواده بر کل نظام و بر تک تک اجزای آنها و روابط آنها با جهان بیرون اثر دارد و آن را دگرگون می‌سازد. بسیاری از اوقات وجود بیماری روانی در یکی از اعضای خانواده به معنی اختلال در روابط کلی افراد خانواده است و از طرف دیگر بهبود فرد بیمار به بهبود کارکرد و روابط کل افراد خانواده بستگی دارد. یکی از دردناک‌ترین جنبه‌های مرتبط با بیماری‌های روانی نه نفس خود بیماری یا علائم آن، بلکه نگرش‌ها و دیدگاه‌های افراد جامعه نسبت به بیماران روانی و خانواده‌های آنان می‌باشد. درصد زیادی از خانواده‌های بیماران روانی مورد تبعیض و تمسخر قرار می‌گیرند و به دلیل انگ یا برچسب، شمار قابل توجهی از آنها از وجود بیمار روانی در خانواده احساس

---

1. Electro Convulsive Therapy(ECT)

- تهیه جزوات و کتاب‌های مناسب و بهره‌گیری.
- برگزاری جلسات مختلف با حضور بیماران و خانواده‌های آنان.
- تهیه و آماده‌سازی و چاپ مقالات مناسب در جراید کثیرالانتشار.

۷-۸ مداخله تیمی درتوان‌بخشی افراد دچار اختلالات روانی

به‌دلیل ماهیت اختلالات روانی و نگرش به عوامل زیستی، روان‌شناسی و اجتماعی، درمان و توان‌بخشی این بیماران مستلزم حضور کار تیمی‌می‌باشد که اصلی‌ترین عناصر آن اعضای متخصص، بیمار و خانواده است. اعضای متخصص تیم (روان‌پزشک، روان‌شناس، کار درمانگر، مددکار اجتماعی، روان پرستار) هریک در حیطه تخصصی خود بیمار را ارزیابی و مورد بررسی قرار می‌دهند و نیازهای درمانی وی را مشخص می‌کنند و با توجه به نیازهای تعیین شده اهداف بازتوانی و دستیابی به اهداف را به‌صورت رفتاری طرح‌ریزی می‌کنند. در توان‌بخشی کمک‌رسانی باید به طریقی عملی شود که بیمار قادر باشد از توانمندی‌های موجودش بهره بگیرد وبه اعتماد به نفس و رضایت فردی نایل گردد.

توان‌بخشی روانی فرایندی حاصل از تلاش اعضای تیم درمان است که با هدف ارتقاء در توسعهٔ توانمندی‌های باقی‌ماندهٔ بیمار، برای رسیدگی به زندگی، آموزش، اجتماعی‌شدن و به‌طور کلی سازگاری در حد طبیعی صورت می‌پذیرد. (خانکه، ۱۳۷۷).

۷-۸-۱ نقش مددکار اجتماعی

مددکار اجتماعی به‌عنوان یکی از اعضای تیم توان‌بخشی نقش به سزایی در درمان و بازتوانی آنان دارد. فعالیت مددکار اجتماعی در چهارچوب اهداف تیمی در مرکز درمانی در ۴ مرحله انجام می‌گیرد که به ترتیب عبارتند از: ارزیابی، درمان، آمادگی برای بازگشت به خانواده و جامعه و پیگیری می‌باشد (کریمی‌درمنی، ۱۳۸۵).

مرحله ارزیابی: این مرحله در زمانی که بیمار در مرکز درمانی بستری و تحت درمان قرار می‌گیرد صورت می‌پذیرد. مددکار اجتماعی در این مرحله با استفاده از ابزارهای مشاهده و مصاحبه با بیمار و اعضای خانواده‌اش و مطالعهٔ پرونده واسناد بیماری، اطلاعاتی ازقبیل وضعیت بیمار و خانواده‌اش و همچنین علائق و انگیزه‌های

۷-۸-۲ نقش روان پرستار

روان پرستار یکی از اعضاء کلیدی در تیم مراقبت‌های بهداشتی و توان بخشی روانی محسوب می‌گردد که نقش ارزنده‌ای در پذیرش، آماده‌سازی برای درمان، مراقبت‌های حمایتی جسمی، روانی و اجتماعی بیمار دارد و مسئول ارائه یک برنامه مراقبتی مشخص برای تسهیل بازتوانی است تا بیمار در وضعیت مطلوبی از بهداشت و سلامت قرار گرفته و از عوارض احتمالی بیماری او پیشگیری شود. روان پرستار در تیم توان‌بخشی نقش مراقبت‌کننده، مشورت‌دهنده و حمایت‌کننده را دارا می‌باشد.

مسئولیت هدایت و حمایت‌کردن تمام برنامه‌های توان‌بخشی، انجام خدمات مراقبتی، کار با بیمار و بستگان وی، انجام آموزش‌های پزشکی، ملاقات و پی‌گیری دائمی، سایر اعضای تیم در حیطه وظایف روان پرستار به‌شمار می‌آید وروان پرستار همچون سایر اعضای تخصصی تیم به تداوم زندگی با مطلوب‌ترین شکل ممکن برای بیمار اهتمام می‌ورزد. ثبت دقیق مشاهدات براساس بررسی کامل وضعیت روانی بیمار و گزارش مشاهدات به اشتغال تحت نظارت در بیماران روانی: بازگشت فرد معلول به زندگی شغلی هدف نهایی خدمات توان‌بخشی است. (کریمی‌درمنی، ۱۳۸۵). اشتغال عامل قدرتمندی در تأمین نیازهای اقتصادی، اجتماعی و روانی محسوب می‌شود و کار نه تنها وسیله کسب معاش بلکه یک شیوه زندگی و یک نقش اجتماعی برای هر فردی به‌شمار می‌آید که در ایجاد روابط شخصی و اجتماعی، احساس ارزشمندی و مسئولیت‌پذیری تأثیرگذار است، بیمار روانی نیز از این قاعده مستثنی نیست، فقدان شغل و بحران‌های پیامد آن، وی را بیشترگرفتار انزوای اجتماعی خواهدنمود.

فراهم‌آوردن موقعیت‌های شغلی به‌گونه‌ای که برای انجام آن کار، آمادگی چندانی نیاز نباشد و بیمار در حین کار به‌طور مداوم، تحت آموزش و حمایت قرار بگیرد مورد توجه می‌باشد. در واقع انجام کاری که به‌منظور درمان و کاملاً هدایت شده، توسط بیمار صورت بپذیرد از اهداف مهم در برگرداندن حس اجتماعی وی به‌شمار می‌آید.

۷-۹ سامان‌دهی درمان اختلالات روانی در جامعه

با توجه به شیوع فراوان و تنوع اختلالات روانی درایران و بروز آنها در دوران نوجوانی

هستند و سعی دارند بخش بزرگتری از شخصیت و نابهنجاری را جستجو کنند. اغلب شیوه‌های آزمون روانی، نسبتاً استانداردشده هستند و همین امر باعث می‌گردد آزمایندگان مختلف اطلاعات تقریباً مشابهی را از بیمار به‌دست بیاورند. شاید پایاترین و معتبرترین آزمون‌های روانی آزمون‌هایی باشند که هوش را اندازه گیری می‌کنند. آزمون‌های هوش نقش مهمی در ارزیابی عقب‌ماندگی ذهنی و آسیب مغزی ایفاء می‌کنند. (روزنهان و سلیگمن، ترجمه سید محمدی، ۱۳۹۰)

اولین آزمون هوش به‌وسیله آلفرد بینه[1] در سال ۱۹۰۵ساخته شد و دوسال بعد بر مبنای تجاربی که به‌دست آمده بود در آن تجدید نظرهایی به عمل آمد. در سال ۱۹۱۶ ترمن[2] این آزمون را از لحاظ زبان، اختصاصات فرهنگی و جغرافیایی با شرایط آمریکا منطبق ساخت که به نام آزمون تجدیدنظرشده استانفورد[3] و یا آزمون استانفورد بینه[4] معروف شده و مورد استفاده قرار گرفت. (میلانی فر، ۱۳۸۹).

مشاهده: شیوه‌های ارزیابی مصاحبه بالینی و آزمون روانی غالباً کلامی‌هستند و افراد برای نشان‌دادن موهبت‌ها و توانایی‌های روان‌شناختی از کلمه‌ها استفاده می‌کنند و کاربرد کلمه‌ها در بزرگ‌نمایی موضوع بی‌تأثیر نمی‌باشد. اظهارنمودن احساسات توسط فرد بیمار به تنهایی کفایت نمی‌کند و این موضوع که مشکل چیست، چند بار اتفاق می‌افتد و چگونه باید به آن پرداخت را منتقل نمی‌کند لذا توجه داشتن به رفتار واقعی در موقعیت‌هایی که فرد با آن مواجه می‌شود ضرورت دارد. به فرد بیمار صرفاً گفته نمی‌شود که او چه هست یا چه چیزی دارد بلکه آنچه را که انجام می‌دهد و شرایطی که در آن، آن را انجام می‌دهد نیز مورد تأکید است.

۷-۵ سبب‌شناسی

برای اختلالات روانی یک علت واحد نمی‌توان ذکر کرد و از آنجا که انسان موجودی زیستی روانی و اجتماعی است، هرسه عامل زیستی، روانی و اجتماعی موردتوجه قرار می‌گیرد. (کریمی درمنی، ۱۳۸۵).

در سال ۱۹۷۹ میلادی، سازمان جهانی بهداشت در اجلاس بین‌المللی، سلامت

---

1. Alfred Binet

باعث پیشگیری از عود برخی از اختلالات روانی می‌شوند.

همان‌طورکه کشف و استفاده از داروهای پزشکی میزان مرگ ومیر در انسان‌ها را کاهش داده است و از این رو مصرف آنها لازم است، داروهای روان پزشکی نیز باعث کاهش‌یافتن تعداد بیماران بستری در آسایشگاه‌های روانی شده و مصرف آنها لازم است و به آنها کمک می‌کند زندگی بهتر و سالم‌تری داشته باشند. (احمدی سرتختی، ۱۳۸۹).

عموماً این باور غلط نسبت به داروهای روان‌پزشکی وجود دارد که تصور می‌شود اعتیادآور است و از خوردن آنها اجتناب می‌شود و این در حالی است که این اختلالات هم به درمان دارویی و هم روان درمانی احتیاج دارند زیرا فعل و انفعالاتی در مغزایجاد شده است و نیاز است که با دارو درمان گردد. (مظاهری، ۱۳۹۰).

داروهای روان‌پزشکی را براساس بیماری‌های رایج روان‌پزشکی می‌توان در گروه‌های ذیل طبقه‌بندی نمود:. (آذر و نوحی، ۱۳۹۰).

- داروهای ضداضطراب، آرام‌بخش و خواب‌آور.
- داروهای ضدافسردگی.
- داروهای ضدجنون (آنتی سایکوتیک‌ها[1]).
- داروهای ضد لرزش(آنتی کولینرژیک [2]).
- داروهای تنظیم‌کننده خلقی [3].
- داروهای مورد استفاده در ترک مواد افیونی.
- داروهای محرک مغزی روانی.[2]
- سایر داروهای مؤثر در روان‌پزشکی. (نظیر هورمون‌های تیروئید که در روان‌پزشکی هورمون‌های تیروئید به عنوان داروهای کمکی با داروهای ضد افسردگی و برای تقویت این گروه داروها در گروهی که پاسخ مثبت ندادند به‌کار می‌رود.)

از جمله قرص‌های مربوط به داروهای ضداضطراب، آرام‌بخش و خواب‌آور و داروهای ضدجنون و داروهای مورد استفاده در ترک مواد افیونی می‌توان به ترتیب به آنتی هیستامین، رسپیریدون[5] ومتادون[6] اشاره داشت.

---

1. Antipsychotic drugs
2. Anticholinergic drugs
3. Mood stabilizers

- آموزش در زمینهٔ نحوه تنظیم بودجه و وضعیت مالی خانواده با توجه به شرایط بیمار.
- آموزش درباره مراحل بعد از ترخیص بیمار از بیمارستان.
- آموزش درباره نحوه مدارا با بیمار پرخاشگر، بیمار منزوی و. . .
- آموزش در زمینه درمان و توان‌بخشی بیمار و به‌ویژه لزوم توجه به تداوم درمان.
- آموزش دربارهٔ نحوه همکاری با تیم درمان و توان‌بخشی (در مراحل مختلف از جمله در مرحله بستری، در مرحله پیگیری پس از ترخیص و. . .).

حمایت از خانواده: خانواده اغلب اولین مراقبان بیمار هستند و در واقع چتر مناسبی برای بیمار به‌منظور تحقق اهداف درمانی و توان‌بخشی به حساب می‌آیند و علاوه بر اینکه بیمار خود را تحت حمایت‌های فیزیکی و عاطفی قرار می‌دهند، بار سنگین هزینه‌های درمان را نیز برعهده گرفته‌اند لذا نیازمند حمایت گسترده‌ای هستند از آن جمله:
- حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی.
- حمایت‌های بیمه‌ای.
- حمایت در جهت تشکیل گروه‌ها و انجمن‌های خودیار.
- حمایت در زمینه پیگیری امور و مطالبات مربوط به بیمار در دستگاه‌های اجرایی و اداری.

آموزش به آحاد جامعه در باب آشنایی با بیماری‌های روانی: اصلی‌ترین برنامه برای آحاد جامعه تغییر در نگرش‌های اجتماعی می‌باشد و ابزار مناسب این کار آموزش است. آموزش به آحاد جامعه درباره بیماری روانی یک ضرورت به‌شمار می‌آید. برخی آموزش‌ها شامل:
- آشنایی با عوامل فشار روانی و زمینه‌های ایجادکننده بیماری.
- افزایش آگاهی درباره درمان‌پذیربودن بیماری و اثر بخشی درمان و توان‌بخشی در بهبودی بیمار.
- آموزش در راستای انگ‌زدایی از خانواده‌های دارای فرداختلالات روانی.
- برخورداری از تفاهم اجتماعی و تعامل با اختلالات روانی.
- احترام به حقوق انسانی افراداختلالات روانی.

برای ارائه آموزش‌ها می‌توان از ابزار و وسایل مختلف استفاده نمود از جمله:
- رسانه‌های همگانی (رادیو، تلویزیون و روزنامه‌ها).

- آموزش در زمینهٔ نحوه تنظیم بودجه و وضعیت مالی خانواده با توجه به شرایط بیمار.
- آموزش درباره مراحل بعد از ترخیص بیمار از بیمارستان.
- آموزش درباره نحوه مدارا با بیمار پرخاشگر، بیمار منزوی و. . .
- آموزش در زمینه درمان و توان‌بخشی بیمار و به‌ویژه لزوم توجه به تداوم درمان.
- آموزش دربارهٔ نحوه همکاری با تیم درمان و توان‌بخشی (در مراحل مختلف از جمله در مرحله بستری، در مرحله پیگیری پس از ترخیص و. . .).

حمایت از خانواده: خانواده اغلب اولین مراقبان بیمار هستند و در واقع چتر مناسبی برای بیمار به‌منظور تحقق اهداف درمانی و توان‌بخشی به حساب می‌آیند و علاوه بر اینکه بیمار خود را تحت حمایت‌های فیزیکی و عاطفی قرار می‌دهند، بار سنگین هزینه‌های درمان را نیز برعهده گرفته‌اند لذا نیازمند حمایت گسترده‌ای هستند از آن جمله:
- حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی.
- حمایت‌های بیمه‌ای.
- حمایت در جهت تشکیل گروه‌ها و انجمن‌های خودیار.
- حمایت در زمینه پیگیری امور و مطالبات مربوط به بیمار در دستگاه‌های اجرایی و اداری.

آموزش به آحاد جامعه در باب آشنایی با بیماری‌های روانی: اصلی‌ترین برنامه برای آحاد جامعه تغییر در نگرش‌های اجتماعی می‌باشد و ابزار مناسب این کار آموزش است. آموزش به آحاد جامعه درباره بیماری روانی یک ضرورت به‌شمار می‌آید. برخی آموزش‌ها شامل:
- آشنایی با عوامل فشار روانی و زمینه‌های ایجادکننده بیماری.
- افزایش آگاهی درباره درمان‌پذیربودن بیماری و اثر بخشی درمان و توان‌بخشی در بهبودی بیمار.
- آموزش در راستای انگ‌زدایی از خانواده‌های دارای فرداختلالات روانی.
- برخورداری از تفاهم اجتماعی و تعامل با اختلالات روانی.
- احترام به حقوق انسانی افراداختلالات روانی.

برای ارائه آموزش‌ها می‌توان از ابزار و وسایل مختلف استفاده نمود از جمله:
- رسانه‌های همگانی (رادیو، تلویزیون و روزنامه‌ها).

دچار اختلال می‌شود و در نتیجه تمایل به کار، حس تشریک مساعی واحساس مسئولیت وی نیز مختل می‌گردد. برای اینکه بیمار بتواند زندگی سودمندی را در اجتماع از سر بگیرد لازم است سلوک و رفتار وی طبیعی شده، احساس مسئولیت و حس اجتماعی را باز یابد. منظور نهایی در فرایند توان‌بخشی که به‌صورت کار تیمی اجرا می‌شود، رفع اختلالات رفتاری و برگرداندن حس اجتماعی به بیماران است.

اثر مستقیم بیماری، در سلوک و رفتار بیماران منعکس می‌شود و به طریقی حس اجتماعی آنان را مختل می‌سازد، بنابراین اگر رفتار آنان طبیعی شود و بتوانند با دیگران رفتار اجتماعی سالم برقرار کنند و قدرت کار خود را باز یابند در این‌صورت چنین بیمارانی را باید بهبود یافته دانست. در کاردرمانی که توسط کاردرمانگر صورت می‌پذیرد، سعی می‌شود روابط بین افراد اصلاح شود و احساس‌های مرضی مانند عدم‌اطمینان و اعتماد، ترس وسوء ظن، خشم و غیره که سبب پیدایش رفتارهای نامناسب شده است ازبین برود و اعتماد بنفس برگردد، تعاملات اجتماعی تقویت شود، افکار هذیانی اصلاح گردد و بیمار طرز معاشرت و رفتار با دیگران را از نو بیاموزد.

در کاردرمانی بیش از هر چیز به اجتماعی‌شدن مجدد اهمیت داده می‌شود. در شرایط درمانی خاصی که در این روش ایجاد می‌گردد حس اجتماعی بیمار یعنی احساس امنیت، احساس مسئولیت وحس همکاری که از نشانه‌های سلامت می‌باشند به بیمار بازگردانده می‌شود.

از وظایف و اهداف کاردرمانی در توان‌بخشی بیماران روانی می‌توان به موارد ذیل اشاره داشت:

- کمک به تیم درمانی در فرایند توان‌بخشی.
- سعی در بهبود و پرورش قابلیت‌های بیمار با ارتقاء و تکامل مهارت‌ها و تواناییهای بیمار.
- کاهش علائم و عوارض بیماری تا آنجا که بیمار وظایف خود را در مسیر واقعیات زندگی و اجتماعی ایفاء نماید.
- بهبود و پرورش تمرکز حواس و دقت و توجه بیمار.
- سعی در افزایش قدرت تصمیم‌گیری و عادات صحیح نسبت به کار و فعالیت‌های روزانه
- ارشاد و تربیت بیماران برای کسب اعتماد به نفس در تأمین زندگی مستقل

سیستمی پدید می‌آورند که نظام نامیده می‌شود و آنها که خود را با این نظامی که مورد تأیید است تطابق دهند افرادی طبیعی و عادی محسوب می‌شوند و طبیعتاً آنها که برخلاف چنین وضع و مسیری قرار می‌گیرند افرادی ناسازگار و غیرعادی نامیده خواهند شد.

حیات اجتماعی برخی انسان‌ها به دلایلی دچار اختلالاتی می‌شود که عارضه این اختلال عامل پدید آورنده معلولیت اجتماعی می‌گردد. پیشگیری از بروز این معلولیت، تشخیص زودرس آسیب‌های اجتماعی و جلوگیری از شدت‌یافتن آن ضرورت اجتناب‌ناپذیری محسوب می‌شود که باید موردتوجه قرار بگیرد.

۸-۲ تعریف معلولیت اجتماعی

معلول اجتماعی به فردی اطلاق می‌گرددکه در نتیجه نابسامانی‌های اجتماعی – اقتصادی، ناهنجاری‌های فرهنگی – تربیتی و وضع نامساعد خانوادگی دچار انواع انحرافات رفتاری و اخلاقی شده باشد. همچنان‌که از تعریف مذکور بر می‌آید، معلول اجتماعی بر حسب عامل انحراف[1] تعریف می‌شود (کریمی‌درمنی، ۱۳۸۵).

۸-۳ تعریف انحراف ازدیدگاه‌های متفاوت

روان‌شناسان: کجروی یا انحراف عبارت است از: خروج از حالت تعادل روانی و رفتاری و یا فقدان همسازی و وحدت بین اجزای شخصیت و داشتن رفتاری منحرفانه.

جامعه‌شناسان: انحراف، رفتاری تبهکارانه محسوب می‌شود که خلاف موازین اجتماعی مورد قبول است و وجودش برای دوام نظام و ایجاد عدالت زیان‌بخش می‌باشد.

حقوقدانان: کجروی عبارت است از انجام عملی که به صورت قانون شکنی و یا سرپیچی از قانون باشد و یا عملی است که قانون‌گذار آن را به عنوان رفتاری ناهنجار و ضداجتماعی معرفی کند.

علمای اخلاق: انحراف عبارت است از عدم رعایت و نادیده‌گرفتن ضوابط اخلاقی جامعه و یا انحراف، نوعی دوری از راه اصلی و سرپیچی و تخلف از

نظر در ارائه تعریف واحد از این پدیده و مفاهیم مرتبط با آن عنوان شده است اما به‌طور کلی تعاریف مختلف دارای سه جزء مشترک می‌باشند که عبارت است از:

- این کودکان وقت زیادی را در خیابان سپری می‌کنند؛
- خیابان منبع معاش کودکان است؛
- از آنها به طور شایسته و مطلوب توسط بزرگسالان نگهداری نمی‌شود.

اقدامات توان‌بخشی کودکان خیابانی: پیشگیری از جمله اقدامات توان‌بخشی در زمینه این کودکان به شمار می‌آید.

الف) پیشگیری اولیه

- اتخاذ سیاست‌هایی که منجر به کاهش فقر، تامین عدالت اجتماعی، تامین رفاه اجتماعی در جامعه می‌گردد.
- تدوین قوانین مناسب جهت حمایت از حقوق کودکان
- گسترش چتر آموزش کودکان در مناطق محروم و ایجاد زمینه‌های مناسب برای ادامهٔ تحصیل کودکان شاغل.

ب) پیشگیری ثانویه

- تعیین پذیرش مسئولیت قانونی کودکان خیابانی توسط یکی از سازمان‌های دولتی از طرف شورای اجتماعی کشور
- شناسایی کودکان خیابانی با بررسی مدارک و شناسنامه‌های آنها برای تفکیک آنان از نظر داشتن خانواده و سایر مشخصات (سن، جنس، و تحصیلات).
- ایجاد پناهگاه‌هایی برای آن گروه از کودکان که بنا عللی مانند مهاجرت، نداشتن سرپناه، وضعیت نامساعد سکونت و. . . شب‌ها را در خیابان سپری می‌کنند.
- ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی به کودکان در این پناهگاه‌ها.
- ارائه کمک‌های مالی و خدمات حمایتی به خانوادهٔ این کودکان.
- به‌کارگماردن آن گروه از کودکان خیابانی که بیش از ۱۵ سال دارند و یا حتی کمتر با رعایت شرایط کار کودکان ونظارت مداوم بر آن. (کریمی‌درمنی، ۱۳۸۵).

محققین اجتماعی و روان‌شناختی را به چاره‌جویی واداشته است و بی‌شک بزهکاری کودک و نوجوان به عنوان یک پدیدهٔ زیستی، روانی و اجتماعی مطرح می‌شود.

اقدامات توانبخشی کودکان بزهکار: مسئولیت جامعه در قبال اطفال بزهکار، بیش از مجرمین بزرگسال است. تحقیقات نشان داده است اکثر مجرمین به عادت کسانی هستند که اولین جرم خود را در سنین طفولیت مرتکب شده اند. بنابراین بازسازی کودکان بزهکار، به مراتب مؤثر تر و ساده‌تر از اقدامات دیررس در سنین بالاتر است. بازداشت موقت و شیوه دستگیری اطفال در قوانین بین‌الملل تغییر کرده است. بازداشت و نگه‌داری اطفال باید آخرین راه بر خورد با بزه کودکان باشد. در پرتو روح کنوانسیون حقوق کودک، نگرش قضایی و سیستم حقوقی، متناسب با نیازهای کودک باشد (دانش، ۱۳۷۲). اقدامات توان‌بخشی برای باز گردانیدن این نوع کودکان به خانواده با توجه به تنوع بزهکاری شایع بین آنان از قبیل سرقت، قاچاق مواد مخدر، ضرب و جرح، انحرافات جنسی، استعمال مواد مخدر بسیار مشکل و مستلزم همکاری صمیمانه جامعه، خانواده، مسئولین کانون اصلاح و تربیت با کادر توان‌بخشی یعنی روان‌پزشکان، روان‌شناسان بالینی و مددکاران اجتماعی خواهد بود. مددکار اجتماعی ضمن همکاری با اعضای تیم در بازسازی شخصیت اطفال بزهکاردر بررسی مسائل و مشکلات آنان در محیط خانواده نقش بسیار مهمی ایفاء می‌نماید و به عبارت دقیق‌تر رابطی است بین مسئولین کانون اصلاح و تربیت و خانواده کودک بزهکار که زمینه را برای بازگشت آنان به خانواده و جامعه مهیا می‌سازد.

۸-۶ محکومین درازمدت زندان‌ها

اصطلاحاً محکومین دراز مدت زندان‌ها به آن گروه از زندانیانی اطلاق می‌گردد که مرتکب جرم و جنایت بزرگ شده‌اند و بدین جهت محکومیت آنها طولانی است.

آثار نامطلوب زندان واقعیتی اسف‌انگیز و انکارناپذیر است. آثاری چون تأثیر محیط زندان در شخصیت و منش زندانی، ایجاد یا تقویت حس انتقام‌جویی و جامعه ستیزی در زندان، ایجاد اختلال و بحران در وضع اقتصادی خانوادهٔ زندانی، محرومیت فرزندان زندانی از سرپرستی و حمایت معنوی می‌تواند زمینه‌ساز پذیرش انواع آسیب‌های اجتماعی باشد.

اقدامات توان‌بخشی معتادین: از اقدامات مؤثر در این مسئله مبادرت در امر بازپروری معتادین می‌باشد. بازپروری معتادین، در معنای کلی، عبارت از فعالیت‌های تربیتی، آموزشی، پزشکی و مددکاری اجتماعی که در جهت اعتیادزادیی و بازگردانیدن فرد معتاد به شرایط طبیعی زندگی صورت می‌گیرد.

به کمک بازپروری، می‌توان شخصیت و منش و رفتار فرد معتاد را بازسازی کرد و او را آمادهٔ زندگی و کار و پذیرش مسئولیت‌های فردی و اجتماعی ساخت، به عبارت دیگر بازپروری فعالیتی است علمی و تخصصی که از طریق آن به مدد شیوه‌ها، فنون تکنولوژی و یا بهره‌گیری از دانش‌های جدید فرد از بندهای اعتیاد نجات می‌یابد و شرایط و امکانات سازگاری با محیط اجتماعی برای او فراهم می‌شود (محسنی تبریزی، الف ۱۳۸۰)

۸-۸ متکدیان

تکدی پدیده‌ای است اجتماعی که هم بر سرنوشت فرد و هم بر کل جامعه اثر می‌گذارد. تکدی از آن رو پدیده‌ای اجتماعی است که در هر جامعه صورتی خاص می‌یابد، انواعی چند می‌پذیرد و با روش‌های خاص متحقق می‌شود. زمانی که در یک جامعه ارزش‌ها سخت مخالف تکدی است، افراد بی‌بضاعت راه‌های دیگری برای ارتزاق می‌یابند و حال آنکه در برخی از جوامع تکدی را از آغاز همچون شیوه‌ای معمول و مقبول مطرح می‌سازند.

متکدیان از طریق جلب ترحم دیگران و جمع‌آوری اعانات، گاهی علاوه بر تأمین معاش خود به مال‌اندوزی می‌پردازند. مسئله عمدهٔ گروه متکدیان، مضاعف بر سربار بودن، آمادگی برای ارتکاب جرائم مختلف است. بررسی‌های انجام شده محرز ساخته که معمولاً در تعداد قابل توجهی از جرائم، ردپای متکدیان مشهود است. ساخت خاص هر جامعه زمینه‌ساز کمیت و کیفیت پدیده تکدی است. به بیان بهتر تکدی در هر جامعه شکل خاص آن جامعه را به خود می‌گیرد و بدون شناخت کل آن جامعه قابل تفسیر یا تقلیل نیست.

بین تکدی و جامعه نوعی کنش و واکنش وجود دارد. از جانبی تکدی در بستر جامعه پدید آمده، رشد می‌یابد و از جانبی دیگر پس از پیداییش خود بر جامعه تأثیر می‌گذارد. شهری که در آن هزاران متکدی وجود دارد خواه ناخواه چهره‌ای زشت،

۷. بیمار افسرده دو قطبی در وضع. . . . کم خواب، پرخور و پرحرف است.

الف) افسردگی　　ب) شیدایی

ج) عدم تناسب عواطف　　د) رفتار غیر عادی

۸. مطابق آمار بین‌المللی. . . . در صد مردم به انواع اختلالات روانی دچارند.

الف) ۱۵　　ب) ۲۰

ج) ۲۵　　د) ۳۰

۹. نقش روان پرستار در توان‌بخشی افراد دچار اختلالات روانی را توضیح دهید.

۱۰. اصلی‌ترین برنامه برای آحاد جامعه در آشنایی با بیماری‌های روانی. . . . . می‌باشد و ابزار مناسب این کار. . . . . است.

۱۱. سامان‌دهی درمان اختلالات روانی در جامعه را توضیح دهید.

مذهب: تخطی از جنبه‌های اعتقادی و تعالیم مذهبی و یا سرپیچی و طغیان در برابر اوامر و منهیات پرودگار (نودهی مقدم وجغتایی، ۱۳۸۵).

۸-۴ طبقه‌بندی معلولان اجتماعی

همانگونه که در فصل اول اشاره گردید معلولان اجتماعی از دیدگاه توان‌بخشی در ۵ طبقه نام‌گذاری می‌گردند که عبارتند از:

- کودکان آسیب‌دیده
- محکومین دراز مدت زندان‌ها
- معتادین
- متکدیان
- روسپیان (زنان ویژه)

۸-۵ کودکان آسیب‌دیده / اقدامات توان‌بخشی

۸-۵-۱ کودکان بی‌سرپرست

کودک بی‌سرپرست به کودکی اطلاق می‌شود که به علل گوناگون از حمایت، مراقبت و نگه‌داری مؤثر توسط خانواده، محروم بوده و امکان زندگی در محیط خانواده را ندارد (محسنی تبریزی، ب۱۳۸۰) به عبارت دیگر اگر کودک قبل از سن تشخیص و قبل از آنکه بتواند به تنهایی نیازهای خود را تأمین نماید اولیای خود را از دست بدهد، بی‌سرپرست نامیده می‌شود (بابایی و همکاران، ۱۳۶۹). از دست دادن سرپرست یکی از عمده‌ترین عواملی است که باعث از هم گسیختگی خانواده‌ها می‌گردد. خانواده با ازدست‌دادن سرپرست خود به عللی چون: فوت، طلاق، از کار افتادگی و یا بیماری دچار مشکلات متفاوتی می‌شود، میزان و نوع این مشکلات با توجه به عوامل مختلف در خانواده‌ها فرق می‌کند. از پیامدهای اولیه ازدست‌دادن سرپرست، پدیدارشدن مشکلات اقتصادی از جمله مشکل تأمین معاش خانواده است. این امر خصوصاً در خانواده‌هایی که از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند و نیز آنهایی که تنها یک نفر تأمین کننده اصلی مایحتاج خانوار است، بیشتر قابل مشاهده است. کار مادر در خارج از منزل و عدم توانایی وی در کنترل فرزندان و همچنین انواع کمبودهای مادی و

باشند (حیات روشنایی، ۱۳۸۱). ازجمله اقدامات مؤثر در پیشگیری از فرار کودکان عبارتند از:

- آموزش اصول و شیوه‌های درست تربیتی به والدین کشور.
- آموزش مهارت‌های زندگی به دختران دانش‌آموز در مدارس.
- ایجاد بانک اطلاعاتی درخصوص دانش‌آموزان دارای مشکلات خانوادگی.
- تدوین دستورالعمل قاطع و واقع‌بینانه برای مربیان و مسئولین مدارس در برخورد علمی و منطقی با دانش‌آموزان مشکل‌دار.
- ایجاد محدودیت در اخراج دانش‌آموزان ناموفق در امر تحصیل.
- تدوین قوانین مناسب حمایتی ازکودکان با شرایط فرهنگی جامعه با ضمانت اجرایی.
- ایجاد و گسترش مراکز راهنمایی و مشاوره در سراسر کشور به‌ویژه مناطقی که بیشترین آمار فرار کودکان را دارند. (صمدی راد، ۱۳۸۱).

۸-۵-۴ کودکان بزهکار

اقدام به هرگونه عملی که برخلاف موازین، مقررات، قوانین و هنجارهای اجتماعی هر جامعه‌ای باشد، در آن جامعه، بزهکاری یا جرم تلقی می‌گردد و کسانی که مرتکب چنین اعمال خلاف می‌گردند، مجرم یا بزهکار نامیده می‌شوند (فرجاد، ۱۳۷۴).

بزهکاری اساساً ویژه یک جامعه یا یک فرهنگ نیست همه جوامع بشری و همهٔ فرهنگ‌ها با آن درگیر و به آن مبتلا هستند. مفهوم بزه در تمام جوامع انسانی، یعنی دست یازی به برخی اعمال علیه قانون که این اعمال می‌توانند دارای ماهیتهای گوناگونی مانند آسیب به اموال، صدمه به افراد، لطمه به نظم عمومی یا ارزش‌های حاکم باشد بین مجرم و بزهکار از لحاظ معنی و مفهوم تفاوتی نیست فقط تفاوت در این است که بزهکار به فردی اطلاق می‌گردد که در هنگام ارتکاب جرم، سن او کمتر از سن معینی باشد (صالح‌فر، ۱۳۷۴).

تعیین میزان سن به دست قانون است و بر حسب جوامع مختلف متفاوت می‌باشد. در ایران این سن ۱۸ سال است. امروزه گرایش کودکان و نوجوانان به بزهکاری، یکی از مهمترین مشکلاتی است که گریبان‌گیر خانواده‌ها و جامعه شده و

بنابراین، محکومین درازمدت زندان‌ها پس از آزادی به علل محکومیتی که داشته‌اند (برچسب سابقه‌داربودن) دوری از جامعه (عدم تعامل زندانی با افراد متعارف جامعه) و تأثیرپذیری از زندانیان دیگر امکان یافتن شغل و ادامهٔ زندگی به طرز عادی از آنان سلب گردیده و لذا در زمرهٔ معلولین اجتماعی قرار می‌گیرند. بدین معنی که مشکلات خانوادگی، بحران‌های عاطفی – روحی و مشکلات رفتاری به این گونه افراد، شخصیتی انعطاف‌ناپذیر و غیرقابل معاشرت با دیگران می‌دهد. از طرفی سوء سابقه و محکومیت کیفری به عوامل مذکور اضافه شده و بدین‌ترتیب محکومین مورد بحث برای همیشه از یافتن حرفه‌ای مناسب که بتواند زندگی آنان را از نظر اقتصادی تامین نماید محروم می‌سازد. از این رو افراد مذکور برای تأمین زندگی خویش با توجه به تأثیرپذیری سوء از زندانیان دیگر مجدداً مرتکب سرقت وجرایم مشابه می‌گردند و این دایرهٔ معیوب گاهی سال‌ها و سال‌ها تکرار می‌گردد و در نتیجه چنین افرادی از نظر اجتماعی شخصی معلول به شمار می‌آیند و برای ادامهٔ زندگی خویش نیاز به اقدامات توان‌بخشی دارند. (کریمی‌درمنی، ۱۳۸۵).

اقدامات توان‌بخشی محکومین درازمدت زندانیان : گرچه از دیرباز تا سال‌های اخیر، هدف اصلی از مجازات زندان تنبیه مجرم و قراردادن او در محیطی بسته و دور از جامعه بوده است، اما طی چند دههٔ گذشته کارشناسان علوم اجتماعی به‌ویژه جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و متخصصین جرم شناسی به این نتیجه رسیده‌اند که علاوه بر هدف یاد شده، نباید از آموزش و بازتوانی زندانیان و فراهم‌آوردن شرایط مناسب برای بازگرداندن آنها به زندگی عادی در جامعه غافل بود.

به طور کلی اهم اقداماتی که در توان‌بخشی محکومین دراز مدت زندان‌ها، در مدت محکومیت آنها انجام می‌پذیرد تا زندانی پس از آزادی بتواند به عنوان یک فرد متعارف در جامعه زندگی نماید، عبارتند از:

۱. تأمین احتیاجات مادی و معنوی خانواده توسط انجمن حمایت از زندانیان نیازمند.

۲. پیشگیری از تأثیر نامطلوب مجازات حبس بر مجرمان از طریق:

- سوادآموزی، حرفه‌آموزی و اشتغال به کار در کارگاه‌های زندان با دریافت دستمزد.
- آموزش مهارت‌های اجتماعی توسط مددکاران اجتماعی و روان‌شناسان از طریق تشکیل جلسات گروهی مددکاری و گروه درمانی
- فعالیت‌های ورزشی و هنری

توان‌بخشی معلولان اجتماعی

اهداف فصل

در پایان این فصل از شما انتظار می‌رود بتوانید:

۱. معلولان اجتماعی را تعریف کنید.
۲. معلولان اجتماعی را از دیدگاه توان‌بخشی طبقه‌بندی کنید.
۳. اقدامات توان‌بخشی در کودکان آسیب‌دیده را به تفکیک توضیح دهید.
۴. پیشگیری ثانویه را در کودکان خیابانی به عنوان یک اقدام توان‌بخشی توضیح دهید.
۵. دلایل عمده فرار کودکان را نام ببرید.
۶. اهم اقدامات توان‌بخشی در محکومین دراز مدت زندان‌ها را لیست نمایید.
۷. بازپروری معتادین را تعریف کنید.
۸. اقدامات مؤثر در برخورد با تکدی را بیان کنید.
۹. توان‌بخشی و بازپروری روسپیان را توضیح دهید.
۱۰. سطوح پیشگیری آسیب‌های اجتماعی را بیان کنید.

۸-۱ مقدمه

انسان موجودی اجتماعی است و اگر حیات اجتماعی از زندگی انسان حذف گردد آدمی قادر نخواهد بود خویشتن را بسازد، به اصول و ضوابط آشنا شود و خود را ملزم به اجرای قوانین نماید. پیروی اعضای جامعه از قرارداد مورد قبول آن جامعه باعث پدیدآمدن نظم می‌شود و مجموعه‌ای متناسب و مرکب از این نظم‌ها در هر جامعه

روانی ممکن است زمینه را برای بروز کج‌روی‌های فرزندان و نوجوانان فراهم سازد و یا موجب اختلال‌هایی در رفتار اجتماعی و موفقیت تحصیلی آنها گردد.

اقدامات توان‌بخشی کودکان بی‌سرپرست: روندتاریخی حمایت از کودکان بی‌سرپرست از گذشته‌های نه چندان دور تاکنون نشانگر اهمیت دادن جامعه نسبت به کودکان بی‌سرپرست می‌باشد. بی‌شک پرورشگاه یا دارالایتام نخستین اقدام رسمی از طرف جامعه محسوب می‌گردد ولی باید درنظر داشت که خانواده نخستین آموزشگاه و محل پرورش انسان است. انتقال دهنده فرهنگ و زمینه ساز تحول و تکامل است در خانواده فرزندان تحت تعلیم و تربیت و نگه‌داری الگوی ثابت تربیتی و پرورشی که همانا پدر و مادر می‌باشند قرار می‌گیرند. درحالی‌که در پرورشگاه به‌هیچ‌وجه الگوی ثابت و خاصی برای تعلیم و تربیت و نگهداری فرزندان وجود ندارد و به‌طور دائم فرزندان در طول زندگی خود با افراد مختلف و متفاوت در تماس بوده و تأثیر می‌پذیرند.

کودک در نظام پرورشگاهی به هیچ‌کس نمی‌تواند دل ببندد و هیچ‌کس را نمی‌تواند از آن خودش بداند، هیچ‌کس در کنار کودک ثابت نیست و همه چیز به طور دایم در حال تغییر می‌باشد. وجود یک رابطه پایدار و با ثبات عاطفی شبیه فضای خانواده بسیار مؤثر است و باعث رشد شخصیت فردی و اجتماعی کودک می‌شود. از این رو سازمان بهزیستی کشور با توجه به تجربه دیگر کشورها به‌ویژه کشور فرانسه به تغییر محیط پرورشگاه‌ها از حالت بزرگتر به حالت‌های کوچکتر و نیز تأکید بر حفظ بافت خانواده و در نهایت پرورش ایتام در خانواده‌ها متمرکز کرده است (کریمی‌درمنی، ۱۳۸۵). از سال ۱۳۷۳ نیز طرح حمایت از ایتام توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) تحت عنوان «اکرام ایتام» به مرحله اجرا در آمده است. براساس این طرح افراد خیر و نیکوکار می‌توانند تکفل یک یا چند ایتام را برحسب شرایط مالی خود عهده‌دار شوند.

۸-۵-۲ کودکان خیابانی

یکی از آسیب‌هایی که به صورت جدی جامعهٔ ما را تهدید می‌کند، گسترش روز افزون کودکان خیابانی است. این پدیده یکی از آشکارترین نشانه‌های سوء رفتار و نبود پایگاه سالم اجتماعی و عدم رعایت و تأمین نیازهای اولیه کودکان است. یکی از مشکلات جدی برای ارائه تعریف نسبتاً جامع از پدیده کودکان خیابانی در ایران فقدان اجماع

۳-۵-۸ کودکان فراری

فرار کودکان از خانه یکی از انواع کجروی‌های اجتماعی محسوب می‌شودکه همانند سایر آسیب‌های اجتماعی با مجموعه پیچیده وبه هم پیوسته‌ای از شرایط و عوامل فردی، خانوادگی و ساختاری در سطح کلان مرتبط است. سرخوردگی‌های کودکان در خانواده، افت تحصیلی، شیوه گذراندن اوقات فراغت، تعامل با افراد و محیط‌های ناسالم، بی‌سوادی، بیکاری واعتیاد والدین واز هم گسیختگی‌ها و سردی محیط خانواده، استفاده ابزاری از کودکان وواداشتن آنان به انجام‌دادن اموری مافوق طاقت و توان، در شدت بخشی به این مسئله بسیار مؤثرند. فرار نوعی رفتار ناسازگارانه است که کودکان مرتکب آن می‌شوند و بدون اجازهٔ والدین یا وصی قانونی خانه را ترک می‌کنند.

در حقیقت فرار از خانه یکی از بازتاب‌های (بدسرپرستی) است که بر امنیت اجتماعی و افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی در کلان شهرها تأثیر می‌گذارد. فرار کودکان از خانه تقریباً در همه کشورها صورت می‌گیرد و از آن به عنوان یک معضل خانوادگی-اجتماعی نام برده می‌شود. فرار دختران بیش از پسران گزارش شده است. بدیهی است فراری اگر دختر باشد احتمال بیشتری دارد که وضعی ناگوارتر از هر پسر فراری داشته باشد. دختران به دلیل فشار خانواده، کنترل شدید و محدودیت در معاشرت با دوستان بیشتر از پسران دست به فرار می‌زنند و در صورت فرار به شهرهای بزرگ رفته و اغلب به پارک‌ها و اماکن عمومی پناه می‌برند. از سوی دیگر این دختران به علت شرایط سنی، بلوغ جنسی و گرایش به خودنمایی و جذب و جلب جنس مخالف، زمینه مساعدی برای انحراف و فساد اخلاقی دارند.

امروزه محققین فرار دختران را یک معضل اجتماعی می‌دانند زیرا زمینه‌ساز انواع جرایم و انحرافات نظیر فحشا، اعتیاد، قاچاق مواد مخدر، سرقت و شیوع بیماری‌های مقاربتی (نظیر ویروس ایدز) می‌باشند (جمشیدی، ۱۳۸۱).

اقدامات توان‌بخشی کودکان فراری: حل این معضل مستلزم کوششی همه‌جانبه می‌باشد. تا زمانی که هنوز پیشگیری از فرار کودکان در رأس برنامه‌های شورای اجتماعی کشور قرار نگرفته است، مراکزی که به طور موقت عهده‌دار نگه‌داری از این‌گونه پسران و دختران می‌شوند، تنها می‌توانند مرهمی بر این زخم چرکین اجتماعی

۳. تدوین برنامهٔ سازگاری زندانی با زندگی در خارج از زندان در ماه‌های آخر محکومیت با استفاده از امکانات موجود در زندان‌ها وخانواده توسط مددکاران اجتماعی زندان (مرخصی کوتاه مدت) (دانش، ۱۳۷۲).

۸-۷ معتادین

تعریف نسبتاً ساده و در عین حال دقیق سازمان جهانی بهداشت از معتاد عبارت است از: فرد با هر نوع وابستگی دارویی و یا روانی به مواد مخدر، معتاد شناخته می‌شود. اصولاً معتاد به کسی اطلاق می‌گردد که به یکی از مواد افیونی اعتیادزا وابستگی نسبی و رفتاری پیدا کرده، به‌طوری‌که در صورت قطع این عمل، با مشکلات جسمی، روانی و رفتاری به تنهایی و یا با هم رو به رو گردد.

علاوه بر این معتاد با تداوم مصرف از نظر ظاهری و رفتاری، به تعریف صوری معتاد در جامعه شبیه شده، آرام آرام هنجارهای جامعه معتادان و فرهنگ متعلق به ایشان را می‌پذیرد، و در نتیجه مصداق برچسبی می‌شود که معتاد نام دارد.

بسیاری از محققان مسائل مربوط به اعتیاد به خصوص اکثر افراد عادی جامعه براین باورند که ساختمان شخصیت برخی افراد برای پذیرش اعتیاد مساعدتر از دیگران است. اینان می‌پندارند که این زمینه مساعد بی گمان شرط اول و لازم ابتلاست و بدین‌ترتیب مسئله را بیش از حد ساده می‌کنند.

تحقیقات اخیر با استناد به مطالعات جامع و مدلل نشان داده شده است که در کنار افراد وابسته به یکی از مواد مخدر، تعداد قابل توجهی از افرادی را می‌توان یافت که از نظر شخصیتی مستعد اعتیاد به مواد مخدرند، یعنی در معرض خطر اعتیاد به یکی از انواع مخدرها قرار دارند. بی‌تردید افرادی که مستعد اعتیاد شناخته می‌شوند، بیش از دیگران در معرض خطر وابستگی قرار دارند. گرچند مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته است از جهت پیشگیری بی‌نهایت سودمند است، باید توجه داشت که تنها این عده نیستند که به اعتیاد گرایش پیدا می‌کنند. البته شرایط عاطفی شخصی برای سوق‌دادن فرد به اعتیاد شرطی لازم است اما مطلقاً شرط کافی به حساب نمی‌آید. (عودهی مقدم و جغتایی، ۱۳۸۵).

۸-۱۱ پیوست‌ها

با برخی از روزهای جهانی آشنا شوید (بر اساس سال میلادی و تقویم شمسی ۱۳۹۱)

۷ خرداد:روز جهانی ام اس (۲۷ می)

۱۱ خرداد:روز جهانی بدون دخانیات (۳۱ می)

۲۳ خرداد:روز جهانی منع کار کودکان (۱۲ ژوئن)

۶ تیر:روز جهانی مبارزه با مواد مخدر(۲۶ ژوئن)

۲۰ شهریور: روز جهانی پیشگیری از خودکشی (۱۰ سپتامبر)

۹ مهر: روز جهانی ناشنوایان (هفته چهارم سپتامبر هفته جهانی ناشنوایان)

۲۱ مهر: روزاسکان معلولان و سالمندان (۱۲ اکتبر)

۲۴ مهر:روز جهانی نابینایان / عصای سفید (۱۵ اکتبر)

۱۱ آذر: روز جهانی مبارزه با ایدز (۱دسامبر)

۱۳ آذر: روز جهانی معلولان (۳ دسامبر)

با پیش کسوتان فعال در حوزه معلولیت آشنا شوید:

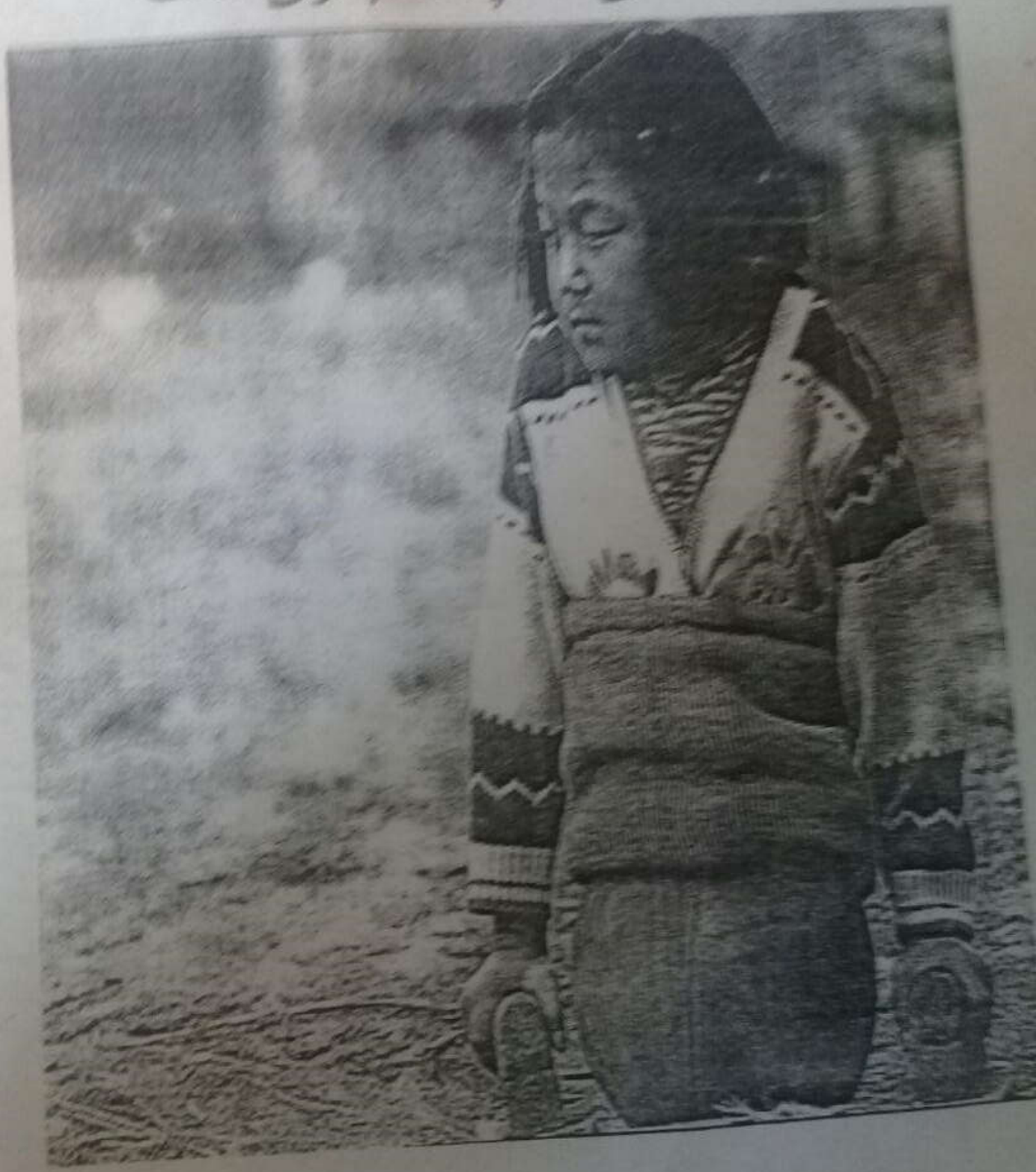
جبار باغچه‌بان: فرزند عسکر در سال ۱۲۶۴ در ایران متولد شد. جد او رضا از اهالی تبریز بود. پدرش عسکر در شهر ایروان با شغل معماری و قنادی روزگار می‌گذراند. تحصیلات باغچه‌بان با اصول قدیمی و در مساجد بود و در ۱۵ سالگی مجبور به ترک تحصیل گردید و به حرفه پدر روی آورد. در دوران جوانی اواز خبرنگاران روزنامه‌های قفقاز و از فکاهه نویسان و شاعران روزنامه فکاهه ملانصرالدین بود.

در سال ۱۹۲۲ میلادی به مدیریت مجله فکاهی لک لک در ایروان رسید. در جریان قحطی و بیماری و جنگ‌های محلی، پس از فوت پدر و مادرش، در سال ۱۲۹۸ به وطن بازگشت ودر مدرسه دولتی احمدیه در مرند با ماهی ۹۰ ریال در سمت آموزگاری مشغول به کار شد. به واسطه روش ابتکاری او در تدریس، در سال ۱۲۹۹ به موجب حکم ریاست فرهنگ تبریز، به آن شهر رفته و مشغول به کار شد. باغچه‌بان در سال ۱۳۰۳ به دستور فیوضات رئیس فرهنگ وقت، اولین کودکستان ایرانی در تبریز با نام باغچه اطفال تأسیس کرد و از همان زمان نام فامیل خود را از عسکرزاده به باغچه‌بان تغییر داد. با این منظور که همان‌گونه‌که معلمین دبستان و دبیرستان‌ها، آموزگار و دبیر نامیده می‌شوند، مربیان کودکستان‌ها هم باغچه بان نامیده شوند.

باغچه‌بان در سال ۱۳۰۳ در تبریز اولین مدرسه مختلط را در شرایطی ایجاد کرد که مردم کمتر حاضر بودند حتی پسران خود را به مدرسه بفرستند. بین دانش‌آموزان اولین کلاس درس باغچه‌بان، سه ناشنواهم بودند که وجود همین سه ناشنوا و را به فکر ایجاد مدرسه مخصوصی برای کودکان ناشنوا انداخت و به دنبال این فکر در سال ۱۳۰۵ در باغچه اطفال، کلاسی برای تعلیم و تربیت ناشنواها تأسیس نمود و سه کودک را یک سال تدریس کرد.

دکتر محسنی رئیس فرهنگ، اعانه باغچه اطفال را قطع کرد و باغچه‌بان در سال ۱۳۰۶ باغچه اطفال را بدون دریافت اعانه اداره کرد. جبار باغچه‌بان در سال ۱۳۰۷، که ریاست فرهنگ با ابوالقاسم فیوضات بود، بر حسب تقاضای وی به شیراز رفت و کودکستانی در شیراز تأسیس کرد و در این کودکستان پنج سال خدمت کرد.

زندگی همچنان جاری است



می‌اندازد. عده بی‌شماری را قربانی می‌سازد و حیات عامه را به نیستی می‌کشاند. خطر فحشا بسیار و اثرات زیانبار آن بر فرد و جامعه فوق‌العاده است.

روسپی کسی است که از روابط جنسی به عنوان یک حرفه‌ای دائمی استفاده می‌نماید. پدیده روسپیگری را به یک واقعیت تلخ اجتماعی که زاییده ضعف اخلاق و تسلط فرهنگ غربی است، توصیف نموده‌اند و از عوامل سبب‌ساز معلولیت اجتماعی شناخته‌اند. روسپیگری می‌تواند زمینه‌ساز عوامل ذیل باشد:

- در جنبهٔ فردی واخلاقی، انحراف جنسی روحیهٔ فضیلت و تقوی را در افراد از بین می‌برد.
- خانواده‌ها را تهدید به نابودی می‌کند زیرا زناشویی و جذابیت ازدواج از میان می‌رود.
- موجب بروز جرائم مثل:قتل، دزدی، استعمال مواد مخدر، قاچاق، جعل و تزویر و... می‌گردد.
- عامل بی‌بند و باری، بیکاری نسل است و تمرّد از قوانین و مشکل آفرینی برای دولت را به دنبال دارد.

اقدامات توان‌بخشی روسپیان (زنان ویژه): فحشا به عنوان یک واقعیت، نیازمند درمان و توان‌بخشی است و به رویکردی آسیب شناسانه و بهداشتی احتیاج دارد زیرا رویکرد اخلاقی و پلیسی مدت‌هاست تأثیر و کارایی خود را از دست داده است (مقدس‌فرد، ۱۳۸۱).

باید بپذیریم که بیشتر روسپیان، قربانیانی هستند که عواملی نظیر فقر، خشونت، تجاوز و نابسامانی‌های خانوادگی آنها را به یک بیماری اجتماعی کشانده است که درمان آن الزاماً در پشت میله‌های زندان امکان‌پذیر نیست. اهم اقدامات در زمینهٔ بازپروری و توان‌بخشی زنان ویژه عبارتند از:

۱. ایجاد ساختارهای حمایت‌کننده در زمینهٔ بازپروری و کاریابی از طریق:
- سواد آموزش و آموزش تعلیمات عمومی؛
- آموزش مهارت‌های زندگی از طریق تشکیل جلسات گروهی مددکاری؛
- حرفه‌آموزی؛
- اقدامات مددکاری به منظور قادرسازی آنان در برخورد با مشکلات و اهتمام به خودکفایی از طریق اشتغال (کاریابی)؛

۲. پیگیری امور پس از اشتغال به کار به‌منظور حصول از سازگاری آنان با جامعه.

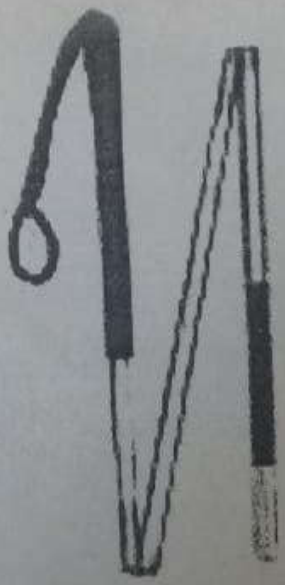
با برخی آرم‌های معلولیت‌ها آشنا شوید



ناشنوا



جسمی- حرکتی



عصای سفید/ نابینا

میرفتاح بعد از مدتی وارد دانشگاه تربیت معلم شد و در رشته تربیت بدنی به تدریس پرداخت. این موضوع برای بسیاری شگفت‌انگیز بود چرا که تدریس آن هم در رشته تربیت بدنی با صندلی چرخدار تا آن زمان محقق نشده بود. در راستای تحقق بخشیدن به خواسته قانونی و بر حق معلولین و حمایت همه‌جانبه از آنان فاطمه میر فتاح به تأسیس یک سازمان مردم نهاد در امور معلولین آسیب دیده نخاعی همت گماشت و توانست به کمک شمار دیگری از فعالان در امور معلولین در سال ۱۳۷۹ «انجمن معلولان ضایعات نخاعی استان تهران» را تأسیس کند. میرفتاح در زمان جنگ تحمیلی نیز با حضور در بیمارستان‌ها و آسایشگاه‌های جانبازان بر بالین جانبازانی که به تازگی از ناحیه نخاع، مصدوم شده بودند حاضر شد و با آموزش‌ها و اظهار نظرهای خود برای تسریع در درمان جانبازان و رسیدن آنان به آمادگی حضور مجدد در جامعه تلاش کرد

ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای تئوری و عملی در زمینه ورزش‌های معلولین موجب شد که امور ورزشی معلولان و جانبازان به صورت نظامند تدوین و ترغیب شود و با پیگیری‌های سرسختانه او ورزش معلولین به عنوان یک واحد درسی در رشته تربیت بدنی در همه مراکز آموزشی تصویب شد. همکاری مستمر با فدراسیون ورزش‌های جانبازان معلولان و کمیته ملی پارالمپیک، برگزاری همایش‌ها و سمینارهای مختلف به منظور ارائه راهکارهای جدید و ثمربخش در اداره امور معلولان، پایه‌گذاری ورزش بانوان معلول، ایجاد گروه تحقیق و انتشار ده‌ها کتاب، مجله و هفته نامه و کمک به حضور زنان ورزشکار معلول در پارالمپیک از جمله مهمترین اقدامات این بانوی سخت‌کوش است. میرفتاح در خردادماه ۱۳۸۹ دارفانی را وداع گفت.

آلوده و نامطلوب دارد. اقتضای حرفه بر زشتی، زشت‌نمایی، کراهت و جلب ترحم از این راه است. بدینسان تکدی و جامعه در تأثیر و تأثر متقابلند و این جریان در هر جامعه و در هر زمان صادق است (نودهی مقدم و جغتایی، ۱۳۸۵).

اقدامات توان‌بخشی متکدیان: تکدی پدیده‌ایست اجتماعی با زمینه‌ها و ابعادی بسیار، لذا در برخورد با این پدیده می‌باید جنبه‌های حقوقی، روانی و فرهنگی آن را مد نظر قرار داد. اهم اقدامات در برخورد با تکدی عبارتند از:

- اقدامات راجع به تکدی نباید مقطعی باشد، بلکه باید همراه با برنامه‌ریزی صحیح انجام پذیرد.
- مبارزه با تکدی و تحت فشار قراردادن آنها، به عنوان تنها عامل جهت رفع تکدی موجب حرکت آنان به سوی دیگر آسیب‌های اجتماعی می‌گردد. لذا فشار به عنوان تنها عامل نمی‌تواند تکدی‌زدا باشد، بلکه میزان منظمی از فشار اجتماعی در این راه می‌تواند مفید باشد.
- متکدیان نیازمند از متکدیان غیر نیازمند تمیز داده شوند و نسبت به مایحتاج و بازپروری آنان اقدام متقضی انجام پذیرد به بیان دقیق‌تر، اصل فردیت قائل‌شدن در مددکاری رعایت گردد، زیرا هر متکدی دارای شرایط خاص و متفاوت می‌باشد.
- در راه کاهش تکدی می‌بایست سیاست‌های ایجاد اشتغال و نیز کاهش رشد مهاجرت به شهر اتخاذ گردد.
- آگاه‌سازی افراد جامعه از عوارض روحیه گداپروری از طریق ایجاد تغییرات در دیدگاه‌های فرهنگی جامعه با استفاده از رسانه‌های گروهی (سیاست‌های دراز مدت).
- برای از بین‌بردن تکدی، ترکیب درست اقدامات وبرنامه‌ریزی هماهنگ باید توسط یک ستاد صورت بپذیرد و در آن از هر اقدام بی‌حساب، مقطعی و برنامه‌ریزی‌نشده اجتناب گردد (ساروخانی، ۱۳۷۷).

۸-۹ روسپیان (زنان ویژه)

یکی از آسیب‌های اجتماعی که خانمان‌سوز و ریشه برانداز است، فحشاست. فحشا آسیبی مهم و اجتماعی است که حیات مادی و معنوی فرد و اجتماع را به خطر

سخن پایانی

در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ۳ پیشگیری مطرح است:

سطح اول در سطح جامعه عمل می‌نماید و شامل آموزش مهارت‌های زندگی برای کل افراد جامعه به‌ویژه کودکان و نوجوانان است.

سطح دوم شامل تشخیص زودرس آسیب‌های اجتماعی همراه با اقدامات هماهنگ اجتماعی می‌باشد.

سطح سوم در صدد جلوگیری از شدت‌یافتن آسیب‌های اجتماعی و کاستن از تنش‌های آن در خانواده و جامعه فعالیت می‌نماید.

۸-۱۰ خودآزمایی

۱. انحراف را از دیدگاه روان‌شناسان و علمای اخلاق تعریف کنید.

۲. اقدامات مؤثر در پیشگیری از فرار کودکان را توضیح دهید. (ذکر ۵مورد)

۳. تفاوت مجرم و بزهکار را بیان کنید.

۴. هر نوع وابستگی..... و..... به مواد مخدر، معتاد شناخته می‌شود.

۵. پیامدهای مثبت بازپروری معتادین را توضیح دهید.

۶. در صورتی که تحت فشار گذاشتن متکدی تنها عامل تکدی‌زدایی محسوب شود چه عواقب دیگری درپی خواهد داشت؟

۷. زنان ویژه به چه زنانی اطلاق می‌شوند؟

۸. اهم اقدامات در زمینهٔ بازپروری و توان‌بخشی زنان ویژه را توضیح دهید.

۹. سطح دوم پیشگیری آسیب‌های اجتماعی به چه معناست ؟

باغچه‌بان در سال ۱۳۱۲ به تهران آمد و نام کودکستان را به کودکستان باغچه بان تغییر داد. در همین سال دبستان ناشنواها را در تهران تأسیس کرد و در همان سال دستگاهی اختراع کرد که ناشنواها از طریق دندان وحس استخوانی قادر به شنیدن می‌شدند این دستگاه پس از تکمیل‌شدن به نام تلفن گنگ در اداره ثبت اختراعات به تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۱۲ به شماره ۱۱۸ به ثبت رسید.

در سال ۱۳۲۲ جمعیتی به نام جمعیت حمایت از کودکان ناشنوا را تأسیس نمود باغچه‌بان در سال ۱۳۲۳ برای مجله‌ای به نام سخن تقاضای امتیاز کرد، اما چون قبلاً امتیاز مجله‌ای به همین نام صادر شده بود، امتیاز مجله زبان به نام او صادر شد و اولین شماره آن در اول بهمن ۱۳۲۳ انتشار یافت. باغچه‌بان طی سال‌ها تعلیم و تربیت به کودکان ناشنوابه روشی دست یافت که امروز آن را روش ترکیبی می‌گویند. میرزا جبار عسکرزاده باغچه بان در روز چهارم آذر ماه سال ۱۳۴۵ خورشیدی دار فانی را وداع گفت.

فاطمه حاج میرفتاح: چهره آشنای معلولان و جانبازان نخاعی، در سال ۱۳۲۵ در تهران متولد شد. وی بعد از گذراندن دوران کودکی، وارد مدرسه ابتدایی تهمینه و سپس در دبیرستان طبری مشغول تحصیل شد و رشته اصلی ورزشی او بسکتبال بود و همین علاقه باعث شد با وجود مخالفت خانواده در انتخاب رشته دانشگاهی، در رشته تربیت بدنی تحصیلات خود را ادامه داد.

میرفتاح در سال ۱۳۴۷ازدواج کرد و تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل به آمریکا برود و در تگزاس موفق شد مدرک کارشناسی ارشد و دکتری خود را در رشته تربیت‌بدنی دریافت کند. وی در سال ۱۳۵۷ در آمریکا بر اثر سانحه رانندگی، دچار معلولیت و آسیب دیدگی نخاعی شد؛ در سال ۱۳۵۹هنگامی‌که تنها فرزندش آرش سه سال بیشتر نداشت در یک مرکز توان‌بخشی در آلمان تحت درمان قرار گرفت که بی‌نتیجه بود و همین مسئله موجب شد تا در سال ۱۳۶۳ همسرش او و پسرش آرش را تنها بگذارد اما این بانوی سخت‌کوش و مقاوم با این که در اوج جوانی بود و از وضعیت دشوار جسمی رنج می‌برد، نه تنها خود را نباخت و منزوی نشد بلکه با همت خود، علاوه بر تربیت فرزندش با حفظ روحیه بالا به خود و هزاران معلول قطع نخاع کمک کرد و بنیانگذار اقدامات مؤثری برای کاهش آلام مصدومان نخاعی شد.

فصل هفتم

توان‌بخشی معلولان روانی

اهداف فصل

در پایان این فصل از شما انتظار می‌رود بتوانید:

۱. اختلال روانی را از دیدگاه توان‌بخشی تعریف کنید.
۲. اختلالات روانی را گروه‌بندی و تفاوت آنها را مشخص کنید.
۳. روش‌های ارزیابی روان‌شناختی اختلال روانی را توضیح دهید.
۴. لیستی از نیازهای توان‌بخشی افراد دچار اختلالات روانی ارائه نمایید.
۵. پیشگیری اولیه از بروز اختلالات روانی را به عنوان نیاز و اقدام توان‌بخشی توضیح دهید.
۶. تأثیر مشاوره برای بیمار دچار اختلال روانی را تشریح کنید.
۷. ابعاد آموزش به خانواده را لیست کنید.
۸. انواع حمایت از خانواده ای که دچار بیمار با اختلال روانی است را نام ببرید.
۹. آموزش به آحاد جامعه را بر اساس نیازهای افراد دچار اختلالات روانی لیست کنید.
۱۰. اهمیت آموزش به خانواده در توان‌بخشی افراد دچار اختلالات روانی را بیان کنید.
۱۱. نقش مددکار اجتماعی را در افراد دچار اختلالات روانی توضیح دهید.
۱۲. پیامدهای منفی عدم ساماندهی به درمان اختلالات روانی در جامعه را ذکر کنید.

۷-۱ مقدمه

بیماری‌های حوزه روح و روان بیماری‌هایی هستند که به‌طور مستقیم اساسی‌ترین لایه